เอกสารวิชาการที่ กว 15/2568



หนังสือเรียนรายวิชา
สุขภาวะและศิลปะ

รหัสรายวิชา สศ310001

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
ในพื้นที่นำร่องตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด

หนังสือเรียนรายวิชา สุขภาวะและศิลปะ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสรายวิชา สศ310001
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567

กรมส่งเสริมการเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

หนังสือเรียนสุขภาวะและศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รหัสรายวิชา สศ310001) เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567 ภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

การจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาสมรรถนะเฉพาะ (มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ) และตัวชี้วัดหรือสมรรถนะย่อยของรายวิชาและระดับที่กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567 สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดกรอบเนื้อหาสาระภายในหนังสือเรียนเล่มนี้ โดยมุ่งหวังให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้จัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและหรือคุณลักษณะตามที่กำหนดไว้ในสมรรถนะเฉพาะ (มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ) และตัวชี้วัดหรือสมรรถนะย่อยของรายวิชาได้

หนังสือเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 15 บท ได้แก่ บทที่ 1 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย บทที่ 2 อาหารและโภชนาการ บทที่ 3 ความปลอดภัยจากการใช้ยา บทที่ 4 โรคทางพันธุกรรม บทที่ 5 การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21 บทที่ 6 ความหลากหลายทางเพศ บทที่ 7 การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ บทที่ 8 ผลกระทบจากสารเสพติด บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ บทที่ 10 กิจกรรมทางกายและกีฬา บทที่ 11 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต บทที่ 12 ศิลปะสากล บทที่ 13 ดนตรีสากล บทที่ 14 นาฏศิลป์สากล และบทที่ 15 การประกอบอาชีพด้านศิลปะ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักวิชาการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือเรียนเล่มนี้ทุกท่าน

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ครูหรือผู้ที่ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในรายวิชา สุขภาวะและศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รหัสรายวิชา สศ310001) ได้โดยการนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ต่อไป

(นายธนากร ดอนเหนือ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**ก**
สารบัญ	**ข**
คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน	**จ**
โครงสร้างรายวิชาสุขภาวะและศิลปะ	**ฉ**
แบบทดสอบก่อนเรียน	**1**
บทที่ 1 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย	**5**
เรื่องที่ 1 โครงสร้าง หน้าที่ การทำงานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย	6
เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย	18
แนวคำตอบกิจกรรม	22
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการ	**24**
เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร	25
เรื่องที่ 2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร	27
เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ	30
แนวคำตอบกิจกรรม	35
บทที่ 3 ความปลอดภัยจากการใช้ยา	**37**
เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีใช้ยา	38
เรื่องที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา	40
เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยา การป้องกัน และการช่วยเหลือ	43
เรื่องที่ 4 การแนะนำในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา	47
แนวคำตอบกิจกรรม	51
บทที่ 4 โรคทางพันธุกรรม	**53**
เรื่องที่ 1 ความหมายของโรค และประเภทของโรคทางพันธุกรรม	54
เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย	58
เรื่องที่ 3 การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม	64
เรื่องที่ 4 การรักษาโรคทางพันธุกรรม	67
เรื่องที่ 5 การป้องกันโรคทางพันธุกรรม	69
แนวคำตอบกิจกรรม	71
บทที่ 5 การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21	**74**
เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะ	75
เรื่องที่ 2 การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ	79
เรื่องที่ 3 สุขภาวะดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21	84
แนวคำตอบกิจกรรม	88

บทที่ 6 ความหลากหลายทางเพศ **91**
เรื่องที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ 92
เรื่องที่ 2 แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ 97
แนวคำตอบกิจกรรม 100
บทที่ 7 การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ **101**
เรื่องที่ 1 หลักการเสริมสร้างและดำรงสุขภาพของบุคคลและชุมชน 102
เรื่องที่ 2 ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 106
เรื่องที่ 3 กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน 112
แนวคำตอบกิจกรรม 124
บทที่ 8 ผลกระทบจากสารเสพติด **126**
เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการแพร่ระบาดของสารเสพติด 127
เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน 130
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 134
แนวคำตอบกิจกรรม 146
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ **148**
เรื่องที่ 1 มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 149
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 152
แนวคำตอบกิจกรรม 156
บทที่ 10 กิจกรรมทางกายและกีฬา **158**
เรื่องที่ 1 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน 159
เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม 169
เรื่องที่ 3 กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 172
เรื่องที่ 4 กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ 177
เรื่องที่ 5 กีฬาบาสเกตบอล 180
แนวคำตอบกิจกรรม 188
บทที่ 11 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต **191**
เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ 192
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จำเป็น 3 ประการ 195
เรื่องที่ 3 ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ไขปัญหาชีวิต 197
เรื่องที่ 4 การแนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น 200
แนวคำตอบกิจกรรม 202
บทที่ 12 ศิลปะสากล **205**
เรื่องที่ 1 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท คุณค่าความสำคัญของศิลปะสากล 206
เรื่องที่ 2 หลักองค์ประกอบศิลป์ 212

เรื่องที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาประดับตกแต่งร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งสถานที่ สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 219
แนวคำตอบกิจกรรม 222
บทที่ 13 ดนตรีสากล 226
เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 227
เรื่องที่ 2 รูปแบบและเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท 229
เรื่องที่ 3 คุณค่าและความไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรีสากล 231
แนวคำตอบกิจกรรม 234
บทที่ 14 นาฏศิลป์สากล 236
เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลประเภทต่าง ๆ 237
เรื่องที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลในโอกาสต่าง ๆ 240
เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน 243
แนวคำตอบกิจกรรม 246
บทที่ 15 การประกอบอาชีพด้านศิลปะ 249
เรื่องที่ 1 ประเภทของการออกแบบ 250
เรื่องที่ 2 การประยุกต์ใช้ศิลปะกับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบ 255
เรื่องที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะของนักออกแบบ 261
แนวคำตอบกิจกรรม 264
แบบทดสอบหลังเรียน 266
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 270
บรรณานุกรม 271
ภาคผนวก 274
คณะผู้จัดทำ 297

คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน

หนังสือเรียนรายวิชาสุขภาวะและศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รหัสรายวิชา สศ310001) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้หนึ่งในการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567

ในที่นี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ จึงมีคำแนะนำการใช้หนังสือเรียนแก่ผู้เรียน และครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ ดังนี้

1. ผู้เรียน และครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ ควรมีการศึกษาสาระสำคัญและสมรรถนะเฉพาะ (มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ) ที่กำหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชาเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ตัวผู้เรียน
2. ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ ควรมีการศึกษาเนื้อหาสาระ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนเล่มนี้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ได้
3. ผู้เรียนควรมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ทราบถึงพื้นความรู้ของตนเองที่มีอยู่ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในแต่ละบท ภายในหนังสือเรียนเล่มนี้
4. ผู้เรียนควรมีการศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาสาระ จากสถานการณ์ เหตุการณ์ กรณีศึกษา เนื้อหา ใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละบท ภายในหนังสือเรียนเล่มนี้อย่างต่อเนื่อง ให้ครบถ้วน ตามลำดับตลอดทั้งเล่ม และถ้าหากพบว่าส่วนใดมีการเขียนคำชี้แจงไว้ ให้ผู้เรียนอ่านและทำความเข้าใจคำชี้แจงนั้นก่อนทุกครั้ง
5. ในระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ หากผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือเรียนเล่มนี้ หรือมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนขอคำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากครูหรือผู้จัดการเรียนรู้
6. ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียนรู้ โดยไม่ดูแนวคำตอบหรือดูเฉลยคำตอบก่อนการทำใบงาน กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดที่กำหนดไว้ในแต่ละบท ภายในหนังสือเรียนเล่มนี้
7. ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ ควรมีการแนะนำแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้อื่นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
8. ผู้เรียนควรมีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ ตามที่ตนเองสนใจและสะดวกในการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชาสุขภาวะและศิลปะ

สาระสำคัญ

การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะและศิลปะมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ โดยทั้งสองสิ่งนี้มีบทบาทที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในเรื่องสุขภาวะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแล เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ความรู้เรื่องระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การเลือกอาหารและโภชนาการที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละวัย ความปลอดภัยจากการใช้ยา การดูแลและป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนจากโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางการพัฒนาสุขภาวะในอนาคตกับการพัฒนาประเทศ ความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศ การเล่นกิจกรรมทางกายและกีฬา ซึ่งสามารถปฏิบัติตนเองได้ให้มีสุขภาวะที่ดี ตลอดทั้งการให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นทั้งในครอบครัวและคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ทักษะชีวิตในการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้อย่างมีศิลปะ และด้านศิลปะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและความสำคัญของศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีสากล ทำให้มีมุมมองถึงวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาคได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขและสมดุล

สมรรถนะเฉพาะ

สุขภาวะ

1. รู้ เข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ

ของร่างกาย อาหารและโภชนาการ ความปลอดภัยจากการใช้ยา โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21 ความหลากหลายทางเพศ การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ ผลกระทบจากสารเสพติด การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกายและกีฬาทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี การดำรงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสาและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในฐานะพลเมืองโลก

3. ปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัย โดยการวางแผนพัฒนาสุขภาพเพื่อดำรงสุขภาพของตนเอง ครอบครัวอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ศิลปะ

1. รู้ เข้าใจ และอธิบายความหมาย ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบ คุณค่าความสำคัญ หลักองค์ประกอบศิลป์ ประเภทของศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สากล

2. ปฏิบัติงานโดยนำความรู้เกี่ยวกับศิลปะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. มีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่า วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ จินตนาการและสร้างสรรค์ของศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สากล

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการ
บทที่ 3 ความปลอดภัยจากการใช้ยา
บทที่ 4 โรคทางพันธุกรรม
บทที่ 5 การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21
บทที่ 6 ความหลากหลายทางเพศ
บทที่ 7 การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ
บทที่ 8 ผลกระทบจากสารเสพติด
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
บทที่ 10 กิจกรรมทางกายและกีฬา
บทที่ 11 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต
บทที่ 12 ศิลปะสากล
บทที่ 13 ดนตรีสากล
บทที่ 14 นาฏศิลป์สากล
บทที่ 15 การประกอบอาชีพด้านศิลปะ

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ระบบใดมีหน้าที่หลักในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
   ก. ระบบย่อยอาหาร
   ข. ระบบประสาท
   ค. ระบบไหลเวียนโลหิต
   ง. ระบบขับถ่าย

2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีผลดีต่อระบบอวัยวะใดมากที่สุด
   ก. ระบบสืบพันธุ์
   ข. ระบบกล้ามเนื้อและระบบหัวใจ
   ค. ระบบประสาท
   ง. ระบบต่อมไร้ท่อ

3. ข้อใด**ไม่ใช่**สิ่งสำคัญที่สุดในการเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย
   ก. การพักผ่อนเพียงพอ
   ข. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
   ค. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
   ง. การท่องเที่ยวกับเพื่อน

4. กิจกรรมใดต่อไปนี้**ไม่**ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย
   ก. การเล่นกีฬา
   ข. การนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
   ค. การเดิน
   ง. การว่ายน้ำ

5. หลักการโภชนาการที่สำคัญที่สุดคือการเลือกรับประทานอาหารประจำวันตามข้อใด
   ก. อาหารที่มีรสชาติอร่อย
   ข. อาหารที่มีไขมันต่ำทุกชนิด
   ค. อาหารที่มีราคาแพงและอร่อย
   ง. อาหารมีความหลากหลายและมีประโยชน์

6. ข้อใดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคโลหิตจาง
   ก. การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ
   ข. การมีระดับวิตามินบี 12 สูงเกินไปในเลือด
   ค. การขาดวิตามินซีในอาหาร
   ง. การขาดโปรตีนในอาหาร

7. อาหารในข้อใดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยมากที่สุด
   ก. สลัดผักอ่อน ไก่ทอด และโยเกิร์ต
   ข. ข้าวสวย ผัดกะเพราหมู และมันต้มขิง
   ค. โจ๊กข้าวกล้องกับไก่สับละเอียด และกล้วยน้ำว้า
   ง. ข้าวต้ม หมูสามชั้นทอด ผัดผักโขม และต้มถั่วเขียว

8. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนควรหลีกเลี่ยงอาหารในข้อใด
   ก. อาหารที่มีโปรตีนสูง
   ข. อาหารที่มีน้ำมันมาก
   ค. อาหารที่มีเส้นใยสูงและแข็ง
   ง. อาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูง

9. ข้อใดคือหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง
   ก. ใช้ยาเมื่อรู้สึกปวดหรือเจ็บ
   ข. ใช้ยาในปริมาณมากเพื่อให้หายเร็ว
   ค. ใช้ยาตามคำแนะนำของเพื่อนหรือญาติ
   ง. ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

10. ข้อใดเป็นความเชื่อที่**ไม่ถูกต้อง**เกี่ยวกับการใช้ยา
   ก. การใช้ยาที่หมดอายุไม่มีผลต่อสุขภาพ
   ข. การใช้ยามากเกินไปอาจมีผลข้างเคียง
   ค. การใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยให้หายเร็ว
   ง. การใช้ยาที่ไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์อาจทำให้เกิดอันตราย

11. ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม
   ก. ความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศ
   ข. ความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
   ค. ความผิดปกติโครโมโซมชนิดออโตโซม
   ง. ความผิดปกติของเซลล์สมอง

12. ข้อใด**ไม่ใช่**โรคทางพันธุกรรม
   ก. ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)
   ข. โรคอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม (dementia syndrome)
   ค. โรคถุงน้ำในไต (Polycystic Kidney Disease)
   ง. โรคประสาทชักกระตุก (Huntington's disease)

13. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ดีที่สุด
   ก. เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว
   ข. หากพ่อหรือแม่มีลักษณะโครโมโซมที่ผิดปกติไม่ควรจะมีบุตร
   ค. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อให้ทราบวิธีวางแผนการมีครอบครัวหรือมีบุตร
   ง. โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่ไม่สามารถคาดเดาการเกิดได้จึงไม่มีวิธีการป้องกัน

14. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
   ก. มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
   ข. ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น
   ค. เจ็บป่วย และตายด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
   ง. สามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีได้

15. ข้อใด**ไม่ใช่**พฤติกรรมของคนที่มีความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม
    ก. ชักนำบุคคลอื่นให้รักษาสิ่งแวดล้อม
    ข. ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับบุคคลรอบข้าง
    ค. ลดการสร้างขยะและมลพิษในชีวิตประจำวัน
    ง. ความสามารถในการกำหนดทางเลือกและปฏิเสธ

16. ข้อใด**ไม่ใช่**สาเหตุที่ฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
    ก. เด็กมีอัตราการหายใจมากกว่ากว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า
    ข. เด็กมีอัตราการหายใจน้อยกว่ากว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า
    ค. เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันปอด และสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่
    ง. เด็กมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบที่ออกไปเล่นในพื้นที่กลางแจ้ง

17. ข้อใดเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลกระทบต่อเกษตรกรรม
    ก. การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เกษตรกรรม
    ข. ทำให้พืชไม่สามารถเติบโตได้ตามปกติ
    ค. การทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
    ง. การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งเกษตรกรรม

18. ข้อใดเป็นความสำคัญของการการป้องกันการเสพติดในครอบครัว
    ก. ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรม
    ข. ช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
    ค. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
    ง. ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อครอบครัว

19. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญในการช่วยป้องกันการเสพติดในครอบครัว
    ก. การมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการใช้ชีวิต
    ข. การให้สิ่งของและเงินทองแก่สมาชิกในครอบครัว
    ค. การใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงในการควบคุมพฤติกรรม
    ง. การสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจ

20. ในกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ข้อใดเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่
    ก. การทำตามกระบวนการที่เคยใช้มาก่อน
    ข. การระดมความคิดโดยไม่มีข้อจำกัด
    ค. การคัดลอกแนวคิดจากผู้อื่น
    ง. การมองหาวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหา

21. ทักษะการจัดการเวลาเป็นทักษะสำคัญในการทำงานและครอบครัวอย่างไร
    ก. ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น
    ข. ช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว
    ค. ช่วยลดปริมาณงานที่ต้องทำ
    ง. ช่วยให้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ

22. ข้อใดต่อไปนี้**ไม่ใช่**วิธีการจัดการความเครียดที่ดี
ก. การออกกำลังกาย ข. การทำงานหนักขึ้น
ค. การหาความรู้เพิ่มเติม ง. การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจ

23. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวช่วยเสริมสร้างอะไร
ก. การเพิ่มรายได้ ข. การทำงานหนักขึ้น
ค. การลดเวลาพักผ่อน ง. ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี

24. ดนตรีสากลสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านใด
ก. การขับขี่ ข. การเขียนโปรแกรม
ค. การคิดวิเคราะห์และการจดจำ ง. การพัฒนาอาชีพทางการแพทย์

25. ไวโอลิน มีวิวัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีชนิดใด
ก. กีตาร์ ข. เรเบก
ค. เซลโล ง. ไวโอล่า

26. เครื่องดนตรีรมทองเหลืองชนิดใดมีลักษณะเด่น คือ มีวาล์วในการปรับระดับเสียง
ก. ทูบา ข. ฮอร์น
ค. ทรัมเป็ต ง. ทรอมโบน

27. องค์ประกอบใดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสมดุลในงานศิลปะ
ก. สี ข. เส้น
ค. รูปทรง ง. ความสมดุล

28. องค์ประกอบใดที่ช่วยทำให้งานศิลปะมีความเคลื่อนไหวและมีชีวิตชีวา
ก. สี ข. เส้น
ค. ขนาด ง. ทัศนียภาพ

29. การเรียนรู้ทักษะนาฏศิลป์สากล**ไม่ได้**ช่วยเสริมสร้างทักษะในด้านใด
ก. ทางสังคม ข. ความมั่นใจในตัวเอง
ค. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ง. การแสดงออกและการสื่อสาร

30. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปะที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ**น้อยที่สุด**
ก. ความมั่นใจในตัวเองและความตั้งใจ
ข. ความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
ค. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายและการตลาด
ง. ความสามารถในการรักษาความลับของลูกค้า

บทที่ 1
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

สาระสำคัญ



อวัยวะต่าง ๆ ทุกส่วนของร่างกายคนเรา ทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบ ทุกระบบต่างมีความสำคัญต่อร่างกายทั้งสิ้น หากระบบใดทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ด้วย ผู้เรียนจึงควรรู้จักโครงสร้าง หน้าที่ การทำงานและการดูแลรักษาป้องกันบำรุงรักษาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งวางแผนและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกายทุกระบบ ให้สมบูรณ์ แข็งแรงทำงานได้ตามปกติอยู่เสมอ จะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง
2. บอกวิธีการดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบที่สำคัญในร่างกาย
3. วางแผน และปฏิบัติตนตามแผนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของตนเองและครอบครัว

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 โครงสร้าง หน้าที่ การทำงานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

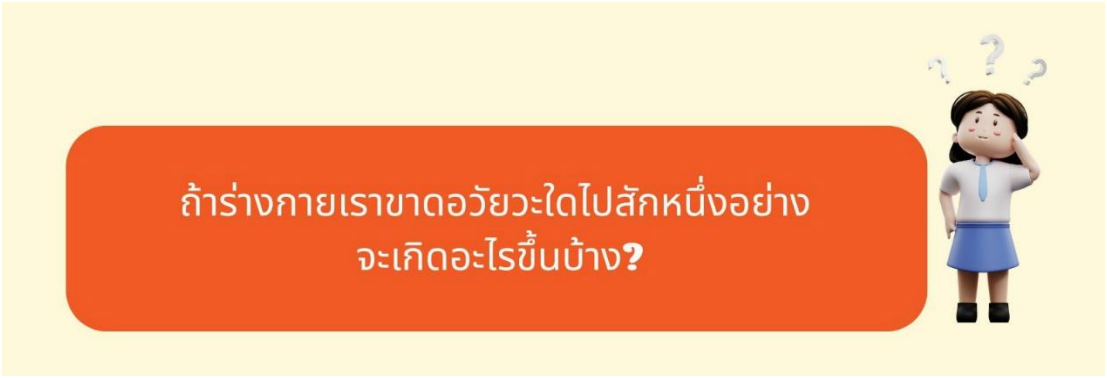
- 1.1 ระบบหายใจ
- 1.2 ระบบย่อยอาหาร
- 1.3 ระบบขับถ่าย
- 1.4 ระบบสืบพันธุ์
- 1.5 ระบบต่อมไร้ท่อ
- 1.6 ระบบประสาท

เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย

เรื่องที่ 1 โครงสร้างหน้าที่การทำงานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

ร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อน ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ทำงานร่วมกันเป็นระบบ เพื่อให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้ ระบบอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

สถานการณ์จำลอง : การผจญภัยในร่างกายมนุษย์

บทนำ : ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวน้อยที่ชื่อว่า “แดง” ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ การเดินทางไปสำรวจระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ และการทำงานของแต่ละระบบ พร้อมทั้งค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับ “บีม” เด็กชายวัยรุ่นที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพ

1. ระบบหายใจ : แดงเดินทางไปยังปอด พบว่า บีมหายใจลำบากเนื่องจากสูบบุหรี่ ทำให้แดงต้องช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยการอธิบายถึงผลกระทบของบุหรี่ต่อปอด และแนะนำวิธีการดูแลปอดให้แข็งแรง
2. ระบบย่อยอาหาร : แดงเดินทางไปยังกระเพาะอาหาร พบว่า บีมมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา แดงจึงต้องอธิบายกระบวนการย่อยอาหาร และแนะนำอาหารที่เหมาะสมต่อการดูแลระบบย่อยอาหาร
3. ระบบขับถ่าย : แดงเดินทางไปยังไต พบว่า ปัสสาวะของบีมมีสีเข้มผิดปกติ แดงจึงต้องอธิบายหน้าที่ของไต และแนะนำวิธีการดูแลไตให้แข็งแรง เช่น การดื่มน้ำให้เพียงพอ

4. ระบบต่อมไร้ท่อ : แดงเดินทางไปยังต่อมไทรอยด์ พบว่า บีมมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย เนื่องจากต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ แดงจึงต้องอธิบายหน้าที่ของต่อมไทรอยด์ และความสำคัญของฮอร์โมนต่อร่างกาย

5. ระบบประสาท : แดงเดินทางไปยังสมอง พบว่า บีมมีความจำสั้นลง เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ แดงจึงต้องอธิบายหน้าที่ของสมอง และแนะนำวิธีการดูแลระบบประสาทให้แข็งแรง เช่น การนอนหลับให้เพียงพอ เป็นต้น



กิจกรรมที่ 2

1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่

2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผังความคิด เรื่อง โครงสร้าง หน้าที่การทำงานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย และนำเสนอในชั้นเรียน



เนื้อหาสาระ

ระบบอวัยวะของร่างกาย ทำหน้าที่แตกต่างกันและประสานกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบที่สำคัญของร่างกาย 6 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีโครงสร้าง หน้าที่และการทำงาน ดังนี้

1. ระบบหายใจ

ระบบหายใจ คือ ระบบนำก๊าซออกซิเจน (Oxygen : O) จากอากาศภายนอกเข้าสู่เซลล์สำหรับทำปฏิกิริยากับสารอาหารต่าง ๆ ภายในเซลล์ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน แล้วถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO_2) อันเป็นส่วนเกินซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเผาผลาญออกจากเซลล์ ซึ่งมิได้สัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง ร่างกายจึงต้องมีวิธีการที่จะช่วยให้ก๊าซที่อยู่ภายนอกติดต่อกับเซลล์ในร่างกาย ดังนั้น จึงเกิดกระบวนการรับ – ส่งก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นโดยอาศัยการทำงานของปอดเป็นเครื่องนำอากาศเข้า - ออกจากร่างกาย และการไหลเวียนของเลือดพาก๊าซเหล่านั้นไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย ร่วมกับการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของระบบหายใจและกล้ามเนื้อของทรวงอกที่ช่วยให้ปริมาตรของทรวงอกขยายออกและหุบเข้าอย่างสม่ำเสมอ

อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ

1) จมูก (Nose) ภายในรูจมูกมีเยื่อบุจมูกและขนจมูกช่วยกรองฝุ่นละออง ต่อจากรูจมูกเข้าไปจะเป็นโพรงจมูกซึ่งมีเยื่อบุอยู่ทั่วผนังของโพรงจมูก

2) คอหอย (Pharynx) เป็นท่อที่อยู่หลังโพรงจมูกและปากบริเวณทางแยกระหว่างระบบหายใจและระบบย่อยอาหาร โดยนำอากาศไปยังกล่องเสียง และนำอาหารไปยังหลอดอาหาร

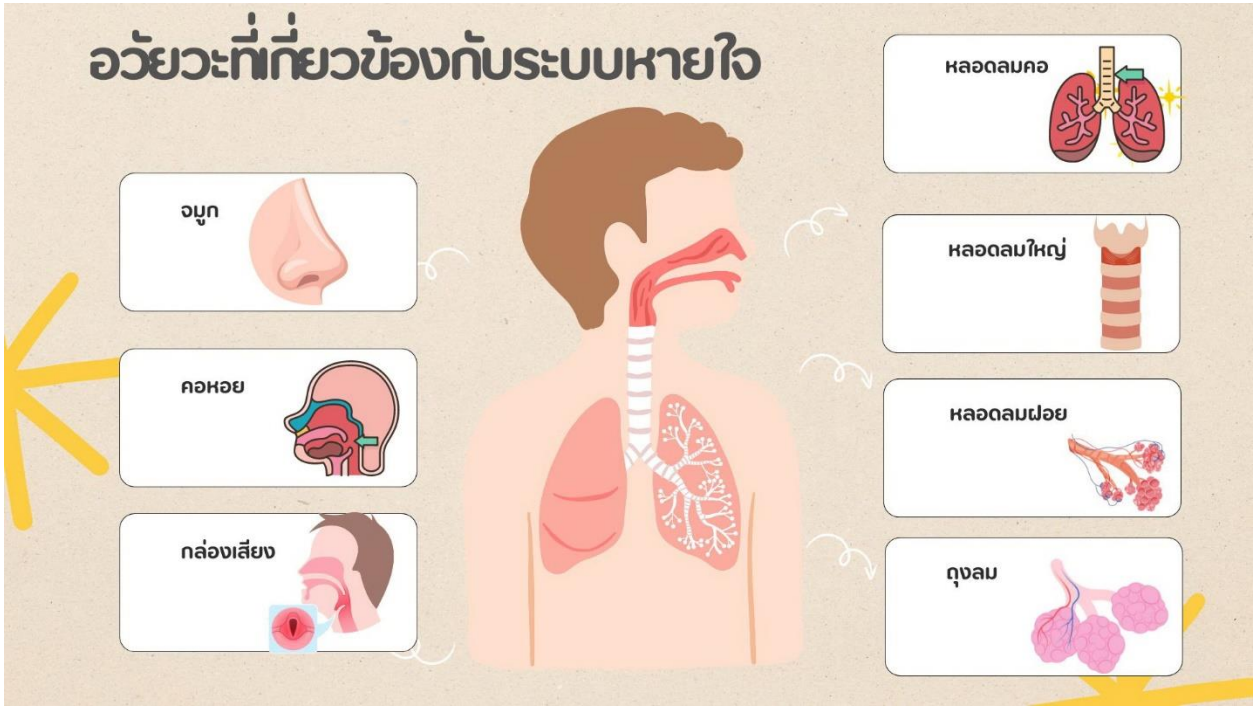
3) กล่องเสียง (Larynx) เป็นท่อระหว่างคอหอยและหลอดลมส่วนต้น ภายในจะมีเส้นเสียงเพื่อช่วยในการเปล่งเสียงส่วนตรงทางเข้าสู่กล่องเสียงจะมีลิ้นปิดหลอดลมเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารลงสู่หลอดลม

4) หลอดลมคอ (Trachea) อยู่ต่อจากกล่องเสียง ผนังด้านในมีเมือกคอยกักฝุ่นละอองไม่ให้ผ่านไปถึงปอด หลอดลมจะยาวไปจนถึงขั้วปอด

5) หลอดลมใหญ่ (Bronchus) เป็นท่อที่แยกจากหลอดลมคอ มี 2 ข้าง หลอดลมจะมีการแตกแขนงเล็กลงไปเรื่อย ๆ จนถึงหลอดลมฝอย

6) หลอดลมฝอย (Bronchiole) หลอดลมฝอยเป็นส่วนสุดท้ายของท่อทางเดินหายใจซึ่งต่อไปจะเป็นพวงถุงลม ซึ่งแต่ละพวงก็จะมีถุงลมหลาย ๆ ถุง

7) ถุงลม (Alveoli) เป็นส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



การทำงานของระบบหายใจ

การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม อากาศเมื่อเข้าสู่ปอดจะไปอยู่ในถุงลม ซึ่งมีลักษณะกลมคล้ายลูกองุ่น ซึ่งปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมข้างละ 150 ล้านถุง แต่ละถุงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร

ถุงลมทุกอันจะมีหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มไว้ การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน และไอน้ำ ผ่านเข้าออกถุงลมโดยผ่านเยื่อบาง ๆ ของถุงลม เลือดจากหัวใจมาสู่ปอด เป็นเลือดที่มีออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูง เมื่อมาสู่ถุงลมจะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยออกซิเจนในถุงลมจะแพร่เข้าสู่เส้นเลือด ขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ในเส้นเลือดจะแพร่เข้าสู่ถุงลม แล้วขับออกทางลมหายใจออก ซึ่งระบบหายใจมีกลไกการทำงาน ดังนี้

1. การหายใจเข้า (Inspiration) กะบังลมจะเลื่อนต่ำลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในบริเวณรอบ ๆ ปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูก หลอดลม และไปยังถุงลมปอด

2. การหายใจออก (Expiration) กะบังลมจะเลื่อนสูง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลง ทำให้ปริมาตรของช่องอกลดน้อยลง ความดันอากาศในบริเวณรอบ ๆ ปอดสูงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายในถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลมและออกทางจมูก

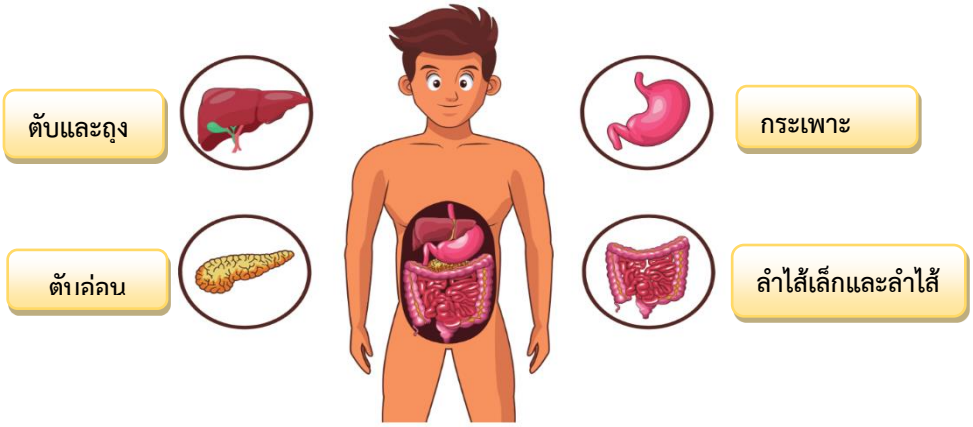
วิธีการดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบหายใจ

1. หลีกเลี่ยงที่ที่อากาศไม่บริสุทธิ์ เพราะจะทำให้ได้รับสารพิษ
2. หาโอกาสไปอยู่ที่ที่อากาศบริสุทธิ์หายใจ เช่น ทุ่งนา ป่าเขา ชายทะเล เป็นต้น

3. ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่
4. ควรตรวจสภาพปอดด้วยการเอกซเรย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นโรคติดต่อทางลมหายใจ
6. เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกาย
7. ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ จะทำให้ความจุปอดดีขึ้น
8. ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหายใจควรรีบพบแพทย์

2. ระบบย่อยอาหาร

มนุษย์เป็นผู้บริโภค โดยการรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต ดำรงอยู่ได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มนุษย์จึงมีระบบการย่อยอาหาร เพื่อนำสารอาหารแร่ธาตุและน้ำให้เป็นพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิต



โครงสร้าง หน้าที่ และการทำงานของระบบย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงจนร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ การทำงานของระบบย่อยอาหาร มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) การย่อยอาหารในปาก เป็นกระบวนการย่อยอาหารส่วนแรก อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร ได้แก่ ฟันและต่อมน้ำลาย ทางเดินอาหารเริ่มตั้งแต่ปาก มีฟันทำหน้าที่บดอาหาร ต่อมน้ำลาย จะหลั่งน้ำลายมาเพื่อย่อยแป้ง ในน้ำลายมีเมือกช่วยในการหล่อลื่นอาหารให้กลืนได้สะดวก การหลั่งน้ำลายอาศัยรสและกลิ่นอาหาร เมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวในปากจะเข้าสู่หลอดอาหารโดยการกลืน

2) การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่อยู่ต่อจากหลอดอาหารใต้กะบังลมด้านซ้ายล่างติดกับลำไส้เล็ก มีลักษณะเป็นกระพุ้งรูปตัวเจ (J) ผนังกั้นเป็นกล้ามเนื้อเรียบ ยืดหดได้ดี

การย่อยในกระเพาะอาหาร ผนังกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ยืดหยุ่นและขยายความจุได้ถึง 1,000 - 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีกล้ามเนื้อหูรูด 2 แห่ง คือ กล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับหลอดอาหาร และกล้ามเนื้อหูรูดที่ต่อกับลำไส้เล็ก ผนังด้านในของกระเพาะอาหารมีต่อมสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยอาหาร เอนไซม์ประกอบด้วย กรดไฮโดรคอลิก (HCL) ช่วยเปลี่ยนเพปซิโนเจนและไทรเรนนิน จากผนังกระเพาะให้เป็นเพปซินและเรนนิน พร้อมที่จะทำงานช่วยย่อยโปรตีน นอกจากนี้ยังสร้างน้ำเมือกมีฤทธิ์เป็นด่าง (base) เคลือบกระเพาะอาหาร โปรตีนจะถูกย่อยในกระเพาะอาหารโดยเอนไซม์เพปซิน

3) การย่อยอาหารในลำไส้ ลำไส้เล็กอยู่ต่อจากกระเพาะอาหาร มีลักษณะเป็นท่อที่ขดซ้อนกันไปมาในช่องท้อง ยาวประมาณ 5 - 7 เมตร ลำไส้เล็กจะผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน

การย่อยอาหารในลำไส้เล็ก อาหารจะเคลื่อนจากกระเพาะอาหารผ่านกล้ามเนื้อหูรูดเข้าสู่ลำไส้เล็ก การย่อยอาหารในลำไส้เล็กเกิดจากการทำงานของอวัยวะ 3 ชนิด คือ ตับอ่อน ผนังลำไส้เล็ก และตับ โดยจะหลั่งสารออกมาทำงานร่วมกัน ดังนี้

3.1) ตับอ่อน (Pancreas) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเอนไซม์ในการย่อยอาหาร เอนไซม์ที่สร้างขึ้นอยู่ในรูปที่ยังทำงานไม่ได้ ต้องอาศัยเอนไซม์จากลำไส้เปลี่ยนสภาพที่พร้อมจะทำงานได้ ซึ่งเป็นเอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีน อีกทั้งยังสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมัน นอกจากนี้ยังสร้างสารโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมีฤทธิ์เป็นด่าง (base) เพื่อลดความเป็นกรดจากกระเพาะอาหาร

3.2) ผนังลำไส้เล็ก ผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) ลำไส้เล็กส่วนต้น หรือ เรียกว่า ดูโอดินัม (Duodenum) สารอาหารเกือบทุกชนิดรวมทั้งวิตามินหลายชนิดจะถูกดูดซึมที่บริเวณดูโอดินัม

2) ลำไส้เล็กส่วนกลาง หรือ เรียกว่า เจจูนัม (Jejunum) จะดูดซึมอาหารพวกไขมัน

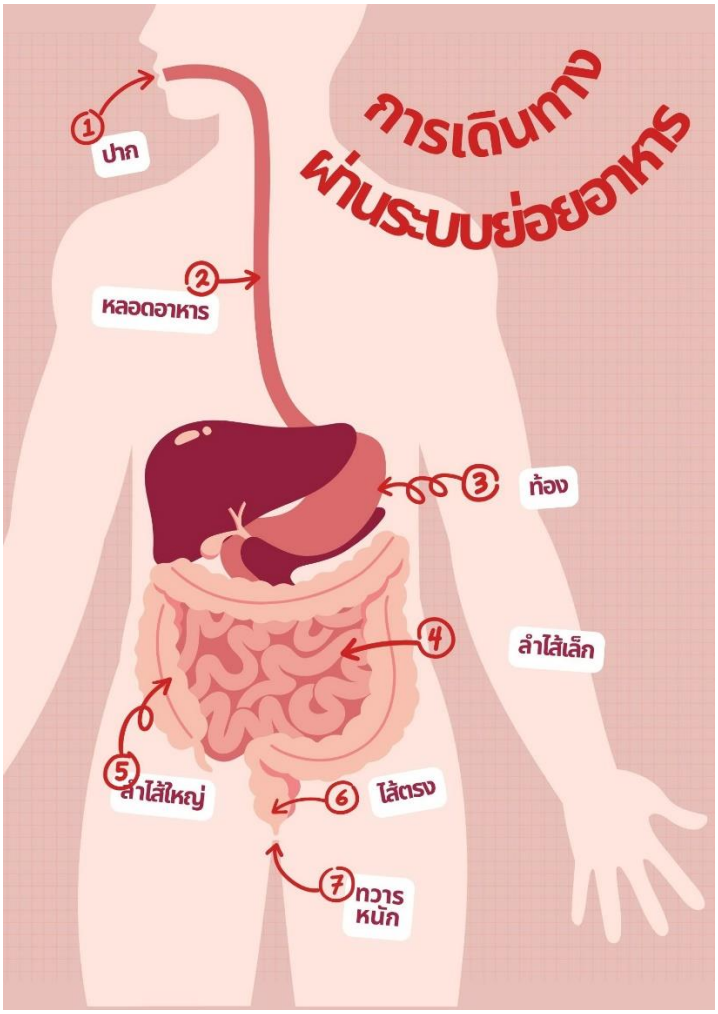
3) ลำไส้เล็กส่วนปลาย หรือ เรียกว่า ไอเลียม (Ileum) ดูดซึมวิตามินบี 12 และเกลือ

การดูดซึมลำไส้เป็นบริเวณที่มีการดูดซึมได้ดีที่สุด ผนังด้านในลำไส้เล็กเป็นคลื่น และมีส่วนยื่นออกมาเป็นปุ่มเล็ก ๆ จำนวนมาก เรียกว่า วิลลัส (villus) ที่ผิวด้านนอกของเซลล์วิลลัสมีส่วนที่ยื่นออกไปอีก เรียกว่า ไมโครวิลไล (microvilli) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึม ภายในวิลลัสแต่ละอันมีเส้นเลือดและเส้นน้ำเหลือง ซึ่งจะรับอาหารที่ย่อยแล้วที่ซึมผ่านผนังบุลำไส้เล็กเข้ามา

3.3) ตับ (Liver) ทำหน้าที่ สร้างน้ำดีเก็บไว้ในถุงน้ำดี น้ำดี มีส่วนประกอบสำคัญ คือ น้ำดีช่วยให้ไขมันแตกตัวและละลายน้ำได้ ทำให้เอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนและลำไส้เล็กย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล

การดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร

1. รับประทานอาหารให้ครบทุกประเภทในแต่ละมื้อ และรับประทานอาหาร แต่พอควรไม่มากหรือน้อยจนเกินไป โดยเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
2. รับประทานอาหารที่สะอาด และปรุงสุกใหม่ ๆ
3. ไม่รับประทานอาหารพร่ำเพรื่อ จุกจิก และทานให้ตรงเวลา
4. อย่ารีบรับประทานอาหารขณะกำลังเหนื่อย
5. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไป
6. ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาและสม่ำเสมอ



3. ระบบขับถ่าย

การขับถ่าย เป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาภายนอกร่างกาย เรียกว่า การขับถ่ายของเสีย อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสีย ได้แก่ ปอด ผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

การกำจัดของเสียทางปอด

การกำจัดของเสียทางปอด กำจัดของเสียออกมาในรูปของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการหายใจ โดยน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่ออก จากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด และเลือดจะทำหน้าที่ลำเลียงไปยังปอด แล้วแพร่เข้าสู่ถุงลมที่ปอด หลังจากนั้นจึงเคลื่อนผ่านหลอดลมแล้วออกจากร่างกายทางจมูก

การดูแลป้องกันความผิดปกติของปอด

1. ควรอยู่ในบริเวณที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. เมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่ที่มีควันหรือฝุ่นละอองมากควรใช้ผ้าปิดจมูก
4. ไม่สูบบุหรี่และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผู้สูบบุหรี่

การกำจัดของเสียทางผิวหนัง

ผิวหนังนอกจากจะทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อแล้ว ยังมีส่วนระบายความร้อนให้แก่ร่างกายเพื่อขับเหงื่อออกสู่ภายนอก เหงื่อที่ร่างกายขับออกมานั้นประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่ และจะมีเกลือบางชนิดถูกขับปนออกมาด้วย จึงทำให้เหงื่อมีรสเค็ม

การดูแลป้องกันความผิดปกติของผิวหนัง

1. อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
2. หลังอาบน้ำ ควรสวมเสื้อผ้าที่สะอาด และเหมาะสมกับอากาศ
3. กินอาหารให้ถูกหลักอนามัยและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ
4. ดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อทำให้ผิวหนังเปล่งปลั่ง
5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น
6. ควรให้ผิวหนังได้รับแสงแดดสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า
7. เมื่อมีสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นกับผิวหนัง ควรปรึกษาแพทย์

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะมี ดังนี้

1. ไต (Kidneys) มีอยู่ 2 ข้าง รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดง อยู่ทางด้านหลังของช่องท้องบริเวณเอวใน ไตจะมีหลอดไต ทำหน้าที่กรองปัสสาวะออกจากเลือด ดังนั้น ไต จึงเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้เป็นโรงงานสำหรับขับถ่ายปัสสาวะด้วยการกรองของเสีย เช่น ยูเรีย เกลือแร่ และน้ำ ออกจากเลือดที่ไหลผ่านเข้ามาให้เป็นน้ำปัสสาวะแล้วไหลผ่านกรวยไตลงสู่ท่อไตเข้าไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ

2. กรวยไต (Pelvis) คือ ช่องกลวงภายในที่มีรูปร่างเหมือนกรวย ส่วนของก้นกรวย จะติดต่อกับก้านกรวย

3. ท่อไต (Useter) มีลักษณะเป็นท่อออกมาจากไตทั้ง 2 ข้าง เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะ จะเป็นทางผ่านของปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ

4. กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder) เป็นที่รองรับน้ำปัสสาวะจากไตที่ผ่านมาทางท่อไต สามารถขยายได้ ขับปัสสาวะได้ประมาณ 1 ลิตร แต่ถ้าเกิน 700 ซีซี (ลูกบาศก์เซนติเมตร) อาจเป็นอันตรายได้ เมื่อมีน้ำปัสสาวะมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นจะรู้สึกปวดปัสสาวะ

5. ท่อปัสสาวะ (Urethra) เป็นท่อที่ต่อจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่อวัยวะเพศ ซึ่งท่อนี้จะเป็นทางผ่านของปัสสาวะเพื่อที่จะไหลออกสู่ภายนอก ปลายท่อจึงเป็นทางออกของปัสสาวะ

การดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

1. ดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว
2. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานเกินไป
3. ไม่ควรรับประทานอาหารรสเค็มมาก
4. ควรป้องกันการเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่มีสารออกซาเลตสูง เช่น หน่อไม้ ชะพลู ผักแพว ผักกระโดน เป็นต้น
5. ควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีน เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
6. เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะควรปรึกษาแพทย์

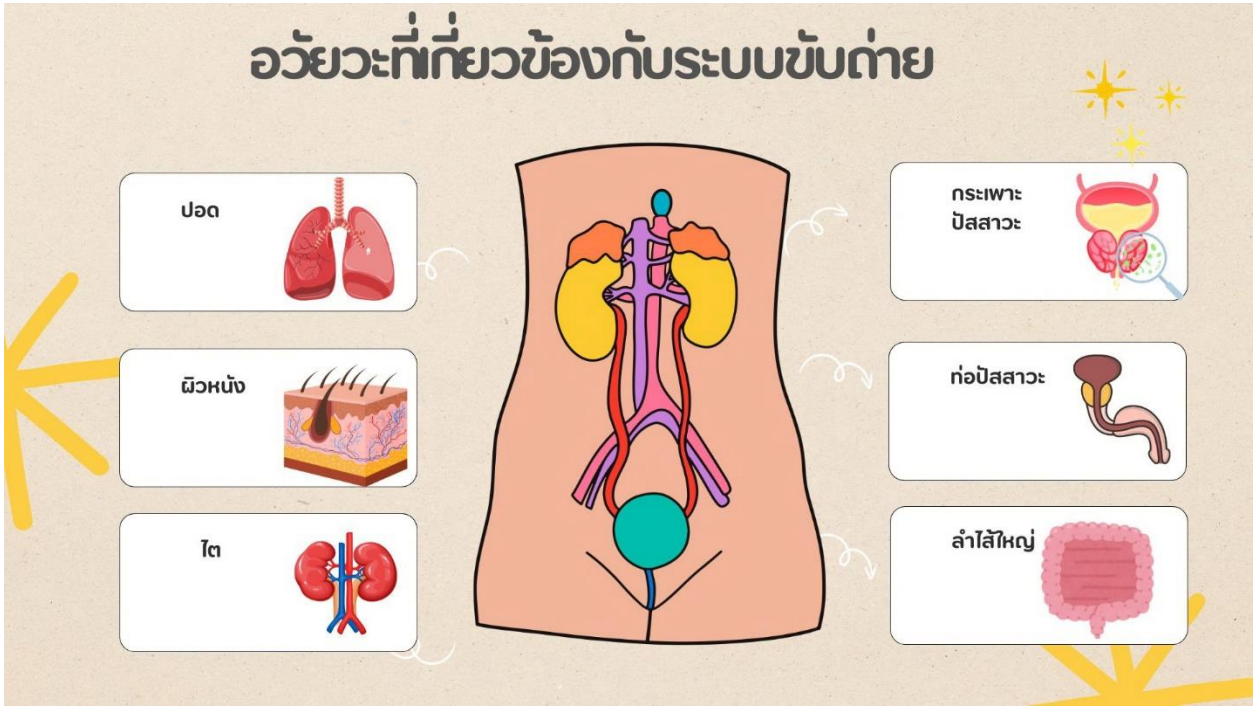
ระบบขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่

การย่อยอาหารจะสิ้นสุดลงบริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ เนื่องจากอาหารที่ลำไส้เล็กย่อยแล้วจะเป็นของเหลว หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ครึ่งแรก คือ ดูดซึมของเหลว น้ำ เกลือแร่ และน้ำตาลกลูโคสที่ยังเหลืออยู่ในกากอาหาร ส่วนลำไส้ใหญ่ครึ่งหลังจะเป็นที่พักกากอาหาร ซึ่งมีลักษณะกึ่งของแข็ง ลำไส้ใหญ่

จะขับเมือกออกมาหล่อลื่น เพื่อให้อุจจาระเคลื่อนไปตามลำไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้น ถ้าลำไส้ใหญ่ดูดน้ำมากเกินไป เนื่องจากอาหารตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่หลายวัน จะทำให้กากอาหารแข็ง เกิดความลำบากในการขับถ่าย ซึ่งเรียกว่า ท้องผูก

การดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบขับถ่าย

1. ไม่กินอาหารที่มีรสจัด
2. กินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด และไม่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
3. ควรกินผักและผลไม้ทุกวัน
4. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว
5. ควรฝึกนิสัยการขับถ่ายให้เป็นเวลา



4. ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์ แบ่งออกเป็น

1) ระบบสืบพันธุ์ชาย

ระบบสืบพันธุ์ชายประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สร้างและส่งสเปิร์มซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย

(1) ลูกอัณฑะ (Testes) : มีหน้าที่ผลิตสเปิร์มและฮอร์โมนเพศชาย

(2) หลอดเก็บสเปิร์ม (Epididymis) : ทำหน้าที่เก็บและพัฒนาสเปิร์มหลังจากผลิตออกจากลูกอัณฑะ

(3) ท่อนำสเปิร์ม (Vas Deferens) : นำสเปิร์มจากหลอดเก็บสเปิร์มไปยังท่อปัสสาวะ

(4) ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) : ผลิตของเหลวที่ช่วยบำรุงสเปิร์มและทำให้เกิดน้ำอสุจิ

(5) องคชาต (Penis) : ทำหน้าที่เป็นทางออกของน้ำอสุจิและปัสสาวะ

2) ระบบสืบพันธุ์หญิง

ระบบสืบพันธุ์หญิง ประกอบด้วย อวัยวะที่ทำหน้าที่สร้างไข่และเป็นแหล่งเกิด และพัฒนาตัวอ่อน ประกอบด้วย

(1) รังไข่ (Ovaries) : ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิง

(2) ท่อนำไข่ (Fallopian Tubes) : นำไข่จากรังไข่ไปยังมดลูก และเป็นที่เกิดการปฏิสนธิของไข่กับสเปิร์ม

(3) มดลูก (Uterus) : ทำหน้าที่รับไข่ที่ปฏิสนธิแล้วและเป็นที่เจริญเติบโตของตัวอ่อน

(4) ปากมดลูก (Cervix) : เป็นทางออกของเลือดประจำเดือนและทางผ่านของสเปิร์มเข้าสู่มดลูก

(5) ช่องคลอด (Vagina) : ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของเด็กในเวลาคลอดและเป็นทางออกของเลือดประจำเดือน

กระบวนการปฏิสนธิ

กระบวนการปฏิสนธิเริ่มต้นเมื่อสเปิร์มเข้าไปพบกับไข่ในท่อนำไข่ หลังจากการปฏิสนธิ ตัวอ่อนจะถูกนำไปฝังตัวในมดลูกและเริ่มพัฒนาต่อไป เมื่อครบกำหนด ตัวอ่อนจะเจริญเป็นทารกและคลอดออกมา

ฮอร์โมนสืบพันธุ์

ฮอร์โมนเป็นส่วนสำคัญของระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง ฮอร์โมนเพศชายหลักคือเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งผลิตโดยลูกอัณฑะ ส่วนฮอร์โมนเพศหญิงหลัก คือ เอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งผลิตโดยรังไข่

5. ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบสื่อสารภายในร่างกายผ่านฮอร์โมน (Hormone) โดยทำหน้าที่ควบคุม เชื่อมโยง ติดต่อประสานและทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของร่างกาย โดยการทำงานจะอยู่ในลักษณะช้า ๆ และส่งผลในระยะยาว เช่น การเจริญเติบโตของร่างกาย การพัฒนาของระบบสืบพันธ์ การมีประจำเดือน การเผาผลาญ การควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยในร่างกายของมนุษย์มีต่อมในร่างกาย 2 ประเภท คือ ต่อมมีท่อ (Exocrine gland) และต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) โดยต่อมไร้ท่อมีโครงสร้าง หน้าที่ และการทำงาน ดังนี้

โครงสร้าง หน้าที่ การทำงานของต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) เป็นต่อมที่สร้างสารเคมีขึ้นมาแล้วส่งไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมายโดยอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด เนื่องจากไม่มีท่อลำเลียงของต่อมโดยเฉพาะ สารเคมีนี้ เรียกว่า ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ มีอยู่หลายต่อมกระจายอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากต่อมไร้ท่อมีหลายชนิด แต่ละชนิดทำงานแตกต่างกัน โดยจะควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโต กระตุ้นหรือยับยั้งการทำงาน ฮอร์โมนสามารถออกฤทธิ์ได้ โดยใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย ต่อมไร้ท่อที่สำคัญ มี 7 ต่อม ได้แก่

1. ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) เป็นต่อมไร้ท่อ อยู่ตรงกลางส่วนล่างของสมอง ต่อมนี้ขับสารที่มีลักษณะขุ่นขาวคล้ายเสมหะ จึงเรียกว่า ต่อมพิทูอิตารี ต่อมใต้สมอง ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันมากชนิดที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ต่อมใต้สมอง ส่วนหน้า ต่อมใต้สมองส่วนกลาง และต่อมใต้สมองส่วนหลัง ต่อมใต้สมองทั้งสามส่วนนี้ต่างกันที่ โครงสร้าง และการผลิตฮอร์โมน

2. ต่อมไทรอยด์ (thyroid) มีลักษณะเป็นพู 2 พู อยู่สองข้างของคอหอย โดยมีเยื่อบาง ๆ เชื่อมติดต่อถึงกันได้ ต่อมนี้ถือได้ว่าเป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากที่สุด ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ได้แก่

1) ฮอร์โมนไธรอกซิน (thyroxin hormone) ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารกระตุ้นการเปลี่ยนไกลโคเจนไปเป็นกลูโคส และเพิ่มการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร จึงเป็นตัวเพิ่มระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด

2) ฮอร์โมนแคลซิโทนิน (Calcitonin) ทำหน้าที่ ลดระดับแคลเซียมในเลือดที่สูงเกินปกติให้เข้าสู่ระดับปกติ โดยดึงแคลเซียมส่วนเกินไปไว้ที่กระดูก

3. ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid gland) อยู่ติดกับเนื้อของต่อมไทรอยด์ทางด้านหลังในคน มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปไข่ขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลปนเหลือง ฮอร์โมนที่สำคัญที่สร้างจากต่อมนี้ คือ พาราธอร์โมน ทำหน้าที่รักษาสมดุลของแคลเซียม และ ฟอสฟอรัสในร่างกายให้คงที่ โดยทำงานร่วมกับแคลซิโตนิน เนื่องจากระดับแคลเซียมในเลือด มีความสำคัญมาก เพราะจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อประสาทและการเต้นของหัวใจ ดังนั้น ต่อมพาราธอร์โมน จึงจัดเป็นต่อมไร้ท่อที่มีความจำเป็นต่อชีวิต

4. ต่อมหมวกไต (adrenal gland) อยู่เหนือไตทั้ง 2 ข้าง ลักษณะต่อมทางขวาเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนทางซ้ายเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ต่อมนี้ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด คือ อะดรีนัลคอร์เทกซ์และอะดีนัลเมดุลลา

5. ตับอ่อน ภายในเนื้อเยื่อตับอ่อนจะมีไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์เป็นต่อมเล็ก ๆ ประมาณ 2,500,000 ต่อม หรือมีจำนวนประมาณร้อยละ 1 ของเนื้อเยื่อตับอ่อนทั้งหมด ฮอร์โมนผลิตจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ ที่สำคัญ 2 ชนิด คือ

5.1 อินซูลิน (Insulin) สร้างมาจากเบตาเซลล์ที่บริเวณส่วนกลางของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ หน้าที่สำคัญของฮอร์โมนนี้ คือ รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ เมื่อร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินจะหลั่งออกมามากเพื่อกระตุ้นเซลล์ตับ และเซลล์กล้ามเนื้อนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์มากขึ้น และเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนเพื่อเก็บสะสมไว้ นอกจากนี้อินซูลินยังกระตุ้นให้เซลล์ทั่วร่างกายมีการใช้กลูโคสมากขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงสู่ระดับปกติ ถ้ากลุ่มเซลล์ที่สร้างอินซูลินถูกทำลายระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงกว่าปกติทำให้เป็นโรคเบาหวาน

5.2 กลูคากอน (Glucagon) เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากแอลฟาเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์อีกประเภทหนึ่งของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ กลูคากอนจะไปกระตุ้นการสลายตัวของไกลโคเจนจากตับและกล้ามเนื้อให้น้ำตาลกลูโคสปล่อยออกมาในเลือดทำให้เลือดมีกลูโคสเพิ่มขึ้น

6. รังไข่ (Ovaries) ต่อมอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงซึ่งอยู่ที่รังไข่จะสร้างฮอร์โมนที่สำคัญ คือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

7. อัณฑะ (Testis) ต่อมอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย ซึ่งอยู่ที่อัณฑะจะสร้างฮอร์โมนที่สำคัญที่สุด คือ เทสโตสเตอโรน ซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อเริ่มวัยหนุ่ม

การดูแลป้องกันความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ

1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีปริมาณที่เพียงพอ
2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารขยะ และอาหารที่มีรสจัด
3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4. อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีพิษ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
6. มองโลกในแง่ดี และหลีกเลี่ยงความเครียด
7. สำรวจความเจริญเติบโตของร่างกาย โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง หากพบว่า ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

6. ระบบประสาท

ระบบประสาท (Nervous System) การทำงานของระบบประสาทเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนมาก และเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในภายนอกร่างกาย ระบบประสาท สามารถแบ่งแยกออก 3 ส่วน ดังนี้

6.1 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system : CNS) ระบบส่วนนี้ ประกอบด้วย สมองและไขสันหลัง (Brain and Spinal cord) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) หน้าที่ของสมอง

(1) ควบคุมความจำความคิด การใช้ไหวพริบ

(2) ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ โดยศูนย์ควบคุมสมองด้านซ้ายจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อด้านขวาของร่างกาย ส่วนศูนย์ควบคุมสมองด้านขวาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อด้านซ้ายของร่างกาย

(3) ควบคุมการพูด การมองเห็น การได้ยิน

(4) ควบคุมการเผาผลาญอาหาร ความหิว ความกระหาย

(5) ควบคุมการกลอกลูกตา การปิดเปิดม่านตา

(6) ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้ทำงานสัมพันธ์กันและช่วยการทรงตัว

(7) ควบคุมกระบวนการหายใจ การเต้นของหัวใจ การหดตัวและขยายตัวของเส้นเลือด

(8) สำหรับหน้าที่ของระบบประสาทที่มีต่อการออกกำลังกาย ต้องอาศัยสมองส่วนกลาง โดยสมองทำหน้าที่นึกคิดที่จะออกกำลังกาย แล้วออกคำสั่งไปยังสมอง เรียกว่า Association motor areas เพื่อวางแผนจัดลำดับการเคลื่อนไหว แล้วจึงส่งคำสั่งต่อไปยังประสาทกลไก (Motor area) ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะส่งคำสั่งลงไปสู่ไขสันหลัง

2) หน้าที่ของไขสันหลัง

(1) ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อตีความและสั่งการ และในขณะเดียวกันก็รับพลังประสาทจากสมองซึ่งเป็นคำสั่งไปสู่อวัยวะต่าง ๆ

(2) เป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex reaction) คือ สามารถที่จะทำงานได้ทันที เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น เมื่อเราเดินไปเหยียบหนามที่แหลมคม เท้าของเราจะยกหนีทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

(3) ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ที่มีเส้นประสาทไขสันหลังไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ซึ่งหน้าที่นี้ เรียกว่า ทรอพฟิคฟังชั่น (Trophic function)

6.2 ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system : PNS)

1) เส้นประสาทสมอง มี 12 คู่ ทอดมาจากสมองผ่านรูต่าง ๆ ของกะโหลกศีรษะ ทำหน้าที่รับความรู้สึก บางคู่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและบางคู่จะทำหน้าที่ทั้งรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว

2) เส้นประสาทไขสันหลัง มี 31 คู่ ถ้าหากเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณใด ได้รับอันตรายอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของอวัยวะที่เส้นประสาทไขสันหลัง ตัวอย่าง เช่น เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณเอวและบริเวณก้นได้รับอันตราย จะมีผลต่ออวัยวะส่วนล่าง คือ ขาเกือบทั้งหมดอาจจะมีอาการของอัมพาต หมดความรู้สึก และเคลื่อนไหวไม่ได้

6.3 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system : ANS)

ระบบประสาทอัตโนมัติส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในและทำงานอยู่นอกอำนาจจิตใจ แบ่งการทำงานได้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) ซิมพาเทติก (Sympathetic division) ทำหน้าที่เร่งการทำงานของอวัยวะภายในให้ทำงานเร็วหนักและแรงขึ้น รวมทั้งควบคุมการแสดงทางอารมณ์ ส่งผลทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันเลือดเพิ่มขึ้น ต่อมต่าง ๆ ทำงานเพิ่มขึ้น เช่น ภาวะของความกลัว ตกใจ โกรธ และความเจ็บปวด หรือเป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยของร่างกายในภาวะฉุกเฉิน ประสาทส่วนนี้ออกจากเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณอกและบริเวณเอว

2) พาราซิมพาเทติก (Parasympathetic division) ประสาทกลุ่มนี้ ทำหน้าที่รั้งการทำงานของอวัยวะภายใน หรือจะทำงานในช่วงที่ร่างกายมีการพักผ่อน ประสาทส่วนนี้มาจากเส้นประสาทก้นกบ และจากสมอง

การดูแลป้องกันความผิดปกติของของระบบประสาท

1. ตรวจร่างกายเกี่ยวกับระบบประสาทอย่างสม่ำเสมอ
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา
3. ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม
4. การใช้สายตา ควรมีแสงสว่างเพียงพอ เช่น การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ เป็นต้น
5. การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรมีการหยุดพักเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้ร่างกาย และตาเกิดอาการเมื่อยล้า
6. พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
7. ทำกิจกรรมเพื่อคลายความเครียด เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง การทำงานอดิเรก การนั่งสมาธิ เป็นต้น
8. หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวางแผนและปฏิบัติตนตามแผนเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของตนเองและครอบครัวได้หรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและทำกิจกรรมสร้างสถานการณ์การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกายตนเองและครอบครัว และนำเสนอหน้าชั้น ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยสถานการณ์ ดังนี้

1) ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นวัยรุ่น และมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน
2) ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ และต้องการดูแลสุขภาพข้อเข่า
3) ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และต้องการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย



เนื้อหาสาระ

การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย เป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว การดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันโรค แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง มีพลังงาน และมีความสุข

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของร่างกาย : โภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อน ความเครียด และสิ่งแวดล้อม

การวางแผน : การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดตารางอาหารและการออกกำลังกาย การจัดสรรเวลาพักผ่อน และการจัดการกับความเครียด

กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ : การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ : สุขภาพที่ดี พลังงานสูง อารมณ์ดี ความมั่นใจ และประสิทธิภาพในการทำงาน

การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย

โภชนาการ : รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืช และโปรตีน ลดอาหารแปรรูป อาหารทอด และเครื่องดื่มหวาน



การออกกำลังกาย : ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เลือกชนิดของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ



การพักผ่อน : นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 7 - 8 ชั่วโมงต่อวัน



การจัดการความเครียด : หาทางผ่อนคลาย เช่น การฟังเพลง การทำสมาธิ หรือการออกไปพักผ่อน



สิ่งแวดล้อม: รักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งแวดล้อม



การดูแลสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ การเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 1 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

เรื่องที่ 1 โครงสร้างหน้าที่การทำงานและการดูแลรักษาระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย



กิจกรรมที่ 1

1. ระบบหายใจ : บุหรี่ทำลายเซลล์ปอด ทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศบริสุทธิ์
2. ระบบย่อยอาหาร : การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนัก ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา และเลือกอาหารที่มีประโยชน์
3. ระบบขับถ่าย : การดื่มน้ำน้อย ทำให้ไตทำงานหนัก ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกาย
4. ระบบต่อมไร้ท่อ : ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์มีผลต่อการเผาผลาญ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
5. ระบบประสาท : การพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้สมองทำงานได้ไม่เต็มที่ ควรนอนหลับให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการใช้สมาร์ตโฟนก่อนนอน



กิจกรรมที่ 2



หมายเหตุ : ครูสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์จำลองและกิจกรรมเสริมให้เหมาะสมกับระดับชั้นและความสนใจของผู้เรียนได้

เรื่องที่ 2 การวางแผนและปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย



กิจกรรม



บทที่ 2
อาหารและโภชนาการ

สาระสำคัญ



มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา สาเหตุและการป้องกันโรคขาดสารอาหาร ตลอดจนสามารถบอกหลักการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลด้านอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยได้

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย



1. อธิบายปัญหา สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคขาดสารอาหาร
2. บอกหลักการ และการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้อย่างเหมาะสม
3. จัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับตนเอง ครอบครัว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

ขอบข่ายเนื้อหา



เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร
- 1.1 โรคลักปิดลักเปิด
- 1.2 โรคคอหอยพอก
- 1.3 โรคเอ๋อ
- 1.4 โรคตาฟาง
- 1.5 โรคโลหิตจาง

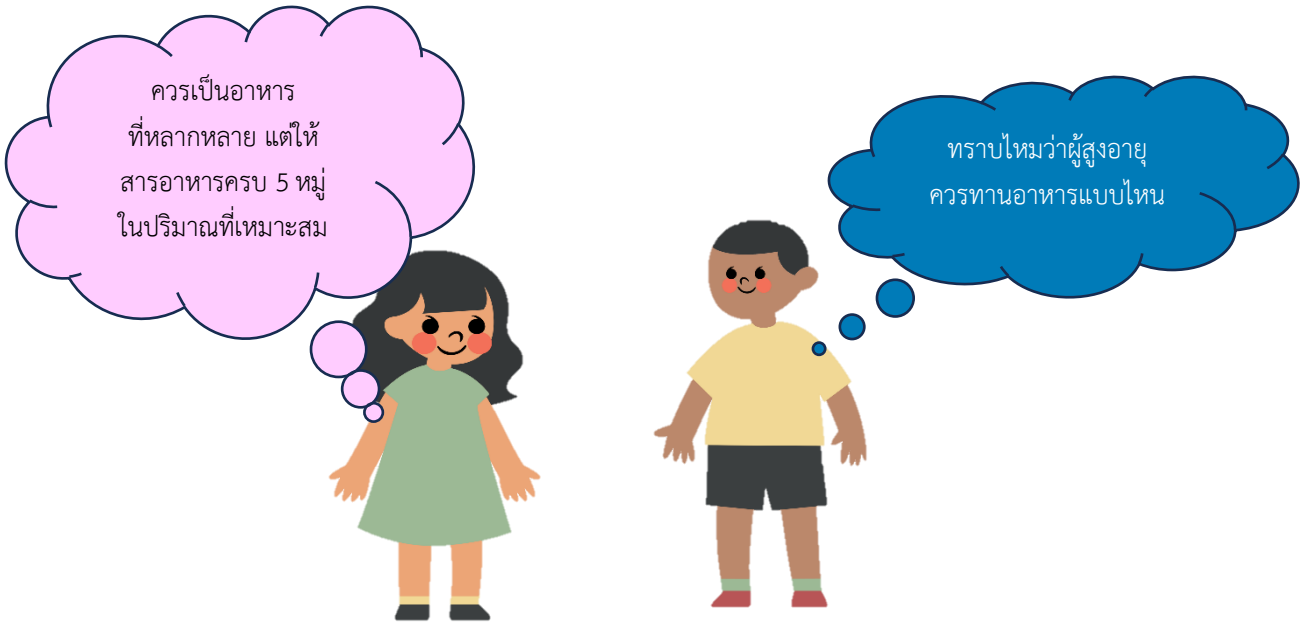
เรื่องที่ 2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร
- 2.1 การปนปื้อน
- 2.2 การปรุงและจำหน่ายอาหาร
- 2.3 ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
- 2.4 สุขลักษณะทั่วไปบริเวณแผงจำหน่าย
- 2.5 สุขลักษณะอาหารถุง

เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
- 3.1 ตนเอง และครอบครัว
- 3.2 ผู้สูงอายุ
- 3.3 ผู้ป่วย

เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร

โรคขาดสารอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยอาจมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย ผิวหนังมีลักษณะผิดปกติ กระดูกหยุดเจริญเติบโต หรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคขาดสารอาหารในอินเทอร์เน็ต ให้อธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้ ปัญหา สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคขาดสารอาหาร แล้วเขียนลงบนกระดาษบรู๊ฟ พร้อมส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

เนื้อหาสาระ

นิสัยโดยส่วนตัวของคนไทยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหาร ทั้งนี้เพราะคนไทยเลือกกินอาหารตามรสปาก รีบร้อนกินเพื่อให้อิ่มท้อง หรือกินตามที่หามาได้ โดยไม่คำนึงถึงว่ามีสารอาหารที่ให้คุณค่าโภชนาการต่อร่างกายครบถ้วนหรือไม่ พฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดโรคขาดสารอาการได้โดยไม่รู้สึกตัว

1.1 โรคเลือดออกตามไรฟัน หรือ โรคลักปิดลักเปิด (Scurvy) เหงือกบวม เหงือกร่นและนุ่มแดง รู้สึกเจ็บ ทำให้มองดูห่างจากฟัน ฟันจะดูยาวขึ้น รู้สึกฟันโยกเมื่อรับประทานอาหาร ถ้าไม่รีบรักษาฟันอาจจะหลุดได้ มีกลิ่นปาก เพราะเศษอาหารสะสมบริเวณตามร่องฟัน และบาดแผลบริเวณเหงือก เป็นที่สะสมของเชื้อแบคทีเรีย

1.2 โรคคอหอยพอก เป็นโรคที่มีต่อมไทรอยด์โตขึ้นหรือมีขนาดใหญ่กว่าปกติ โดยอาจพบร่วมกับก้อนที่ต่อมไทรอยด์หรือไม่ก็ได้ ผู้ป่วยที่มีคอพอกอาจมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ หรือต่ำกว่าปกติก็ได้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของคอพอกในผู้ป่วยแต่ละราย

1.3 โรคเอ๋อ เกิดจากมารดาขาดสารไอโอดีนในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งสารไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่พบมากในอาหารทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และจำพวกเกลือไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน เป็นต้น ถ้าขาดสารไอโอดีนทำให้ไทรอยด์ต่ำ (Hypothyroidism) ซึ่งหากไทรอยด์ต่ำ อาการรุนแรง จะส่งผลให้ทารกพิการแต่กำเนิด มีสติปัญญาล่าช้า หรือเป็นเด็กปัญญาอ่อน

1.4 โรคตาฟาง หรือตามัว ลักษณะของอาการของตามัว อาการโดยทั่วไป มีดังนี้ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเพ่งมองผ่านดวงตาอ่อนหล้า ตามัวมองไกลไม่ชัด และดวงตาไม่สามารถปรับรูม่านตาในการมองเห็นในยามกลางคืนได้ไม่เต็มที่ ปวดบริเวณศีรษะ ใบหน้าบิดเบี้ยว ทำให้การควบคุมดวงตาเบลอ ไม่โฟกัสกับสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นรอบ ๆ ได้ชัดเจน

1.5 โรคโลหิตจาง คือ ภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกติหรือภาวะซีด (Anemia) ทำให้ผลิตออกซิเจนได้น้อยกว่าปกติ ส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ภาวะนี้พบได้บ่อยในบุคคลทั่วไป โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายและความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะโลหิตจางของแต่ละคน



เรื่องที่ 2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร

การสุขาภิบาลอาหาร เป็นการบริหารจัดการและการควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอน พยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตราย หรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของผู้บริโภค



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยที่เปลี่ยนเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบก่อให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาความไม่สะอาดปลอดภัยของอาหารที่บริโภค

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร และส่งตัวแทนนำเสนอเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับการปนเปื้อน การปรุงและจำหน่าย ผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหาร สุขลักษณะทั่วไปบริเวณแผงจำหน่ายสุขลักษณะอาหารถุง



เนื้อหาสาระ

หลักการสุขาภิบาลอาหาร คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุง การบำรุงรักษา และการแก้ไข เพื่ออาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วมีผลดีต่อสุขภาพอนามัยโดยให้อาหารมีความสะอาด ปลอดภัย และมีความน่าบริโภค มีหลักการดังนี้

2.1 การปนเปื้อนของอาหาร หมายถึง การที่มีสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาหาร เช่น เชื้อโรค สารเคมี หรือสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น ปะปนลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือไม่สบายของบุคคลที่บริโภคอาหารที่ได้รับการปนเปื้อนเข้าไป

2.2 การปรุงและจำหน่ายอาหาร การจัดการเกี่ยวกับอาหารสด อาหารแห้ง และอาหารปรุงสำเร็จ

- อาหารสดที่นำมาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

- อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม เก็บเป็นสัดส่วน และมีการปกปิด ไม่วางบนพื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อน

- เนื้อสัตว์เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

- อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นำมาใช้ในกระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมาย

- มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตามชนิดของอาหาร สำหรับอาหารบริโภคเย็น เช่น สลัด ซูชิ ควรเก็บที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

- อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการปนเปื้อน วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

2.3 ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

- ต้องมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคน่ารังเกียจตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โรคไข้รากสาดน้อย ไข้สุกใส โรคบิด โรคคางทูม วัณโรค โรคเรื้อน โรคผิวหนังน่ารังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสเอ

- ไม่แสดงอาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในขณะปฏิบัติงาน และหากมีโรคให้หยุดงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด

- กรณีมีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด และไม่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

- มีหลักฐานผ่านการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานจัดการอบรมที่กำหนด

- ต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ โดยสวมเสื้อมีแขน มีเครื่องแบบ และสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

- มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่สูบบุหรี่ หรือการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารในขณะปฏิบัติงาน

- ต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค

2.4 สุขลักษณะทั่วไปบริวณแผงจำหน่าย สถานที่จำหน่ายและบริโภคอาหาร

- ต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุด และทำความสะอาดง่าย

- ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชำรุดระบายอากาศได้เพียงพอ

- หากสถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบร่วมด้วย

- มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ

- มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ

- โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบ ปรุงอาหาร หรือจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายและคงสภาพดี

- โต๊ะหรือเก้าอี้ที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุด วัตถุดิบสำหรับปรุงประกอบต้องมีภาชนะรองรับและตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

2.5 สุขลักษณะอาหารถุง

- ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับการสัมผัสอาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุด

- มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีการปกปิดมิดชิด

เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัย อย่างไรก็ดีความต้องการอาหารในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน เช่น วัยเด็กต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโต เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายต้องมีการควบคุมน้ำหนักเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดังนั้น ควรมีแนวทางในการเลือกอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ จนถึงวัยสูงอายุ



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว เช่น ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นต้น แล้วบันทึกลงในตารางแล้วเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน

กลุ่มบุคคล	อาหาร
ตา / ยาย	…… …… ……
พ่อ / แม่	…… …… ……
พี่สาว / พี่ชาย	…… …… ……
น้องสาว / น้องชาย	…… …… ……
อื่น ๆ ……	…… …… ……



เนื้อหาสาระ

อาหารที่เรารับประทานแต่ละวันนั้น แต่ละประเภทให้ปริมาณของสารอาหารและให้พลังงาน ที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ในการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อแต่ละวัน ควรเลือกรับประทานอาหารสลับกันไป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอและถูกสัดส่วนตามบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. ตนเอง และครอบครัว สารอาหารประเภทต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อร่างกาย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน และร่างกายมีความต้องการเป็นปริมาณมาก ส่วนวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดไม่ให้พลังงานแต่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มนุษย์แต่ละเพศแต่ละวัย แต่ละสภาพต้องการพลังงานและสารอาหารประเภทต่าง ๆ ในปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้น ในการเลือกกินอาหาร จึงจะควรเลือกให้พอเหมาะกับเพศ วัย และสภาพของแต่ละบุคคลด้วยเพื่อร่างกายจะได้เติบโตอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม อาหารที่คนเรารับประทานกันเป็นประจำมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารต่างประเภทในปริมาณมากน้อยต่างกัน โดยปกติในแต่ละวันร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารแต่ละประเภทในปริมาณต่างกัน

2. ผู้สูงอายุ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

การจัดอาหารให้ผู้สูงอายุ ควรคำนึงถึงผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล เพราะผู้สูงอายุแต่ละบุคคลอาจจะชอบอาหารไม่เหมือนกัน บางครั้งไม่จำเป็นว่าทุกมื้อจะต้องได้รับสารอาหารครบทุกประเภทอยู่ในมื้อเดียว

1) ในการจัดอาหารนี้อาจจะต้องแบ่งอาหารให้เป็นอาหารมื้อย่อย 4 – 5 มื้อ เพื่อลดปัญหาการแน่นท้อง

2) อาหารที่จัดควรจะเป็นอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด ถ้าเป็นผักควรจะหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นึ่งหรือต้มให้นิ่ม

3) พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊ส หรือท้องอืด เช่น ถั่วบางประเภท

4) อาหารควรเป็นอาหารที่มีคุณภาพ เช่น คาร์โบไฮเดรตในรูปเชิงซ้อน คือ ไม่ได้ผ่านขบวนการขัดสี และโปรตีนจากปลา

5) เน้นให้ใช้วิธีการนึ่งมากกว่าทอด เพื่อลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะได้รับเกินเข้าไป

6) อาหารเสริมที่แนะนำ ควรเสริมผักและผลไม้ให้มากขึ้น พวกตำลึง ผักบุ้ง คะน้า มะเขือเทศ ส้มเขียวหวาน กล้วยสุก มะละกอสุก จะช่วยเพิ่มให้ผู้สูงอายุได้รับกากใย ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี

7) พยายามกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม การได้ออกกำลังกาย จะทำให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น

8) การดูแลทางด้านจิตใจ การให้ความเอาใจใส่กับผู้สูงอายุสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง หรือท่านรู้สึกว่าท่านหมดความสำคัญกับครอบครัว

9) การจัดอาหารให้มีสีสันน่ากิน โดยพยายามใช้สีที่เป็นธรรมชาติ ปรุงแต่งให้อาหารมีหน้าตาน่ารับประทาน อาหารที่จัดให้ควรจะอุ่นหรือร้อนพอสมควร เพื่อเพิ่มความอยากอาหารให้มากขึ้น

10) ไม่ควรให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด จะเกิดอาการปวดมวนท้อง หรือทานแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายตัว อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อทางเดินอาหารได้

สรุป วัยสูงอายุ เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญ เราถือว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี เพราะฉะนั้นลูกหลานหรือผู้ดูแล หรือแม้แต่ตัวผู้สูงอายุเอง ควรเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การบริโภคอาหารที่ดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เราควรจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีต่อไป

3. ผู้ป่วย อาหารสำหรับผู้ป่วย คนเราเมื่อเจ็บป่วยย่อมจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะเรื่องอาหารเป็นพิเศษ ผู้ป่วยมีลักษณะการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ย่อมต้องการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน ดังนี้

อาหารธรรมดา สำหรับผู้ป่วยธรรมดาที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงที่ต้องรับประทานอาหารเฉพาะจะเป็นอาหารที่มีลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับอาหารปกติ เป็นอาหารหลัก 5 หมู่ ให้ได้สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

อาหารอ่อน เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยวได้ตามปกติ ผู้ป่วยภายหลังการพักฟื้น หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลัน เช่น ท้องร่วง บิด เป็นต้น อาหารประเภทนี้จะเป็นอาหารที่มีเนื้อนิ่ม มีรสอ่อน ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็งหยาบ ไม่มันจัด เช่น นม ครีม ไข่ทุกชนิดที่ไม่ใช้วิธีทอด ปลานึ่งหรือย่าง เนื้อบด ไก่ต้มหรือตุ๋น ซุปใส แกงจืด ผักที่มีกากน้อยและไม่มีกลิ่นฉุนต้มสุกบดละเอียด น้ำผลไม้คั้น กล้วยสุก เป็นต้น

อาหารเหลว เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังผ่าตัดและผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีกาก มี 2 ชนิด คือ

1) อาหารเหลว เช่น น้ำชาใส่มะนาวและน้ำตาล กาแฟใส่น้ำตาล ซุปใสที่ไม่มีไขมัน น้ำข้าวใส สารละลายน้ำตาลหรือกลูโคส เป็นต้น ซึ่งจะให้กินทีละน้อยทุก 1 - 2 ชั่วโมง เมื่อผู้ป่วยกินได้มากขึ้น จึงค่อยเพิ่มปริมาณ

2) อาหารเหลวข้น เป็นของเหลวหรือละลายเป็นของเหลว เช่น น้ำข้าวข้น ข้าวบดหรือน้ำซุป นมทุกชนิด เครื่องดื่มผสมนม น้ำผลไม้ น้ำต้มผัก ไอศกรีม ตับบดผสมซุป เป็นต้น



ภาพอาหารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge/food/

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 2 อาหารและโภชนาการ

เรื่องที่ 1 โรคขาดสารอาหาร



กิจกรรม

ปัญหา สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคขาดสารอาหาร

ปัญหา : โรคขาดสารอาหารเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

สาเหตุ : ปัญหาทางจิตใจ อาจทำให้ความอยากอาหารลดลง อาการป่วย เช่น อาเจียน ท้องเสีย ทำให้ความอยากอาหารลดลง โรคที่ส่งผลต่อการดูดซึมและการย่อยอาหาร เช่น โรคเซลิแอค ภาวะจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุล การใช้ยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียง เช่น ท้องเสีย หรืออาเจียน

อาการ : น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ผมร่วง ตัวซีด ง่วง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ เป็นลมหมดสติ ฯลฯ

การป้องกัน : การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนม รับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนและครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลักและสารอาหารที่ต้องการในปริมาณน้อยอย่างเพียงพอ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ

เรื่องที่ 2 หลักการสุขาภิบาลอาหาร



กิจกรรม

หลักสุขาภิบาลอาหารเป็นหลักการสำคัญในการรับรองความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร โดยมีเป้าหมายหลักในการป้องกันการปนเปื้อนของอาหารจากสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้สัมผัสอาหาร: ผู้ปรุงอาหาร ผู้เสิร์ฟอาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีสุขนิสัยที่ดี และปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ และสวมถุงมือเมื่อสัมผัสอาหาร

ภาชนะและอุปกรณ์: ต้องสะอาด ปลอดภัย และใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการสัมผัสอาหาร

สถานที่: สถานที่ปรุงและจัดจำหน่ายอาหารต้องสะอาด ไม่มีหยากไย่ และมีการระบายน้ำที่ดี

อาหาร: เลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพดี เก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม และแยกอาหารสดและอาหารปรุงสุก

สัตว์และแมลงนำโรค: ควบคุมการเข้าถึงของสัตว์และแมลงนำโรคในพื้นที่เตรียมและจัดจำหน่ายอาหาร

การปฏิบัติตน : ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนและหลังจัดการอาหาร, ใช้ถุงมือเมื่อสัมผัสอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน เก็บภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดและวางสูงจากพื้น การดูแลสุขภาพ ตัดเล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ และไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่จัดการอาหาร

เรื่องที่ 3 การจัดโปรแกรมอาหารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ



กิจกรรม

กลุ่มบุคคล	อาหาร
ตา / ยาย	กินข้าวเป็นหลัก เน้นข้าวกล้อง ข้าวขัดสีน้อย กินพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากเป็นประจำ กินปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเป็นประจำ อาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด
พ่อ / แม่	อาหารปกติ การจัดอาหารในจาน ให้มีผัก 2 ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน และข้าว - แป้ง เลือกอาหารที่ใช้ วิธีการนึ่ง ต้ม อบ แทนการผัดหรือทอด พร้อมผลไม้
พี่สาว / พี่ชาย	อาหารปกติ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เช่น ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ทุกชนิด และผัก ผลไม้ตามฤดูกาล
น้องสาว / น้องชาย	ให้ความสำคัญกับอาหารเช้า รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรให้เด็กได้บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนม เพื่อให้ได้รับโปรตีนและแคลเซียม
อื่น ๆ	

บทที่ 3
ความปลอดภัยจากการใช้ยา

สาระสำคัญ

ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต ปัจจุบันมีการวิจัยและผลิตยาใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลก ถึงแม้ว่ายาจะเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตของทุกคน แต่บางครั้งก็สามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้าผู้ใช้ไม่มีความรู้หรือมีความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยา จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตขึ้นได้ ดังนั้น ผู้ใช้ยาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ หลักการและวิธีใช้ยา ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยา การป้องกันและการช่วยเหลือ และทราบถึงการใช้เลือกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายหลักการและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
2. วิเคราะห์ผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยา
3. จำแนกอันตรายที่เกิดจากการใช้ยา การป้องกันและการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
4. แนะนำข้อมูลข่าวสารและความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ครอบครัว และชุมชน

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใช้ยา
เรื่องที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา
- ยาบำรุงกำลัง
- ยาที่ทำจากอวัยวะสัตว์ เช่น อุ้งตีนหมี ดีงู สมองลิง ยาดองงูเห่า เป็นต้น

เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยา การป้องกัน และการช่วยเหลือ
เรื่องที่ 4 การแนะนำในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา

เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีการใช้ยา

ยาใช้รักษาหรือทำให้ผู้ป่วยหายป่วยและร่างกายดีขึ้นได้ ยาทุกชนิดไม่ว่าจะได้มาจากการจ่ายยาของแพทย์ หรือยาที่หาซื้อตามร้านขายยาล้วนแล้วแต่มีทั้งประโยชน์และโทษ หากใช้ยาไม่ถูกวิธี ดังนั้น ผู้ใช้ยาจึงจำเป็นต้องศึกษาหลักการและวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ยาได้ถูกต้องและปลอดภัย

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

“จะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรใช้ยาอะไร ในปริมาณเท่าไหร่ ถึงจะถูกต้องตามหลักการและวิธีการใช้ยา”

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

เกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับยา

1. ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารกี่นาที
2. เมื่อยาหมดอายุแล้วควรทำอย่างไร
3. ความสำคัญของการอ่านฉลากยา



เนื้อหาสาระ

หลักและวิธีการใช้ยา ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด เลือกชนิดยาให้ถูกกับโรค ใช้ยาให้ถูกกับขนาด ควรรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล ไม่ใช้ยาหมดอายุและไม่ใช้ยาโดยไม่จำเป็น

1. หลักการและวิธีการใช้ยา

1) อ่านฉลากยาให้ละเอียด ยาทุกชนิดจะมีฉลากยาบอกชื่อ ขนาดและวิธีใช้ ตัวยาที่ใช้ข้อห้ามในการใช้ วันผลิตและวันหมดอายุ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ระบุไว้บนฉลากยา ผู้ใช้จึงควรอ่านให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

2) ใช้ยาให้ถูกชนิดและประเภท การใช้ยาต้องใช้ให้ถูกชนิดและประเภท ซึ่งถ้าผู้ใช้ยาหยิบยาไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และรักษาโรคไม่หาย เนื่องจากยาบางชนิดจะมีชื่อ สี รูปร่าง หรือภาชนะบรรจุคล้ายกัน แต่ตัวยา สรรพคุณยาที่บรรจุภายในจะแตกต่างกัน

3)ใช้ยาให้ถูกขนาด ยาแต่ละชนิดมีปริมาณการใช้แตกต่างกัน เนื่องจากการใช้ยาตามขนาดจะมีผลในการรักษาโรค ถ้าได้รับขนาดของยาน้อยกว่าที่กำหนดหรือได้รับขนาดของยาเพียงครึ่งหนึ่ง อาจทำให้การรักษาโรคนั้นไม่ได้ผลและเชื้อโรคอาจดื้อยาได้ แต่หากได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นจึงต้องใช้ยาให้ถูกต้องขนาดตามชนิดของยา

4) ใช้ยาให้ถูกเวลา ยาที่ผู้ป่วยได้รับต้องรับประทานตามเวลาที่แนะนำ เพื่อให้ได้ผลในการออกฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมีหลักการใช้ยาก่อนอาหาร หลังอาหาร และก่อนนอน ดังนี้

4.1 ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

4.2 ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารทันที หรือหลังอาหาร 15 - 30 นาที

4.3 ยาก่อนนอน ควรรับประทานก่อนเข้านอน หรือก่อนนอน 15 – 30 นาที

5) ใช้ยาให้ถูกวิธี เนื่องจากการนำยาเข้าสู่ร่างกายมีหลายวิธี เช่น การกิน การทา การฉีด เป็นต้น การจะใช้วิธีการใดขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของยานั้น ๆ ดังนั้น ก่อนใช้ยาต้องอ่านฉลากแนะนำการใช้ก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าใช้ยาไม่ถูกวิธีอาจให้โทษและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

6) ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล แพทย์จะจ่ายยาตรงตามโรคของแต่ละบุคคล และจะเขียนหรือพิมพ์ชื่อคนไข้ไว้หน้าซองยา จึงไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นใช้เพราะอาจไม่ตรงกับโรคและมีผลเสียได้ เนื่องจากยาบางชนิดห้ามใช้ในเด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์ ยาบางชนิดมีข้อห้ามใช้กับบุคคลที่ป่วยเป็นโรคบางโรค ซึ่งถ้านำไปใช้จะมีผลข้างเคียงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยาได้

7) ไม่ใช้ยาหมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ ไม่ควรใช้ยาหมดอายุเนื่องจากตัวยาสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคนั้นได้เสื่อมสลายจนเหลือปริมาณน้อยซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาโรค รวมทั้งยาที่มีลักษณะภายนอกเปลี่ยนแปลงไปจากปกติทั้งรูปร่าง สี กลิ่น รสชาติ ไม่ควรใช้ยาดังกล่าวเพราะเสื่อมคุณภาพอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

8) การใช้ยาโดยไม่จำเป็น การใช้ยาโดยไม่จำเป็นหรือใช้ยาที่มากเกินไปก่อให้เกิดผลเสียทั้งกับตัวผู้ป่วยเองและประเทศชาติ การใช้ยาในปริมาณมากเกินไป เช่น ทำให้เชื้อดื้อยา เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อก็ต้องใช้ยาที่มีราคาแพงขึ้น หรือไม่มียาใช้เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และเป็นการเสียเงินค่ายาโดยไม่จำเป็น

นอกจากผู้ใช้ยาจะต้องยึดหลักการและวิธีการใช้ยาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักการและวิธีการใช้ยาอีกหลากหลายวิธี ดังนั้น ผู้ใช้ยาต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้ยา และสิ่งสำคัญในการใช้ยาต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านยาโดยตรงเพื่อให้สามารถใช้ยาได้ถูกต้องและปลอดภัย

เรื่องที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา

ความเชื่อเป็นการเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ก็ได้ ความเชื่ออาจเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือการได้รับข้อมูลต่อ ๆ กันมา ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา ที่พบว่ายังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่อันมีสาเหตุมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยา หรือจากสาเหตุใดก็ตาม การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายอย่างแน่นอน

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



- ในชุมชนหรือครอบครัวของผู้เรียนมีความเชื่อกับเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างไร มีผลกระทบหรือไม่อย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ศึกษาสถานการณ์ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยาและตอบคำถาม

สถาณการณ์ที่ 1 นายกวี อายุ 18 ปี เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอล เขาเชื่อว่าการทานยาบำรุงกำลังจะช่วยให้เขาเล่นได้ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น จึงซื้อยามาทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

สถานการณ์ที่ 2 คุณลุงสยาม อายุ 60 ปี ได้ยินมาว่าการรับประทานยาดองงูเห่าจะช่วยบำรุงกำลังและรักษาโรคข้อเสื่อม จึงตัดสินใจซื้อมาทานตามคำแนะนำของเพื่อนบ้าน

จากสถานการณ์ทั้ง 2 สถานการณ์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น



เนื้อหาสาระ

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยามีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ เช่น การเกิดผลข้างเคียง การดื้อยาและโรคเรื้อรัง การใช้ยาตามความเชื่อโดยไม่ปรึกษาแพทย์นั้นเป็นอันตราย เพราะยาบำรุงกำลังอาจมีสารกระตุ้นที่เป็นอันตราย และยาดองงูเห่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนและอาจมีพิษร้ายแรง การใช้ยาอย่างถูกต้องควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เสมอ

1. ความเชื่อว่ายาบำรุงกำลัง คือ สิ่งที่ปลอดภัยและทำให้แข็งแรง

ยาบำรุงกำลังที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 ชนิด

1.1 ชนิดแรก เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมมาก่อน มักทำในรูปเครื่องดื่ม มีส่วนผสมของตัวยาคาเฟอีน และวิตามินต่าง ๆ คาเฟอีนในเครื่องดื่มประเภทนี้จะเป็นตัวกระตุ้นสมองและการกระตุ้นของหัวใจให้ตื่นตัวอยู่ระยะหนึ่ง ผู้ดื่มจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ขยันขันแข็ง ไม่ง่วง เช่นเดียวกับการดื่มกาแฟ และการดื่มเป็นประจำจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจได้ง่าย

1.2 ชนิดที่สอง เป็นเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียเกลือแร่คราวละมาก ๆ เช่น ท้องเสีย หรืออาเจียนอย่างแรง เป็นต้น โดยคนปกติถ้าดื่มเครื่องดื่มนี้เป็นประจำจะทำให้เป็นโรคไต หัวใจ และความดันโลหิตสูงได้ง่าย

2. ความเชื่อว่ายาที่ทำจากอวัยวะสัตว์เป็นยาเพิ่มพลังทางเพศ

ความเชื่อว่า ยาที่ทำจากอวัยวะสัตว์ เช่น อุ้งตีนหมี ดีงู สมองลิง เป็นต้น เป็นยาเพิ่มพลังทางเพศ นั้น มีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ในเรื่องนี้ พบว่า สูตรยาเพิ่มพลังทางเพศที่ปรุงขึ้นจากชิ้นส่วนของสัตว์มักมีสมุนไพรตุ๋นรวมอยู่ด้วย ยาบางตำรามีเหล้าหรือแอลกอฮอล์ชนิดอื่น ๆ ผสม เช่น อวัยวะเพศเสือดองเหล้า เลือดหมีผสมไวน์ ยาดองงูเห่า เป็นต้น จนแพทย์แผนปัจจุบันมีความเห็นคล้อยตามกันว่า อวัยวะเพศหรืออวัยวะทั้งหลายที่ดองอยู่ในโหล น่าจะเป็นเพียงของลวงตาที่กระตุ้นความเชื่อของมนุษย์ต่อพลังงทางเพศของตน แอลกอฮอล์ต่างหากที่กระตุ้นให้ผู้ดื่มเกิดความคึกคัก แพทย์ยังพิสูจน์ว่า อวัยวะเพศของสัตว์ทุกชนิดมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ทั่วไป ฮอร์โมนเพศที่อาจมีอยู่ในอัณฑะสัตว์นั้น เมื่อผ่านกระบวนการต้ม ตุ๋น ย่าง หรือเมื่อถูกร่างกายย่อยสลายแล้ว ไม่อาจจะยืนยันได้ว่า ฮอร์โมนเพศนั้นจะคงอยู่ สำหรับอุ้งตีนหมีโดยเฉพาะนั้น หากนำมาย่างไฟจะมีไขมัน 43.90 % โปรตีน 55.23 % ทำให้มีคุณค่าเท่ากับเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานกันโดยทั่วไปเท่านั้นเอง

3. ความเชื่อว่ายาทรามาดอลให้เกิดอาการเคลิ้มเมา

ยาที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มนำมาทำเป็นเครื่องดื่ม เพื่อหวังผลให้เกิดอาการเคลิ้มเมา โดยปกติแล้วยาทรามาดอลเป็นยาที่ใช้แก้ปวดในระดับรุนแรง ถึงรุนแรงที่สุด และจะใช้กับผู้ที่แพ้ยาแก้ปวดในกลุ่มอื่น แต่สำหรับอาการปวดปานกลางหรืออาการปวดทั่วไป เช่น ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น จะไม่ใช้ยาทรามาดอลรักษา สาเหตุที่ไม่ใช้ทรามาดอล เป็นทางเลือกแรกในการรักษาอาการปวด เนื่องจากยามีผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อระบบประสาทและระบบหายใจ คือ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน มึนงง เคลิ้ม เฉื่อยชา ที่สำคัญหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา เช่น รูม่านตาหด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว ชัก ระบบการหายใจทำงานช้าลง จนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ และอาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้

4. ความเชื่อว่ายาระบายใช้ลดน้ำหนัก

อาการท้องผูกนั้น หมายถึง การถ่ายแข็ง และความถี่ในการถ่ายน้อยกว่า 3 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ซึ่งหาก มีอาการเช่นนี้ต้องใช้ยาระบายช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้น แต่มักมีการเข้าใจผิดว่า การใช้ยาระบาย จะช่วยลดน้ำหนัก เพราะทำให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อย ๆ ซึ่งในความจริงแล้วยาระบายไม่ได้มีผลต่อการลดแคลอรี่หรือทำให้

น้ำหนักลดได้ และการรับประทานยาระบายเป็นประจำโดยไม่ได้มีอาการท้องผูก จะทำให้ลำไส้เฉื่อยจนไม่สามารถถ่ายเองได้

5. ความเชื่อว่าให้ใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บคอ

หลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อเจ็บคอต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาจึงจะหาย แต่แท้จริงแล้ว อาการเจ็บคอ ร้อยละ 80 นั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งอาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสนั้น สามารถหายเองได้ด้วยการรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเอง ดังนั้น การรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสจึงไม่มีประโยชน์ เพราะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ และที่สำคัญการใช้ยาปฏิชีวนะนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์หรือเภสัชกรว่า อาการที่เป็นอยู่นั้นเป็นอาการแสดงของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ และต้องวิเคราะห์อีกว่าติดเชื้อชนิดไหน เนื่องจากยาปฏิชีวนะนั้นมีหลายกลุ่ม ฉะนั้น การซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง และใช้อย่างพร่ำเพื่อจะทำให้เกิดการดื้อยาได้

6. ความเชื่อว่ายาคุมกำเนิดเร่งผมยาว

มีการเผยแพร่เรื่องที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนำยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดมาบดผสมกับแชมพูแล้วสระผม จะช่วยทำให้ผมยาวเร็วขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริง เพราะยาคุมกำเนิดนั้น เป็นยาที่ประกอบไปด้วยฮอร์โมนเพศที่มีฤทธิ์ในการคุมกำเนิด ซึ่งหากนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจเกิดผลเสียจากการระคายเคืองและไม่ได้ผลตามที่หวังไว้ด้วย

7. ความเชื่อว่ากินยาดักเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

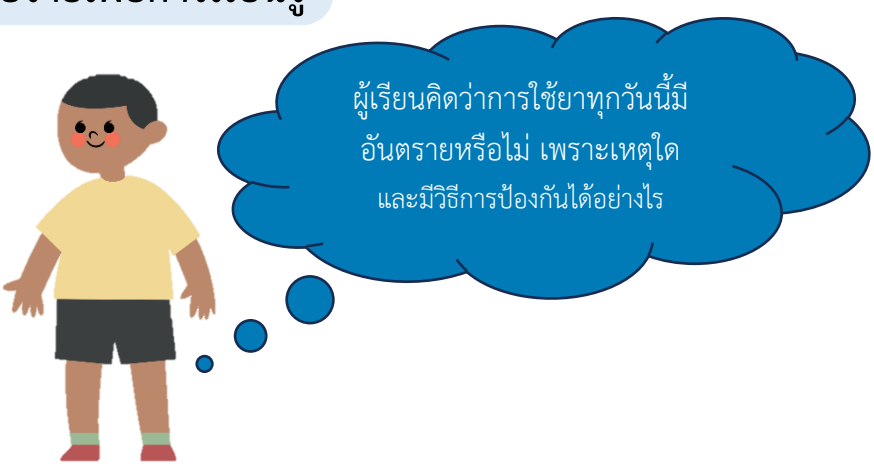
ความเชื่อที่ว่า หากรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ให้กินยาดักไว้ก่อน โดยคิดว่ายาจะสามารถป้องกันไข้หวัดได้ โดยเฉพาะการกินยาพาราเซตามอลหรือยาลดไข้ชนิดอื่น ๆ ในความจริงนั้น ยาเหล่านี้มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดลดไข้ แต่ไม่ได้มีสรรพคุณในการป้องกันอาการป่วย ดังนั้น การกินยาดักไข้ตอนที่ยังไม่มีอาการจึงไม่สามารถช่วยป้องกันการเป็นไข้ได้ อีกทั้งยาทุกชนิดมีผลข้างเคียง และอาจเกิดอันตรายหากกินติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม หากกินเกินวันละ 8 เม็ด ติดต่อกันเกิน 5 วัน จะส่งผลให้ตับทำงานหนัก จนเซลล์ตับถูกทำลาย และมีโอกาสเกิดภาวะตับอักเสบได้ในที่สุด

นอกจากความเชื่อหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาดังกล่าวข้างต้น พบว่า ยังมีความเชื่ออีกหลายความเชื่อที่ผู้ใช้ยาไม่ทราบข้อมูลความจริง ดังนั้น ผู้ใช้ยาต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการใช้ยา อย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือหลงเชื่อสิ่งที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียล โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างละเอียดหรือมีคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ความเชื่อต้องอยู่บนพื้นฐานที่อาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิดอันตรายในการใช้ยา

เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยา การป้องกันและการช่วยเหลือ

ยาเป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือให้คุณเมื่อใช้ถูกและให้โทษเมื่อใช้ผิด ผู้ใช้ยาพึงระลึกถึงอันตรายที่อาจเกิดจากยาไว้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ยารักษาตนเอง แต่ถ้าเป็นการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์แล้วโอกาสที่จะเกิดผลเสียนับว่ามีน้อยมาก อันตรายจากยาอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น เกิดจากตัวยาเอง เกิดจากความแตกต่างในตัวผู้ใช้ยา ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อยาที่ผิดปกติและเกิดจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

เกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาและวิธีการป้องกัน

ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาและวิธีการป้องกัน

คำถาม :

1. อาการของการแพ้ยาที่รุนแรงที่สุดคืออะไร
2. เมื่อรับประทานยาเกินขนาด ควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก
3. อาการข้างเคียงของยาลดน้ำมูก



เนื้อหาสาระ

การใช้ยาบางครั้ง อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ยา เช่น การแพ้ยา อาการข้างเคียง การติดยา และพิษของยา ดังนั้น ก่อนการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร การอ่านฉลากยาอย่างละเอียด และการหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างยา

1. การแพ้ยา อาการที่ปรากฏมีตั้งแต่อาการทางผิวหนัง เป็นผื่นคัน ลมพิษ ผิวเกรียมไหม้ ปากไหม้ บวม หอบ หยุดหายใจ จนถึงตายได้ อาการจะปรากฏเฉพาะบางคน และเฉพาะบางชนิดของยา เท่านั้น ถ้ามีการแพ้ยาให้หยุดใช้ยาทันที และปรึกษาบุคลากรสาธารณสุข

2. อาการข้างเคียงของยา เช่น ยาลดน้ำมูก มีฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ คือ ทำให้ง่วงนอน ดังนั้น ควรศึกษาอาการข้างเคียง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

3. การติดยา ผู้ใช้ยาเป็นระยะเวลานานอาจเกิดการติดยาได้ ซึ่งเมื่อขาดยาจะทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น หรือการเสพยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็จะก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงเพิ่มขึ้น

4. พิษของยาโดยตรง การใช้ยาย่อมมีทั้งคุณและโทษโดยหลีกเสี่ยงไม่ได้ ซึ่งการใช้ยาอาจเกิดพิษโดยตรงต่ออวัยวะต่าง ๆ ดังนี้

1) พิษต่อตับ เช่น พาราเซตามอล ยาสเตียรอยด์ ยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น
2) พิษต่อไต เช่น ยาจำพวกซัลฟา ยานีโอมัยซิน กรดบอริก เป็นต้น
3) พิษต่อกระเพาะอาหาร เช่น แอสไพริน สเตียรอยด์ (เพรดนิโซโลนเด็กซาเมทาโซน) เป็นต้น
4) พิษต่อหูภายใน เช่น กานามัยซิน ยาสเตร็ปโตมัยซิน ควินิน เป็นต้น
5) พิษต่อการสร้างเม็ดเลือด เช่น ไดพัยโรน คลอแรมเฟนิคอล เฟนิลบัวคาโซน เป็นต้น

การป้องกันอันตรายจากการใช้ยา

ยาสามารถบรรเทาอาการป่วย ใช้รักษาโรคและทำให้ร่างกายดีขึ้นได้ แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนัก คือ ยาทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีอันตรายเช่นเดียวกับที่มีคุณประโยชน์ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้ง การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นหัวใจของการรักษาโรค ดังนั้น จึงควรรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสูงสุด ดังนี้

1. ปรึกษาพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกร

เมื่อเราต้องพบแพทย์หรือซื้อยามาใช้จะต้องมีการปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรา เช่น ประวัติการแพ้ยา การรับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่น ๆ ร่วมอยู่ด้วย การอยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ข้อจำกัดบางประการในการใช้ยา เป็นต้น เพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว และสามารถจ่ายยาได้อย่างถูกต้อง หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรให้ละเอียด ซึ่งจะเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้ยาได้

2. การทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุด

เมื่อได้รับยาแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

2.1 ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุด เช่น จำชื่อสามัญทางยาและชื่อทางการค้าของยาให้ได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่แพ้ ลดการใช้ยาซ้ำซ้อน และได้รับยาเกินขนาด จำลักษณะของยา เช่น สี กลิ่น รูปร่างของเม็ดยา เป็นต้น

2.2 เมื่อสภาพของยาเปลี่ยนแปลงไปจากเริ่มแรก เช่น สีเปลี่ยน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว เพราะยาเสื่อมสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น

2.3 ตั้งใจฟังการอธิบายวิธีการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกร เช่น เวลาของการรับประทานยา ปริมาณหรือจำนวนยาที่ใช้ ระยะเวลาการรับประทาน และผลข้างเคียงหลังจากรับประทานยา เป็นต้น

3. อ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำอธิบายอย่างเคร่งครัด

การใช้ยาควรทำความเข้าใจวิธีการใช้ยาให้ละเอียดและถูกต้อง หากไม่เข้าใจตรงส่วนใดควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อ่านฉลากยาอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รับประทานยาถูกต้อง เก็บยาในพื้นที่ที่เหมาะสมตามที่ระบุบนฉลากของยา ไม่ควรเก็บยาต่างชนิดกันไว้ในภาชนะเดียวกันเพราะอาจเกิดการปนเปื้อน ควรหาถุงแยกออกจากกันและไม่ควรเก็บยาสำหรับใช้ภายในและภายนอกไว้ใกล้เคียงกัน เพราะอาจเกิดการสับสนในการใช้ได้

4. หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างกันของยา

การใช้ยาควรมีการสอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญว่ายาที่รับประทานมีปฏิกิริยาระหว่างยา อาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารเสริมหรือไม่ เพื่อเป็นการระวังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทุกครั้งที่ได้รับยามาใหม่ ควรนำยาเดิมที่รับประทานอยู่ไปแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรตรวจสอบและจัดยาใหม่ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและได้ยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

5. ตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

ผู้ใช้ยาควรทราบวิธีการใช้ยา เพื่อลดอาการข้างเคียง เช่น ควรรับประทานยาหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อลดอาการปวดท้อง เป็นต้น โดยผู้ใช้ควรให้ความสำคัญกับอาการต่าง ๆ ของร่างกาย สังเกตตนเอง หากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

การป้องกัน ปฏิบัติตนเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาสามารถทำได้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นซึ่งไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริง แต่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งและควรระลึกไว้เสมอว่าการมีส่วนร่วมกับแพทย์ เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ยาของตัวท่านเองอย่างใกล้ชิดจะทำให้มีความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือกรณีเกิดอันตรายจากการใช้ยา

เมื่อใช้ยาผิดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเมื่อใช้ยาไม่ถูกต้องจะต้องให้การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนส่งโรงพยาบาล การช่วยเหลือกรณีเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิด มีดังนี้

1. ใช้ยาทาผิด ซึ่งอาจทำให้เกิดผื่นคัน ปวด บวม หรือมีอาการอักเสบบริเวณผิวหนังที่ทายา การแพ้ยารับประทาน อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ จึงควรมีการปฐมพยาบาลโดยการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

1.1 ล้างบริเวณที่เกิดอาการแพ้ยาด้วยน้ำสะอาด โดยให้น้ำไหลผ่านหลาย ๆ ครั้ง ไม่ขยี้หรือถูผิวหนังบริเวณนั้น เพราะจะทำให้ยาที่ทาไว้กระจายมากขึ้น การล้างด้วยน้ำสะอาดจะช่วยชะล้างยาที่ทาไว้หรือทำให้ยานั้นเจือจางลง เมื่อล้างแล้วใช้ผ้าสะอาดซับเบา ๆ

1.2 ถ้ามีอาการปวด บวม และบริเวณอวัยวะที่ทายามีความร้อนมากกว่าปกติ ให้พักอยู่นิ่ง ๆ หรือให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด และสังเกตดูว่าอาการปวด บวม ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ และรีบปรึกษาแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องต่อไป

1.3 ห้ามนำยาหรือสารใด ๆ มาทาบริเวณที่แพ้ยาโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้

2. การรับประทานยาผิด กรณีผู้ใช้ยารับประทานยาผิดควรช่วยเหลือ ดังนี้

2.1 พยายามทำให้อาเจียนออกมาโดยเร็วที่สุด อาจใช้นิ้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา

2.2 รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

3. การรับประทานยาเกินขนาด กรณีผู้ใช้ยารับประทานยาเกินขนาดอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ยานอนหลับ หรือยาแอสไพริน (Aspirin) เป็นต้น มีวิธีช่วยเหลือ ดังนี้

3.1 เจือจางสารพิษ ด้วยการให้ดื่มน้ำหรือนม

3.2 ทำให้ผู้รับประทานยาเกินขนาดอาเจียน โดยการใช้วิธีล้วงคอหรือกวาดคอ เพื่อกระตุ้นให้อยากอาเจียน

3.3 รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยา การป้องกัน และการช่วยเหลือที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวนการที่สร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ยาได้มีความรู้ ความเข้าใจอันตรายที่เกิดจากการใช้ยา การป้องกันและระวังเพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงจากอันตรายในการใช้ยาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตนเองอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่ในการใช้ยาอย่างถูกต้อง

เรื่องที่ 4 การแนะนำในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา

ข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา อันตรายและความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับสุขอนามัย รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รู้เท่าทันและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตราย ซึ่งโดยหลักเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องดำเนินงานบริการข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ในปัจจุบันผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาจากแหล่งใด และมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าเชื่อถือได้หรือไม่



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

สร้างคลิปวีดิทัศน์ “ตรวจสอบข้อมูลยาด้วยตัวเอง”

ให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างคลิปวีดิทัศน์เพื่อสอนวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับยา เช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง



กิจกรรมที่ 2

สร้างโปสเตอร์ “แหล่งข้อมูลยาที่น่าเชื่อถือ”

ให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลยาที่น่าเชื่อถือ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อ เช่น ทำไมต้องเชื่อถือข้อมูลจากแพทย์ วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกแบบโปสเตอร์เพื่อนำเสนอ



เนื้อหาสาระ

การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยานั้นสำคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควรเลือกข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น แพทย์ เภสัชกร หรือหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการเชื่อข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น โซเชียลมีเดียที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน การอ่านฉลากยาอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้เราใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ควรตรวจสอบข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และระวังข้อมูลที่ชี้นำหรือมีอคติ

การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมาจากหลายช่องทาง แต่จะทราบหรือรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นจริงและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิต ดังนั้น ประชาชนทั่วไปหรือผู้ใช้ยาควรเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาได้ ดังนี้

1. ข้อมูลจากแพทย์หรือเภสัชกร แพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านยามากที่สุด ซึ่งเป็นผู้ดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้ยา ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาจากแพทย์หรือเภสัชกรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลายด้าน ทั้งในเรื่องการรักษา การจ่ายยา การให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยา การติดตามการแก้ปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วย การผลิตและประกันคุณภาพยา และการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ผู้ใช้ยาควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด

2. ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ยาสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาจากอินเทอร์เน็ตได้ แต่ต้องพิจารณา วิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากแหล่งใด เชื่อถือได้หรือไม่ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย โรงพยาบาล สถานพยาบาล แพทย์หรือเภสัชกร เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาจากความทันสมัย ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลประกอบการพิจารณา เนื่องจากแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีข้อจำกัดในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3. ข้อมูลจากสื่อหนังสือ ตำรา ผู้ใช้ยาควรมีการพิจารณาแหล่งการผลิตสื่อ หนังสือ ตำราเกี่ยวกับยานั้น ๆ ว่า มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด ตลอดทั้งความทันสมัยของการผลิตสื่อนั้น ๆ ว่า ผลิตมานานหรือไม่ อย่างไร

4. ข้อมูลจากบทความ ข้อมูลการใช้ยาจากบทความ จะเป็นข้อมูลความรู้ใหม่หรือเป็นเรื่องเพิ่มเติมความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วเป็นงานเขียนที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นการเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องหลักเพียงเรื่องเดียว ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเลือกเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองต้องการทราบรายละเอียด

5. ข้อมูลจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นใจความสำคัญที่อ่านเข้าใจง่าย การจะเลือกใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การใช้ยานั้น สิ่งสำคัญในการเลือกหรือนำข้อมูลไปใช้ คือ แหล่งที่มาของข้อมูลต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือควรมาจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าข้อมูลข่าวสารหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ยามาจากหลายแหล่งและหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ผู้ใช้ยาควรพิจารณาถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้ยาได้ถูกต้องไม่เกิดอันตรายต่อตนเอง

แหล่งข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา

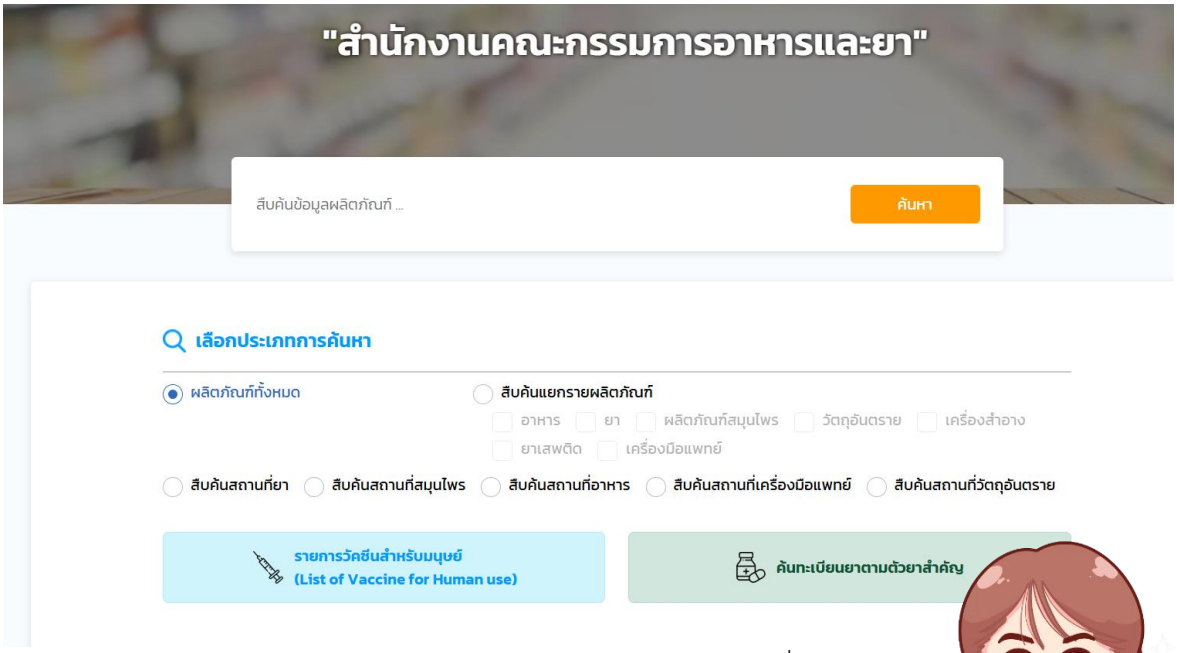
แหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาให้กับประชาชนได้ทราบหรือสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาและด้านสุขภาพได้มีดังนี้

ระดับหมู่บ้านและตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานแพทย์ประจำตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้กระทรวงสาธารสุขจัดให้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะนำเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน

ระดับอำเภอ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลอำเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น ที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยาให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ระดับจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไปที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลประจำจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นศูนย์กลางของเขต โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดทหารเหล่าต่าง ๆ เป็นต้น และจังหวัดยังมีโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกแพทย์

แหล่งข้อมูลของหน่วยงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนของแหล่งข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาแก่ครอบครัวและชุมชน



ภาพแหล่งข้อมูลของรัฐในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยา



แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 3 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

เรื่องที่ 1 หลักการและวิธีใช้ยา



กิจกรรม

1) ยาก่อนอาหาร ควรรับประทานก่อนอาหารประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

2) เมื่อยาหมดอายุแล้วควรอย่างไร ควรทิ้งเนื่องจากตัวยาสำคัญที่ใช้ในการรักษาโรคนั้นได้เสื่อมสลายจนเหลือปริมาณน้อยซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาโรค

3) ความสำคัญของการอ่านฉลากยา ทำให้เราทราบชื่อของยา ขนาดและวิธีการใช้ ตัวยาที่ใช้ ข้อห้ามในการใช้ วันผลิตและวันหมดอายุ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ระบุไว้บนฉลากยา

เรื่องที่ 2 ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ยา



กิจกรรม

สถาณการณ์ที่ 1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. ผลข้างเคียง: ยาบำรุงกำลังหลายชนิดมีส่วนผสมของสารกระตุ้น เช่น คาเฟอีน ซึ่งหากรับประทานในปริมาณมากเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ กระวนกระวาย ปวดหัว และความดันโลหิตสูงได้

2. การดื้อยา: การใช้ยาบำรุงกำลังอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ร่างกายดื้อต่อสารกระตุ้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไป ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง

3. ปัญหาสุขภาพในระยะยาว: การใช้ยาบำรุงกำลังในระยะยาว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต

4. การละเมิดกฎกติกา: ในการแข่งขันกีฬาบางประเภท การใช้ยาบำรุงกำลังที่มียาต้องห้ามเป็นส่วนผสม ถือเป็นการทำผิดกฎกติกา และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

สถาณการณ์ที่ 2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

1. อันตรายจากพิษ: งูเห่ามีพิษร้ายแรง การนำส่วนใดส่วนหนึ่งของงูเห่ามาดองและรับประทาน อาจทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรง พิษเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ชาตามร่างกาย หายใจลำบาก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

2. การปนเปื้อนของเชื้อโรค: กระบวนการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้

3. ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน: การอ้างว่ายาที่ทำจากอวัยวะสัตว์ เช่น อุ้งตีนหมี ดีงู สมองลิง สามารถรักษาโรคได้นั้น เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน การใช้ยาเหล่านี้จึงถือเป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็น

4. กฎหมายควบคุม: การผลิตและจำหน่ายยาที่ทำจากอวัยวะสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และอาจเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย

เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์อันตรายจากการใช้ยา การป้องกัน และการช่วยเหลือ



กิจกรรม

1. เสียชีวิตจากการแพ้ยา
2. เจือจางสารพิษ ด้วยการให้ดื่มน้ำหรือนม
3. ทำให้ง่วงนอน

บทที่ 4
โรคทางพันธุกรรม

สาระสำคัญ



โรคทางพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือการกลายพันธุ์ในยีนหรือโครโมโซม ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายและทำให้เกิดอาการหรือความผิดปกติในสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้ และบางโรคอาจเกิดจากการกลายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้ถ่ายทอดจากพ่อแม่ ซึ่งผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติกับบุคคลทั่วไป โดยต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอและควรมีการตรวจจากแพทย์ก่อนการแต่งกายเพื่อวางแผนการป้องกันการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. บอกความหมายของโรคทางพันธุกรรมได้
2. บอกประเภทของโรคทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยได้
3. อธิบายสาเหตุ อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษาและการป้องกันโรคทางพันธุกรรมได้

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความหมายของโรค และประเภทของโรคทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย
เรื่องที่ 3 การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 4 การรักษาโรคทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 5 การป้องกันโรคทางพันธุกรรม

เรื่องที่ 1 ความหมายของโรค และประเภทของโรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรม เป็นความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกาย และโรคทางพันธุกรรมมีหลากหลายประเภท ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย จึงควรเข้าใจถึงโรคทางพันธุกรรม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า “โรคทางพันธุกรรม” อย่างไร และในชุมชนหรือคนที่พบเห็นมีผู้เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนสรุป 1) ความหมายของโรคทางพันธุกรรม และ 2) ประเภทของโรคทางพันธุกรรม ในรูปแบบแผนที่ความคิด หรือ แผนภาพ



เนื้อหาสาระ

ความหมายโรค

โรค (disease) คือ ความผิดปกติบางอย่างที่มีผลเสียต่อโครงสร้างและการทำงานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจมีผลเพียงบางส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือมีผลทั้งตัว โดยทั่วไปแล้วจะไม่นับรวมการบาดเจ็บจากปัจจัยภายนอก

โรคโดยส่วนใหญ่เป็นภาวะทางการแพทย์ (medical condition) ซึ่งทำให้มีอาการและอาการแสดงต่าง ๆ โรคอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สารก่อโรค หรือเชื้อก่อโรค หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายในก็ได้ เช่น การทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นปัจจัยภายใน สามารถทำให้เกิดโรคได้หลายอย่าง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคภูมิแพ้ โรคภูมิต้านตนเอง เป็นต้น

ในกรณีของมนุษย์ “โรค” อาจหมายรวมถึงภาวะอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด การทำหน้าที่บกพร่อง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ปัญหาสังคม และการเสียชีวิตต่อผู้ที่มีโรค (ผู้ป่วย) หรือผู้อื่นอีกด้วย บางนิยามอาจนับรวมไปถึงการบาดเจ็บ ความพิการ ความผิดปกติ กลุ่มอาการ การติดเชื้อ อาการ พฤติกรรมผิดปกติ และโครงสร้างร่างกายที่มีรูปร่างหรือการทำงานผิดปกติด้วยก็ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ในบางกรณีอาจไม่ถูกนับรวมเป็นโรค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำนิยามไปใช้ประโยชน์ โรคอาจไม่ได้มีผลต่อเฉพาะร่างกายของผู้ป่วย แต่อาจมีผลต่อจิตใจ และมุมมองต่อความเป็นไปของโลกได้ด้วย

โรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรม (Genetic disorder) คือ โรคหรือความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติของยีนซึ่งเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรม โดยมีทั้งโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ (inherited) และไม่ถ่ายทอด (non - inherited) โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ที่มีความต่างกันดังนี้

1. โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Inherited genetic disorder) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน เมื่อยีนถูกถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานจึงทำให้เกิดความผิดปกติหรือส่งต่อการเป็นพาหะให้กับลูกหลานได้

2. โรคทางพันธุกรรมที่ไม่ถ่ายทอด (Non - inherited genetic disorder) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน ไม่ได้มาจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน แต่มาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นเอง โดยมีความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติ

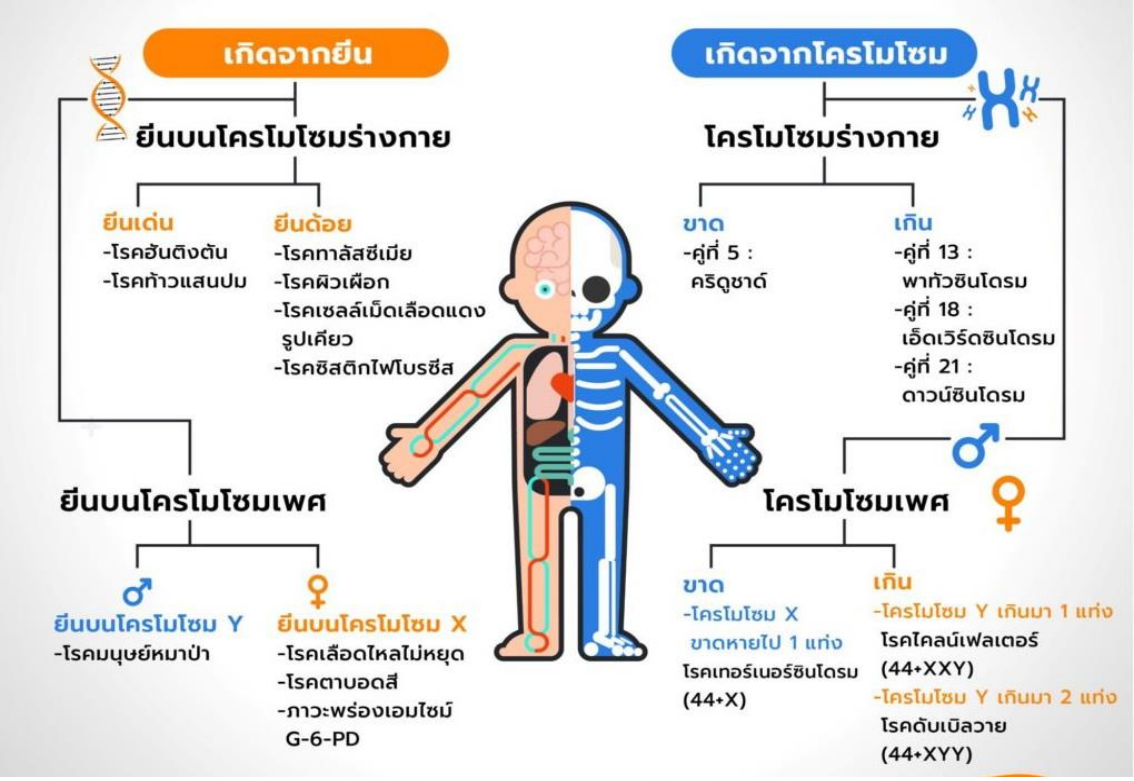
ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า โรคทางพันธุกรรม เป็นโรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก หรือจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานได้ ซึ่งโรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันมักเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้ทั้งจากบรรพบุรุษที่เป็นพาหะหรือเป็นโรค เช่น ธาลัสซีเมีย (Thalassemia), โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia), โรคตาบอดสี (Color Blindness) เป็นต้น

สรุปได้ว่า โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Inherited genetic disorder) และ โรคทางพันธุกรรมที่ไม่ถ่ายทอด (Non-inherited genetic disorder) เป็นโรค 2 กลุ่มของโรคทางพันธุกรรม (Genetic disorder) ส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานบางโรค แต่ในความจริงนั้นยังมีโรคทางพันธุกรรมหลายโรคที่ควรทำความรู้จัก โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรมที่มีมากถึง 4 ประเภท ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถตรวจคัดกรองเพื่อทราบความเสี่ยงในระหว่างตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ประเภทของโรคทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. โรคที่เกิดจากความผิดปกติบนออโตโซม (Autosome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในร่างกายที่มี 44 แท่ง หรือ 22 คู่ เป็นความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดปกติที่จำนวนออโตโซม และความผิดปกติที่รูปร่างโครโมโซม

2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศ (Sex chromosome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศจำนวน 1 คู่ หรือ 2 แท่ง ในผู้หญิงจะเป็นโครโมโซม XX ส่วนในผู้ชายจะเป็นโครโมโซม XY จะมีโอกาสเกิดขึ้นมากในเพศใดเพศหนึ่ง ตัวอย่างของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในโครโมโซมเพศ ได้แก่ โรคธาลัสซีเมีย โรคตาบอดสี โรคบกพร่องทางเอนไซม์ เป็นต้น



รูปภาพที่ 1 โรคทางพันธุกรรม ที่มา : https://learnneo.in.th/โรคทางพันธุกรรม-ที่เกิด/.

โรคทางพันธุกรรม

หากพ่อหรือแม่มีลักษณะโครโมโซมที่ผิดปกติ หรือเกิดการผ่าเหล่าในกระบวนการปฏิสนธิ ก็จะทำให้เด็กที่เกิดออกมามีลักษณะผิดปกติที่เรียกโรคทางพันธุกรรมได้ โรคทางพันธุกรรม สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามการเกิดโรคและลักษณะทางพันธุกรรม ดังนี้

1. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว คือ โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผ่าเหล่าของยีน โดยการผ่าเหล่านี้อาจเกิดขึ้นที่โครโมโซมเพียงแท่งเดียว หรือที่โครโมโซมหลายแท่งก็ได้ ความผิดปกติอาจเกิดจากการถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมของยีน 2 ชนิด คือ ยีนเด่น (Dominant) และยีนด้อย (Recessive) ดังนี้

1.1 โรคที่เกิดจากยีนเด่น เกิดจากการที่ทารกได้รับยีนเด่นมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง ซึ่งการได้รับยีนเด่นที่มีพันธุกรรมผิดปกติเพียง 1 ยีน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ถึง 50% ต่างจากโรคจากยีนด้อยที่ต้องมียีนด้อย 2 ยีนขึ้นไป จึงจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ โดยโรคที่เกิดจากยีนเด่น เช่น โรคประสาทชักกระตุก โรคท้าวแสนปม และโรคถุงน้ำในไต เป็นต้น

1.2 โรคที่เกิดจากยีนด้อย เป็นโรคที่เกิดจากการได้รับยีนด้อยจากพ่อและแม่ โดยจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อพ่อและแม่อยู่ในสถานะเป็นพาหะทั้งคู่ เด็กที่เกิดจึงจะมีโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อย หากมีเพียงพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นพาหะ หรือมีอาการป่วยเพียงคนเดียว โอกาสที่เด็กจะได้รับยีนที่แสดงโรค

ก็จะน้อยลง โรคที่เกิดจากยีนด้อย ได้แก่ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว โรคซีสติกไฟโบรซีส โรคฟีนิลคีโตนูเรีย และโรคถุงน้ำในไตในยีนด้อย

1.3 โรคที่เกิดจากโครโมโซมเพศ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดได้น้อย โดยมีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของยีนเด่น และยีนด้อยที่อยู่ภายในโครโมโซมเพศ ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) เป็นต้น

2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม มีสาเหตุเกิดจากลักษณะโครโมโซม หรือจำนวนของโครโมโซมผิดปกติ ซึ่งสามารถแบ่งความผิดปกติของโครโมโซมได้เป็น 2 แบบ ได้แก่

2.1 ความผิดปกติที่จำนวน เกิดจากการที่โครโมโซมมีจำนวนเกินหรือขาดไป โรคทางพันธุกรรมที่เกิดในกลุ่มนี้ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม และโรคเทอร์เนอร์ เป็นต้น

2.2 ความผิดปกติของลักษณะโครโมโซม เกิดจากลักษณะของโครโมโซมผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น เช่น ขาดหายไป หรือมีโครโมโซมซ้ำกัน อยู่ผิดตำแหน่ง ขาดออกจากกัน กลับหัวกลับหาง หรือมีลักษณะคล้ายแหวนหรือเป็นวงกลม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติเหล่านี้ ได้แก่ โรคมนุษย์หมาป่า หรือโรคจาคอบเซน

3. โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน โดยมีปัจจัยมาจากวิถีการใช้ชีวิต หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโรคในกลุ่มที่พบได้บ่อย เช่น โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือโรคมะเร็ง เป็นต้น

เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย

โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมีมากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของสารพันธุกรรม แต่ที่พบได้บ่อยนั้น เช่น โรคถุงน้ำในไต โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว โรคซีสติกไฟโบรซีส โรคประสาทชักกระตุก โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย ดาวน์ซินโดรม และโรคตาบอดสี เป็นต้น



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนเคยพบบุคคลที่เป็นโรคทางพันธุกรรมในชุมชนหรือไม่ และมีลักษณะอย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เคยพบหรือพบได้บ่อย ๆ ในชุมชน



กิจกรรมที่ 2

ให้ผู้เรียน สรุป “โรคทางพันธุกรรม” ที่พบได้บ่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรค สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรค เป็นแผนผังความคิด



เนื้อหาสาระ

1. โรคทางพันธุกรรมที่สำคัญ

1.1 ดาวน์ซินโดรม (Down's syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง จากปกติที่มี 2 แท่ง ลักษณะของเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมนั้นจะมีศีรษะเล็ก ตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน ลิ้นยื่นออกมา ปากเล็ก มือสั้น และอาจมีโรคประจำตัวติดมาตั้งแต่กำเนิด เช่น โรคหัวใจพิการ โรคลำไส้อุดตัน ต่อมไทรอยด์บกพร่อง เป็นต้น โรคนี้มักพบได้บ่อยในแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก

1.2 เอ็ดเวิร์ดซินโดรม (Edwards syndrome) ส่งผลให้เด็กมีความผิดปกติทางสติปัญญา ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วมือบิดงอ และกำแน่นเข้าหากัน เป็นโรคที่ทำให้เด็กเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย

1.3 ตาบอดสี (Color blindness) มักเป็นโรคที่มีมาแต่กำเนิด และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาการของผู้ที่เป็นโรคนี้ คือ จะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียวกับสีแดง หรือสีน้ำเงินกับสีเหลืองได้ โดยจะเกิดขึ้นกับดวงตาทั้งสองข้าง และไม่สามารถรักษาได้

1.4 ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) เป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด หรือเลือดออกง่าย เพราะขาดสารที่ทำให้เลือดแข็งตัว พบมากในเพศชาย อาการของโรคนี้คือ เลือดออกมากผิดปกติ ข้อบวม มักเกิดแผลฟกช้ำขึ้นเอง เป็นต้น

1.5 โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) อาการเริ่มแรกจะคล้ายกับเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง เช่น ผิวซีด ผิวเหลือง เหนื่อยง่าย การเจริญเติบโตช้า ปัสสาวะสีเข้ม เป็นต้น การรักษาจะทำได้โดยการให้เลือด และการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้อื่น

1.6 โรคลูคิเมีย (Leukemia) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคที่เกิดจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาวออกมามากผิดปกติ และเม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อโรคได้ จึงป่วยเป็นไข้บ่อย โดยอาการที่แสดงออกมา คือ มีไข้สูง เป็นหวัดเรื้อรัง วิงเวียน ศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด เป็นต้น บางรายอาจมีอาการรุนแรงทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนการรักษานั้นสามารถทำได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะ หรืออาจใช้เคมีบำบัดเพื่อให้ไขกระดูกกลับมาทำหน้าที่ตามปกติ

โรคทางพันธุกรรมหลายโรคมักเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะเกิดจากความผิดปกติของยีนในร่างกาย ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อให้ทราบว่าตนเองมียีนแฝงหรือเป็นพาหะนำโรคหรือไม่ เพื่อการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคของลูกน้อยในอนาคตได้

2. โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย

โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความผิดปกติของสารพันธุกรรม แต่ที่พบได้บ่อยนั้น ได้แก่

2.1 โรคถุงน้ำในไต

อาการ ที่พบบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่แพทย์มักจะพบผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหลัง มีไข้ ปัสสาวะบ่อย เจ็บบริเวณซี่โครงหรือสะโพก เบื้องต้นจะมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจพบภาวะแทรกซ้อนอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะเป็นเลือด ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อย ตรวจพบซีสต์ที่ตับหรือตับอ่อน ลิ้นหัวใจผิดปกติ นิ่วในไต การโป่งพองของผนังหลอดเลือดแดง ท้องบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ ภาวะครรภ์เป็นพิษ (ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์) เป็นต้น

สาเหตุ เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทำให้เกิดโรคถุงน้ำในไต ส่วนใหญ่คนในครอบครัวสามารถส่งต่อยีนที่ผิดปกติให้บุตรหลานได้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย

การป้องกันและวิธีรับมือกับโรคถุงน้ำในไต การเตรียมตัวรับมือก่อนการวางแผนมีบุตรควรขอคำแนะนำจากแพทย์ช่วยประเมินความเสี่ยงในการส่งต่อโรคถุงน้ำในไตไปยังลูกหลาน

2.2 โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell disease)

อาการ ปกติแล้วมักจะแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก อาจพบได้ในทารกตั้งแต่อายุ 4 เดือน แต่โดยทั่วไปมักปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 เดือนขึ้นไป อาการมักจะมีความคล้ายคลึงกันทุกรูปแบบ แตกต่างกันที่ความรุนแรงมากน้อย

การดูแลตัวเองที่บ้าน สิ่งที่ผู้ป่วยสามารถทำได้เองที่บ้านมีดังต่อไปนี้

1) ใช้แผ่นประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวด

2) รับประทานอาหารเสริมกรดโฟลิก ตามคำแนะนำของแพทย์

3) รับประทานผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ชนิดโฮลเกรน เพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้น

4) ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะเซลล์เคียววิกฤต

5) ออกกำลังกายสม่ำเสมอและการลดความเครียดก็สามารถช่วยลดภาวะวิกฤตได้เช่นกัน

6) รีบพบแพทย์ทันทีหากผู้ป่วยพบว่าคุณอาจมีการติดเชื้อเกิดขึ้น การรักษาการติดเชื้อแต่เริ่มแรกจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตได้

2.3 โรคซีสติกไฟโบรซีส (Cystic fibrosis)

อาการ สัญญาณและอาการของโรคซิสติกไฟโบรซิสแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค สัญญาณและอาการอาจเกิดขึ้นในช่วงอายุใดก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอาจเกิดอาการผิดปกติ เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง และปอดบวมเรื้อรัง เป็นต้น บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

1) ระบบหายใจ ผู้ที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสที่เกิดการอุดตันของเมือกในท่อระบบหายใจอาจพบอาการ เช่น ไอเรื้อรัง มีเสมหะ หายใจไม่ออก อดทนต่อความเหนื่อยระหว่างการออกกำลังกายได้น้อย การติดเชื้อในปอดกำเริบ อาการคัดจมูกหรือจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

2) ระบบย่อยอาหาร เมือกสามารถขัดขวางระบบย่อยอาหารอาจนำไปสู่อาการ เช่น การดูดซึมสารอาหารไม่สมบูรณ์ อุจจาระมีกลิ่นและเป็นคราบมัน ปัญหาในการเพิ่มน้ำหนัก ปัญหาการเจริญเติบโต ลำไส้อุดตันโดยเฉพาะในทารกแรกเกิด อาการท้องผูกเรื้อรังหรือรุนแรง เป็นต้น

2.4 โรคประสาทชักกระตุก (Huntington's disease)

อาการ โรคประสาทชักกระตุก อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรม หรือสุขภาพจิตของผู้ป่วย ซึ่งปกติแล้วโรคนี้จะแสดงอาการเมื่อมีอายุประมาณ 30 - 50 ปี แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น โดยอาการจะแย่ลงเรื่อย ๆ หลังจากเริ่มมีอาการของโรคดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการที่แตกต่างกันไปตามระยะของโรค ดังนี้

การรักษา โรคประสาทชักกระตุก ปัจจุบันแพทย์ยังไม่สามารถรักษาโรคประสาทชักกระตุกได้ ทำได้เพียงรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยเท่านั้น เช่น

1) รักษาด้วยยา เช่น ยาช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้อกระตุก ยาต้านอาการทางจิต ยาช่วยรักษาการเคลื่อนไหวผิดปกติโคเรีย ยาต้านเศร้าหรือยารักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ เป็นต้น

2) รักษาด้วยจิตบำบัด การรักษาโดยจิตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยอาจใช้วิธีพูดคุยเพื่อช่วยจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้ป่วย จัดการกับความคาดหวังของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

ช่วยเตรียมแผนรับมือกับอาการที่อาจเกิดขึ้น หรือแนะนำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว

3) รักษาด้วยอรรถบำบัด คือ การให้นักอรรถบำบัดแก้ไขการพูด ช่วยพัฒนาทักษะการพูดของผู้ป่วยให้ดีขึ้น และแนะนำอุปกรณ์เสริมเพื่อฝึกพูด

4) รักษาด้วยกายภาพบำบัด การออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยเพื่อพัฒนาความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความสมดุลและการประสานงานของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย

5) รักษาด้วยกิจกรรมบำบัด นักกิจกรรมบำบัดอาจช่วยแนะนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือสมาชิกในครอบครัวได้ เช่น ติดตั้งราวจับภายในบ้าน ติดตั้งอุปกรณ์เสริมช่วยในการอาบน้ำหรือการแต่งตัว เป็นต้น

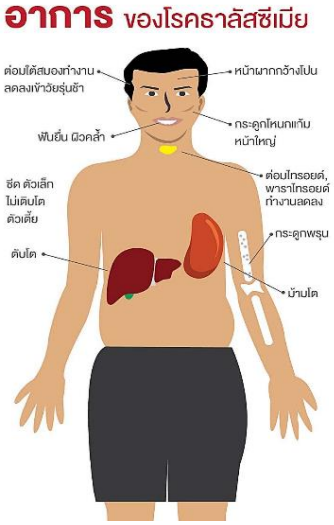
นอกจากการรักษาโดยแพทย์แล้ว สมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล รวมถึงตัวผู้ป่วยเองอาจดูแลอาการเบื้องต้นด้วยตนเองที่บ้านได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วย เช่น หากผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักให้มีสุขภาพดี อาจต้องรับประทานอาหารมากกว่า 3 มื้อหรือรับประทานอาหารเสริม ส่วนผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหาร อาจต้องเลือกรับประทานอาหารที่กลืนง่ายหรือเลือกอุปกรณ์รับประทานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาด้านความจำหรือปัญหาทางจิต อาจแก้ปัญหาด้วยการใช้ปฏิทินและจดตารางเวลาเพื่อป้องกันการลืม หรือจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เรียบง่ายและเงียบสงบป้องกันความเครียด เป็นต้น

2.5 โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)

ธาลัสซีเมีย คือ โรคโลหิตจางทางพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในเม็ดเลือดแดง ทำให้ผลิตเม็ดเลือดแดงได้น้อย มีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นและแตกง่าย และทำให้ขาดเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

สาเหตุ มีสาเหตุเกิดจากการได้รับการถ่ายทอดยีนกลายพันธุ์ระดับหน่วยย่อยโมเลกุลของฮีโมโกลบิน ในโมเลกุลของฮีโมโกลบินมีสายโกลบินสองคู่ การได้รับยีนบกพร่องหรือมีการขาดหายไปของสายโกลบินสายใดสายหนึ่ง เป็นสาเหตุสำคัญที่ให้เป็นโรคธาลัสซีเมีย ทั้งนี้ระดับความรุนแรงของอาการธาลัสซีเมียขึ้นอยู่กับจำนวนยีนบกพร่องที่ได้รับ หรือจำนวนยีนที่ขาดหายไป

อาการ แม้ว่าจะเป็นธาลัสซีเมียชนิดเดียวกัน แต่อาการธาลัสซีเมียของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพาหะ ธาลัสซีเมียที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย มีภาวะซีดเล็กน้อย ภาวะเจริญเติบโตช้า หัวใจทำงานหนัก



การรักษา แพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษา ธาลัสซีเมีย โดยขึ้นอยู่กับชนิด และระดับความรุนแรงของธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีผลการตรวจเป็นพาหะธาลัสซีเมีย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยา ผู้ที่ผลการตรวจระบุเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ และควรมีการตรวจค่าเลือด และดูแลติดตามอาการเป็นระยะตลอดชีพ

การอยู่ร่วมกับธาลัสซีเมียให้มีสุขภาพดี มีวิธีการ คือ ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียส่วนใหญ่มักมีสุขภาพเป็นปกติ ไม่มีอาการของโรค และไม่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม แพทย์แนะนำให้ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียที่ต้องการมีบุตร ควรเข้ารับ

คำปรึกษาจากแพทย์ก่อนการมีบุตรเพื่อวางแผนการมีบุตรอย่างปลอดภัยและเพื่อป้องกันการส่งต่อพาหะธาลัสซีเมียไปยังลูกหลานในอนาคต

2.6 โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia)

โรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลีย เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดขึ้นเฉพาะในเพศชาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีเลือดออกผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรืออาจพบได้ในวัยเด็กถึงวัยรุ่น ภายหลังมีการกระแทกของกล้ามเนื้อและข้อระหว่างพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

อาการ อาการเลือดออกของโรคฮีโมฟีเลียมีลักษณะเด่น ๆ คือ มีเลือดออกในข้อ ซึ่งอาจเกิดภายหลังอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระแทก เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น

แนวทางการรักษาและดูแลคุณภาพชีวิต โรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มีแนวทางการรักษา 2 แบบ คือ การรักษาเมื่อมีเลือดออก และการรักษาแบบป้องกัน

เมื่อการดูแลคุณภาพชีวิตและการรักษาผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องและตลอดชีวิต จึงมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยทั้งผู้ป่วยและแพทย์ให้สามารถติดตามอาการและการรักษาต่อเนื่อง เช่น แอปพลิเคชันต่าง ๆ อาทิ HemMobile แอปพลิเคชันนี้เป็นเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวให้กับผู้ป่วย บันทึกอาการเลือดออกผิดปกติและการฉีดแฟคเตอร์ลงในแอปพลิเคชันเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังแพทย์ที่ทำการรักษาให้ทราบถึงอาการเลือดออกของผู้ป่วย และให้การรักษาอย่างเหมาะสมและแม่นยำมากขึ้น เป็นต้น

2.7 ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)

ดาวน์ซินโดรม เป็นภาวะโครโมโซมผิดปกติ และเป็นโรคพันธุกรรมที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีพัฒนาการล่าช้า มีใบหน้าเป็นลักษณะเฉพาะ และมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ระดับเชาวน์ปัญญาโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอยู่ประมาณ 50 เทียบเท่ากับเด็กอายุ 8 - 9 ปี



อาการ

- มีโครงสร้างทางใบหน้าที่โดดเด่นชัดเจน เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หูเล็ก ตาเรียว หางตาเฉียงขึ้น มีจุดสีขาวอยู่ที่ตาดำ คอสั้น แขนขาสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้น
- นิ้วสั้น มือสั้น เท้าสั้น อาจพบเส้นลายมือตัดเป็นเส้นเดียว
- ลิ้นจุกอยู่ที่ปาก
- ตัวอ่อนปวกเปียก กล้ามเนื้อหย่อน ข้อต่อหลวม
- เชาวน์ปัญญาต่ำ ทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการ



การป้องกันดาวน์ซินโดรม ในปัจจุบันมีการเจาะเลือดแม่เพื่อตรวจโครโมโซมได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป หากคุณแม่กังวลกับปัจจัยเสี่ยงที่ว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม ควรปรึกษาแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร

การรักษาดาวน์ซินโดรม ดาวน์ซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ และรักษาในด้านร่างกายควบคู่กับการฝึกทักษะรับมือข้อบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนา และปรับปรุงทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

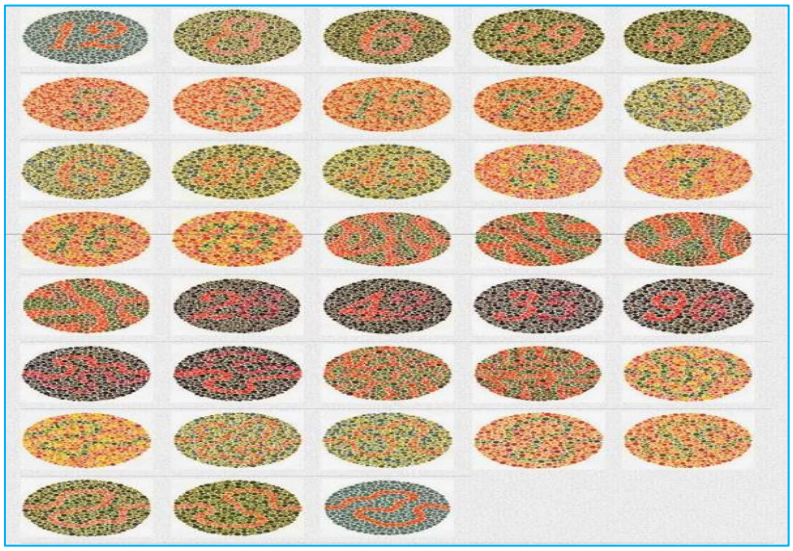
2.8 โรคตาบอดสี (Color Blindness)

โรคตาบอดสี ภาวะพร่องการมองเห็นสี ผู้ที่มีอาการตาบอดสีจะมีการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้มีสายตาปกติ โดยส่วนใหญ่มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ที่เป็นตาบอดสีจะยังคงมองเห็นภาพได้ชัดเจน แต่เห็นสีต่าง ๆ ผิดจากคนปกติ โดยไม่สามารถมองเห็นสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงินได้ชัดเจน

อาการ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับน้อย สีภาพที่เห็นอาจไม่เหมือนคนทั่วไป แต่สามารถบอกได้ว่าน่าจะเป็นสีอะไร
2. ระดับปานกลาง ความสามารถในการแยกสีน้อยลง
3. ระดับรุนแรง เห็นทุกอย่างเป็นสีขาวกับดำ ซึ่งระดับนี้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก

วิธีการทดสอบตาบอดสีโดยแผ่นทดสอบอิชิฮารา (Ishihara plates)



ที่มา : https://www.sikarin.com/health/โรคตาบอดสี-เป็นอย่างไร.

การรักษา สำหรับผู้ที่เป็นตาบอดสีโดยกรรมพันธุ์ไม่สามารถรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้ โดยหากผู้ป่วยทราบว่าตนเองเป็นตาบอดสีแต่กรรมพันธุ์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดภาวะตาบอดสีในเครือญาติ ในกรณีที่ไม่เป็นตาบอดสีแต่กำเนิด ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการเกิดตาบอดสี เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเหมาะสม

เรื่องที่ 3 การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการระบุและเข้าใจถึงสาเหตุของโรค โดยใช้กระบวนการทางแพทย์ ซึ่งการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม จะช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลรักษาที่เหมาะสมและช่วยในการวางแผนชีวิตในอนาคตได้



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ถ้าผู้เรียนพบผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรม จะดูได้อย่างไรว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมแบบง่าย ๆ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนจับคู่ข้อความทางด้านซ้ายและขวาให้ตรงกัน โดยนำตัวอักษรมาไว้หน้าข้อที่ตรงกัน

.....	1. การตรวจเพื่อหาระบุความผิดปกติของของยีนในร่างกาย	ก. โรคทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
.....	2. การตรวจนับและดูการทำงานของระดับโปรตีนภายในสารพันธุกรรม	ข. การตรวจสารพันธุกรรม
.....	3. การตรวจลักษณะของยีน หรือ DNA	ค. การตรวจโครโมโซม
.....	4. การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมโดยการตรวจประวัติครอบครัวและการตรวจทางพันธุกรรม	ง. การตรวจพันธุกรรม



เนื้อหาสาระ

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมนั้น แพทย์จะคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของพ่อแม่ ประวัติครอบครัว และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลการตรวจพันธุกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ โดยสิ่งที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยหาโรคทางพันธุกรรม

1. ความสำคัญของการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

1.1 การวางแผนการรักษาและการดูแล

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาและการดูแลที่เหมาะสมได้ เช่น การให้คำแนะนำในการรักษาโรคหรือการดูแลอาการของโรคที่ไม่สามารถรักษาหายขาด

1.2 การให้คำปรึกษาด้านพันธุกรรม

หลังจากการวินิจฉัย ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางพันธุกรรมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคไปยังลูกหลาน หรือทางเลือกในการป้องกันและดูแล

1.3 การเลือกวิธีการวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น

การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น ซึ่งอาจทำให้สามารถทำการรักษาหรือจัดการกับโรคได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. กระบวนการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

2.1 การตรวจร่างกาย

ลักษณะทางกายภาพสามารถบ่งบอกความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ โดยวิธีดังกล่าวจะทำเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรมจะทำการตรวจวัดขนาดศีรษะ ระยะห่างระหว่างดวงตา ความยาวของแขนและขา อาจมีการตรวจระบบประสาท ตรวจสายตา และเอกซเรย์ดูภายในร่างกาย เพื่อนำมาวินิจฉัยว่าทารกป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมหรือไม่

2.2 ประวัติสุขภาพของพ่อและแม่

ประวัติการรักษาต่าง ๆ ของพ่อและแม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิดถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ได้ว่าทารกที่กำลังจะเกิดมาหรือเกิดมาแล้วนั้นมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือไม่

2.3 ประวัติสุขภาพของครอบครัว

ความผิดปกติทางพันธุกรรมมักเกิดขึ้นภายในครอบครัว ดังนั้น หากแพทย์ทราบว่ามีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมใด ๆ ก็ตาม ก็จะทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์แบบแผนความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมที่อาจเกิดกับทารกที่กำลังจะเกิดมาได้

2.4 การตรวจพันธุกรรม

เป็นการตรวจที่สามารถระบุความผิดปกติของพันธุกรรมได้ชัดเจน และสามารถตรวจได้หลายวิธี โดยมักใช้การตรวจพันธุกรรมกับกรณีดังต่อไปนี้

2.4.1 ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ของแม่

2.4.2 ตรวจหาความผิดปกติของยีนในร่างกายของพ่อและแม่ที่อาจถ่ายทอดไปสู่ลูกได้

2.4.3 การตรวจคัดกรองตัวอ่อนในครรภ์ของแม่เพื่อหาโรคทางพันธุกรรม

2.4.4 ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมในผู้ใหญ่ก่อนที่จะเกิดอาการขึ้น

2.4.5 ตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันโรคในผู้ที่เริ่มมีอาการของโรคทางพันธุกรรม

2.4.6 ตรวจวินิจฉัยเพื่อใช้ประกอบในการเลือกใช้ยาและปริมาณของยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

ในการตรวจ แพทย์จะนำเอาตัวอย่างเลือดหรือเนื้อเยื่อของผู้เข้ารับการตรวจ หรือใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อนำตัวอย่างดีเอ็นเอของทารกในครรภ์ส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ โดยในการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ 3 วิธี คือ

1) การตรวจสารพันธุกรรม เป็นการตรวจโดยนำยีน หรือดีเอ็นเอ (DNA) ช่วงสั้น ๆ มาตรวจเพื่อระบุลักษณะของยีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกลายพันธุ์ซึ่งนำไปสู่โรคทางพันธุกรรมหรือไม่

2) การตรวจโครโมโซม เป็นการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม หาความเปลี่ยนแปลงในโครโมโซม ความยาว และจำนวน

3) การตรวจสารชีวเคมีในพันธุกรรม เป็นการตรวจนับและดูการทำงานของระดับโปรตีนภายในสารพันธุกรรม ซึ่งความผิดปกติเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้

การตรวจพันธุกรรมสามารถทำได้ตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ หรือแม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วก็สามารถตรวจได้ ซึ่งการตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์พบความผิดปกติที่แม้จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่ก็ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการดูแลและประคับประคองอาการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การตรวจพันธุกรรมยังช่วยให้บุคคลในครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงที่จะมีการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว

เรื่องที่ 4 การรักษาโรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ เพียงแต่เป็นการรักษาตามอาการหรือการรักษาแบบประคับประคอง แต่ในปัจจุบันมีความพยายามศึกษาค้นคว้าวิธีการรักษาโรคทางพันธุกรรมอย่างต่อเนื่อง



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

กิจกรรม คนตาบอดสีจะมีผลกระทบในชีวิตประจำวันอย่างไร และสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ ?



เนื้อหาสาระ

การรักษาโรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรมเกิดขึ้นจากสารพันธุกรรมที่เป็นต้นกำเนิดของเซลล์ในร่างกาย จึงทำให้โรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงรักษาตามอาการ หรือประคับประคองสุขภาพของผู้ป่วยให้สมบูรณ์มากที่สุด ได้แก่

1. การรักษาตามอาการ เป็นการใช้ยาตามอาการที่เกิดขึ้น เช่น ยาที่ช่วยควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ยากันชัก ยารักษาความผิดปกติของเม็ดเลือด ยารักษาภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ยากดภูมิคุ้มกัน และยาเคมีบำบัด

2. การบำบัด เช่น กายภาพบำบัด การบำบัดการพูด กิจกรรมบำบัด การแนะนำสถานศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

3. การวางแผนโภชนาการ และการใช้วิตามินเสริม

4. การรักษาอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนถ่ายเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การฉายรังสีรักษามะเร็ง และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะ

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมจำเป็นต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามอาการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

ในปัจจุบันมีการรักษาแบบใหม่ที่เรียกว่า การรักษาด้วยวิธียีนบำบัด (Gene Therapy) ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงยีนของผู้ป่วย ทำให้ความผิดปกติลดลงหรือหมดไปได้ แต่การรักษาดังกล่าวก็ยังไม่มีผลยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย

เรื่องที่ 5 การป้องกันโรคทางพันธุกรรม

โรคทางพันธุกรรม ถึงแม้จะยังไม่วิธีการรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ ซึ่งหากครอบครัวได้มีการตรวจสอบความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมแล้ว จะสามารถหาทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวกับลูกที่จะเกิดมาได้



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันโรคทางพันธุกรรม



เนื้อหาสาระ

การป้องกันโรคทางพันธุกรรม

การป้องกันโรคทางพันธุกรรม สามารถทำได้หลายแนวทาง โดยเน้นการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางหลัก ๆ ได้แก่

1. การให้ความรู้และคำปรึกษาทางพันธุกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่อาจถ่ายทอดในครอบครัว ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมก่อนวางแผนมีบุตร

2. การตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม ตรวจหายีนที่อาจก่อให้เกิดโรคในพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ตรวจคัดกรองทารกในครรภ์ เช่น การตรวจน้ำคร่ำ หรือ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)

3. การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ร่วมกับการตรวจคัดกรองตัวอ่อนก่อนฝัง (PGT) คัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อนำไปฝังในครรภ์

4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงสารพิษที่อาจกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ เช่น ควันบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเคมี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ

5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรม การพัฒนาแนวทางรักษา เช่น การบำบัดด้วยยีน (Gene Therapy) การใช้ CRISPR ในการแก้ไขยีนที่มีความผิดปกติ

6. การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมโครงการตรวจคัดกรองพันธุกรรมในระดับประเทศ สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม

แนวทางเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางพันธุกรรมและเพิ่มโอกาสในการมีบุตรที่แข็งแรง

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 4 โรคทางพันธุกรรม

เรื่องที่ 1 ความหมายของโรค และประเภทของโรคทางพันธุกรรม



กิจกรรม

โรคทางพันธุกรรม คือ โรคหรือความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติของยีนซึ่งเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรม โดยมีทั้งโรคที่สามารถ ถ่ายทอดได้ และ ไม่ถ่ายทอด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ที่มีความต่างกันดังนี้

1. โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน เมื่อยีนถูกถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานจึงทำให้เกิดความผิดปกติหรือส่งต่อการเป็นพาหะให้กับลูกหลานได้

2. โรคทางพันธุกรรมที่ไม่ถ่ายทอด คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนไม่ได้มาจากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน แต่มาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นเอง โดยมีความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติ

เรื่องที่ 2 โรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย



กิจกรรมที่ 1

1. โรคดาวน์ซินโดรม ลักษณะของเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมนั้นจะมีศีรษะเล็กตาเฉียงขึ้น ดั้งจมูกแบน

2. โรคตาบอดสี อาการของผู้ที่เป็นโรคนี้ คือ จะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีเขียวกับสีแดง หรือสีน้ำเงินกับสีเหลืองได้

3. โรคธาลัสซีเมีย จะคล้ายกับเด็กที่มีภาวะโลหิตจาง เช่น ผิวซีด ผิวเหลือง เหนื่อยง่าย การเจริญเติบโตช้า เป็นต้น



กิจกรรมที่ 2

โรคทางพันธุกรรม ที่พบได้บ่อย

โรค : ดาวน์ซินโดรม

สาเหตุ : เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาทั้งอันหรือบางส่วน

อาการ : มีโครงสร้างทางใบหน้าที่โดดเด่นชัดเจน เช่น หน้าแบน หัวเล็ก หูเล็ก ตาเรียว หางตาเฉียงขึ้น มีจุดสีขาวอยู่ที่ตาดำ คอสั้น แขนขาสั้น ตัวเตี้ยกว่าคนในวัยเดียวกันเมื่อโตขึ้น นิ้วสั้น มือสั้น เท้าสั้น ฯลฯ

การป้องกันโรค : ปัจจุบันมีการเจาะเลือดแม่เพื่อตรวจโครโมโซมได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป หากคุณแม่กังวลกับกับปัจจัยเสี่ยงที่ว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรม ควรปรึกษาแพทย์หากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร

เรื่องที่ 3 การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนจับคู่ข้อความทางด้านซ้ายและขวาให้ตรงกัน โดยนำตัวอักษรมาไว้หน้าข้อที่ตรงกัน

.....ง.....	1. การตรวจเพื่อหาระบุความผิดปกติของของยีนในร่างกาย	ก. โรคทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
.....ค.....	2. การตรวจนับและดูการทำงานของระดับโปรตีนภายในสารพันธุกรรม	ข. การตรวจสารพันธุกรรม
.....ข.....	3. การตรวจลักษณะของยีน หรือ DNA	ค. การตรวจโครโมโซม
.....ก.....	4. การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมโดยการตรวจประวัติครอบครัวและการตรวจทางพันธุกรรม	ง. การตรวจพันธุกรรม

เรื่องที่ 4 การรักษาโรคทางพันธุกรรม



กิจกรรม

ตาบอดสีกับผลกระทบในชีวิตประจำวัน

ผู้ป่วยตาบอดสีอาจมองเห็นสีผิดเพี้ยนไปบ้าง ซึ่งอาจเกิดความยุ่งยากในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกสีของสิ่งของ ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีอาจจะมองไม่เห็นหรือจำแนกสีหนึ่งออกจากอีกสีได้ยาก เช่น สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลือง ทำให้สีที่เห็นผิดเพี้ยนไป

1. วัยเด็ก-วัยเรียน มีผลกระทบต่อเรื่องของการเรียนศิลปะ การประเมินพัฒนาการด้านภาษาและพัฒนาการในการเรียนรู้

2. งานที่ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ งานด้านเคมี จิตรกร นักบิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่ต้องมีการใช้สีเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสิ่งต่าง ๆ

3. ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีสามารถสอบใบขับขี่ได้ หากสามารถบอกความแตกต่างของสัญญาณไฟจราจรได้อย่างถูกต้อง และผ่านเกณฑ์ประเมินอื่น ๆ

เรื่องที่ 5 การป้องกันโรคทางพันธุกรรม



กิจกรรม

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และต้องการมีบุตร ควรทำการตรวจทางพันธุกรรมเพิ่มเติมด้วยวิธีการตรวจขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ โดยวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจทางพันธุกรรม ได้แก่ การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจโครโมโซม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และพ่อแม่ทราบถึงความผิดปกติของทารกที่จะเกิดมาได้

บทที่ 5
การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21

สาระสำคัญ

ในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมทุกระดับอย่างทั่วถึง การพัฒนาสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมาก ทั้งความฉลาดด้านสุขภาพ และความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีสุขภาวะดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะได้
2. บอกความฉลาดด้านสุขภาพ และความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาวะได้
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีสุขภาวะที่ดีในฐานะพลเมืองโลก

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
เรื่องที่ 2 การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
- 2.1 ความฉลาดด้านสุขภาพ
- 2.2 ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 3 สุขภาวะดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะ

ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเราในหลายด้าน และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึง เทคโนโลยีและการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เราต้องเผชิญและตอบสนอง เพื่อรักษาและส่งเสริมสุขภาวะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว





ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเราอย่างไร และเราจะมีวิธีการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรบ้าง

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมการเรียนรู้แบบอภิปราย (Discussion-Based Learning)

- **คำถาม**: 1) เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราอย่างไร
  2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร
- ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น เทคโนโลยี วิถีชีวิต หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อสรุปของกลุ่มตนเอง



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)

- **วิเคราะห์กรณีศึกษา**: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบและวิธีการตอบสนอง และอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาและเสนอแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ



กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Hands-On Activities)

- **การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)**: ให้ผู้เรียนสร้างแผนที่ความคิดเพื่อเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับผลกระทบต่อสุขภาวะ ให้ผู้เรียนอภิปรายนำเสนอหน้าชั้นเรียน



เนื้อหาสาระ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้คนในหลายด้าน ทั้งในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลดีและผลเสียที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร

1.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกและทันที ส่งผลให้การทำงานและการดำรงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น

1.2 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์มากเกินไปส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ เช่น โรคเกี่ยวกับสายตา การนั่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคกระดูกและข้อ รวมถึงภาวะทางจิตใจ เช่น การเครียดจากการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา



2. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ

2.1 มลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 และมลพิษจากโรงงานและการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคผิวหนัง และโรคหัวใจ

2.2 มลพิษทางสิ่งแวดล้อมในเมืองทำให้มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง



3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมและการย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทสู่อุตสาหกรรมเมือง ทำให้เกิดความเครียดจากการทำงานและการขาดการออกกำลังกาย

3.2 ความแออัดในเมืองและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอาจนำไปสู่โรคที่เกี่ยวกับการขาดการดูแลสุขภาพ เช่น โรคกระเพาะอาหาร ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และโรคอุบัติใหม่จากการแพร่ระบาด

4. การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและพฤติกรรม

4.1 ผู้คนในสังคมศตวรรษที่ 21 มักใช้เวลามากในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสาร ส่งผลให้ขาดการออกกำลังกายและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและการมีชีวิตที่สมดุล

4.2 การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้เกิด "สังคมก้มหน้า" ซึ่งไม่เพียงแค่ลดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แต่ยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5. ปัญหาสุขภาพจิต

5.1 การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลทำให้เกิดภาวะเครียดจากการทำงานที่ไม่หยุดหย่อนและการเชื่อมต่อที่ไม่สมดุล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์

5.2 ความรู้สึกโดดเดี่ยวและการขาดการสนับสนุนจากการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล

ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีทั้งผลดีและผลเสียต่อสุขภาวะ โดยเฉพาะในด้านมลพิษและการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น การพัฒนาสุขภาวะที่ดีในยุคนี้จึงต้องมีการสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและมีสุขภาพที่ดี.

เรื่องที่ 2 การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ หมายถึง การเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะจึงจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทักษะและความรู้จากหลายด้าน เพื่อให้ผู้คนรับมือและสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพที่ดีทั้งในระดับบุคคลและสังคม ซึ่งการบูรณาการทักษะเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว





ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสุขภาวะของคุณอย่างไร และมีวิธีการใดบ้างที่สามารถทำเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

กิจกรรม “สุขภาพดี...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

1. อภิปรายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ วิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหารที่ปลูกแบบออร์แกนิก ซึ่งเป็นการผลิตที่ยึดหลักธรรมชาติโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือการลดการใช้พลาสติกมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
2. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการค้นคว้าวิธีการลดการปล่อยมลพิษ การใช้พลังงานสะอาด หรือเลือกใช้พลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรม “การทำอาหารเพื่อสุขภาพ”

1. การอธิบายความสำคัญของการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกอาหารจากแหล่งที่ยั่งยืนหรือการลดการใช้พลาสติก
2. จัดเวิร์คชอปการทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน เช่น อาหารออร์แกนิกหรืออาหารที่ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
3. หลังจากการทำอาหาร ให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม



เนื้อหาสาระ

ความฉลาด สามารถสร้างให้เกิดการยอมรับ การชื่นชม การยกย่องและความไว้วางใจจากบุคคลอื่น อันเป็นการให้คุณค่าและโอกาสกับบุคคล ความฉลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต่างแสวงหาและคนส่วนใหญ่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปูพื้นฐานสำหรับตนเองในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในชีวิต การงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งการอยู่รอดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

สิ่งสะท้อนถึงความฉลาดมีมากมายหลายประการ อาทิ การอ่านหนังสือ ความสามารถในการจำ ความคิด ความรู้ ทักษะชีวิต การใช้ชีวิต การประสบความสำเร็จ ฯลฯ อย่างไรก็ตามปัจจัยพื้นฐานสำคัญของความฉลาด คือ การอ่านหนังสือได้หรือการรู้หนังสือ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือหรือการรู้หนังสือ กล่าวกันว่าการรู้หนังสือ (literacy) เป็นความสามารถในการอ่าน เขียน พูดภาษาหลัก การคำนวณและคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตและการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของตัวเองและสามารถพัฒนาตนเองได้ การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ คือ ความฉลาดด้านสุขภาพและความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 ความฉลาดด้านสุขภาพ



ความฉลาดด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี การที่จะมีความฉลาดทางสุขภาพได้ คน ๆ นั้นจะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูล รู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเข้าถึงซึ่งแหล่งความรู้หรือการได้มาซึ่งความรู้ด้านสุขภาพ

2) การมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และเป็นปัจจุบัน

3) การโต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด อ่าน เขียน รวมทั้งสื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจมาสื่อสารแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่ม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินก่อนที่จะตัดสินใจ

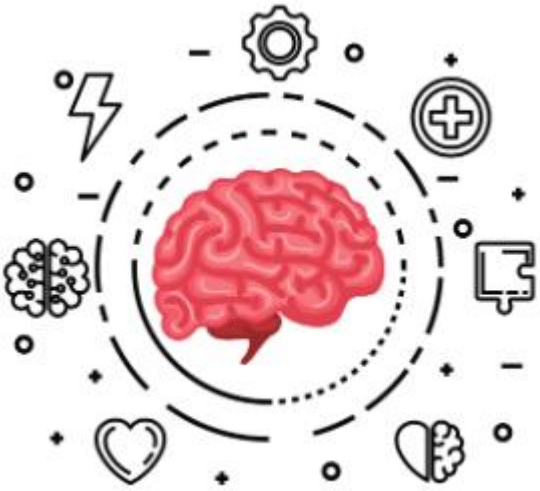
4) การตัดสินใจ ความสามารถในการกำหนดทางเลือกและปฏิเสธ หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ โดยมีการใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี ผลเสียเพื่อการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง พร้อมแสดงทางเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

5) การลงมือปฏิบัติ ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

6) การบอกต่อ ความสามารถในการชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นและสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสุขภาพที่สื่อนำเสนอเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี

จะเห็นได้ว่า ความฉลาดทางสุขภาพเป็นต้นทุนชีวิตที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิต โดยสามารถเริ่มได้ที่ตัวเองและขยายไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อยกระดับการมีสุขภาพดีของสังคมไทยต่อไป

ระดับความฉลาดทางสุขภาพ จำแนกเป็น 4 ระดับ





ระดับความฉลาดทางสุขภาพ	รายละเอียด
ระดับ 1	ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่จำเป็นต่อความเข้าใจและการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นความสามารถในการประยุกต์ทักษะด้านการอ่านและความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข อาทิ การอ่านใบยินยอม ฉลากยา การเขียนข้อมูลการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อรูปแบบ การให้ข้อมูลทั้งข้อความเขียนและวาจาจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ ได้แก่ การรับประทานยากำหนดการนัดหมาย
ระดับ 2	ความฉลาดทางสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ ทักษะพื้นฐานและการมีพุทธิปัญญารวมทั้งทักษะทางสังคมที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร แยกแยะลักษณะการสื่อสารที่แตกต่างกัน รวมทั้งประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับ 3	**ความฉลาดทางสุขภาพขั้นวิจารณญาณ** ได้แก่ ทักษะทางปัญญาและสังคมที่สูงขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและควบคุมจัดการสถานการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ความฉลาดทางสุขภาพระดับวิจารณญาณเน้นการกระทำของปัจเจกบุคคล (individual action) และการมีส่วนร่วมผลักดันสังคม การเมืองไปพร้อมกัน จึงเป็นการเชื่อมประโยชน์ของบุคคลกับสังคมและสุขภาพของประชาชนทั่วไป
ระดับ 4	**การรู้เท่าทันสื่อ** ได้แก่ สภาวะที่เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ความหมายของ เนื้อความ ประเมินคุณค่าและเจตนาที่สื่อนำเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ

ความฉลาดทางสุขภาพ เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิวัฒนาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะสภาวะโรคภัยไข้เจ็บ มีการเปลี่ยนแปลงไปกับยุคสมัย ดังนั้น การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพอยู่เสมอจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้เป็นคนทันโลกและทันโรค โดยอาศัย

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เมื่อบุคคลมีความฉลาดทางสุขภาพจะมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อีกด้วย

2.2 ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม



โลกปัจจุบันประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลายประการ การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องปรับเปลี่ยนระบบคิดของคนในสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกความรับผิดชอบที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเด็ก

ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Intelligence) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงการกระทำต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงการปฏิบัติตนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นชีวิตสีเขียว (Green life) ซึ่งทุกคนสามารถสร้างระบบคิดด้านสิ่งแวดล้อม (environmental thinking) ให้มีความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ยาก โดยเริ่มต้นจากพฤติกรรมสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. ลดการสร้างขยะและมลพิษในชีวิตประจำวัน
3. ทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยการไม่ทำลาย
4. ชักนำบุคคลอื่นให้รักษาสิ่งแวดล้อม
5. ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับบุคคลรอบข้าง
6. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม
7. เป็นตัวแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนและชุมชน

สรุปได้ว่า ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรต้องตระหนักและมีจิตสำนึกให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันปลูกฝัง เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้คนในสังคมมีจิตใจรักสิ่งแวดล้อม (Environmental mind) อย่างฝังรากลึกและเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติต่อไป

เรื่องที่ 3 สุขภาวะดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

การพัฒนาสุขภาวะที่ดีเพื่อเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลพร้อมกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้แต่ละคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี แต่ยังช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรสำหรับทุกคนด้วย

แนวคิดหลักในการเป็นพลเมืองโลกที่ดีในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรู้และการศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น การสร้างสุขภาวะดีและการเป็นพลเมืองโลกที่รับผิดชอบในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ





ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนคิดว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองมีผลต่อการเป็นพลเมืองโลกอย่างไร? และการรักษาสุขภาพที่ดีสามารถช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร?

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

กิจกรรม “การพัฒนาสุขภาวะเพื่อพลเมืองโลก”

ผู้เรียนร่วมกันสร้างแผนการหรือโปรแกรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในการส่งเสริมสุขภาวะและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงระหว่างสุขภาวะส่วนบุคคลและบทบาทของพลเมืองโลก เช่น การดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ให้ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ หรือการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และให้ผู้เรียนสะท้อนถึงประสบการณ์และผลกระทบที่มีต่อสุขภาวะของตนเองและสิ่งแวดล้อม







เนื้อหาสาระ

ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เช่น

1. การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการทำงาน การศึกษา การสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวัน

2. การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำธุรกิจและวัฒนธรรมทางออนไลน์ ตลอดจนความเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงการเมือง การต่อสู้สิทธิและความเท่าเทียม และการให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคนแต่ละช่วงวัย

3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การสื่อสารและการคมนาคมที่ดีขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเร่งการสร้างงานและการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน

4. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เกิดการเสื่อมสภาพทางสิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องให้ดำเนินการในเรื่องของการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียของชีวิตทางทะเล การเสื่อมสภาพของชีวิตทางธรรมชาติและความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาในยุคปัจจุบัน

โลกศตวรรษที่ 21 เป็นโลกดิจิทัล เทคโนโลยีกลายเป็นวัตถุดิบหนึ่งของการพัฒนาเสมอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษา เป็นต้น เมื่อโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว คนเราจะต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและก้าวทันโลกดิจิทัลด้วยการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นประกอบด้วย

1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
2. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
3. ทักษะการสื่อสาร
4. ทักษะการทำงานเป็นทีม

ปัจจุบันนี้แม้ว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวในเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและประชาชนมีความรู้มากขึ้น แต่มักพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือพฤติกรรมทำลายสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ป้องกันได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเครียด โรคซึมเศร้า ฯลฯ พฤติกรรมการกินไม่ถูกต้อง ไม่ใส่ใจในการออกกำลังกาย หรือไม่ใส่ใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่ ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การเดินทาง รวมทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจ ทำให้เกิดความเครียดไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หากไม่มีการจัดการใด ๆ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถ้าหากเรามีความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตจะทำให้เราสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัย แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติและมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน ตลอดจนสามารถควบคุม

อารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ย่อมมีผลมาจาก**สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางสติปัญญา**ที่ดี จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วย สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข



แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 5 การพัฒนาสุขภาวะในศตวรรษที่ 21

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อสุขภาวะ



กิจกรรมที่ 1

แนวคำตอบ เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรา ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะในหลายด้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สมาร์ตโฟนและโซเชียลมีเดีย ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว แต่การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียดและภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดปัญหาด้านร่างกาย เช่น ปวดหลังและปัญหาสายตา

แนวคำตอบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อสุขภาพของเรา ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น เช่น คลื่นความร้อนและน้ำท่วม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมอุตสาหกรรมก็เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ เช่น โรคทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ้



กิจกรรมที่ 2

แนวคำตอบ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีวิธีการตอบสนอง ดังนี้

การแพร่ระบาดของโรคใหม่ ๆ เช่น COVID-19 มีผลกระทบสำคัญต่อสุขภาวะทั่วโลก นอกจากผลกระทบทางกายภาพจากการติดเชื้อแล้ว ยังมีผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากการแยกตัวทางสังคมและความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางไกล (telemedicine) ก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด

วิธีการตอบสนองต่อผลกระทบ

1. การสนับสนุนด้านสุขภาพกาย ได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์ การสนับสนุนวัคซีน
2. การสนับสนุนด้านสุขภาพจิต ได้แก่ การให้คำปรึกษาและการบำบัด การส่งเสริมกิจกรรมผ่อนคลาย สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด
3. การปรับวิถีชีวิต ได้แก่ การสนับสนุนการทำงานจากที่บ้าน การพัฒนาทักษะใหม่ เช่น สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ผ่านการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน
4. การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การสนับสนุนธุรกิจและการจ้างงาน การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
5. การปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้แก่ การวางแผนฉุกเฉิน การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Hands-On Activities)

- **การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)**
  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับผลกระทบต่อสุขภาวะ



เรื่องที่ 2 การพัฒนาความฉลาดในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรม “สุขภาพดี...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

สุขภาพของมนุษย์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว การเปลี่ยนแปลง หรือการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น มลพิษทางอากาศและน้ำ สามารถทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจและระบบทางเดินน้ำดีได้ นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมยังรวมถึงปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพด้วย

วิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การลดการปล่อยมลพิษ ใช้พลังงานสะอาด เลือกใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้รถสาธารณะ รถจักรยาน หรือเดินแทนเพื่อลดมลพิษทางอากาศ



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรม “การทำอาหารเพื่อสุขภาพ”

การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเรา การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย นี่คือเหตุผลสำคัญในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ

เหตุผลสำคัญในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงโรค อาหารสุขภาพช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็น เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และใยอาหาร ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

เรื่องที่ 3 สุขภาวะดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21



กิจกรรมที่ 1

กิจกรรม “การพัฒนาสุขภาวะเพื่อพลเมืองโลก”

บทบาทของพลเมืองโลกในการดูแลสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างมาก

ดูแลสุขภาพ: พลเมืองต้องตระหนักถึงสิทธิและบทบาทในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษ เพื่อสร้างชุมชนยั่งยืน

พลเมืองอาหาร: การเลือกอาหารที่มีสุขภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและระบบอาหาร



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

1) รีไซเคิลและใช้ซ้ำ : นำขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ หรือใช้กระดาษทั้งสองด้านก่อนทิ้ง
2) ปลูกต้นไม้ : ช่วยฟอกอากาศและสร้างบรรยากาศที่สดชื่น
3) แยกขยะ : แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลและลดขยะที่ต้องกำจัด
4) ใช้ถุงผ้า : เลือกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดขยะ
5) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ : ดูแลไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและฟื้นฟูสิ่งที่สูญเสียไป

บทที่ 6
ความหลากหลายทางเพศ

สาระสำคัญ

เพราะโลกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศชายและหญิง แต่ในปัจจุบันยังประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มี “ความหลากหลายทางเพศ” หรือ “LGBTQ+” ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ การเรียนรู้อย่างเข้าใจจะนำไปสู่การเปิดกว้างและการยอมรับ ส่งผลให้เกิดความเสมอภาคทางเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนบนความหลากหลายทางเพศตามมติของสหประชาชาติภายในปี ค.ศ. 2030

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. สามารถอธิบายและมีความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ +)
2. บอกแนวทางการอยู่ร่วมกับบุคลลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
เรื่องที่ 2 แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ

เรื่องที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

ความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หมายถึง การยอมรับและเข้าใจว่ามีความหลากหลายในเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ ไม่ได้มีแค่เพียงชายหรือหญิงเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือที่มีเพศสภาพไม่ชัดเจน เช่น LGBTQ+ (เลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, คนข้ามเพศ, คนเควียร์ และอื่นๆ)

การอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติในบริบทของความหลากหลายทางเพศนั้นสำคัญมาก เนื่องจากทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติรวมถึงการเคารพในสิทธิของผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ หรือดูถูกเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศของใครคนใดคนหนึ่ง



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

เรารู้จักความหมายของความหลากหลายทางเพศอย่างไร และหากในชุมชนของเรามีบุคคลที่มีเพศสภาพ เป็น LGBTQ+ เราจะปฏิบัติอย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมทางเพศของ LGBTQ+ ว่ามีลักษณะหรือพฤติกรรมทางเพศอย่างไร มาพอสังเขป







เนื้อหาสาระ

ความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ

ความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หมายถึง การยอมรับและเข้าใจว่ามีความหลากหลายในเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของมนุษย์ ไม่ได้มีแค่เพียงชายหรือหญิงเท่านั้น แต่ยังมีผู้ที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดหรือที่มีเพศสภาพไม่ชัดเจน เช่น LGBTQ+ (เลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, คนข้ามเพศ, คนเควียร์ และอื่น ๆ)

ในความเป็นจริงโลกนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศชายและหญิงเท่านั้น “LGBTQ” จึงกลายเป็นคำที่ใช้เรียกตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเริ่มใช้จากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและนักสิทธิมนุษยชนในสหรัฐ ตั้งแต่ช่วงกลางยุค 80 ในระยะแรกนั้นมีตัวย่อเพียง 4 ตัว คือ LGBT แต่เมื่อมีเพศวิถีที่หลากหลายมากขึ้นจึงมีการเติมตัวอักษรต่าง ๆ และเครื่องหมายบวกเข้ามาภายหลัง เช่น LGBTQ+, LGBTQIA+ เป็นต้น โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ หรือ ICD ฉบับล่าสุด โดยย้ายหัวข้อ “การมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด” ออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม และย้ายไปอยู่ในหมวด “กรณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ” เพราะการมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดนั้นไม่ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต



ภาพ ทำความเข้าใจ LGBTQ+ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2566)

ความหมายของอักษรย่อ LGBTQ+

L (Lesbian)	คือ	ผู้หญิงที่มีรสนิยมชอบผู้หญิง
G (Gay)	คือ	ผู้ชายที่มีรสนิยมชอบผู้ชาย หรืออาจกล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน (homosexual)
B (Bisexual)	คือ	คนที่มีรสนิยมสามารถชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
T (Transgender)	คือ	บุคคลข้ามเพศ การเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตนไปเป็นเพศตรงข้าม อาจเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศมาจากผู้ชาย หรือผู้ชายที่ข้ามเพศมาจากผู้หญิง
Q (Queer/Questioning)	คือ	คนที่ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องมีรสนิยมชอบเพศไหน หรือกำลังตามหาตัวตน
+	คือ	ความหลากหลายทางเพศด้านอื่น ๆ เช่น
● **I (Intersex)**	คือ	กลุ่มคนที่มีสองเพศ (ในทางการแพทย์) ทั้งโครโมโซมและอวัยวะเพศ
● **A (Asexual)**	คือ	กลุ่มคนที่ไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศกับผู้อื่น

นอกจากนี้ความหลากหลายทางเพศยังสามารถอธิบายตามความหมายของรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศได้ ดังนี้

รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) คือ ความรู้สึก รสนิยมทางเพศ รวมถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่

➢ รักต่างเพศ คือ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้าม หรือบุคคลต่างเพศ เช่น ผู้ชายที่ชอบผู้หญิง หรือผู้หญิงที่ชอบผู้ชาย

➢ รักเพศเดียวกัน คือ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ เลสเบี้ยน (Lesbian) และเกย์ (Gay)

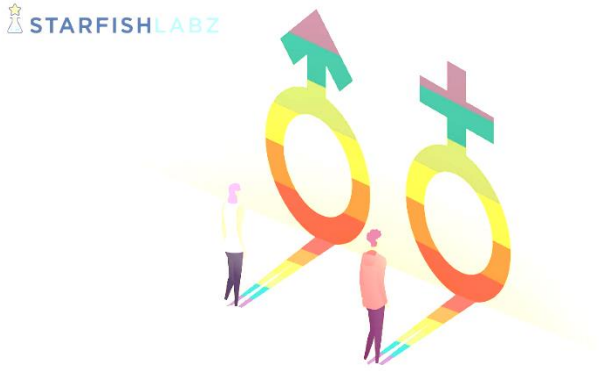
➢ ไบเซ็กชวล (Bisexual) คือ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยจะมีอารมณ์เสน่หากับเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกันก็ได้

➢ ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ ผู้ที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เพียงรู้สึกสนิทสนม ผูกพันกับบุคคลอื่น

อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) ความรู้สึกภายในของบุคคลในการเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศสถานะอื่น ๆ หรือการมีหรือไม่มีเพศสถานะก็ได้ ซึ่งทุกคนล้วนมีอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด (sex assigned at birth)

การเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หากผู้เรียนและคนในสังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถหลีกเลี่ยงการใช้คำที่มีความหมายเชิงลบในเชิงเหยียดต่อรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศต่อบุคคลอื่นซึ่งเป็นคำที่ไม่ควรนำมาใช้เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกเพศอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของทุกคนในสังคม ตัวอย่างคำที่ไม่ควรใช้ คือ คนเบี่ยงเบนทางเพศ รักร่วมเพศ สาวประเภทสอง สายเหลือง ไส้เดือน แต๋ว เก้ง กวาง ขุดทอง เป็นต้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ



ภาพ โลกนี้ไม่ได้มีแค่ชายหญิง
ที่มา: สตาร์ฟิช อะคาเดมี (2566)

เพศสถานะสอดคล้อง (Cis/cisgender)

คำที่ถูกใช้ในการอธิบายบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด ซึ่งเป็นคำที่ตรงกันข้ามกับบุคคลข้ามเพศ (trans/transgender)

เพศสภาพ (Gender)

เพศที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่ให้เมื่อร่างกายเกิดมาเป็นหญิง หรือเกิดมาเป็นชาย โดยสังคมและวัฒนธรรมได้หล่อหลอมบทบาทหน้าที่ของความเป็นหญิงและความเป็นชายไว้แตกต่างกัน

การแสดงออกทางเพศ (Gender Expression)

การที่บุคคลมีวิธีในการสื่อสารเพศสถานะ เช่น การไม่ระบุความเป็นเพศ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง ซึ่งกระทำผ่านลักษณะทางกายภาพ เช่น เสื้อผ้า ทรงผม และการใช้เครื่องสำอาง เป็นต้น มารยาท วิธีการพูด และรูปแบบพฤติกรรมเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)

ความรู้สึกภายในของบุคคลในการเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศสถานะอื่น ๆ หรือการมีหรือไม่มีเพศสถานะก็ได้ ซึ่งทุกคนล้วนมีอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด (sex assigned at birth)

คำระบุเพศสถานะ (Gender Marker)

การที่บุคคลถูกบันทึกว่าเป็นเพศสถานะอะไรในเอกสารทางการ ในประเทศไทยถูกกำหนดให้มีผู้ชาย ผู้หญิง และยังหมายรวมถึงคำนำหน้านาม ได้แก่ นาย นาง และนางสาว

เพศกำกวม/ลักษณะของเพศสรีระ (Intersex/Sex Characteristics)

บุคคลที่มีเพศกำกวมเกิดมาโดยมีลักษณะของเพศสรีระ เช่น อวัยวะเพศ ต่อมบ่งเพศ และรูปแบบโครโมโซม ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบเพศแบบขั้วตรงข้าม คือ เพศชายและเพศหญิง คำว่า เพศกำกวม จึงหมายรวมถึงความผันแปรของร่างกายในลักษณะต่าง ๆ ในบางกรณีลักษณะของเพศกำกวมจะมองเห็นได้เมื่อแรกเกิด หรืออาจไม่เห็นจนกว่าจะย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือบางส่วนก็ไม่แสดงให้เห็นทางกายภาพ มีเพียงโครโมโซมที่ผันแปร การเป็นเพศกำกวมจึงเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของเพศสรีระ (sex/sex characteristics) ซึ่งอาจต่างไปจากวิถีทางเพศ (sexual orientation) หรืออัตลักษณ์ทางเพศสถานะก็ได้ บางคนอาจเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ เลสเบี้ยน คนรักสองเพศหรือคนไม่มีเพศก็ได้เช่นกัน

ไม่อยู่ในระบบเพศขั้วตรงข้าม (Non-binary)

คำที่ใช้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งไม่ใช่เพียงความเป็นชายหรือความเป็นหญิงเท่านั้น

เพศสรีระ (Sex/Sex Characteristics)

คำที่อ้างถึงลักษณะทางชีววิทยาที่ใช้แบ่งแยกคนว่าเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง

เพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด (Sex assigned at birth)

เพศสรีระที่บุคคลถูกกำหนดให้เมื่อแรกเกิดหรือหลังจากเกิดได้ไม่นาน การกำหนดนี้อาจไม่ได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศเมื่อบุคคลนั้นเติบโต คนส่วนมากมักมีอัตลักษณ์ทางเพศที่สอดคล้องไปกับเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด แต่สำหรับบุคคลข้ามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศมีความแตกต่างจากเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด

วิถีทางเพศ (Sexual Orientation)

คำที่อ้างถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความดึงดูดทางเพศลึกซึ้งใกล้ชิด รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่น ซึ่งคนเราอาจดึงดูดทางเพศกับคนที่มีเพศสถานะเดียวกัน (คนรักเพศเดียวกัน เกย์ เลสเบี้ยน) หรือคนต่างเพศสถานะ (คนรักต่างเพศ) หรืออาจมากกว่าหนึ่งเพศสถานะก็ได้เช่นกัน (คนรักสองเพศหรือรักได้ทุกเพศ)

บุคคลข้ามเพศ (Trans/transgender)

คำที่ใช้อธิบายบุคคลซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างไปจากเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิด

ผู้ชายข้ามเพศ (Transgender man)

คำที่ใช้อธิบายบุคคลข้ามเพศที่นิยามตนเองเป็นผู้ชาย กล่าวคือ บุคคลที่มีเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศหญิงหรืออื่น ๆ แต่นิยามว่าตนเป็นเพศชาย

ผู้หญิงข้ามเพศ (Transgender woman)

คำที่ใช้อธิบายบุคคลข้ามเพศที่นิยามตนเองเป็นผู้หญิง กล่าวคือ บุคคลที่มีเพศที่ถูกกำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศชายหรืออื่น ๆ แต่นิยามว่าตนเป็นเพศหญิง

เมื่อศึกษาคำนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเราจะเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายทางเพศที่มีอยู่มากมาย หากเป็นยุคก่อนสิ่งเหล่านี้อาจถูกมองว่าผิดปกติ แต่เมื่อวิวัฒนาการต่าง ๆ ก้าวหน้ามากขึ้น ก็ทำให้ค้นพบว่าธรรมชาติของมนุษย์หลากหลายเกินกว่าจะจำกัดอยู่แค่ชายและหญิง การศึกษาจาก Census Data พบว่ามีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันถึง 46,770 ราย เฉพาะในประเทศออสเตรเลียโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2006 ถึง 83% แม้จำนวนคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศจะเพิ่มขึ้นและดูเหมือนว่าสังคมเริ่มให้การยอมรับ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้และมองว่าความแตกต่าง คือ ความเจ็บป่วยหรือผิดปกติ ซึ่งหากพิจารณาอย่างเปิดใจ ทุกคนในโลก มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตของตนเองได้ตราบเท่าที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเพศไหน อัตลักษณ์ทางเพศแบบใด ก็สามารถเลือกรูปแบบการใช้ชีวิต เลือกรูปแบบการแสดงออกของตนเองได้ และคนอื่นในสังคมก็ควรเคารพสิทธิ์ของพวกเขาในฐานะคนเท่ากัน

เรื่องที่ 2 แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ

ปัจจุบันมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสังคมก็พร้อมที่จะเปิดรับกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้การให้เกียรติ เคารพ และสร้างความเท่าเทียมในทุกคนไม่ว่าเพศใดก็ตาม จะเป็นการสร้างสังคมให้น่าอยู่ ด้วยแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

จากคำพูดที่ว่า : จงปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ ให้เกียรติและศักดิ์ศรีอย่างที่พึงปฏิบัติกับผู้อื่น อย่างที่ตนคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง ผู้เรียนคิดว่าคำกล่าวถูกต้องหรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่างไร



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ในชุมชนของเรามีประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย และมีความต่างในเรื่องของอายุและความเชื่อในเรื่องเพศ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มคนที่เรียกว่า เป็น LGBTQ+ อยู่ด้วย และยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ผู้เรียนมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้คนในชุมชนนั้นเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข



แนวทาง
การอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ



เนื้อหาสาระ

การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ควรที่จะให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในสังคม โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ เพราะความเสมอภาคถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติและไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่คาดเดาเกี่ยวกับเพศสภาพ (gender) หรือความสัมพันธ์ของบุคคลอื่น

2. เคารพในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ถามคำถามที่เป็นการละลาบละล้วงหรือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรถามผู้อื่นหรือคาดหวังว่าผู้อื่นจะไม่ถามตนเอง เช่น การถามเกี่ยวกับสรีระร่างกาย ความสัมพันธ์ ชีวิตทางเพศ หรือการรับบริการทางการแพทย์ หากคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะถามคำถามส่วนตัว ควรถามบุคคลนั้นก่อนว่าเขายินดีหรือไม่

3. อย่าคาดหมายว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนพร้อมที่จะพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ อย่าคาดหมายว่าบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนี้ หากต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมควรทำการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

4. เคารพในความเป็นส่วนตัว ไม่บอกผู้อื่นเกี่ยวกับเพศสภาพ รวมถึงสถานะของการเป็นบุคคลข้ามเพศของผู้อื่น สำหรับบุคคลข้ามเพศ (transgender) เมื่อเปลี่ยนผ่าน (transition) บุคคลนั้นจะนิยามตนเองโดยเพศที่บุคคลนั้นต้องการ เช่น เป็นชาย หรือเป็นหญิง ไม่ใช่บุคคลข้ามเพศ บุคคลบางบุคคลอาจต้องการการนิยามอื่น

5. เมื่อบุคคลปรารถนาให้ผู้อื่นคิดว่าตนมีเพศสภาพใด ก็ควรคิดและปฏิบัติต่อบุคคลนั้นตามเพศสภาพดังกล่าว

6. ใช้ชื่อและสรรพนามที่บุคคลนั้นต้องการ หากไม่แน่ใจ ควรถามด้วยความสุภาพ หากใช้ถ้อยคำผิด ควรแก้ไข ขอโทษและปล่อยผ่านไป ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่

7. เมื่อเขียนหรือกล่าวถึงบุคคลข้ามเพศ อย่าดูถูกอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นโดยเขียนเน้นชื่อหรือสรรพนามที่บุคคลนั้นต้องการด้วยวิธีการใด ๆ

8. ทำความเข้าใจว่าบุคคลข้ามเพศมีสิทธิที่จะใช้พื้นที่ที่เหมาะกับเพศที่บุคคลนั้นเลือก เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทั้งในขณะและหลังการเปลี่ยนผ่าน

9. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพให้เกียรติและศักดิ์ศรีอย่างที่พึงปฏิบัติกับผู้อื่น รวมถึงอย่างที่ตนคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเอง

หากทุกคนเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติใด ๆ แล้ว ก็จะนำไปสู่การยอมรับและให้เกียรติโดยจะแสดงออกด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสังคมจะน่าอยู่และเป็นที่พึงปรารถนาสำหรับคนทุกคนซึ่งเราสามารถสร้างได้

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 6 ความหลากหลายทางเพศ

เรื่องที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ



กิจกรรม

ความหมาย LGBTQ+ คือ

L (Lesbian)	คือ	ผู้หญิงที่มีรสนิยมชอบผู้หญิง
G (Gay)	คือ	ผู้ชายที่มีรสนิยมชอบผู้ชาย หรืออาจกล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน (homosexual)
B (Bisexaul)	คือ	คนที่มีรสนิยมสามารถชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
T (Transgender)	คือ	บุคคลข้ามเพศ การเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตนไปเป็นเพศตรงข้าม อาจเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศมาจากผู้ชาย หรือผู้ชายที่ข้ามเพศมาจากผู้หญิง
Q (Queer/Questioning)	คือ	คนที่ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องมีรสนิยมชอบเพศไหน หรือกำลังตามหาตัวตน
+	คือ	ความหลากหลายทางเพศด้านอื่น ๆ เช่น
I (Intersex)	คือ	กลุ่มคนที่มีสองเพศ (ในทางการแพทย์) ทั้งโครโมโซมและอวัยวะเพศ
A (Asexual)	คือ	กลุ่มคนที่ไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศกับผู้อื่น

เรื่องที่ 2 แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างให้เกียรติ



กิจกรรม

การให้คนในชุมชนได้ยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อาจมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. การให้ความรู้สร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ โดยให้ความเข้าใจในความหมายของความหลากหลายทางเพศ ธรรมชาติ และความตระหนักในสิทธิของแต่ละบุคคลในเลือกจะเป็นหรือไม่เป็น

2. การส่งเสริมความเท่าเทียม ปลูกฝังความคิดเรื่องความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความแตกต่างทางเพศ

3. การสร้างพื้นที่ปลอดภัย สนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศของตนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกดขี่หรือละเมิด

การสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างให้เกียรติและเคารพในความหลากหลายทางเพศจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุข

บทที่ 7
การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ

สาระสำคัญ



การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามหลักการจัดกิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน จะส่งผลดีต่อสุขภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายหลักการเสริมสร้างและดำรงสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้
2. อธิบายผลกระทบของปัญหาสุขภาพที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
3. วางแผน เสริมสร้างและดำรงสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 หลักการเสริมสร้างและดำรงสุขภาพของบุคคลและชุมชน
เรื่องที่ 2 ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เรื่องที่ 3 กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน

เรื่องที่ 1 หลักการเสริมสร้างและดำรงสุขภาพของบุคคลและชุมชน

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการในการเพิ่มความสามารถให้กับบุคคล ประชาชน เพื่อให้สามารถ ควบคุมปัจจัยกำหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้ ทั้งสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- การเสริมสร้างสุขภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการดำรงชีวิตประจำวันของบุคคลและชุมชน
- อะไรคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลในชุมชนของเรา

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านสื่อ

- ให้ผู้เรียนเลือกสื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น วิดีโอ หนังสือ บทความ
- ให้ผู้เรียนทำการศึกษาและสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากสื่อนั้น ๆ



เนื้อหาสาระ

1. ความหมายของสุขภาพ

มนุษย์เกิดมาย่อมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความสุขของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ ที่สำคัญคือ สภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ หรือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นั่นเอง เมื่อมนุษย์มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ จะทำให้มีความสามารถในการปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไร้ความกังวล ไม่มีความเครียด และไม่มีความขัดแย้งภายใน สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถกระทำตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีสมรรถภาพในการทำงาน ดังนั้น **ความหมายของคำว่า สุขภาพ (Health) ขององค์การอนามัยโลก คือ ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มิใช่เพียงความปราศจากโรคและความพิการเท่านั้น**

2. ความสำคัญของสุขภาพ

สุขภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะความสุขหรือความทุกข์ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสุขภาพเป็นสำคัญ ความสำคัญของสุขภาพสรุปได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

2.1 ความสำคัญต่อตนเอง บุคคลจะมีความสุขหรือความทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพเป็นสำคัญ หากมีสุขภาพกายดี คือ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนและมีสุขภาพจิตที่ดี คือ ไม่คิดอิจฉาริษยาหรืออาฆาตมาดร้ายต่อผู้อื่น ผู้นั้นย่อมมีแต่ความสุข ในทางตรงกันข้าม หากสุขภาพกายไม่ดี คือ ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นประจำ และมีสุขภาพจิตไม่ดี คือ จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีที่สิ้นสุด มีความริษยาอาฆาตมาดร้ายผู้อื่น ผู้นั้นจะมีแต่ความทุกข์ สุขภาพกายและจิตจะเสื่อมโทรมหาความสุขในชีวิตไม่ได้

2.2 ความสำคัญต่อครอบครัว สุขภาพมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้แก่ครอบครัว เพราะครอบครัวย่อมประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นพื้นฐานสำคัญ คือ พ่อ แม่ ลูก การที่พ่อแม่ลูกมีสุขภาพกายและจิตที่ดีย่อมทำให้ครอบครัวมีความสุข ในทางกลับกันหากสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวย่อมจะเกิดขึ้นได้

2.3 ความสำคัญต่อสังคม ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนมาก แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งปัญหาที่เกิดจากสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต อาจเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น โรคที่เกิดจากความอ้วนจนเกินไป โรคที่เกิดจากความเครียดเพราะสภาพปัญหาทางสังคม เป็นต้น



3. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพและจิตที่ดี

ผู้ที่มีสุขภาพที่ดีจะต้องมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คนที่มีสุขภาพกายดี หมายถึง คนที่มีร่างกาย ทั้งอวัยวะต่าง ๆ และระบบการทำงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปกติ

คนที่มีสุขภาพดีจะมีลักษณะ ดังนี้

1) มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคงและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
2) สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหนื่อยเร็ว
3) อวัยวะและระบบทุกส่วนของร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปกติ
4) อัตราการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม
5) ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และไม่มีโรคประจำตัว
6) สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และมีหน้าตาสดชื่นแจ่มใส

คนที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง คนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ สามารถควบคุมอารมณ์ ทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คนที่มีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะ ดังนี้

1) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน ที่ทำงาน เป็นต้น

2) มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดที่เป็นอิสระ กล้าตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ดื้อรั้นและพร้อมที่จะเผชิญกับผลที่จะตามมา

3) สามารถเผชิญกับความเป็นจริง โดยแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

4) สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงความโกรธ เกลียดหรือรัก เสียใจ ผิดหวัง จนมากเกินไป

5) รู้จักรักผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่รู้จัก ไม่ใช่รักแต่ตัวเอง มีความปรารถนาและยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขและประสบความสำเร็จ

6) มีความสุขในการทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่ย่อท้อและไม่เปลี่ยนงานบ่อย ๆ

7) มีความกระตือรือร้น มีความหวังในชีวิต สามารถทนรอคอยในสิ่งที่มุ่งหวังได้

8) มองโลกในแง่ดี ไม่หวาดระแวงและพอใจในสภาพของตนเองที่เป็นอยู่

9) มีอารมณ์ขัน หาความสุขได้จากทุกเรื่อง ไม่เครียดจนเกินไป สามารถพักผ่อนสมองและอารมณ์ได้เหมาะสมกับเวลาและโอกาส

10) รู้จักผ่อนคลายโดยการพักผ่อนในเวลา สถานที่และโอกาสที่เหมาะสม

4. หลักการดูแลรักษาสุขภาพและสุขภาพจิต

การที่บุคคลจะมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตดี และเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคมนั้น จะต้องมีความรู้และสามารถปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยได้อย่างถูกต้อง

หลักการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีดังนี้

4.1 มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี โดยการรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้สารอาหารครบถ้วน โดยควรรับประทานผลไม้และผักสดทุกวัน ดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว ไม่ควรดื่มน้ำชา กาแฟ หรือเสพสารเสพติดประเภทต่าง ๆ

4.2 รู้จักออกกำลังกายให้เหมาะสม การออกกำลังกายจะช่วยให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย จึงควรออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที การเลือกประเภทของการออกกำลังกายต้องคำนึงถึงสภาพร่างกาย วัย สถานที่และความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลด้วย

4.3 รู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายให้เหมาะสม แต่ละบุคคลจะมีภารกิจในการทำกิจกรรม เพื่อการดำรงชีวิตแตกต่างกันและระบบขับถ่ายจะขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายตามอวัยวะต่างๆ หากไม่ทำความสะอาดจะทำให้เกิดของเสียต่าง ๆ หมักหมมอยู่และเป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ทุกคนจึงควรทำความสะอาดร่างกาย โดยอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด

4.4 ขับถ่ายให้เหมาะสมและเป็นเวลา ทุกคนควรถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา วันละ 1 ครั้ง อย่ากลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ เพราะจะทำให้ของเสียหมักหมมและเป็นอันตรายต่อระบบขับถ่ายได้ เช่น อาจจะเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก โรคท้องผูก หรือโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ/เบาขัด เป็นต้น

4.5 พักผ่อนให้เพียงพอ การพักผ่อนจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย อวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีเวลาพักเพื่อจะเริ่มทำหน้าที่ในวันต่อไปอย่างสดชื่น นอกจากร่างกายจะได้พักผ่อนแล้วยังทำให้สมองได้พักผ่อนอีกด้วย

4.6 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในชีวิตประจำวันแต่ละบุคคลต้องพบปะกับผู้คนมากหน้า หลายตา ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียนและสถานที่ราชการต่าง ๆ การที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข บุคคลย่อมต้องเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถลดความขัดแย้งต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

4.7 ใช้บริการสุขภาพตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากเกิดเจ็บป่วย บุคคลต้องรู้จักใช้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ความเจ็บป่วยลุกลามมากยิ่งขึ้น นอกจากการใช้บริการทางสุขภาพเพื่อรักษาโรคแล้ว ยังสามารถใช้บริการทางสุขภาพเพื่อป้องกันโรคได้โดยการตรวจร่างกายเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย

เรื่องที่ 2 ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน

สุขภาพดี เป็นเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนา แต่ไม่สามารถหยิบยื่นให้กันได้และไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ถึงแม้จะร่ำรวย มีเงินทองหากไม่ดูแลตนเองให้ดี สุขภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสร้าง การมีสุขภาพดี ไม่ได้หมายถึงน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่หมายถึง การดูแลตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุของโรคและความเจ็บป่วย สนับสนุนกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในปัจจุบันมีอะไรบ้างและมีสาเหตุจากอะไร
- ปัญหาสุขภาพมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไรในแง่ของร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิตประจำวัน

กิจกรรการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

การอภิปรายผลกระทบ

- แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในปัจจุบันมีอะไรบ้าง มีสาเหตุจากอะไร มีผลกระทบต่อตนเองอย่างไรในแง่ของร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร

เนื้อหาสาระ

1. ปัจจัยกำหนดสุขภาวะหรือความมีสุขภาพดี (Health determinants)

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพ หมายถึง สภาวะแวดล้อมของบุคคลตั้งแต่เกิด เติบโต ทำงาน และชราภาพ ซึ่งสภาวะนั้นถูกกำหนดโดยระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการกระจายทรัพยากรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก ปัจจัยเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลมีความแตกต่างกันในเชิงสังคมและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในด้านสุขภาพ ประกอบด้วย อายุ (Age) เพศ (sex) ปัจจัยส่วนบุคคลที่กำหนดมาแต่เกิด (Hereditary) ปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนบุคคล (Individual lifestyle factors) ปัจจัยเครือข่ายทางสังคมและชุมชน (Social and community networks) การเกษตร ผลิตอาหาร การศึกษา สิ่งแวดล้อมใน

การทำงานสภาพความเป็นอยู่และการทำงาน การว่างงาน สุขอนามัยการบริการสุขภาพ ที่อยู่อาศัย สภาพเศรษฐกิจและสังคม (General socioeconomic) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (cultural and environmental conditions)

จำแนกปัจจัยกำหนดสุขภาพออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ปัจจัยด้านบุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบบริการสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้

1.1 ปัจจัยด้านบุคคล

ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย ปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ และพฤติกรรม ส่วนปัจจัยทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่กำเนิดที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทั้ง 2 ฝ่าย คือ พันธุกรรมที่แฝงตัวอยู่ในโครโมโซมของทุกคน ส่วนปัจจัยด้านจิตใจครอบคลุมความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อและค่านิยมของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวกำหนดการเกิดโรค ทั้งปัจจัยด้านพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทั่วไป และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ

1.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคม ดังนี้

1) สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพทั้งหมด เช่น ที่อยู่อาศัย การจราจร สวนสาธารณะ อุปกรณ์ออกกำลังกาย เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน บุหรี่ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพและสังคม เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ซึ่งเปรียบได้กับ agent ในเชิงระบาดวิทยาที่มีผลต่อการเกิดโรค ประกอบด้วย เชื้อโรค สัตว์ และมนุษย์ ผักผลไม้ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ครอบครัว ชุมชน นโยบายสาธารณะ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาการว่างงาน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยมของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

1.3 ระบบบริการสาธารณสุข ครอบคลุมทั้งสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขส่งผลต่อ การลดอัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้โดยเฉพาะ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เน้นที่การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ป้องกันได้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพไทย

ปัจจัยที่กระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพไทย ประกอบด้วย 9 ด้าน

1. เทคโนโลยีปัจจุบัน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพมีความสำคัญมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน มีเทคโนโลยีสีเขียว

2. การขนส่งรถยนต์เป็นพาหนะที่สำคัญ โดยปริมาณการขนส่งและสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับโลจิสติกส์ในภูมิภาค

3. อาหารและเกษตรกรรม ความต้องการอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มากขึ้น พืชอาหารถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทางเลือก อาหารปลอดภัยมากขึ้น

4. สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญระหว่างประเทศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของภาคต่าง ๆ สูงขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำหายไป มลพิษโดยรวมมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองและอุตสาหกรรม

5. โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ โรคระบาด ปัญหาจากเชื้อดื้อยา โรคระบาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อย แต่มีความรุนแรงไม่มาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นผลดีต่อการป้องกัน และควบคุมโรค

6. ลักษณะเฉพาะของคนไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่มีจิตสำนึกสาธารณะ และไม่มีระเบียบวินัย การศึกษายังเน้นสอนด้านวิชาการมากกว่าจริยธรรม

7. ประชากร สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมืองในต่างจังหวัด แรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

8. การเมือง มีเหตุการณ์รุนแรงทางสังคมและการเมืองนำไปสู่การปฏิรูปใหญ่ของโครงสร้างทางการเมืองและกฎหมาย ไม่เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง

9. เศรษฐกิจ เศรษฐกิจดีขึ้น โดยเฉพาะในแถบชายแดนมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูง การคลังรัฐบาลอาจมีปัญหาเนื่องจากนโยบายประชานิยม

2. ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย และวิธีง่าย ๆ ในการหลีกเลี่ยงจากปัญหาเหล่านี้

2.1 ความเครียด เมื่อต้องการที่จะลดความเครียดในชีวิตประจำวัน ให้เริ่มต้นจากการพิจารณาถึงสาเหตุที่มา ซึ่งอาจจะมาจากความต้องการในสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงจากคู่ของคุณ ความรับผิดชอบในบุตรหลาน และอื่น ๆ การพิจารณาถือเป็นขั้นตอนแรกในการระบุที่มาของความวิตกกังวลทั้งหลาย เรียนรู้วิธีที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการรับมือกับความเครียด เปิดใจให้กว้าง มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า การออกกำลังกายนั้นช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเชิงบวกออกมา ซึ่งอาจเป็นการช่วยแม้เพียงเล็กน้อยให้คลายคิ้วที่ขมวดอยู่ตลอดเวลาได้ เมื่อมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหา ปฏิบัติตาม 4 ข้อนี้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

1) หลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จำเป็น

2) แก้ไขสถานการณ์ที่คุณสามารถทำได้

3) ปรับให้เข้ากับความเครียด

4) ยอมรับสิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

2.2 ไข้หวัดทั่วไป ไข้ทั่วไปหรือไข้หวัดเป็นโรคที่รบกวนเราจนอาจจะต้องขออนุญาตลาป่วยได้ มี 6 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไข้หวัดได้ง่าย ๆ

1) ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้งด้วยน้ำและสบู่

2) ล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที และช่วยเหลือบุตรหลานให้ทำความสะอาดเช่นเดียวกัน หากไม่มีน้ำหรือสบู่ ให้ใช้เพียงแอลกอฮอล์และกระดาษชำระในการทำความสะอาด ไวรัสต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดสามารถอาศัยอยู่บนผิวหนังของเราได้ การล้างมือปกติแล้วนั้นสามารถช่วยปกป้องจากการเป็นไข้หวัดได้

3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรือปากด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง

4) ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราและทำให้เราเจ็บป่วยได้

5) หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้กับผู้ป่วยที่มีอาการ

6) ผู้ป่วยสามารถกระจายไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้หวัดทั่วไป ดังนั้น งดติดต่อกับผู้ป่วยรายอื่น

2.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด การที่ LDL (คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี) และ HDL สูง (คอเลสเตอรอลที่ดี) อยู่ในระดับต่ำ ล้วนถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่รู้จักกันดีที่สามารถนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่นั่นไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเดียวที่ควรระวัง หากมีความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษา ประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคเบาหวาน ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย การสูบบุหรี่และการดำเนินชีวิตประจำก็ยังสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้หญิงที่อายุผ่านวัยหมดประจำเดือน และผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี สามารถมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาให้เกิดโรคได้อีกด้วย

- คุณสามารถลดปัจจัยความเสี่ยงได้โดย :
- ตรวจระดับคอเลสเตอรอลอยู่เป็นประจำและรักษาให้อยู่ในระดับตามที่แพทย์แนะนำ

- ตระหนักถึงประวัติความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว
- รักษาอาการโรคเบาหวานหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน
- หากทำได้ ควรเลิกสูบบุหรี่
- ออกกำลังกายเป็นประจำ ปรึกษาแพทย์เพื่อเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากที่สุด

2.4 โรคเบาหวาน โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่แพร่หลายมากที่สุดในสังคมของเรา ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตอาหารและของหวาน เบาหวานสามารถป้องกันได้ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนเหล่านี้

- เลือกรับประทานธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแทนการรับประทานคาร์โบไฮเดรตธรรมดา
- ไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาล และเลือกน้ำเปล่า กาแฟ หรือน้ำชาแทน
- เลือกรับประทานไขมันดีแทนไขมันเลว
- จำกัดการรับประทานเนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูป เลือกรับประทานเมล็ดถั่ว ธัญพืช หรือปลา แทน
- พยายามลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

2.5 สายตาสั้น อันเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่อายุยังน้อย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากว่า 30% ของเด็กที่อายุ 6 - 7 ปี มีวิสัยทัศน์ที่บกพร่อง และในเด็กอายุ 10 – 12 ปี นั้น เพิ่มขึ้น ถึง 60% เลยทีเดียว

- สายตาสั้นสามารถป้องกันได้โดยมาตรการป้องกันอย่างง่าย และกระตุ้นให้มีวิธีการในเชิงบวกมากขึ้นในการดูแลสุขภาพสายตา

- กิจกรรมกลางแจ้งจะช่วยทำให้มีการใช้โฟกัสของสายตาทั้งระยะไกลและใกล้ ซึ่งถือเป็นการออกกำลังสายตาอย่างหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพตาดีขึ้นและทำให้สายตาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

3. การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

การวางแผนดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตัวของเราเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัว เกิดความรักในครอบครัว ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต คุณค่าของการวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว คำว่า “สุขภาพดี” ในแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาวะสังคม หรือรูปแบบของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วสุขภาพดีอย่างน้อยจะต้องหมายถึง ความสมบูรณ์ของทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดได้เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่ระบบต่าง ๆ ที่สำคัญของร่างกาย การที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ หากแต่จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดี ดังนี้

- สามารถที่จะกำหนดวิธีการหรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของตัวเราเองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

- สามารถที่จะกำหนดช่วงเวลา ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม อาจจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายในช่วงเช้า หรือในบางครอบครัวอาจจะมีเวลาว่างในช่วงเย็น ก็อาจจะกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นก็ได้ หรืออาจจะกำหนดช่วงเวลาในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

- เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ นับว่าเป็นการสร้างสุขภาพ ซึ่งจะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลในภายหลัง

- ช่วยในการวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัว เนื่องจากไม่ต้องใช้จ่ายเงินไปในการรักษาพยาบาล
- ส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว
- ทำให้คุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น

การดูแลสุขภาพตนเอง

การรู้จักและสร้างนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพหรือดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งกายและใจ อารมณ์และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถ้าตัวเองมีวินัยเรื่องสุขภาพมีความรู้เรื่องสุขภาพก็จะเป็นผลดีต่อทุก ๆ ด้าน ซึ่งการดูแลสุขภาพของคนนั้นพัฒนาตามวัย ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ โดยต้องดูแลแตกต่างกันไป การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีสามารถทำได้ดังนี้

– **ออกกำลังกายสม่ำเสมอ** ควรออกกำลังกายอย่างถูกวิธีของการออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 - 5 วัน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้

– **การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง** รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เสริมด้วยผักผลไม้ทุก ๆ มื้อ เพื่อช่วยการทำงานของระบบขับถ่าย ช่วยเสริมสร้างสมอง ช่วยป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน มะเร็ง สมองเสื่อม

– **การพักผ่อนและการนันทนาการ** การพักผ่อน เป็นการสร้างภูมิต้านทานโรค เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน เป็นการพักการทำงานของกล้ามเนื้อให้ลดการทำงานหนัก ๆ เพื่อฟื้นคืนสู่สภาพปกติ การพักผ่อนมีหลายวิธี รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ แต่การพักผ่อนวิธีที่ดีที่สุด คือ การพักผ่อนตอนกลางคืน วันละ 6 - 8 ชม.

– **หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง** หมายถึง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นบ่อนทำลายสุขภาพ หรือเป็นสาเหตุของการที่จะเกิดอุบัติภัยและภัยอันตราย เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเสพสารเสพติดที่จะเป็นตัวทำลายระบบประสาทและสมอง การสำส่อนทางเพศและพฤติกรรมประมาท

– **สร้างทักษะในชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ** การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุขหรือความเป็นอยู่ทั่วไป ซึ่งต้องเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามารถที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคมที่เป็นลบ เช่น การมั่วสุม สารเสพติด หรือ การถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยทักษะที่จำเป็น เช่น ทักษะในการจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัว

– **การมีพัฒนาการทางด้านปัญญา** ซึ่งมีวิธีหลากหลายที่จะช่วยให้บุคคลลดละความเห็นแก่ตัว มุ่งเข้าถึงความดี เช่น การศึกษา การเล่นกีฬา การศาสนา การรวมกลุ่ม การเจริญภาวนา การสัมผัสธรรมชาติ เป็นต้น ที่จะทำให้เข้าถึงความสุขทางปัญญา ทำให้สุขภาพจิตดี ซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีตามมา

– **มีการเรียนรู้ที่ดี** เช่น การอ่านหนังสือ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสนุก ทำให้เกิดปัญญา เกิดความคิด ความสุข สร้างแรงจูงใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

– **การจัดสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อสุขภาพ** ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางสังคม สามารถทำได้ เช่น การมีสุขาภิบาลที่ดี สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค การมีสัมพันธภาพและมิตรไมตรีต่อกัน

ครอบครัวเป็นสังคมเล็ก ๆ สังคมหนึ่ง มีสมาชิกเพียงแค่พ่อ แม่ ลูก หรือเป็นสังคมของกลุ่มญาติ อันประกอบด้วยบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน แต่ทุกคนต้องมีความห่วงใย มีความรัก เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ซึ่งเมื่อทุกคนต่างก็ดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บไข้แล้ว สุขภาพส่วนรวมหรือสุขภาพของครอบครัวก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ตามไปด้วย



เรื่องที่ 3 กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน เป็นกระบวนการในการเพิ่มความสามารถให้กับบุคคล เพื่อให้สามารถควบคุมปัจจัยกำหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพทั้งสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา ของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได้ โดยกิจกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามบริบทของพื้นที่



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- กิจกรรมใดในชุมชนที่สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางกายภาพของประชาชนได้บ้าง

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

การบรรยายและการอภิปราย:

- ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาของชุมชนเกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน เช่น สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
- แบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะที่ชุมชนของตนเผชิญอยู่



กิจกรรมที่ 2

การศึกษากรณีศึกษา:

- ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาของชุมชนที่มีการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เช่น ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ชุมชนที่มีการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น สรุปและนำเสนอผลการศึกษา



เนื้อหาสาระ

1. กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กิจกรรมการออกกำลังกายสามารถทำได้หลายลักษณะด้วยกันตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อการนันทนาการ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด เป็นต้น

หลักการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ควรยึดขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย แบ่งลักษณะการเตรียมความพร้อม ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนออกกำลังกาย มีดังนี้

- มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงและมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
- ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย
- มีการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์
- ไม่รับประทานอาหารจนอิ่ม
- แต่งกายพร้อมและเหมาะกับชนิดและประเภทของกิจกรรมออกกำลังกาย
- รู้จักการใช้และเล่นเครื่องออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

2) การเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย หมายถึง การอบอุ่นร่างกาย ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- บริหารทุกส่วนของร่างกายให้พร้อมที่จะออกกำลังกาย
- ใช้เวลาในการบริหารร่างกายประมาณ 5 – 10 นาที และควรบริหารอวัยวะส่วนที่จะใช้ในการออกกำลังกายให้มากกว่าปกติ
- เริ่มบริหารร่างกายจากเบา ๆ แล้วจึงหนักขึ้น
- ควรให้ความสำคัญกับการบริหารข้อต่อในส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษ
- ควรมีการบริหารร่างกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ (stretching)
- มีความพร้อมทางด้านจิตใจ คือ มีความสุข มีความเต็มใจที่จะได้ออกกำลังกาย

ผลของการอบอุ่นร่างกาย จะส่งผลต่อร่างกายดังนี้

- ทำให้สภาพร่างกายโดยทั่วไปพร้อมจะออกกำลังกาย
- ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายพร้อมที่จะทำหน้าที่ โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ
- ช่วยปรับระดับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
- ช่วยลดและป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
- ทำให้ร่างกายสามารถออกกำลังกายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเต็มความสามารถ

ขั้นตอนที่ 2 การออกกำลังกาย โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาทีขึ้นไป ขีดจำกัดสูงสุดจะใช้เวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น คือ ร่างกายและจิตใจของผู้นั้น กล่าวคือ ร่างกายไม่มีอาการเมื่อยล้าหรือส่งผลต่อการบาดเจ็บ ส่วนสภาพจิตใจมีความพร้อมและมีความสนุกเพลิดเพลิน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยทั่วไปแล้วการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรจะใช้เวลาประมาณ

20 - 60 นาทีต่อวัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา การบริหารร่างกาย การเต้นแอโรบิก เป็นต้น

หลักการในการพิจารณาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีดังนี้

- ความถี่ของการออกกำลังกาย หมายถึง จำนวนวันในการออกกำลังกาย โดยทั่วไปแล้วควรออกกำลังกายทุกวันหรืออย่างน้อยวันเว้นวัน
- ความหนักของการออกกำลังกาย หมายถึง ความพอเหมาะของการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปมักจะใช้อัตราการเต้นของชีพจรเป็นตัวกำหนด
- ความนานในการฝึกแต่ละครั้ง หมายถึง ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ประมาณ 20 - 60 นาที
- รูปแบบการออกกำลังกาย หมายถึง วิธีการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ออกกำลังกาย เช่น กีฬา กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 การปรับร่างกายเข้าสู่สภาพปกติหลังการออกกำลังกาย เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะขณะที่ร่างกายทำงานอย่างหนักแล้วหยุดการออกกำลังกายทันทีทันใด อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น เกิดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เกิดอาการเป็นไข้เนื่องจากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีหลักปฏิบัติหลังการออกกำลังกาย ดังนี้

- อย่าหยุดการออกกำลังกายทันทีทันใด ควรอบอุ่นร่างกายเบา ๆ จนถึงน้อยสุดแล้วจึงหยุด เวลาที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายหลังการออกกำลังกาย (cool down) ประมาณ 10 - 20 นาที
- ไม่ควรดื่มน้ำจำนวนมากหรือรับประทานอาหารทันที
- ควรพักให้ร่างกายมีเวลาปรับสภาพสู่ปกติพอสมควรก่อนอาบน้ำ
- หลังจากการออกกำลังกายแล้วควรเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายใหม่ เพราะชุดที่ใช้ในการออกกำลังกายจะเปียกชุ่ม และทำให้ร่างกายปรับสภาพได้ไม่ดี อาจจะทำให้เป็นไข้ได้
- ควรใช้ท่าบริหารร่างกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (stretching) จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย ช่วยลดอาการตกค้างของของเสียหลังการออกกำลังกาย และที่สำคัญคือ ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ผลการออกกำลังกายส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

1) **ผลการออกกำลังกายต่อระบบกล้ามเนื้อ** ได้แก่
   - กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น (เส้นใยกล้ามเนื้อหนาขึ้น) ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
   - กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น หรือสามารถทำงานให้มากหรือหนักเพิ่มขึ้น มีความทนทานมากขึ้นหรือทำงานได้นานขึ้น
   - ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อจะปรับตามลักษณะของการใช้ในการออกกำลังกาย
   - กล้ามเนื้อสามารถทนความเจ็บปวดได้ดีขึ้น
2) **ผลการออกกำลังกายต่อระบบกระดูกและข้อต่อ** ได้แก่
   - กระดูกจะมีความหนาและเพิ่มขนาดมากขึ้นโดยเฉพาะวัยเด็ก
   - กระดูกมีความเหนียวและแข็ง เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก
3) **ผลการฝึกต่อระบบหายใจ** ได้แก่
   - ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจดีขึ้น
   - ขนาดของทรวงอกเพิ่มขึ้น

- ปอดมีขนาดใหญ่และมีความจุเพิ่มขึ้น

- อัตราการหายใจลดลงเนื่องจากการหายใจแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดโลหิตต่อครั้งมากขึ้น (อัตราการหายใจของคนปกติ 16 - 18 ครั้งต่อนาที)

4) ผลการออกกำลังกายต่อระบบไหลเวียน ได้แก่

- การสูบฉีดของระบบไหลเวียนดีขึ้น ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
- ขนาดของหัวใจใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น
- หลอดเลือดมีความเหนียว ยืดหยุ่นดีขึ้น

5) ผลการออกกำลังกายต่อระบบอื่น ๆ

- ระบบประสาทอัตโนมัติ ทำงานได้สมดุลกัน (Sympathetic and Parasympathetic) ทำให้การปรับตัวของอวัยวะให้เหมาะกับการออกกำลังกายได้เร็วกว่า การฟื้นตัวเร็วกว่า

- ต่อมหมวกไต เจริญขึ้น มีฮอร์โมนสะสมมากขึ้น

- ตับ เพิ่มปริมาณและน้ำหนัก ไกลโคเจนและสารที่จำเป็นต่อการออกกำลังกายไปสะสมมากขึ้น

6) ช่วยป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายมีการใช้พลังงานที่ได้รับจากสารอาหารต่าง ๆ โดยไม่มีการสะสมไว้เกินความจำเป็น แต่ถ้าขาดการออกกำลังกายจะทำให้สารอาหารที่มีอยู่ในร่างกายถูกสะสมและถูกเปลี่ยนเป็นไขมันแทรกซึมอยู่ตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคอ้วน

7) ผลต่อจิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

- ด้านจิตใจ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์แล้ว จิตใจก็ร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่กัน เนื่องจากเมื่อร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าได้ออกกำลังกายร่วมกันหลาย ๆ คน เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีมจะทำให้เกิดการเอื้อเฟื้อ มีเหตุผล อดกลั้น สุขุม รอบคอบ และมีความยุติธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัยกัน

- ด้านอารมณ์ มีอารมณ์เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น ช่วยคลายความเครียดจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน จึงสามารถทำงานหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้านสติปัญญา การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความคิดอ่านปลอดโปร่ง มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีทางของเกมการแข่งขัน ซึ่งบางครั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

- ด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและผู้อื่นได้ดี เพราะการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายรวมกันเป็นหมู่มาก ๆ จะทำให้เกิดความเข้าใจ และเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

การออกกำลังกายมิใช่จะให้ประโยชน์แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น บางครั้งอาจเกิดโทษได้ ถ้าการออกกำลังกายหรือการฝึกฝนทางร่างกายไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเกิดการบาดเจ็บ ดังนั้นจึงมักพบว่า จำนวนของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬานั้นมีอัตราค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาที่เคยเข้ามาร่วมแข่งขันในระดับชาติแล้วก็ตาม ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการออกกำลังกาย หากมีไม่เพียงพอแล้วย่อมก่อให้เกิดการบาดเจ็บในขณะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้

ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย

1. ควรเริ่มออกกำลังกายอย่างเบาๆ ก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความหนักของการออกกำลังกายในวันต่อ ๆ ไปให้มากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน

2. ผู้ที่เพิ่งฟื้นจากไข้หรือมีโรคประจำตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย

3. ผู้ที่ประสงค์จะออกกำลังกายหนัก ๆ โดยเฉพาะผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี จะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน

4. ในระหว่างการออกกำลังกาย ถ้ารู้สึกผิดปกติ เช่น หน้ามืด หอบมาก และชีพจรเต้นเร็ว ต้องหยุดการออกกำลังกายทันที และถ้าต้องการจะออกกำลังกายใหม่ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์เสียก่อน

5. การออกกำลังกายแต่ละครั้ง ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเอง

6. การออกกำลังกายที่จะให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ควรต้องออกแรง โดยให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทุกส่วนทำงานมากกว่าปกติหรือเพื่อให้รู้สึกเหนื่อย เช่น หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเต้นเร็วขึ้น เป็นต้น

7. ผู้ที่มีภารกิจประจำวันที่ไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อการออกกำลังกายได้ ควรเลือกกิจกรรมที่ง่าย และกระทำได้ในบริเวณบ้าน ใช้เวลาสั้น ๆ เช่น เดินเร็ว ๆ กายบริหาร วิ่งเหยาะ ๆ กระโดดเชือก เป็นต้น

8. เครื่องมือที่ช่วยในการออกกำลังกาย เช่น เครื่องเขย่า สั่น ดึง ดัน เพื่อให้ร่างกายไม่ต้องออกแรง กระแทกนั้นมีประโยชน์น้อยมาก เพราะว่าการออกกำลังกายจะมีประโยชน์หรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายได้ออกกำลังกายแรงมากน้อยเพียงใด

9. การออกกำลังกายควรกระทำให้สม่ำเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 20 - 30 นาที เพราะร่างกายต้องการอาหารเป็นประจำทุกวันฉันใด ร่างกายต้องการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันฉันนั้น

10. เพื่อให้การออกกำลังกายมีความสนุกสนาน หรือมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นควรทำสถิติเกี่ยวกับการออกกำลังกายเป็นประจำควบคู่ไปด้วย เช่น จับชีพจร นับอัตราการหายใจ เป็นต้น

11. การออกกำลังกายควรกระทำให้สม่ำเสมอทุกวัน เป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งในการปรับปรุงและรักษาสุขภาพเท่านั้น ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องมีการรับประทานอาหารที่ดี และมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วย

12. พึงระวังเสมอว่า ไม่มีวิธีการฝึกหรือออกกำลังกายวิธีลัดเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย แต่การฝึกหรือการออกกำลังกายต้องอาศัยเวลาค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อใดที่ไม่ควรออกกำลังกาย

การออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอจะซาบซึ้งในความจริงข้อนี้เป็นอย่างดี บางคนบอกว่า การออกกำลังกายเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะถ้าประพฤติปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัยแล้วหากไม่ได้ออกกำลังกายสักวัน จะรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควร ซึ่งเป็นความจริง (เพราะร่างกายไม่ได้หลั่งสารสุขเอนเดอร์ฟินออกมา)

ข้อควรระมัดระวัง หรืองดออกกำลังกายชั่วคราว ในกรณีต่อไปนี้ คือ

1. เจ็บป่วยไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไข้หรือมีอาการอักเสบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

2. หลังจากฟื้นไข้ใหม่ ๆ ร่างกายยังอ่อนเพลียอยู่ หากออกกำลังกายในช่วงนี้ จะทำให้ร่างกายยิ่งอ่อนเพลียและหายช้า

3. หลังจากการกินอาหารอิ่มใหม่ ๆ เพราะจะทำให้เลือดในระบบไหลเวียนถูกแบ่งไปใช้ในการย่อยอาหาร เพราะฉะนั้นเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ออกกำลังกายจะลดลงทำให้กล้ามเนื้อหย่อนสมรรถภาพ และเป็นตะคริวได้ง่าย

4. ช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดและอบอ้าวมาก เพราะร่างกายจะสูญเสียเหงื่อและน้ำมากกว่าปกติทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หรือเป็นลมหมดสติได้ (ยกเว้นนักกีฬามืออาชีพที่มีความจำเป็นต้องออกกำลังกาย)

อาการที่บ่งบอกว่าควรหยุดออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของทุกคน แต่การออกกำลังโดยที่ร่างกายไม่พร้อมหรือฝืนจนเกินไป อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ สัญญาณอันตรายที่ควรหยุดออกกำลังกาย มีดังนี้

1. รู้สึกใจสั่น หรือใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

2. เจ็บแน่นหน้าอก

3. หายใจไม่ทัน หายใจขัดเป็นช่วง ๆ

4. มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เริ่มรู้สึกว่ากำลังจะไม่ได้สติ

5. เหงื่อออกมากผิดปกติ

หากมีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้นเพียง 1 อาการ ควรหยุดออกกำลังกาย แล้วนั่งพักจนกว่าร่างกายจะเป็นปกติ โดยสาเหตุอาจมาจากพักผ่อนน้อยเกินไป ได้รับพลังงานต่อวันไม่เพียงพอ หักโหมมากเกินไป สภาพอากาศ หรือสภาวะขาดน้ำ เพราะฉะนั้น หากอยากออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ควรฝืนร่างกายจนเกินไป

รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1. การเดิน เป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวกที่สุด แต่ให้ประโยชน์และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายไม่แพ้การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาชนิดอื่น ๆ การเดินสามารถทำได้ทุกเวลาและสถานที่ วิธีการเดินที่ควรรู้และปฏิบัติตามมีดังนี้

1.1 ควรเริ่มจากท่ายืนก่อน ปล่อยตัวตามสบาย และหายใจปกติ

1.2 ขณะเดินให้เงยหน้าและมองตรงไปให้ไกลที่สุด เพราะหากเดินก้มหน้าจะทำให้ปวดคอและปวดหลังได้

1.3 เดินให้เต็มเท้าโดยเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าแล้วยกเท้าขึ้น ให้หัวแม่เท้ายกขึ้นจากพื้นเป็นส่วนสุดท้าย

1.4 ในการเดินควรเริ่มต้นจากเดินช้า ๆ ก่อนประมาณ 5 นาที แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มความเร็วจนหัวใจเต้นถึงอัตราสูงสุดของมาตรฐาน คือ 200 ครั้ง/นาที สำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายอาจเริ่มเดินครั้งละ 10 นาที หรือจนกว่าจะรู้สึกหอบเหนื่อยเล็กน้อย เว้นไป 1 – 2 วัน แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาเดินแต่ละครั้งจนสามารถเดินติดต่อกันได้ อย่างน้อย 30 นาที โดยเดินสัปดาห์ละ 3 – 5 ครั้ง

1.5 ขณะเดินมือทั้ง 2 ข้าง ควรปล่อยตามสบายและเหวี่ยงแขนไปทั้งแขนเพื่อเพิ่มแรงส่ง ถ้าหากเดินแล้วหัวใจยังเต้นไม่เร็วพอ ให้เพิ่มความเร็วในการเดินหรือแกว่งแขนขาให้แรงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้เร็วขึ้นได้

1.6 รองเท้าใช้ใส่เดินควรเป็นรองเท้าที่มีพื้นกันกระแทกที่ส้นเท้าและหัวแม่เท้า สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เท้า

2. การวิ่ง การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่คนนิยมกันมากซึ่งง่ายและสะดวกพอ ๆ กับการเดิน แต่การวิ่งมีให้เลือกหลายแบบ การที่จะเลือกวิ่งแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกและความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล เช่น การวิ่งเหยาะ ๆ การวิ่งเร็ว การวิ่งมาราธอน การวิ่งอยู่กับที่ หรือการวิ่งบนสายพานตามสถานที่ออกกำลังกายทั่วไป การวิ่งต่อครั้งควรมีระยะทาง 2 - 5 กิโลเมตร และสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 5 ครั้ง ซึ่งมีเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้

2.1 การวิ่งอยู่กับที่ ต้องยกเท้าแต่ละข้างให้สูงประมาณ 8 นิ้ว ซึ่งมีข้อจำกัดที่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ น้อย ไม่มีการยืดหรือหดของกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นข้อด้อยกว่าการวิ่งแบบอื่น ๆ

2.2 การวิ่งบนสายพาน เป็นการวิ่งที่ปลอดภัยกว่าการวิ่งกลางแจ้ง ไม่ต้องเผชิญกับสภาพที่มีฝนตก แดดร้อน หรือมีฝุ่นละอองต่าง ๆ และถ้าใช้สายพานชนิดใช้ไฟฟ้าจะมีระบบต่าง ๆ บนจอภาพ ทำให้ทราบว่า การวิ่งของเรานั้นมีความเร็วอยู่ในระดับใด วิ่งได้ระยะทางเท่าไร และมีอัตราการเต้นของชีพจรเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับโปรแกรมออกกำลังกายในครั้งต่อไป การวิ่งบนสายพาน มีข้อเสีย คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะเครื่องมีราคาแพง และการใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายของเอกชนจะต้องเสียค่าบริการซึ่งมีราคาแพงเช่นกัน ดังนั้น ควรใช้บริการของภาครัฐที่ให้บริการด้านนี้โดยตรง คือ สถานที่ออกกำลังกายที่

จัดบริการโดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้

2.3 การวิ่งกลางแจ้ง เป็นการวิ่งที่ทำให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ ถ้าวิ่งในสวนสาธารณะหรือวิ่งออกไปนอกเมืองจะได้ชมทิวทัศน์ ทำให้ไม่เบื่อและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในกรณีที่ออกวิ่งเพียงคนเดียว

3. การขี่จักรยาน การขี่จักรยานไปตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นการออกกำลังกายที่ให้ประโยชน์ด้านการทรงตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และเป็นการฝึกความอดทนด้วย การขี่จักรยานในสวนสาธารณะหรือในที่ไม่มีมลพิษนั้น นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพจากความเพลิดเพลินในการชมทิวทัศน์รอบด้านและอากาศที่บริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากการขี่จักรยานแบบตั้งอยู่กับที่ในบ้านหรือสถานที่ออกกำลังกาย การขี่จักรยานมีเทคนิคง่าย ๆ ที่ควรปฏิบัติดังนี้

3.1 ปรับที่นั่งของจักรยานให้เหมาะสม เพราะในการปั่นต้องมีการโยกตัวร่วมด้วย

3.2 ในการปั่นจักรยานให้ปั่นด้วยปลายเท้าตรงบริเวณโคนนิ้ว

3.3 ถ้าเป็นจักรยานแบบตั้งอยู่กับที่ ในช่วงแรกของการฝึกควรตั้งความฝืดให้น้อยเพื่ออบอุ่นร่างกายประมาณ 3 - 4 นาที แล้วจึงค่อย ๆ ปรับเพิ่มความฝืดของล้อมากขึ้นจนหัวใจเต้นเร็วถึงอัตราที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย แล้วจึงค่อย ๆ ลดความฝืดลงจนเข้าสู่ระยะผ่อนคลาย เมื่อชีพจรเต้นช้าลงจนเป็นปกติจึงหยุดปั่นจักรยานได้

4. การเต้นแอโรบิก เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นการออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ประโยชน์จากการเต้นแอโรบิก คือ การสร้างความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจเทคนิคในการเต้นแอโรบิก มีดังนี้

4.1 ต้องเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา เพื่อให้การเต้นของหัวใจอยู่ในระดับที่ต้องการ

4.2 ใช้เวลาในการเต้นแอโรบิกครั้งละ 20 - 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

4.3 สถานที่ที่ใช้ในการเต้นแอโรบิกควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และถ้าพื้นที่ใช้เต้นเป็นพื้นแข็ง ผู้เต้นจะต้องใส่รองเท้าสำหรับเต้นแอโรบิกโดยเฉพาะ ซึ่งพื้นรองเท้าจะช่วยรองรับแรงกระแทกได้

4.4 ควรหลีกเลี่ยงท่ากระโดด เพราะการกระโดดทำให้เท้ากระแทกกับพื้น

กิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าว เราสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ ดังนั้น จึงควรหาเวลาว่างในแต่ละวันทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสนใจและความพร้อมด้านร่างกาย เวลา สถานที่ อุปกรณ์ ได้แก่ การว่ายน้ำ กิจกรรมเข้าจังหวะ ลีลาศ รำวง การรำไม้พลอง โยคะ ไทเก๊ก ฯลฯ รวมถึงกีฬาเพื่อสุขภาพอื่น ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาที่กล่าวมาแล้ว สามารถเล่นเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์ในชุมชนได้

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย

ผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทุกโรคที่ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ หากได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายที่ถูกต้องตามสภาพและอาการของโรคจะช่วยให้โรคที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายมีทั้งคุณและโทษ หากไม่รู้จักวิธีที่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวจะต้องคำนึงถึงสุขภาพความ

พร้อมของร่างกาย โดยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดและให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม ทั้งนี้ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้

หลักในการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยทุกโรคที่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ ควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

1. ควรค่อยทำค่อยไป เริ่มตั้งแต่น้อยไปหามากแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นและเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ

2. ควรออกกำลังกายโดยสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 10 - 15 นาที เป็นอย่างน้อย

3. ต้องให้ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณสำคัญ เช่น ท้อง แขน ขา หลัง ลำตัว กล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด ต้องทำงานหนัก

4. ผู้ที่มีความดันเลือดสูง ปรอทวัดด้านบนเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท ด้านล่างเกิน 100 มิลลิเมตรปรอท ต้องให้แพทย์ตรวจ และให้ความดันด้านบนลดลงต่ำกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท และความดันล่าง ต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท เสียก่อนจึงออกกำลังกาย จะโดยวิธีรับประทานยาลดความดันก็ได้

5. สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน 200 มิลลิกรัมปรอท ต้องให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่า 160 มิลลิกรัมปรอท เสียก่อน จึงค่อยออกกำลังกาย โดยวิธีรับประทานยาที่หมอสั่งเป็นประจำ หรือลดอาหารพวกแป้ง และน้ำตาลลงมาก ๆ แล้วกินผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดแทน

6. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจทุกชนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย หรือวิ่งแข่งขันประเภทต่าง ๆ

7. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีน้ำหนักเกินมาก ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะเริ่มต้นออกกำลังกาย

8. ผู้ป่วยทุกคนหรือคนปกติที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพและจิตใจก่อนลงมือออกกำลังกาย เมื่อแพทย์อนุญาตให้ออกกำลังกาย จึงค่อย ๆ เริ่มไปออกกำลังกายทีละน้อย ๆ

สำหรับผู้ป่วยทุกโรค การออกกำลังกายควรเริ่มต้นจากการเดินเป็นวิธีที่ปลอดภัยเป็นโอกาสให้ร่างกายได้ทดลองโดยเริ่มเดินประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวในการที่ต้องทำงานหนักขึ้น ควรสังเกตตัวเองว่าถ้าออกกำลังกายถูกต้องแล้วร่างกายจะกระปรี้กระเปร่า นอนหลับสนิท จิตใจร่าเริง มีเรี่ยวแรงมากขึ้น

หลังจากเดินช้าใน 2 สัปดาห์แรกจึงค่อยเดินเร็วให้ก้าวเท้ายาว ๆ ขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 - 4 ถ้าไม่เจ็บป่วยไม่มากนัก พอขึ้นสัปดาห์ที่ 5 อาจจะเริ่มวิ่งเบา ๆ สลับกับการเดินก็ได้ ถ้ามีอาการผิดปกติเตือน เช่น วิงเวียน หัวใจเต้นแรงมาก หรือเต้นถี่สลับเบา ๆ หายใจขัด รู้สึกเหนื่อยผิดปกติหรืออาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็ควรหยุดออกกำลังกาย การวิ่งระยะต้น ๆ ควรวิ่งเหยาะ ๆ ช้า ๆ วันละ 5 - 10 นาที แล้วค่อยเพิ่มขึ้นทีละน้อย

การออกกำลังกายที่ปลอดภัยที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ป่วย คือ กายบริหาร ยืดเส้น ยืดสาย ให้กล้ามเนื้อข้อต่อได้ออกแรงโดยยืดหลัก ดังนี้

1. กายบริหารวันละ 10 นาทีทุกวัน

2. ท่าที่ใช้ฝึกควรเป็น 6 - 7 ท่า ต่อวันใน 2 สัปดาห์แรกให้ฝึกท่าละ 5 - 10 รอบ สัปดาห์ 3 - 4 รอบ เพิ่มเป็น 12 รอบ

3. เปลี่ยนท่าฝึกไม่ให้เบื่อหน่าย เลือกท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ เช่น ท่อนขา ท่อนแขน ต้นคอ หัวไหล่ เป็นต้น

4. ท่าซอยเท้าอยู่กับที่และท่ากระโดดเชือก ถ้าเลือกทำให้พึงระวังเป็นพิเศษ ในผู้ป่วยหนักและผู้สูงอายุ

5. ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าแข็งแรง สดชื่นก็ไม่ควรฝึกหักโหมออกกำลังกายมากเกินไป ท่าบริหารแต่ละท่าไม่ควรฝึกเกินท่าละ 30 รอบ และไม่ฝึกเกิน 30 ท่า ในแต่ละวัน

6. ตรวจสอบความก้าวหน้าในการออกกำลังกายโดยการชั่งน้ำหนัก ส่วนคนที่มีรูปร่างได้สัดส่วนน้ำหนักไม่ควรเปลี่ยนแปลงมากนัก

7. วัดชีพจรที่ซอกคอหรือข้อมือคนทั่ว ๆ ไป ถ้าไม่เจ็บป่วยเป็นไข้ ผู้ชายเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจร 70 - 75 ครั้งต่อนาที ผู้หญิง 74 - 76 ครั้งต่อนาที ส่วนผู้ป่วยที่มีพิษไข้จะมีชีพจรสูงกว่าปกติ แต่ถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ชีพจรควรลดลงอย่างน้อยจากเดิม 5 - 10 ครั้งต่อนาที แสดงว่า หัวใจทำงานดีขึ้น

การออกกำลังกายแต่ละประเภท มีลักษณะเฉพาะที่ผู้ออกกำลังกายต้องคำนึงถึง เช่น การขี่จักรยานมีจุดที่ควรระมัดระวังอยู่ที่หัวเข่า ผู้ที่ข้อเข่าไม่แข็งแรงหรือมีการอักเสบ ถ้าออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานจะทำให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น การเลือกวิธีการออกกำลังกายจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของสภาพร่างกาย โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อวัยวะส่วนที่เสี่ยงอันตรายของตนเองให้น้อยที่สุดหรือรักษาให้หายเสียก่อน จึงค่อยออกกำลัง โดยเริ่มจากเบา ๆ แล้วเพิ่มความหนักทีละน้อย

ส่วนบุคคลที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายและต้องสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายหรือหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง ทั้งนี้ การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเป็นโทษอย่างแน่นอน นอกจากนี้พึงระลึกว่า การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนหนึ่ง อาจไม่ใช่การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับอีกคนหนึ่ง

2. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน

2.1 แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

กฎบัตรกรุงเทพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ได้ถูกบัญญัติขึ้นในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2548 กฎบัตรกรุงเทพสนับสนุนและกำหนดขึ้นบนพื้นฐานของคำนิยม หลักการและกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรออตตาวา ซึ่งเป็นกฎบัตรการส่งเสริมสุขภาพของโลกที่บัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 จากการประชุมที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา และข้อเสนอแนะจากการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งต่อ ๆ มา ได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิกในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ซึ่งกฎบัตรกรุงเทพจะต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเพื่อการบรรลุสุขภาพดี การทำให้ประชาชน มีสุขภาพดีขึ้น ต้องอาศัยการดำเนินการทางการเมืองที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและการชี้นำอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมสุขภาพทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกมีมาตรการต่าง ๆ ที่ให้พิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิผลเป็นจำนวนมาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างเป็นรูปธรรม ตามกลยุทธ์ของการส่งเสริมสุขภาพ เราควรมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมและทุกพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็น ดังนี้

1) การชี้นำเพื่อสุขภาพโดยตั้งบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและภราดรภาพ

2) การลงทุนเพื่อการพัฒนานโยบายที่ยั่งยืนและเพื่อการดำเนินงาน ตลอดจนจัดโครงสร้างพื้นฐานที่จะจัดการกับปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดด้านสุขภาพ

3) การสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพ การถ่ายทอดความรู้และศึกษาวิจัย ตลอดจนมีความแตกฉานด้านสุขภาพ

4) การออกระเบียบและกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากอันตรายและมีโอกาสที่จะมีสุขภาพเท่าเทียมกัน

5) การสร้างภาคีเครือข่ายและพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน

2.2 บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของคนทุกคน เพราะการมีสุขภาพดีจะทำให้เราสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองได้อย่างเต็มที่ ในทางตรงข้าม บุคคลที่มีสุขภาพไม่ดี นอกจากจะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่แล้ว บางรายยังเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัวในการดูแลอีกด้วย ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง นอกจากจะไม่สามารถประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้แล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลอีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นภาระของผู้อื่น ดังนั้น ทุกคนจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนควรช่วยดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเท่าที่จะสามารถทำได้

การดูแลสุขภาพถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุกคน เพราะ สุขภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่สามารถหยิบยื่นให้กันและกันได้ การที่เราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการคือ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม คุณภาพของบริการสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทำของบุคคลที่มีผลต่อสุขภาพ โดยแสดงออกให้เห็นได้ในลักษณะของการกระทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อสุขภาพและการไม่กระทำในสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้น เราจึงควรมีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อ **การสร้างเสริมสุขภาพ** และป้องกันโรคในมิติของสุขภาพทั้ง 4 ด้านให้สอดคล้องกับนโยบายเมืองไทยแข็งแรง ดังนี้

1) มิติทางกาย มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็น ไม่ตายก่อนวัยอันควร เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นสามารถกลับคืนได้รวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์และสาธารณสุขได้

2) มิติทางจิตใจ มีจิตใจดี มีความสุข ไม่เครียดและรู้จักวิธีจัดการกับความเครียด

3) มิติทางสังคม มีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมีสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาชญากรรมและความรุนแรงน้อย

4) มิติด้านปัญญา หรือจิตวิญญาณมีจิตใจที่เปี่ยมสุขเข้าถึงความดีงามถูกต้องมีจิตใจดี มีเมตตากรุณาและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

2.3 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชน มีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ สร้างทักษะให้บุคคล ชุมชน สังคม สามารถดูแลสุขภาพของตนในการดำเนินชีวิตยามปกติและเมื่อเกิดการเจ็บป่วย เราจึงควรรู้จักและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ดังนี้

1) การสร้างเสริมสุขภาพกาย เป็นการปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

2) การสร้างเริมสุขภาพจิต เป็นการปฏิบัติตัวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต ให้มีจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีอารมณ์ มีสติ สามารถจัดการกับความเครียดได้โดยการมองโลกในแง่ดี ฝึกคิดในทางบวก รู้จักวิธีการจัดการความเครียด

3) การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคม สามารถทำได้โดยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

4) การสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญา หรือจิตวิญญาณ ทำได้โดยการยึดมั่นในหลักศาสนา และวัฒนธรรมที่ดีงาม ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

2.4 การรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ได้แก่

1) การรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของกลุ่มบุคคลวัยต่าง ๆ เช่น สตรีมีครรภ์ มารดาหลังคลอด เด็กทารก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เป็นต้น

2) การรวมกลุ่มเพื่อออกกำลังและเล่นกีฬา ซึ่งปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความสนใจสนับสนุนส่งเสริมกันมาก เช่น การรวมกลุ่มเต้นแอโรบิก การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เป็นต้น

3) การรวมกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมการพักผ่อนและนันทนาการ เช่น การท่องเที่ยว การร้องเพลง เล่นดนตรี การบำเพ็ญประโยชน์ การปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ ฯลฯ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ไม่หนักเกินไป แต่สร้างความเพลิดเพลินและความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสมาชิกเป็นหลัก

4) การรวมกลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญไหว้พระ การปฏิบัติศาสนกิจ การฝึกสมาธิ ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ควรครอบคลุมหลักการดูแลสุขภาพกายด้านอาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อน นันทนาการ และการเสริมสร้างสุขภาพจิต โดยการรวมกลุ่มสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคนในชุมชน จะก่อให้เกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่าย และเกิดความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน อันจะส่งผลให้เกิดพลังความเข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

2.5 โรคที่เป็นปัญหาในชุมชนและหลักการป้องกันโรค

โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมักจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชน เพราะฉะนั้น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคต่าง ๆ และหลักการป้องกัน จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ โดยมีหลักป้องกันโรค ดังนี้

1) การป้องกันโรคล่วงหน้า หมายถึง การป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งสามารถแบ่งแนวทางในการป้องกันโรคได้ 2 แนวทาง คือ

- การป้องกันโรคทั่วไป คือ แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

- การป้องกันโรคเฉพาะอย่าง คือ แนวทางการเสริมสร้างให้ร่างกายมีความต้านทานโรคต่าง ๆ เช่น การให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ

2) การป้องกันโรคในระยะที่โรคเกิดขึ้นแล้ว หมายถึง การป้องกับโรคในระยะที่เกิดโรคขึ้นในชุมชน โดยกำหนดแนวทางการระงับโรค การป้องกันการแพร่เชื้อ และการระบาดของโรคในชุมชน เช่น ควบคุมสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

3) การป้องกันโรคภายหลังการเกิดโรค หมายถึง การป้องกันโรคหลังเกิดโรคหรือเป็นโรคแล้ว เพื่อป้องกันจากความพิการ การไร้สมรรถภาพ หรือลดผลเสียจากโรคแทรกซ้อน

2.6 แนวร่วมในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

กลวิธีในการสร้างแนวร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน

1) การมีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหาและความต้องการของชุมชน

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยสมาชิกของชุมชนร่วมกันคิดและตัดสินใจ

3) การมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมสุขภาพ โดยสมาชิกต้องร่วมกันทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

5) การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยสมาชิกต้องนำผลการจัดทำกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากนี้ การสร้างแนวร่วมในชุมชนยังก่อให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชนอีกด้วย

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 7 การเสริมสร้างและดำรงสุขภาพ

เรื่องที่ 1 หลักการเสริมสร้างและดำรงสุขภาพของบุคคลและชุมชน



กิจกรรม

จากบทความ เรื่อง 5 วิธีการดูแลสุขภาพ สร้างสุขภาพที่ดีได้ด้วยมือเรา สรุปได้ว่า

1. การเลือกรับประทานอาหาร อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อร่างกาย การจะเกิดผลดีหรือผลเสียนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมถูกหลักวิธีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ร่างกายนำไปพัฒนาและซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ ลดอาหารที่มีแคลอรีสูง เช่น ของทอด ปิ้ง - ย่าง หรืออาหารที่มีไขมันเยอะ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์

2. บริหารสมอง การบริหารสมองเป็น 1 ใน 5 วิธีการดูแลสุขภาพที่จะเป็นแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงได้ เช่น เกมอักษรไขว้ เกมจำตำแหน่งภาพ เกมจับผิด เกมซูโดกุ หรือเกมหมากรุกจีน นอกจากนี้ควรหันมารับประทานผลไม้พวกส้ม องุ่น เบอร์รี่ เพราะผลไม้จำพวกนี้มีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดอาการหลง ๆ ลืม ๆ

3. พักสายตาจากการเสพสื่อโซเชียล ถ้าใช้สายตามากเกินไปนอกจากจะทำให้เป็นคนติดโซเชียลแล้วยังอาจทำให้กล้ามเนื้อดวงตาเมื่อยล้าหรือตาแห้ง เพราะต้องคอยจ้องอยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการเบลอ สายตาพร่ามัวหรือสายตาสั้นได้ ควรพักสายตาและบริหารดวงตาของเราด้วย เช่น กะพริบตา กลอกตา ไปมาเพื่อป้องกันตาแห้งหรือมองไปยังวัตถุที่อยู่ไกล ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายดวงตาลงได้

4. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี อวัยวะภายในร่างกายยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังทำให้เรามีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพจิตก็ดีตามไปด้วย จึงควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีหลังเลิกงาน

5. พักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพดีสร้างได้ง่าย ๆ เพียงแค่เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เมื่อทำกิจวัตรต่าง ๆ ในแต่ละวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอน เพราะร่างกายจะได้ซ่อมแซมฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ ควรนอนให้ครบ 8 ชั่วโมงและนอนให้เป็นเวลา

เรื่องที่ 2 ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน



กิจกรรม

- การอภิปรายควรเน้นที่การหาวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การสร้างความรู้และความเข้าใจในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรค

เรื่องที่ 3 กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน



กิจกรรมที่ 1

สุขภาวะชุมชนคืออะไรและสำคัญอย่างไร

- สุขภาวะชุมชน คือ สภาพที่ชุมชนและคนในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน



กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมใดบ้างที่สามารถเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนได้

- กิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน เช่น การเดินวิ่ง การเต้นแอโรบิก
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น การทำสมาธิ การฝึกโยคะ
- การปลูกผักสวนครัว การปลูกต้นไม้ในชุมชน
- การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ

บทที่ 8
ผลกระทบจากสารเสพติด

สาระสำคัญ

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้ มีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแก่ผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้
2. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
3. มีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกัน สารเสพติดในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
4. แนะนำสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดแก่ครอบครัวและผู้อื่น

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการแพร่ระบาดของสารเสพติด
เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และการแพร่ระบาดของสารเสพติด

ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดนับว่ารุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุที่ทำให้บุคคลหันมาใช้สารเสพติด เช่น เกิดจากความเครียด จากชีวิตส่วนบุคคล จากความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ หรือแรงกดดันจากสังคม ส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะสุขภาพที่ทรุดโทรมลง การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของสารเสพติดเกิดจากการขยายตัวของเครือข่ายการค้าและการผลิตการกระจายของสารเสพติดผ่านกลุ่มผู้ค้ายาและการเข้าถึงง่ายผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้การควบคุมและป้องกันมีความท้าทายสูง ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยหลักของปัญหานั้น ๆ ซึ่งทำให้สามารถวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดการแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

อะไรคือสาเหตุและผลกระทบของการติดสารเสพติดให้โทษ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ในชุมชนและสังคมของเรามีปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดมากมาย มีทั้งผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลัก และส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง

เนื้อหาสาระ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เราจะจึงจำเป็นต้องทราบถึงสาเหตุ ผลกระทบของสารเสพติด เพ่อให้เกิดความตระหนักในการแก้ปัญหาสารเสพติด

1. สาเหตุของการติดสารเสพติดให้โทษ

1.1 สาเหตุทางด้านบุคคล

1.1.1 ถูกชักชวน

1.1.2 สภาพความกดดันทางครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของพ่อแม่ เป็นต้น

1.1.3 ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น คนขับรถหรือลูกเรือในทะเล เป็นต้น

1.1.4 เกิดความเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิตใจ อาจมีการใช้สารเสพติดเพื่อบรรเทาอาการป่วยทางกายและทางจิตบางชนิดนานติดต่อกันจนติดยาได้

1.1.5 ถูกหลอกลวงโดยผู้รับไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนรับมาเป็นสารเสพติดหรือโดยการผสมปลอมปนกับอาหาร ของขบเคี้ยว

1.2 สาเหตุจากตัวยาหรือสารเสพติด

ตามปกติแล้วตัวยาหรือสารเสพติดจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ถ้าคนไม่นำมาใช้ แต่เมื่อบุคคลใช้ยาหรือสารเสพติด คุณสมบัติเฉพาะของสารนั้นจะทำให้เกิดการเสพติดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของสารเสพติดที่ใช้

1.3 สาเหตุจากสภาพแวดล้อม

1.3.1 อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อ - ขาย หรือเสพสารเสพติด

1.3.2 สภาพแวดล้อมบังคับ โดยเฉพาะผู้ที่ติดสารเสพติดแล้วต้องการจะเลิกเสพเมื่อเข้ารับการรักษาหายแล้ว สังคมอาจจะไม่ยอมรับ แหล่งงานปฏิเสธการรับเข้าทำงาน เนื่องจากมีประวัติติดสารเสพติด จึงทำให้ต้องกลับไปอยู่ในสังคมสารเสพติดเช่นเดิม

2. ผลกระทบและโทษภัยของสารเสพติด

ผลกระทบอันเกิดจากการใช้สารเสพติด นอกจากจะมีผลโดยตรง ก่อให้เกิดต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพเองแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ ดังนี้



รูปภาพที่ 1 ผลกระทบ และโทษภัยของสารเสพติด

2.1 ผลกระทบต่อตัวผู้เสพ ฤทธิ์ของสารเสพติด จะมีผลต่อระบบประสาทและระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายตลอดจนจิตใจของผู้ที่เสพเสมอ ดังนั้น จะพบว่า สุขภาพร่างกายของผู้ที่เสพยาจะทรุดโทรมทั้งร่ายกายและจิตใจ เช่น มีรูปร่างผอม ซูบซีด ผิวคล้ำ ไม่มีแรง อ่อนเพลียง่าย สมองเสื่อม และความจำสับสน เป็นโรคติดเชื้ออื่น ๆ ได้ง่าย เช่น โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภูมิต้านทานในร่างกายจะลดลง มีสภาวะทางจิตใจไม่ปกติ สภาพจิตใจเสื่อมลง อารมณ์แปรปรวนง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล ความรู้สึกฟุ้งซ่าน ซึ่งจากผลร้ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะผลักดันให้ผู้เสพยาเสพติดเป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจในการดำเนินชีวิตในสังคม ขาดความเชื่อมั่น สูญเสียบุคลิกภาพ ไม่สนใจตนเอง ไม่สนใจการงานหรือการเรียน และผู้เสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุถึงขั้นพิการ เช่น พลัดตกจากที่สูงขณะทำงาน หกล้ม อันเนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลต่อระบบประสาทและสมอง

2.2 ผลกระทบต่อครอบครัว การติดสารเสพติดนอกจากจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังทำให้ผู้เสพกลายเป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ห่วงใยดูแลครอบครัว ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น ต้องสูญเสียเศรษฐกิจและรายได้ของครอบครัว เนื่องจากต้องนำเงินมาซื้อสารเสพติด บางรายอาจต้องสูญเสียเงินจำนวนไม่น้อยเพื่อรักษาตนเองจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้สารเสพติด กลายเป็นภาระของครอบครัวในที่สุด อีกทั้งนำไปสู่ปัญหาครอบครัว เกิดการทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว เป็นต้น

2.3 ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ที่เสพสารเสพติด นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นำไปสู่ปัญหาสังคมส่วนรวมได้เช่น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น ปล้น จี้ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์ ปัญหาอุบัติเหตุ เช่น รถชน หรือตกจากที่สูง และปัญหาโรคเอดส์ เป็นต้น นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า ตลอดจนทรัพย์สินของตนเองและ

ส่วนรวมอย่างไร้ประโยชน์ ทำให้เป็นภาระของสังคมส่วนรวม ในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน และงบประมาณในการปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในที่สุด

2.4 ผลกระทบต่อประเทศชาติ ผู้ที่เสพสารเสพติดและตกเป็นทาสของสารเสพติดอาจกล่าว ได้ว่าเป็นผู้ที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากผู้ที่เสพสารเสพติดทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังคนและงบประมาณแผ่นดินจำนวนมหาศาล เพื่อใช้จ่ายในการปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดสารเสพติดทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เกิดความไม่สงบสุขของบ้านเมือง ทำให้เศรษฐกิจทรุด บั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติ ต้องสูญเสียกำลังสำคัญของชาติอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะถ้าผู้ที่เสพสารเสพติดเป็นเยาวชน

สาเหตุสำคัญของการติดสารเสพติด ส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคล ซึ่งอาจจะถูกหลอกให้ลองหรือจากสภาพแวดล้อม ซึ่งการติดสารเสพติดนั้นจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้เสพสารเสพติดเอง ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบนี้ไปสู่การพัฒนาแนวทางการแก้ไขและป้องกันการติดสารเสพติดในชุมชน

เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชน

การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชนสามารถทำได้โดยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของสารเสพติดผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและให้การสนับสนุนบุคคลที่เสี่ยงต่อการเสพติด



รูปภาพที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติด

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์พบผู้ติดยาเสพติด เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร เพื่อให้ตัวเองได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ผู้เรียนมีแนวทาง การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติดในชุมชนอย่างไร เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาสาระ

ปัญหายาเสพติด คือ ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือใช้ยาในทางที่ผิดซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์อันเนื่องมาจากความคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์จากฤทธิ์ของยา ดังนั้น การป้องกันปัญหาสารเสพติดได้แก่ การป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาของมนุษย์ที่เกิดจากการคิดพึ่งยาและหวังผลจากฤทธิ์ยานั้นเอง ซึ่งบุคคลในข่ายที่ต้องป้องกันไม่ให้ทำพฤติกรรมใช้สารเสพติดอาจ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. กลุ่มที่ยังไม่เคยใช้ยาและยังไม่เริ่มใช้ยา
2. กลุ่มที่เคยใช้ยา ซึ่งจำแนกออกได้เป็นพวกที่เคยลองใช้แล้วเลิก พวกที่ใช้เป็นครั้งคราว พวกที่ใช้บ่อย ๆ เป็นประจำแต่ยังไม่ถึงขั้นติดยา และพวกติดยาใช้ยาแล้ว
3. กลุ่มที่ใช้ยาเป็นประจำหรือติดยาที่ผ่านการบำบัดรักษาและเลิกใช้ยาติดยามาแล้ว

เนื่องจากบุคคลทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมานี้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ใช้ยา และติดยาในอนาคตได้ เช่นเดียวกัน กิจกรรมขอบข่ายงานป้องกันจึงจำเป็นต้องครอบคลุมบุคคลทั้งสามกลุ่ม โดยที่ผู้ดำเนินงานป้องกัน เป้าหมาย

แต่ละกลุ่มจะต้องกำหนดมาตรการและวิธีการใช้แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

ลักษณะงานด้านป้องกัน (Prevention) มี 3 ระดับด้วยกัน คือ

1. การป้องกันขั้นพื้นฐาน (Primary Prevention)

การป้องกันพื้นฐานหรือบางคนเรียกว่าการป้องกันเบื้องต้น หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปิดประตูที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดอย่างถาวร ให้เยาวชนตัดสินใจด้วยตนเองที่จะไม่ใช้ยาเสพติด ไม่คิดจะเสี่ยง ทดลอง เป็นการมุ่งป้องกันคนส่วนใหญ่ของแผ่นดินไม่ให้เข้าไปหายาเสพติดเป็นการป้องกันอย่างถาวร

งานป้องกันขั้นพื้นฐานจึงนับเป็นงานที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ความสำเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ แต่ในขณะเดียวกันเป็นงานที่มีความสลับซับซ้อนทำได้ยาก เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยต่อเนื่องกันไปจนพ้นวัยเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายให้ช่วยกันทำ

2. การป้องกันขั้นที่สอง (Secondary Prevention)

การป้องกันขั้นที่สองนี้ใช้กันในความหมายที่แบ่งเป็น 2 นัย นัยหนึ่ง หมายถึง การป้องกันโดยทางอ้อม ซึ่งหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางไม่ให้ยาเข้าไปสู่คน โดยมีจุดหมายที่เริ่มจากตัวยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลัก ซึ่งตรงกันข้ามกับการป้องกันขั้นพื้นฐานที่มุ่งป้องกันไม่ให้คนเข้าไปหายา ด้วยการมองภาพที่คนเป็นจุดตั้งต้น

ดังนั้น การป้องกันขั้นที่สอง ตามความหมายนี้จึงครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับการปราบปราม ยึดอายัด เผาทำลายยาเสพติด การสกัดกั้น การตรวจเข้ม การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปประจำทำการสอดแนมในโรงเรียน รวมถึงมาตรการตรวจจับ จำแนกเพื่อแยกผู้ใช้ยาเสพติดไปรับการบำบัดรักษาฟื้นฟู หรือป้องกันไม่ให้ผู้ติดยาสามารถเผยแพร่ยาเสพติดไปสู่ผู้ไม่ใช้เสพติดด้วย

ส่วนอีกนัยหนึ่งเป็นความหมายที่มักใช้กันในวงการของผู้มีอาชีพแนะแนว ในความหมายของการดำเนินการช่วยเหลือให้ผู้ที่เคยลองใช้ยาเสพติด หรือผู้ที่ใช้ยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นครั้งคราวหรือใช้บ่อย ๆ แต่ยังไม่ติดยา ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดนั้น ๆ เป็นมาตรการแยกคนออกจากยา หรือดึงคนติดยาออกจากยาเสพติดด้วยมาตรการแนะแนวให้คำปรึกษาและจิตเวชบำบัด เป็นการป้องกันที่เน้นการสกัดกั้นเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของกลุ่มผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้ว

3. การป้องกันขั้นที่สาม (Tertiary Prevention)

การป้องกันขั้นที่สาม คือ การป้องกันการติดซ้ำ (Relapse) เป็นมาตรการที่ใช้สำหรับผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาด้วยการถอนพิษยาแล้วไม่ให้กลับไปติดยาซ้ำใหม่อีก เป็นมาตรการเสริมที่สนับสนุนมาตรการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้หายขาดจากยาแล้วอยู่อย่างปลอดภัยจากยาเสพติดได้ยาวนานขึ้นก่อนที่จะหวนกลับไปติดยาอีก โดยใช้มาตรการทุกชนิดที่มุ่งให้ผู้ติดยาหายจากอาการติดยาทางจิตด้วยมาตรการฟื้นฟูจิตใจ (Rehabilitation) ด้วยวิธีจิตเวชบำบัด (Psychological therapy) การให้คำปรึกษา (Social counseling) กลุ่มบำบัด (Group therapy) และนันทนาการบำบัด (Recreational therapy) เป็นต้น

การป้องกันผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดแล้วไม่ให้กลับไปติดยาใหม่อีก ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการป้องกันที่มุ่งลดความต้องการยาลงด้วยการสกัดกั้นไม่ให้กลับไปใช้ยาอีก ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พวกเขานำยาเสพติดไปเผยแพร่ต่อให้คนอื่นได้ด้วย

สรุปแล้วการป้องกันขั้นพื้นฐาน นั้นเป็นการป้องกันมิให้มีการทดลองใช้ยา การใช้ยาในทางที่ผิดหรือมิให้มีผู้เสพติดรายใหม่ ๆ เกิดขึ้น การป้องกันขั้นที่สองเป็นการเร่งรีบนำผู้ที่ติดยาแล้วไปบำบัดรักษา และการที่จะทำการป้องกันการเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในสาเหตุและองค์ประกอบของปัญหาการเสพติดเสียก่อน องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการติดยานั้น ได้แก่ คน ยา และปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้มีการติดยา การวางแผนแก้ไขและป้องกัน จึงจำต้องศึกษาหาสาเหตุเฉพาะและให้การป้องกันให้ตรงกับสาเหตุหลัก ดังนั้น การป้องกันการเสพติดที่เจาะจงถึงสาเหตุนั้น มีแนวทาง 3 แนวทาง ได้แก่

1. การป้องกันในวงกว้าง เป็นการป้องกันโดยเน้นเป้าหมายที่สังคมโดยทั่วไปมุ่งสร้างสังคมให้ตระหนักถึงพิษและภัยของยาเสพติด ลดความต้องการของสังคม และลดการตอบสนองของยาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานมีหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาสุขภาพ การสร้างเสริมศีลธรรม การใช้กฎหมาย การพัฒนาสังคม ฯลฯ กลวิธีของการป้องกันในแนวกว้าง ได้แก่

1.1 การให้การศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตและการไม่พึ่งพายาเสพติด โดยเน้นถึงการพัฒนาตนเองและจิตใจให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีคุณค่า สร้างสุขนิสัย และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ

1.2 การให้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องของปัญหายาเสพติดเพื่อให้ชุมชนได้วิเคราะห์ เลือกข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

1.3 การจัดกิจกรรมทางเลือก ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นฐานของบุคคลและชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้เวลาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

2. การป้องกันในวงแคบ มุ่งเน้นเฉพาะบุคคลบางกลุ่ม หรือชุมชนบางแห่งที่เสี่ยงต่อปัญหาการเสพติด กลวิธีในการดำเนินงาน การป้องกันในวงแคบ ได้แก่

2.1 การฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแก่กลุ่มแกนนำและกลุ่มประชาชนให้มีความรู้ด้านการป้องกันการเสพติด การใช้ยาในทางที่ถูก โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มแกนนำประยุกต์ความรู้นั้นไปปฏิบัติในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ส่วนกลุ่มประชาชนนั้นให้มีความรู้และมีพฤติกรรมต่อต้านการเสพติดโดยตรง

2.2 การรณรงค์ เป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยการระดมสื่อต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

2.3 การปฏิบัติการทางสังคม เป็นวิธีการที่หวังผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ขจัดแหล่งมั่วสุม กวาดล้างแหล่งผลิต ฯลฯ

3. การป้องกันกรณีพิเศษ เป็นการป้องกันที่เน้นในวงแคบที่สุด โดยเป้าหมายอยู่ที่ผู้ค้าผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และครอบครัว เช่น บุคคลที่กำลังเผชิญกับปัญหาของตนเอง บุคคลที่ครอบครัวแตกแยก ผู้ติดยาที่ผ่านการถอนพิษยามาแล้ว กลวิธีในการป้องกันในกรณีพิเศษนี้ ได้แก่

3.1 การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ผู้ติดยาได้ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาของตนในการติดยา

3.2 การให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นการให้แนวทางปฏิบัติสำหรับเลือกปฏิบัติในกรณีที่เกิดปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด

3.3 การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อลดความกดดันในครอบครัวและให้แนวปฏิบัติแก่ครอบครัวของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อลดปัญหาของตนเอง

3.4 การให้สุขศึกษา เป็นการให้ความรู้เรื่องยาและสุขภาพอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาในทางที่ผิดอีก

3.5 การให้กำลังใจ เพื่อเพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้ติดยาในขณะที่กำลังเผชิญปัญหาที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดอีก

3.6 การฝึกอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามความสามารถและความถนัดของตนเป็นการลดความกดดันด้านเศรษฐกิจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การป้องกันสิ่งเสพติดในชุมชนดังกล่าว มีทั้งในวงกว้างและในวงแคบ ซึ่งการป้องกันมิใช่เพียงหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน/องค์กร หรือจากบุคคลทุกระดับเข้ามามีส่วนนร่วมในการป้องกัน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของครอบครัวและคนในชุมชนนั้น ๆ เองที่จะร่วมกันในการป้องกันการติดสารเสพติด

กลวิธีทุกอย่างสามารถนำไปปฏิบัติพร้อม ๆ กันได้หลายกลวิธีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันในระดับไหน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิด หรือป้องกันการติดซ้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาการติดสารเสพติด ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง

เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาสเพติดที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และความปอลดภัยของประชาชน โดยการมีกฎหมายที่ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด ป้องกันอาชญากรรม สร้างสังคมปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีการใช้ พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรบ้าง
- ผู้เรียนร่วมอธิบายถึงความหมายของยาเสพติดเบื้องต้นตามกฎหมาย พร้อมบอกรายละเอียดถึงบทลงโทษทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

เหตุใดประเทศไทยของเราจึงมีการประกาศใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564

เนื้อหาสาระ

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดได้ให้ความหมายของคำว่ายาเสพติดไว้ ดังนี้

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย

“ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึง ยาสามัญประจำบ้านบางตำรับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยยา



รูปภาพที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

"วัตถุออกฤทธิ์" หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์

"สารระเหย" หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายหรือจิตใจซึ่งทำให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีการออกพระราชบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายฉบับ ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ คือ

เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง จึงได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้จำเป็นต้องกำหนดให้มีระบบอนุญาตเพื่อให้การควบคุมและการใช้ประโยชน์ ยาเสพติดในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดและการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การเสพติดยาเสพติด ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายยาเสพติดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกำหนดให้มีระบบคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความหลากหลายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามและควบคุมยาเสพติด และรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ดังนี้

1.1 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด

1.1.1 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564

1.1.2 ประมวลกฎหมายยาเสพติด

1.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

1.3 พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2565

2. บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด

2.1 บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
การผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน15 ปี และปรับไม่เกิน 1,500,000 บาท	ม.90 ม.145 วรรคหนึ่ง ม.34 ม.35
การผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เป็นการกระทำ ดังต่อไปนี้ (1) การกระทำ เพื่อการค้า (2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน (3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ (5) การกระทำ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (6) การกระทำ โดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ	จำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท	ม.90 ม.145 วรรคสอง ม.34 ม.35
การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตที่เป็นการกระทำ ดังต่อไปนี้ (1) การกระทำ โดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการ หรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอาชญากรรม (2) การทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป	ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต	ม.90 ม.145 ม.34 ม.35
การนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก	ปรับครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท	ม.136 ม.36
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.107 ม.164
การเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1	จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.104 ม.162 ม.113 ม.114

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.106 ม.171 วรรคหนึ่ง
การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี และ ปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท	ม.106 ม.171 วรรคสอง
การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 5,000,000 บาท	ม.106 ม.171 วรรคสาม
-โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาต -เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการ โฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา	- จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ - ต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	ม.137 ม.37

2.2 บทกำหนดโทษ ยาเสพติดในประเภทที่ 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท	ม.34, ม.35, ม.91, ม.146 วรรคหนึ่ง
การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ (1) การกระทำเพื่อการค้า (2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม ประชาชน (3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน18 ปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถาน อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ (5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ	จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท - 1,500,000 บาท	ม.34 ม.91 ม.146 วรรคสอง
นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวใน แต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก	ปรับไม่เกิน 5,000 บาท	ม.136 ม.36
การผลิต นำเข้า หรือ ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ปลอม	จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท	ม.52 ม.142 วรรคหนึ่ง
จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ปลอม	จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท	ม.52 ม.142 วรรคสอง
การผลิต นำเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผิดมาตรฐาน	จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.53 ม.143 วรรคหนึ่ง
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผิดมาตรฐาน	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.53 ม.143 วรรคสอง
การนำเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เสื่อมคุณภาพ	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.54 ม.144 วรรคหนึ่ง

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
จำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เสื่อมคุณภาพ	จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.54 ม.144 วรรคสอง
การผลิต หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ	ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท	ม.95 ม.150
การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อเสพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.107 ม164
เสพยาเสพติด	จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.104 ม.162 ม.113 ม.114
การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.106 ม.171 วรรคหนึ่ง
การจูงใจ ชักนำยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิด ด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท	ม.106 ม.171 วรรคสอง
การจูงใจ ชักนำยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดย เป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคล อายุไม่เกิน18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจ ให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำ ความผิดทางอาญา	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท - 5,000,000 บาท	ม.106 ม.171 วรรคสาม
ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สูญหายหรือมีการนำไปใช้ในทางไม่ชอบ	ปรับไม่เกิน 50,000 บาท	ม.135 ม.33 (2)
-โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต -เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับ ผู้โฆษณา	-จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	ม.137 ม.37

2.3 บทกำหนดโทษ ยาเสพติดในประเภทที่ 3 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	**บทกำหนดโทษ**	**มาตราที่เกี่ยวข้อง**
ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท	ม.35 (2) ม.92 ม.147
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้ อยู่ประจำควบคุมกิจการ	ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท	ม.95 ม.150
ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท	ม.52 ม.142 วรรคหนึ่ง
ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ปลอม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท	ม.52 ม.142 วรรคสอง
ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.53 ม.143 วรรคหนึ่ง
ผู้ใดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ผิดมาตรฐาน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.53 ม.143 วรรคสอง
ผู้ใดนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.54 ม.144 วรรคหนึ่ง
ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.54 ม.144 วรรคสอง
ผู้ใดแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาเสพติด ให้โทษในประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท	ม.49 วรรคสอง, ม.158
ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตหรือ นำเข้าตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ไม่ตรงตามรายการที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้	ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท	ม.49 ม.101 ม.159

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ	ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.49 ม.102 ม.160
ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท	ม.51 ม.103 ม.161 วรรคหนึ่ง
ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท	ม.51 ม.103 ม.161วรรคสอง
ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 นำเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก	ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท	ม.36 ม.136
ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.37 ม.137 วรรคหนึ่ง
เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.37 ม.137 วรรคสอง
ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ต้องรับโทษปรับรายวันด้วย	ต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	ม.37 ม.137 วรรคสาม

2.4 บทกำหนดโทษ ยาเสพติดในประเภทที่ 4 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท	ม.34 ม.91 ม.146 วรรคหนึ่ง
การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำดังต่อไปนี้	จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท - 1,500,000 บาท	ม.34 ม.91 ม.146 วรรคสอง

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
(1) การกระทำเพื่อการค้า (2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม ประชาชน (3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน18 ปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ (5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ		
นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวใน แต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก	ปรับไม่เกิน 5,000 บาท	ม.136 ม.36
โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต - เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการ โฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับ ผู้โฆษณา	- จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ - ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	ม.137 ม.37

2.5 บทกำหนดโทษ ยาเสพติดในประเภทที่ 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต	ต้องระวางโทษไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท	ม.35 (4) หรือวรรคสอง ม.93 ม.148
ถ้าการกระทำความผิดเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ (1) การกระทำเพื่อการค้า (2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในประชาชน (3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนา หรือสถานที่ราชการ (5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท	
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5	ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.104 ม.162

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดชักจูง ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำ ผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยวิธีประการอื่นใดให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5	ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.106 ม.171
ถ้าการกระทำความผิดได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป	ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1,500,000 บาท	ม.171
ถ้าการกระทำความผิดเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา	ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท	
ผู้ใดใช้อุบายล่อลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำ ผิดศีลธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐาน ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5	ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น	ม.128
โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต	จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.37 ม.137
เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา	ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง	
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อเสพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.107 ม.164
ผู้ใดผลิต นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ปลอม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.52 ม.142
ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ปลอม	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท	
ผู้ใดผลิต นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผิดมาตรฐาน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.53 ม.143

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผิดมาตรฐาน	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.143
ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เสื่อมคุณภาพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.54 ม.144
จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เสื่อมคุณภาพ	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	
ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 สูญหาย หรือมีการนำไปใช้โดยมิชอบ	ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท	ม.33(2) ม.135
ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยายาเสพติดให้โทษประเภท 5 นำเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งโดยอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก	ต้องระวางโทษปรับ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท	ม.36 ม.136
ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ในระหว่างที่เภสัชกรไม่ได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ	ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท	ม.95 ม.150

2.6 บทกำหนดโทษ สารระเหย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า สารระเหยไม่จัดให้มีภาพเครื่องหมายหรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือ หีบห่อที่บรรจุสารระเหยก่อนนำออกจำหน่าย	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.97 ม.154
จำหน่ายสารระเหยโดยไม่มีภาพเครื่องหมาย หรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามกฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.98 ม.155
จำหน่ายสารระเหยหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลที่อายุไม่เกิน 18 ปี เว้นแต่เป็นการจำหน่ายหรือจัดหาโดยสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.99 ม.156

ลักษณะความผิด	บทกำหนดโทษ	มาตราที่เกี่ยวข้อง
จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย	จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.100 ม.157 วรรคหนึ่ง
จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี	จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.100 ม.157 วรรคสอง
เสพสารระเหย	จำคุกไม่เกิน1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.105 ม.163
ชักนำ ยุยง ส่งเสริมให้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจให้ผู้อื่นเสพสารระเหย	จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.106 ม.173 วรรคหนึ่ง
ชักนำ ยุยง ส่งเสริมให้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจให้หญิงหรือบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี เสพสารระเหย หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจ ให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญาหรือ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา	จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ	ม.106 ม.173 วรรคสอง

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 8 ผลกระทบจากสารเสพติด

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบและ การแพร่ระบาดของสารเสพติด



กิจกรรม

สาเหตุและผลกระทบของการติดสารเสพติดให้โทษ มีดังนี้

สาเหตุของการติดสารเสพติดให้โทษ ได้แก่ สาเหตุทางด้านบุคคล สาเหตุจากตัวยาหรือสารเสพติด และสาเหตุจากสภาพแวดล้อม

ผลกระทบและโทษภัยของสารเสพติด ได้แก่ ผลกระทบต่อตัวผู้เสพ ผลกระทบต่อครอบครัว ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อประเทศชาติ

เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมในการป้องกันสิ่งเสพติดในชุมชน



กิจกรรม

การมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพติด ยกตัวอย่างเช่น

1. การให้การศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ในการสร้างคุณภาพชีวิตและการไม่พึ่งพายาเสพติด โดยเน้นถึงการพัฒนาตนเองและจิตใจให้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีคุณค่า สร้างสุขนิสัย และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ

2. การให้ข้อมูลและข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องของปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนได้วิเคราะห์ เลือกข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

3. การจัดกิจกรรมทางเลือก ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นฐานของบุคคลและชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้เวลาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการช่วยพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

4. การฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแก่กลุ่มแกนนำและกลุ่มประชาชนให้มีความรู้ ด้านการป้องกันการเสพติด การใช้ยาในทางที่ถูก โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มแกนนำประยุกต์ความรู้นั้นไปปฏิบัติในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ส่วนกลุ่มประชาชนนั้นให้มีความรู้และมีพฤติกรรมต่อต้านการเสพติดโดยตรง

5. การรณรงค์ เป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยการระดมสื่อต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

6. การให้กำลังใจ เพื่อเพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้ติดยาเสพติดในขณะที่กำลังเผชิญปัญหาที่อาจนำไปใช้ในทางที่ผิดอีก

เรื่องที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด



กิจกรรม

1. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน
3. การป้องกันอาชญากรรมและความรุนแรงในสังคม
4. การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
5. การตอบสนองต่อปัญหาค้ามนุษย์และการค้ายาเสพติดข้ามประเทศ
6. การบำบัดและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
7. การป้องกันและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

บทที่ 9
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

สาระสำคัญ



"อากาศ" ถือเป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานทางกายภาพเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ เมื่ออากาศเต็มไปด้วยมลพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซอันตรายและฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทำร้ายระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และเยื่อบุนัยน์ตา จมูก รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมีความรู้ที่ถูกต้องจะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายความหมายสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งบอกค่าดัชนีคุณภาพอากาศอันตรายและวิธีป้องกันตนเองและครอบครัวจากฝุ่น PM 2.5 ได้
2. อธิบายความหมายสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

เรื่องที่ 1 มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิด ฝุ่น PM 2.5 การมีความรู้ที่ถูกต้องจะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมความคิด อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ดังต่อไปนี้

1. ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร และสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5
2. การวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ
3. อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 และวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5



เนื้อหาสาระ

ปัจจุบันอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงตามเมืองสำคัญต่าง ๆ เต็มไปด้วยฝุ่นมลพิษมากขึ้น ซึ่งค่ามลภาวะทางอากาศของประเทศสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ฝุ่น PM 2.5 คือ PM 2.5 ย่อมาจาก Particulate Matters 2.5 หมายถึง ฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร (ไมครอน) ซึ่งด้วยขนาดอนุภาคที่เล็กมาก ๆ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ถ้ามีปริมาณสูงมาก ก็จะดูคล้ายหมอกหรือควัน

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ (Combustion particles) จากที่ต่าง ๆ เช่น

- ◉ ท่อไอเสียรถยนต์ หรือเครื่องยนต์
- ◉ ควันบุหรี่ ควันธูป
- ◉ การเผาขยะ เผาป่า เผาหญ้า
- ◉ การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงาน หรือ เชื้อเพลิงในครัวเรือน

ด้วยขนาดที่เล็กมาก ๆ ของฝุ่น PM 2.5 ทำให้สามารถลอดผ่านกลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง ขนจมูก เยื่อเมือกในหลอดลม รวมไปถึงเซลล์ที่ทำหน้าที่ดักจับสิ่งแปลกปลอมในถุงลมเข้าสู่ถุงลมปอด และซึมเข้ากระแสเลือด ทำให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้

ผลเสียต่อร่างกาย

1. ภายนอกร่างกาย

1. ผิวหนัง

1.1 เกิดผิวหนังอักเสบ ระคายเคืองผิว ผื่นแดงคัน

1.2 ซึมผ่านเข้ารูขุมขน เกิดผิวหน้ามันขึ้น และทำให้เกิดการอัดตันของรูขุมขน เกิดสิว

1.3 ฝุ่นที่ซึมผ่านเข้าสู่ชั้นผิวหนัง จะเกิดการอักเสบ และกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระที่ทำลายผิว ทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรและจุดด่างดำ

2. ภายในร่างกาย

ระบบการหายใจ

เกิดการอักเสบที่เยื่อบุทางเดินหายใจ ตั้งแต่โพรงจมูกจนถึงปลายสุดของถุงลม ทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบการหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หรือ โรคหอบหืด จะเกิดการกำเริบของโรคได้ง่ายขึ้น และรุนแรงมากขึ้น คือ ภูมิแพ้กำเริบ แสบจมูก แสบตา มีน้ำมูก คัดจมูก หลอดลม อักเสบ ไอ หรือโรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพองกำเริบ ไอ หอบเหนื่อย และหายใจลำบาก มีเสียงหายใจดังจากหลอดลมตีบ ส่วนผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวดังกล่าว สามารถแสดงอาการเช่นเดียวกันได้ หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นระยะเวลานาน สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดได้สูงขึ้น รวมถึงสามารถเข้าไปทำลายปอดของเด็กได้ง่ายกว่าปกติ

ระบบหลอดเลือด

นอกจากนี้ ฝุ่น PM 2.5 ที่เข้าสู่กระแสเลือด จะทำให้เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือด ในระยะยาวส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายจากเส้นเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบ

การป้องกันตัวจาก PM 2.5 ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่มีการดึง PM 2.5 ออกจากร่างกายได้ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้มลพิษร้ายเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นการรักษาที่ดีที่สุด

การดูแล ป้องกันตนเอง ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรอยู่ในบ้านหรืออาคารที่มีเครื่องฟอกอากาศ
- สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ เช่น หน้ากาก N95 เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน
- ควรทำความสะอาดผิว ล้างหน้าให้สะอาดทันทีหลังจากที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นมลพิษ
- สวมเสื้อแขนยาว เพื่อปกป้องผิวไม่ให้ระคายเคือง
- ทาครีมบำรุงผิว เพื่อให้ความชุ่มชื้นและทำให้เกราะป้องกันผิวแข็งแรงขึ้น
- พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผลไม้หรือวิตามินที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี ดื่มน้ำสะอาด เพื่อช่วยในการขับสารพิษจากร่างกาย

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษหรือฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นได้หรือไม่แน่ใจ การป้องกันตนเองได้ผลหรือไม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีอาการ เช่น หายใจลำบาก หน้ามืด อ่อนแรง หรือไอติดต่อกันรุนแรง เป็นต้น ควรรีบพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความผันแปรตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น การศึกษาถึงสาเหตุ ผลกระทบ จะช่วยให้เกิดผลกระทบได้น้อยลง



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. ช่วยกันแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดได้อย่างไร
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อสัตว์ต่าง ๆ อย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ให้ผู้เรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร
2. ให้ผู้เรียนอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. ให้ผู้เรียนอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



เนื้อหาสาระ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบของสภาพอากาศในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์โดยส่วนใหญ่ สาเหตุหลักมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีลักษณะเหมือนผ้าห่มคลุมโลกไว้ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงไม่ระบายออกและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ก๊าซเหล่านี้เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์หรือการเผาถ่านหิน เพื่อทำความร้อนในอาคาร เป็นต้น การเตรียมที่ดินและแผ้วถางป่าก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นกัน ส่วนหลุมฝังกลบขยะนั้นเป็นแหล่งก๊าซมีเทนขนาดใหญ่ ภาคพลังงาน อุตสาหกรรม การขนส่ง อาคารการเกษตร และการใช้ที่ดิน ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซ

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจะทำให้สภาพอากาศและสมดุลทางธรรมชาติแปรปรวน ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งหมดบนโลก ดังนี้

1. อุณหภูมิสูงขึ้น

เมื่อความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น อุณหภูมิพื้นผิวของโลกก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย เกือบทุกภูมิภาคบนโลกต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนมากขึ้น อุณภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน และทำให้การทำงานหรือการเดินทางลำบากขึ้น ไฟป่าก็จะเกิดง่ายขึ้น และลุกลามเร็วกว่าเดิม อุณหภูมิในบริเวณขั้วโลกเหนือสูงขึ้นด้วย

2. พายุรุนแรงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลต่อปริมาณฝน โดยทำให้เกิดพายุที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและชุมชน

3. ภัยแล้งสาหัสขึ้น

หลายภูมิภาคเริ่มขาดแคลนน้ำ ความแห้งแล้งจะยิ่งทำให้พายุฝุ่นและพายุทรายรุนแรงมากขึ้นจนอาจพัดพาทรายปริมาณหลายพันตันข้ามทวีปได้ ทะเลทรายที่ขยายตัวทำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดลง ผู้คนมากมายไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

4. น้ำทะเลร้อนและสูงขึ้น

มหาสมุทรต้องดูดซับความร้อนส่วนใหญ่อันเกิดจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้น้ำแข็งละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นภัยต่อชุมชนริมชายฝั่งและบนเกาะต่าง ๆ นอกจากความร้อนแล้วมหาสมุทรยังต้องดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ จนทำให้น้ำทะเลเป็นกรดและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล

5. สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งบนบกและในน้ำ ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น ภัยธรรมชาติก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะไฟป่า สภาพภูมิอากาศที่สุดขั้ว หรือการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชและโรคระบาด สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจย้ายถิ่นอาศัยเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่บางชนิดก็ไม่สามารถทำได้ ขณะนี้โลกกำลังสูญเสียสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ในอัตราที่เร็วกว่าช่วงเวลาใด ๆ ที่เคยบันทึก

ไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ถึง 1,000 เท่า สิ่งมีชีวิตกว่า 1 ล้านชนิดเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ภายในไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

6. อาหารขาดแคลน

สภาพอากาศที่แปรปรวนและรุนแรงซ้ำเติมปัญหาความอดอยาก และภาวะทุพโภชนาการตลอดจนสร้างความเสียหายต่อการประมง การเพาะปลูก และปศุสัตว์ เพราะความร้อนทำให้แหล่งน้ำแห้งและพื้นที่ทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ลดลง มหาสมุทรที่เป็นกรดมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลที่ใช้หล่อเลี้ยงผู้คนหลายพันล้านคน การเปลี่ยนแปลงของหิมะและน้ำแข็งในบริเวณขั้วโลกเหนือส่งผลกระทบอย่างหนักต่อปริมาณอาหารที่มาจากการเลี้ยงปศุสัตว์ การล่าสัตว์ และการประมง ความร้อนที่สูงยังทำให้ปริมาณน้ำและทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์หดหาย กระทบต่อปริมาณพืชผล และปศุสัตว์

7. ปัญหาสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น เช่น โรคมาลาเรีย ส่งผลให้ผู้คนเจ็บป่วยเสียชีวิตจำนวนมากจนระบบสุขภาพไม่อาจรองรับได้ ส่วนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูก หรือหาอาหารได้เพียงพอ ผู้คนก็ต้องเผชิญผลเสียต่อสุขภาพในด้านอื่นด้วย เช่น ความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการเป็นต้น

วิธีลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยการดำเนินการ 10 อย่าง ต่อไปนี้

• ประหยัดพลังงานที่บ้าน : เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ซักผ้าด้วยน้ำเย็น หรือตากผ้าแทนการใช้เครื่องอบผ้า

• เดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะ : จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแรงอีกด้วย หากคุณต้องเดินทางไกล ลองเปลี่ยนมาโดยสารรถไฟหรือรถประจำทาง และติดรถไปกับผู้อื่นเมื่อทำได้

• รับประทานผักให้มากขึ้น : แค่รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช และลดเนื้อสัตว์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากนมให้น้อยลง ก็สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก โดยทั่วไปกระบวนการผลิตอาหารที่มาจากพืชจะสร้างก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า

• เลือกวิธีเดินทาง : การนั่งเครื่องบินให้น้อยลงเป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากทำได้ควรนัดพบกันในทางออนไลน์หรือขึ้นรถไฟแทน

• รับประทานอาหารให้หมด : การทิ้งอาหารที่เหลือเป็นการสูญเสียทรัพยากรและพลังงานที่ใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยง ผลิต บรรจุ และขนส่งอาหารนั้น ๆ และอาหารที่บูดเน่าอยู่ในบ่อขยะ ก็จะปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงมาก ดังนั้น ควรรับประทานอาหารให้หมด และส่วนที่เหลือใช้หมักทำปุ๋ย

• ลด ใช้ซ้ำ ซ่อมแซม และรีไซเคิล : อุปกรณ์ไฟฟ้า เสื้อผ้า และสินค้าอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ณ จุดใดจุดหนึ่งของการผลิต ตั้งแต่การหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต และการขนส่งสินค้าสู่ตลาด เราสามารถช่วยรักษาสภาพอากาศของเราด้วยการซื้อของให้น้อยลง ซื้อของมือสอง ทำการซ่อมหากซ่อมได้ และรีไซเคิล

• เปลี่ยนแหล่งพลังงานในบ้าน : เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสีเขียว เช่น ลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ หรือติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน

• เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า : ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้แก๊สหรือดีเซล

• เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : ทุกการใช้จ่ายส่งผลกระทบต่อโลกทั้งสิ้น ควรเลือกสนับสนุนสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เลือกซื้ออาหารตามฤดูกาลที่ผลิตในท้องถิ่น เลือกผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย

• เป็นกระบอกเสียง : ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรียกร้องให้ผู้นำท้องถิ่นและระดับโลกเห็นความสำคัญและรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลัก คือ การกระทำของมนุษย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยร่วมกันประหยัดพลังงาน เลือกรับประทานอาหารจากพืชผัก การรับประทานอาหารให้หมด และอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการร่วมกันรักษาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวคำตอบ
บทที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

เรื่องที่ 1 มลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5



กิจกรรม

1. ฝุ่น PM 2.5 คืออะไร และสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งเล็กมากจนขนจมูกไม่สามารถกรองได้ ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น:

- การเผาไหม้เชื้อเพลิง: จากเครื่องยนต์ดีเซล, รถยนต์, และมอเตอร์ไซค์
- การเผาขยะและการเกษตร: การเผาขยะในที่โล่งและการเผาเพื่อทำการเกษตร
- ไฟป่าและการก่อสร้าง: การเกิดไฟป่าและการก่อสร้างอาคาร
- โรงงานอุตสาหกรรม: การผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไม่สะอาด

2. การวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

การวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลัก ค่า AQI จะแบ่งออกเป็นหลายระดับเพื่อเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น:

- ดี: AQI 0-50
- ปานกลาง: AQI 51-100
- ไม่ดีสำหรับกลุ่มเสี่ยง: AQI 101-150
- ไม่ดี: AQI 151-200
- อันตราย: AQI 201-300
- อันตรายมาก: AQI 301-500

3. อันตรายจากฝุ่น PM 2.5 และวิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5

ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและหัวใจ เนื่องจากสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ได้ อันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ได้แก่:

- โรคทางเดินหายใจ: เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง
- โรคหัวใจ: เช่น หัวใจขาดเลือด
- มะเร็ง: องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า PM 2.5 เป็นสารก่อมะเร็ง

วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5

- สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น: ใช้หน้ากากที่มีคุณภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5
- ใช้เครื่องฟอกอากาศ: ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5
- หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี: หลีกเลี่ยงการออกไปในพื้นที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 สูง

- ลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงฝุ่นหนาแน่น: ลดการออกกำลังกายหรือกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 สูง

เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)



กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. ให้ผู้เรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคืออะไร

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและรูปแบบของสภาพอากาศซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสมดุลของธรรมชาติ

2. ให้ผู้เรียนอธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    1. การผลิตพลังงาน
    2. การตัดไม้ทำลายป่า
    3. การคมนาคมขนส่ง
    4. การผลิตอาหาร
3. ให้ผู้เรียนอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    1. อุณหภูมิสูงขึ้น
    2. พายุรุนแรงขึ้น
    3. ปัญหาสุขภาพ
    4. สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์
4. ให้ผู้เรียนอธิบายลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
    1. ลดการตัดไม้ทำลายป่า
    2. เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
    3. เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน
    4. บริโภคอย่างพอดีเพื่อลดปริมาณขยะ

บทที่ 10
กิจกรรมทางกายและกีฬา

สาระสำคัญ



การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว หัวใจและปอดแข็งแรง ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดี ส่งผลให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ทำงานดี เช่น เอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อแข็งแรง ประชาชนทุกเพศวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมทางกายมีหลากหลาย ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนได้อีกด้วย

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายประเภทกิจกรรมทางกายและกีฬาได้
2. ปฏิบัติตน ตามกฎ กติกา ระเบียบและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เล่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
3. อธิบายวิธีการเล่นกีฬา การป้องกัน และนำไปใช้ในการเล่นกีฬาและกิจกรรมทางกายได้
4. เล่นกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน
เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องที่ 3 กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
เรื่องที่ 4 กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 5 กีฬาบาสเกตบอล

เรื่องที่ 1 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนผ่านกิจกรรมทางกายมีความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่ไม่ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรมทางกายสามารถช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลดีต่อสมาธิ การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กด้วย



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ในชุมชนของผู้เรียนมีกิจกรรมทางกายอะไรบ้าง และเคยได้ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร มีผลดีต่อสุขภาพของตนเองอย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้



กิจกรรม

ร่วมกันอภิปรายกลุ่ม

1. กิจกรรมทางกายมีประโยชน์อะไรบ้างต่อสุขภาพ
2. ในชุมชนของคุณมีกิจกรรมทางกายอะไรบ้างที่คนในชุมชนสามารถเข้าร่วมได้



เนื้อหาสาระ

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เกิดขึ้นในชุมชน จึงเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันพบว่า คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด โดยการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตดังกล่าวเป็นหลัก

คนไทยมีความคุ้นเคยกับคำว่า “ออกกำลังกาย” มาช้านาน โดยความหมายของ “การออกกำลังกาย” (Exercise) คือ การกระทำใด ๆ ที่ทำให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแบบซ้ำ ๆ มีแบบแผน หรือกติกา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อสังคมและเพื่อความสนุกสนาน

ในขณะที่ประชาคมโลก รวมถึงสังคมไทยสมัยใหม่รับรู้ความหมาย “กิจกรรมทางกาย” (Physical Activity) ที่กว้างกว่าการออกกำลังกาย กล่าวคือ กิจกรรมทางกาย มีความหมายครอบคลุมถึงการขยับ

เคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ในอิริยาบทต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงานโดยกล้ามเนื้อ อันรวมทั้งการออกกำลังกาย การทำงาน การเดินทาง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ โดยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา ปานกลาง และหนัก

ทั้งนี้ พึงระลึกว่า การมีกิจกรรมทางกาย ไม่ว่าจะมีระยะเวลา รูปแบบ หรือความหนักเบาแค่ไหน ย่อมดีกว่าไม่มีกิจกรรมทางกายหรือมีแต่พฤติกรรมเนือยนิ่ง



ดังนั้น การขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถและการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง จึงเป็นแนวคิดสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน เนื่องจากพบว่า โรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไม่ใช่โรคติดเชื้อ แต่เรากำลังเผชิญกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง รวมถึงโรคหลอดเลือดและโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคดังกล่าว คือ

- การกินอาหารไม่ถูกต้อง เช่น หวาน มัน เค็ม มากเกินไป
- การขาดการออกกำลังกาย
- การสูบบุหรี่
- การดื่มแอลกอฮอล์

1. ความหมายของกิจกรรมทางกาย (Physical activity)

กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้มากพอจนมีการใช้พลังงานมากกว่าขณะนั่ง นอนนิ่ง ๆ เช่น การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน และการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ซึ่งจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง

2. กิจกรรมทางกาย ทำแค่ไหนจึงจะพอดี

พลังงานที่ร่างกายใช้ขณะนั่ง นอนนิ่ง ๆ โดยทั่วไปร่างกายจะใช้พลังงาน 1 เม็ท (MET) ต่อนาที ทั้งนี้ เราควรมีกิจกรรมทางกายเพื่อใช้พลังงาน อย่างน้อย 600 - 1,200 METs ต่อสัปดาห์ แต่หากต้องการออกกำลังกายให้แข็งแรง ควรมีกิจกรรมทางกาย 3,000 - 4,000 METs ต่อสัปดาห์

ลองมาคำนวณดูว่า สัปดาห์นี้ เราใช้พลังงานไปกี่เม็ท (MET)

พลังงานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม ต่อ 1 ชั่วโมง มีดังนี้



กระโดดเชือก ใช้พลังงาน 660 METs ต่อ ชั่วโมง



รีดผ้าหรือล้างจาน ใช้พลังงาน 108 METs ต่อ ชั่วโมง



ซ่อมแซมบ้าน ใช้พลังงาน 360 METs ต่อ ชั่วโมง



ปั่นจักรยาน (ความเร็วปานกลาง) ใช้พลังงาน 450 METs ต่อ ชั่วโมง



นั่งนิ่ง หรือ นอนหลับ ใช้พลังงาน 1 METs ต่อ 1 นาที ชั่วโมงละ 60 METs



ทำอาหารหรือเลี้ยงเด็กเล็ก 120 METs ต่อ ชั่วโมง



วิ่งเหยาะ (ความเร็วปานกลาง) ใช้พลังงาน 480 METs ต่อ ชั่วโมง



กวาดบ้านหรือดูดฝุ่น ใช้พลังงาน 198 METs ต่อ ชั่วโมง



วิ่งช้า ๆ หรือเดินเร็ว ใช้พลังงาน 360 METs ต่อ ชั่วโมง



เดินขึ้นบันได ใช้พลังงาน 300 METs ต่อ ชั่วโมง



ตัดหญ้า ใช้พลังงาน 330 METs ต่อ ชั่วโมง

3. ประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย

3.1 ประโยชน์ทางสังคม ทำให้มีเพื่อนมีการพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มทักษะทางสังคม มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น

3.2 ประโยชน์ต่อจิตใจ ลดความวิตกกังวล ซึมเศร้า เครียด ปรับปรุงอารมณ์ เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง มีสมาธิดีขึ้น และเพิ่มความรู้สึกดีในชีวิตประจำวัน

3.3 ประโยชน์ต่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก การทำกิจกรรมที่ใช้แรงสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก

4. มาออกกำลังกายกันดีกว่า

กิจกรรมทางกายที่มีเป้าหมายเพื่อการออกกำลังที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ควรออกกำลังกายทั้งสองรูปแบบ คือ แบบเพิ่มความแข็งแรงและแบบเพิ่มความทนทาน โดยหากออกกำลังกายเพียงพอจะทำให้หัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อมีความทนทานไม่เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อไม่ล้าง่าย สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้นานขึ้น รวมทั้งลดการบาดเจ็บ เช่น กล้ามเนื้อตึง ปวด เอ็นยึดฉีกขาดได้ง่าย ซึ่งพบได้บ่อยมากขึ้นในผู้ที่นั่งนาน ๆ หรือทำงานในท่าเดิม ๆ เป็นเวลานาน ที่เรียกว่า โรคออฟฟิศซินโดรม

5. แนวทางการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพที่ดี จะต้องทำอย่างสมดุล ไม่น้อยหรือมากเกินไปให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ และอวัยวะสำคัญได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการออกกำลังกายที่สมดุลได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หมายถึง การออกกำลังกายสู้กับแรงต้านด้วยแรงต้านที่มากแต่จำนวนครั้งที่ทำน้อย โดยมักทำในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งแขน ขา และลำตัว

2) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน หมายถึง การออกกำลังกายที่มีแรงต้านด้วยแรงต้านที่น้อยแต่จำนวนครั้งที่ทำจะมาก โดยจะไปเพิ่มความทนทานให้แก่หัวใจและกล้ามเนื้อ

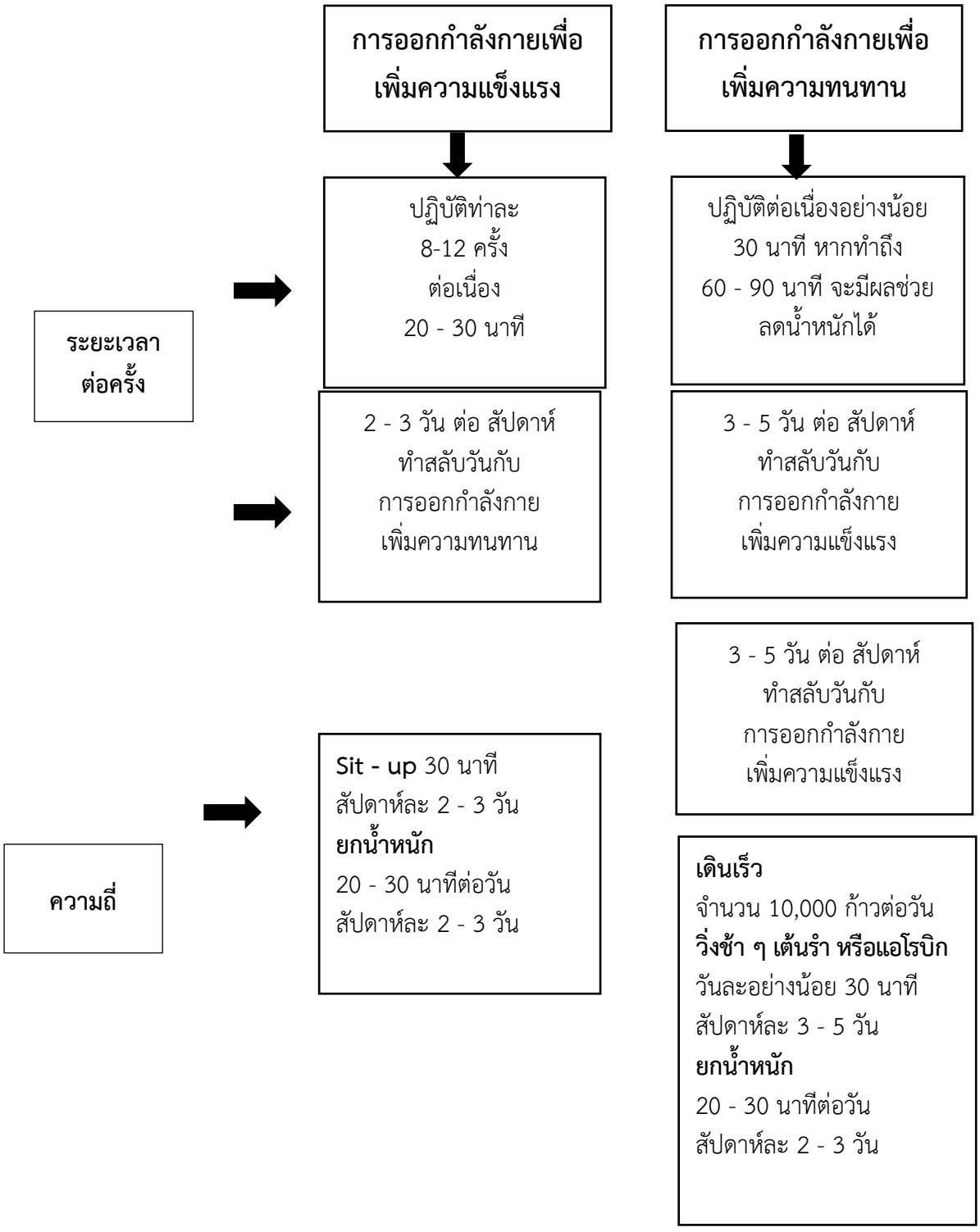
กิจกรรมในกลุ่มเพิ่มความแข็งแรง ได้แก่

- ยกน้ำหนัก
- โหนบาร์
- ลุก - นั่ง (Sit up)
- weight training

กิจกรรมในกลุ่มเพิ่มความทนทาน ได้แก่

- เดิน/วิ่งช้า ๆ
- การออกกำลังกายในน้ำ
- การเต้นจังหวะช้า ๆ
- การปั่นจักรยาน

} โดยออกกำลังในระดับที่ขณะออกกำลังกายยังสามารถพูดจาโต้ตอบกันได้


การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน
ระยะเวลาต่อครั้ง
ปฏิบัติท่าละ 8-12 ครั้ง ต่อเนื่อง 20 - 30 นาที
ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที หากทำถึง 60 - 90 นาที จะมีผลช่วยลดน้ำหนักได้
2 - 3 วัน ต่อ สัปดาห์ ทำสลับวันกับการออกกำลังกายเพิ่มความทนทาน
3 - 5 วัน ต่อ สัปดาห์ ทำสลับวันกับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
3 - 5 วัน ต่อ สัปดาห์ ทำสลับวันกับการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
ความถี่
Sit - up 30 นาที สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน
ยกน้ำหนัก 20 - 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน
เดินเร็ว จำนวน 10,000 ก้าวต่อวัน
วิ่งช้า ๆ เต้นรำ หรือแอโรบิก วันละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 - 5 วัน
ยกน้ำหนัก 20 - 30 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน

6. ขั้นตอนการออกกำลังกาย

1) ก่อนออกกำลังกาย ต้องอบอุ่นร่างกาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อประมาณ 5 - 10 นาที



ภาพคนยืดเหยียด

2) ขณะออกกำลังกาย ให้ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสลับกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานโดยทำสลับวันกัน



ภาพคนวิ่ง/คนยกน้ำหนัก

3) ระหว่างออกกำลังกาย ฝึกการหายใจร่วมด้วยโดยทำเป็นช่วง ๆ จะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นไม่เหนื่อยเร็ว โดยสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ให้ท้องพอง กลั้นไว้ แล้วจึงค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกจนหมดให้ ท้องแฟบ ทำเช่นนี้เป็นจังหวะต่อเนื่อง จะช่วยให้ปอดรับออกซิเจนเข้าไปได้เต็มที่

4) หลังการออกกำลังกาย เมื่อออกกำลังกายนานและหนักเพียงพอจนครบระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ค่อย ๆ ลดการออกกำลังกายให้ช้าลง เบาลง เพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ไม่ควรหยุดทำทันที ซึ่งอาจเป็นอันตราย เช่น หน้ามืด วิงเวียน ควรปฏิบัติต่อไปช้า ๆ ประมาณ 5 - 10 นาที

5) การคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย ให้ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัก ๆ เช่น ยืดขา แขน หลัง คอ ฯลฯ ต่อเนื่องอีก 5 - 10 นาที จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย สดชื่น นอนหลับสบายหรือปฏิบัติภารกิจต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การฝึกหายใจดีอย่างไร

- ลดอัตราการเต้นของหัวใจ
- ลดความดันโลหิต
- เพิ่มระดับความทนต่อความปวด
- ผ่อนคลายความตึงเครียด
- ลดอัตราการอยากสูบบุหรี่

ดังนั้น การฝึกหายใจให้ถูกวิธี จะเป็นประโยชน์ต่อระบบร่างกายภายใน ซึ่งขั้นตอนวิธีการฝึกหายใจ มีดังนี้

วิธีการฝึกการหายใจ

1. การฝึกหายใจทำได้ทั้งขณะนั่งหรือนอนหงาย
2. ใช้มือวางบริเวณใต้ลิ้นปี่ (บริเวณกระบังลม)
3. หายใจเข้า สูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ จนรู้สึกว่าบริเวณหน้าท้องพองออก กลั้นไว้ชั่วระยะเท่าที่ทำได้
4. ผ่อนลมหายใจเข้าออกทางจมูกหรือปากช้า ๆ จนรู้สึกว่าหน้าทองยุบแฟบลง
5. ทำเช่นเดียวกัน 5 - 6 ครั้ง ใน 1 ชั่วโมง
6. ขณะฝึกลมหายใจ หากมีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ให้หยุดทันที



รูปแสดง การวางมือบริเวณหน้าท้องขณะฝึกหายใจ

8. การยืดเหยียดเพื่อยืดหยุ่น

ทำไมต้องยืดเหยียด

การยืดเหยียดทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย จะช่วยยืดคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สะดวก ไม่ยึดตึง หรือฉีกขาดง่าย เป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายที่สำคัญ

วิธีการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

1. ควรยืดกล้ามเนื้อแต่ละส่วนช้า ๆ ให้รู้สึกตึง จนกระทั่งไม่สามารถยืดต่อไปได้ แต่ยังไม่รู้สึกเจ็บ
2. เมื่อยืดถึงจุดที่ตึงสุด แต่ไม่เจ็บ ให้ค้างไว้ 30 วินาที โดยนับ 1 - 30
3. ระหว่างการยืดเหยียด เพิ่มความยืดหยุ่น ป้องกันการบาดเจ็บ



ภาพคนยืดเหยียดแขนด้านหน้า



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อแขนด้านหลัง



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อท้องแขน



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อหน้าอก



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลัง



ภาพคนยืดลำตัวและสะโพก



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อขาด้านหน้า



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง



ภาพคนยืดกล้ามเนื้อน่อง

9. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

9.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มความทนทาน



9.2 กิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง

Sit – up (ลุก นั่ง) 30 นาที สัปดาห์ละ 2 - 3 วัน



ภาพ คน Sit - up

เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรมทางกาย ไม่ได้มีผลดีแค่ต่อสุขภาพร่างกายของเราเท่านั้น แต่ยังมีผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากด้วย การออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย สามารถนำมาซึ่งประโยชน์หลากหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้



กิจกรรม

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. กิจกรรมทางกายมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างกิจกรรมทางกายที่สามารถนำมาใช้เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้
3. การทำกิจกรรมทางกายมีผลอย่างไรต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ในชุมชน



เนื้อหาสาระ

การร่วมกิจกรรมทางกายของประชาชนในประเทศเป็นเรื่องสำคัญเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้ด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การที่ประชาชนมีสุขภาพดีสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ได้ ซึ่งรวมถึงการลดจำนวนคนและจำนวนครั้งในการเข้ารักษาพยาบาลและการลดการใช้ยา

2. กระตุ้นการท่องเที่ยวและกีฬา กิจกรรมทางกาย เช่น การวิ่งมาราธอน การเดินป่า ปีนเขา การแข่งขันกีฬา หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจ

3. สร้างงาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส คลับกีฬา และธุรกิจอุปกรณ์กีฬา สามารถสร้างงานให้กับประชาชน

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานที่มีสุขภาพดีมักมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ลดการลาหยุดงาน และมีความสามารถในการทำงานมากขึ้น

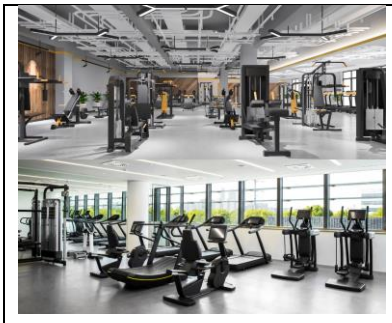
ด้านสังคม

1. การส่งเสริมสุขภาพจิต การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ส่งผลให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งสามารถส่งผลในทางบวกต่อสังคม

2. การสร้างความสามัคคีและความร่วมมือ กิจกรรมทางกาย เช่น การเล่นกีฬาเป็นทีม ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล

3. การเสริมสร้างชุมชน กิจกรรมทางกายในชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

4. ลดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง การมีกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายช่วยลดโอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การเสพสารเสพติดและอาชญากรรม



ภาพธุรกิจฟิตเนส



ภาพคนวิ่งมาราธอน



ภาพคนเดินป่า ปีนเขา

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายมีผลดีทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกาย จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ได้แก่

1. ส่งเสริมสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ: การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติ

2. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน: คนที่มีสุขภาพดีมักจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่า ลดการลาหยุดงานเนื่องจากการเจ็บป่วย และสามารถทำงานได้นานขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมมีความเข้มแข็ง

3. สร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ: อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เช่น โรงยิม ร้านขายอุปกรณ์กีฬา และโครงการส่งเสริมสุขภาพ มีการสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน: กิจกรรมทางกาย เช่น กีฬาและการออกกำลังกายร่วมกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เพิ่มความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน

5. พัฒนาคุณภาพชีวิต: การมีกิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอ ช่วยให้คนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ลดความเครียด และเพิ่มความสุขในการใช้ชีวิต

สรุปได้ว่า กิจกรรมทางกายไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคล แต่ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทำให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านอย่างยั่งยืน

“การออกกำลังกายนั้น ทำน้อยเกินไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ทำมากเกินไปร่างกายและจิตใจก็จะช้ำ”

(จาก พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9)

ขยับบ่อย ๆ เปลี่ยนอิริยาบท เป็นการออกกำลังกายทั้งกวาด แกว่ง เดิน วิ่ง ว่าย ขยับ เคลื่อนไหว หายใจถูกวิธี ดีต่อสุขภาพกายใจ

เรื่องที่ 3 กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถนะของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ผู้สูงอายุยังสามารถทำงานและมีรายได้เลี้ยงตนเองได้ ในขณะที่การดูแลด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่สมดุลจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- กิจกรรมทางกายทำไมถึงสำคัญต่อผู้สูงอายุ
- กิจกรรมทางกายประเภทใดที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้อย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้



กิจกรรม

1) ทำไมกิจกรรมทางกายถึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ
2) เราควรเลือกกิจกรรมทางกายแบบไหนสำหรับผู้สูงอายุ
3) ควรทำกิจกรรมทางกายบ่อยแค่ไหน
4) มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการทำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ



เนื้อหาสาระ

1. กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีสมวัย

การที่ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดี จะต้องมีการเคลื่อนไหว ทำกิจกรรมที่มีการเผาผลาญใช้พลังงาน คำพูดที่ว่า “แก่แล้ว ไม่ต้องทำอะไร ควรอยู่เฉย ๆ” จึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้สูงอายุควรปฏิบัติ รวมทั้งลูกหลานควรเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมที่มีการออกแรงใช้พลังงาน แต่ไม่หนักเกินไป โดยเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายให้สมดุลทั้งประเภทยืดเหยียดและประเภทเคลื่อนไหวออกแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เพิ่มความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้คล่องตัว ผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ จะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และดูอ่อนกว่าวัย สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ

2. หลักการของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

2.1 เน้นกิจกรรมทางกายประเภทแอโรบิก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทำงานได้ดี รวมทั้ง การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มการทรงตัว เพื่อป้องกันการหกล้ม การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง

2.2 ความหนักเบาของกิจกรรม ควรออกกำลังกายให้หนักในระดับปานกลางและมีความต่อเนื่องวันละอย่างน้อย 30 นาที 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ทำความสะอาดบ้าน ทำสวน เป็นต้น

หากผู้สูงอายุต้องการเคลื่อนไหวออกกำลังกายที่มีระดับความหนักมากขึ้น เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬาแบดมินตัน เล่นเทนนิส ที่มีการออกแรงมากขึ้น สามารถทำได้ตามสภาพความพร้อมของร่างกาย โดยการออกกำลังกายระดับหนักนี้ ควรปฏิบัติต่อเนื่องวันละอย่างน้อย 15 นาที 5 วันต่อสัปดาห์

2.3 เลือกประเภทของกิจกรรมทางกายที่ผู้สูงอายุชื่นชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี สามารถเลือกกิจกรรมทางกายได้อย่างหลากหลาย โดยเน้นที่มีความสนุกสนาน เข้าร่วมกิจกรรมหรือออกกำลังกายแล้วไม่เหนื่อยเกินไป ระยะเวลาเหมาะสม ต่อเนื่อง จนเกิดความแข็งแรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด

2.4 ต้องมีการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย (Cool down) ประมาณ 5 - 10 นาที เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่น การยืดเหยียด การบริหารแขน ขา คอ บ่า ไหล่ หลัง ด้วยท่ากายบริหารง่าย ๆ

2.5 ตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนการออกกำลังกายหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย โดยพิจารณาเบื้องต้นด้วยตนเอง หากพบอาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น ปวดตึง มึนศีรษะ วิงเวียน หน้ามืดเวลาก้มเงย ฯลฯ ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือออกกำลังกาย เมื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและออกกำลังกายด้วยความหนักเบาตามสภาพร่างกาย จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย

3. ประเภทของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

แม้ผู้สูงอายุ จะอยู่ในวัยที่ร่างกายเริ่มมีความเสื่อมถอย อาจมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง กระดูกข้อต่อเสื่อม ฯลฯ การเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเหมือนในวัยหนุ่มสาว แต่การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เพียงพอ จะช่วยให้ร่างกายปรับสภาพความสมดุล ฟื้นฟูสมรรถภาพ เกิดความกระชุ่มกระชวย จิตใจเบิกบานขึ้นได้ ซึ่งกิจกรรมทางกายที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

- กิจกรรมสร้างความสมดุลป้องกันการหกล้ม
- กิจกรรมเพิ่มความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
- กิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด

3.1 กิจกรรมสร้างความสมดุลป้องกันการหกล้ม

กิจกรรมประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากการทรงตัวที่ดีจะช่วยป้องกันการหกล้ม อันจะเป็นอันตราย เช่น กระดูกหัก ศีรษะแตก และอาจถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ การฝึกความสมดุลเพื่อช่วยด้านการทรงตัว ได้แก่



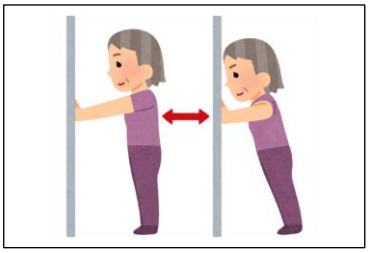
ยืนทรงตัว

- เป็นการฝึกการทรงตัวอย่างง่าย โดยยืนจับเก้าอี้ แล้วยกขาค้างไว้ ทีละข้าง ยกค้างไว้นาน ข้างละ 30 – 60 วินาที ต่อครั้ง **ทำอย่างน้อยข้างละ 3 - 4 ครั้ง**



ย่ำเท้าอยู่กับที่

- ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่ คล้ายการเดินแต่ไม่เคลื่อนที่ โดยให้ยกเข่าสูงเท่าที่จะทำได้ ทำสลับซ้ายขวาอยู่กับที่ แกว่งแขนไปมา พร้อมกันเป็นจังหวะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป เน้นการทรงตัวไม่ให้เอียงไปมา หากกลัวล้มให้หาที่จับหรือเอามือแตะผนังไว้แล้วยกขาสลับ **ทำข้างละ 30 – 60 วินาที 3 - 4 ครั้ง**



ยืนดันพื้นกับผนัง

- ให้ยืนห่างจากผนังประมาณหนึ่งช่วงแขน เอนตัวไปข้างหน้า แขนทั้งสอง ยันผนังไว้โดยให้มือแตะลักษณะตั้งฉาก ทาบไปกับผนัง ขาทั้งสองเหยียดตึงไม่ขยับ ออกแรงดันฝ่ามือเข้ากับผนัง จนรู้สึกเกร็งบริเวณหน้าอก ทำค้างไว้นับ 1 – 10 แล้วกลับมายืนตัวตรงที่ตำแหน่งเดิม **ทำรอบละ 15 - 20 ครั้ง อย่างน้อย 3 - 4รอบ**
-



เดินต่อเท้า

- ให้ฝึกก้าวสลับซ้ายขวาโดยให้ส้นเท้าต่อกับปลายนิ้วเท้า ทำต่อเนื่องช้า ๆ โดยฝึกการทรงตัวได้ดี ป้องกันการหกล้ม **เดิน 20 - 30 ก้าว อย่างน้อย 3 - 4 ครั้ง**

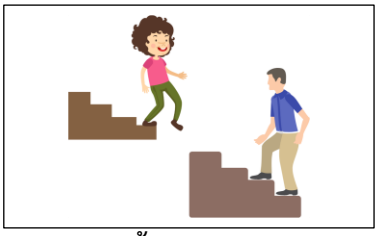
3.2 กิจกรรมเพิ่มความคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

กิจกรรมทางกายประเภทนี้ จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว เป็นการช่วยเสริมทักษะในการดูแลตนเอง สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ และช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ได้แก่



นั่งแตะปลายเท้า

- เริ่มจากนั่งเหยียดขาทั้งสองไปข้างหน้า ปลายเท้าตั้งขึ้น เอื้อมมือทั้งสองข้างไปแตะปลายเท้า พยายามให้เข่าตึงราบ หากยังแตะไม่ถึงให้ค่อย ๆ ขยับไปแตะขา หรือข้อเท้า ทำค้างไว้ แล้วเริ่มใหม่ ค่อย ๆ เหยียดออกไปจนสุดเท่าที่จะทำได้ ไม่รีบร้อน จนหลังส่วนล่างและน่องยืดเหยียดได้ในที่สุด ท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อขาด้านหลังและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมีความยืดหยุ่น ลดอาการปวดหลังได้ การเคลื่อนไหวจะคล่องแคล่วขึ้น **ทำค้างไว้ 20 - 30 วินาที 3 - 4 ครั้ง**



ก้าวขึ้น-ลงบันได

- ให้เริ่มจากก้าวเท้าขวาหรือซ้ายขึ้นก่อนก็ได้ แล้วก้าวขาอีกข้างขึ้นอีกขาก้าวลง สลับกัน ท่านี้ช่วยให้ข้อเท้า เข่า สะโพก ทำงานไปพร้อมกัน และช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรง **ทำต่อเนื่อง 20 - 30 ครั้ง ข้างละ 3 - 4 รอบ**

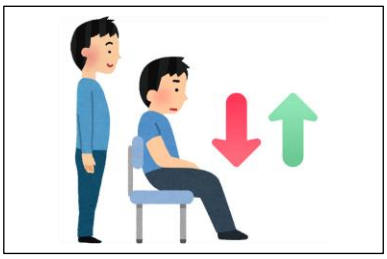


นั่งบิดลำตัวไปด้านข้าง

- ท่านี้เริ่มจากนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ที่มั่นคง ยกแขนทั้งสองขึ้นระดับไหล่ เหยียดแขนตรง แล้วบิดลำตัวไปทางซ้ายขวาสลับกัน ขณะบิดตัวให้ร่างกายส่วนล่างอยู่กับที่ลำตัวส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไป เคลื่อนไปทางซ้าย ขวา จนสุด ทำช้า ๆ จะช่วยให้กล้ามเนื้อด้านข้างกระชับ มีความแข็งแรง ข้อต่อกระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้ดี ลดอาการตึงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น **ทำต่อเนื่องรอบละ 20 - 30 ครั้ง 3 - 4 รอบ**

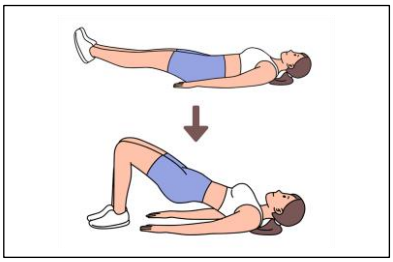
3.3 กิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด

กิจกรรมประเภทนี้จะช่วยให้หัวใจ ปอด และหลอดเลือดมีความแข็งแรง การสูบฉีดเลือดของหัวใจดี อวัยวะส่วนอื่น ๆ ก็จะทำงานได้ดีตามไปด้วย



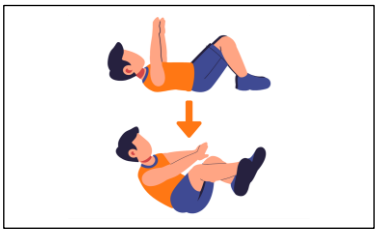
ลุกนั่ง ก้นแตะเก้าอี้

- เลือกเก้าอี้ที่มีความแข็งแรง ไม่เลื่อนไป - มา จากนั้นให้ยืนหน้าเก้าอี้ ค่อย ๆ งอเข่า นั่งลงก้นแตะเก้าอี้ ลำตัวตั้งตรง แล้วกลับลุกยืนขึ้น ทำสลับลุกนั่ง เช่นนี้ จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง กระชับ ข้อต่อเข่าทำงานได้ดี ป้องกันอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุได้ **ทำท่านี้ 15 - 20 ครั้งต่อรอบ ค่อย ๆ ทำอย่างช้า ๆ**



นอนหงาย ยกสะโพก

- ให้นอนราบกับพื้น ชันเข่าทั้งสองขึ้น สะโพกแนบพื้น มือทั้งสองวางแนบลำตัว จากนั้นยกสะโพกขึ้นให้ลำตัวเป็นเส้นตรง กล้ามเนื้อก้นและต้นขาหลังหดเกร็ง ทำขึ้นลงช้า ๆ ท่านี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและหลังส่วนล่าง ช่วยในการทรงตัวของผู้สูงอายุ **ทำขึ้นลงช้า ๆ รอบละ 15 – 20 ครั้ง 3 - 4 รอบ**



นั่งงอตัว

- นอนราบกับพื้น ชันเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นยกลำตัวขึ้น โดยออกแรงที่กล้ามเนื้อหน้าท้อง เอามือทั้งสองข้างแตะเข่า ค้างไว้ นับ 1-10 แล้วนอนราบลงไปใหม่ ทำเช่นนี้ต่อเนื่อง จะช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับและแข็งแรงมากขึ้น **ทำรอบละ 15 – 20 ครั้ง 3 - 4 รอบ**

เรื่องที่ 4 กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ

การเล่นกีฬาทุกชนิดมีผลต่อสุขภาพแตกต่างกัน และแม้จะเล่นกีฬาชนิดเดียวกัน หากผู้เล่นขาดทักษะความชำนาญหรือเล่นในระยะเวลานานมากน้อยต่างกัน ก็จะส่งผลต่อสุขภาพแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมอากาศ สถานที่เล่นก็มีผลต่อสุขภาพด้วย เช่น มีฝนตก อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป มีฝุ่นควันพิษจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ จึงหมายถึง การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดการออกกำลังกาย ช่วยฟื้นฟูและดำรงรักษาสุขภาพ ไม่ให้เสื่อมถอยเร็วเกินไป

ดังนั้น กีฬาเพื่อสุขภาพจึงมีลักษณะแตกต่างจากกีฬาเพื่อการแข่งขัน เพราะมิได้เกี่ยวข้องหรือมุ่งหมายชัยชนะหรือความเป็นเลิศ แต่มุ่งเพื่อร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายความเครียดเป็นหลัก



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- กีฬามีบทบาทอย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย
- การออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
- การออกกำลังกายมีผลต่อการลดความเครียดและความวิตกกังวลอย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

การบรรยายและการอภิปราย

กิจกรรม: ให้ครูหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพและกีฬา มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นที่ได้รับฟัง



กิจกรรมที่ 2

คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. กีฬาใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
   ก. ยกน้ำหนัก ข. โยคะ
   ค. วิ่งจ๊อกกิ้ง ง. ขี่ม้า
2. การเล่นกีฬามีผลต่อสุขภาพจิตอย่างไร
   ก. ช่วยลดความเครียด ข. ทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น
   ค. ไม่มีผลต่อสุขภาพจิต ง. ทำให้เกิดความเครียดชั่วคราว
3. การออกกำลังกายแบบใดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ?
   ก. การยกน้ำหนักหนัก ๆ ข. การเดินเร็ว
   ค. การกระโดดเชือก ง. การวิ่งมาราธอน
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประเภททีม
   ก. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ข. พัฒนาทักษะการสื่อสาร
   ค. เพิ่มความมั่นใจในตนเอง ง. เล่นกีฬาให้เก่งขึ้น
5. ควรใช้เวลานานเท่าไรในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ผลดีต่อสุขภาพ
   ก. 10 นาที ข. 20 นาที
   ค. 30 นาที ง. 60 นาที



เนื้อหาสาระ

การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และช่วยให้จิตใจแจ่มใส ผ่อนคลายจากความเครียด ช่วยให้หลับสบาย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นหรือการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เล่นกีฬาควรเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความชอบ ความถนัดของตนเองเป็นสำคัญ

กีฬาสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

1. การพัฒนาร่างกาย: การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีความทนทานต่อโรคต่าง ๆ

2. การพัฒนาจิตใจ: การเล่นกีฬาช่วยลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี การออกกำลังกายสามารถกระตุ้นการปล่อยสารเคมีในสมองที่ทำให้รู้สึกดี เช่น เอ็นโดรฟิน

3. การส่งเสริมทักษะสังคม: กีฬาช่วยให้ผู้เล่นพัฒนาทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

4. การส่งเสริมการมีวินัย: การเล่นกีฬาต้องการการฝึกฝนและความมุ่งมั่น ซึ่งช่วยสร้างนิสัยการมีวินัย ความรับผิดชอบ และการตั้งเป้าหมายในชีวิต

5. การป้องกันโรค: การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

กีฬาสร้างเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ การเลือกกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความสนใจจะช่วยให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุกและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาว

ลักษณะของกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

1. เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เล่น
2. หัวใจ ปอด และระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรง ทนทาน
3. ผู้เล่นสามารถควบคุมความหนักเบาในการเล่นได้ด้วยตนเอง
4. สามารถปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอได้
5. มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุน้อยหรือไม่มีเลย
6. ปฏิบัติง่าย ไม่มีกฎ กติกายุ่งยาก
7. มีความสนุกเพลิดเพลิน ไม่สิ้นเปลือง



เรื่องที่ 5 กีฬาบาสเกตบอล

การเล่นบาสเกตบอล ทักษะพื้นฐานมีความจำเป็นและสำคัญมาก ผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องจนเกิดความชำนาญเสียก่อน ทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วย การยืนเตรียมพร้อม การหยุดการเคลื่อนที่ การจับลูกบอล การเคลื่อนที่เพื่อเล่นบาสเกตบอล การส่งลูกบอล การรับลูกบอล การยิงประตู

บาสเกตบอล เป็นกีฬาที่จัดอยู่ในกลุ่มกีฬาประเภททีมที่มีคุณลักษณะพิเศษสองประการ คือ เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของผู้เล่นในทีม (Team work) และเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการเล่น (Speed game) นอกจากนี้ทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวมีความจำเป็นและสำคัญมาก ผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งการยืน การเคลื่อนที่ การหยุด และการกระโดด ให้ถูกต้องจนเกิดความชำนาญ เพื่อที่จะได้ให้มีความพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็ว

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- อะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของนักบาสเกตบอลที่ดี
- การเล่นบาสเกตบอลสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการทำงานเป็นทีมได้อย่างไร

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

การส่งบอล

คำถาม: อธิบายวิธีการส่งบอลแบบ Chest Pass

กิจกรรมที่ 2

การเลี้ยงบอล

คำถาม: อธิบายขั้นตอนการเลี้ยงบอลที่ถูกต้อง

กิจกรรมที่ 3

การยิงประตู

คำถาม: อธิบายขั้นตอนการชู้ตบอลที่ถูกต้อง



เนื้อหาสาระ

1) การส่งบอล

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกีฬาประเภททีมจำเป็นต้องมีการส่งและรับในระหว่างผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน ลักษณะของวิธีการส่งลูกในกีฬาบาสเกตบอล มีดังนี้

1. การส่งลูกสองมือระดับอก
2. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ
3. การส่งลูกสองมือเหนือไหล่ด้านข้าง
4. การส่งลูกสองมือด้านข้าง
5. การส่งลูกสองมือล่าง
6. การส่งถูกมือเดียวเหนือไหล่
7. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ด้านข้าง
8. การส่งลูกมือเดียวมือล่าง
9. การส่งลูกมือเดียวข้างลำตัว
10. การส่งลูกมือเดียวข้ามไหล่
11. การส่งลูกบอลกระดอน
12. การส่งลูกพลิกแพลง

2. การเลี้ยงบอล

ทักษะพื้นฐานในกีฬาบาสเกตบอลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล คือ การกดลูกลงต่อเนื่องกันจากลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ไม่ว่าผู้เล่นจะยืนอยู่กับที่หรือกำลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม การเลี้ยงลูกจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการเล่นบาสเกตบอล ผู้เล่นทุกคนจึงควรฝึกให้เกิดความชำนาญและคล่องแคล่ว ว่องไว โดยสามารถเลี้ยงลูกกบอลได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา และพร้อมที่จะหยุดส่งยิงประตู หรือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันที การเลี้ยงลูกบอลโดยทั่วไป ผู้เล่นจะกางนิ้วออกตามธรรมชาติ โดยใช้แรงจากฝ่ามือและนิ้วมือ ขณะที่เลี้ยงลูกบอลต้องสังเกตสถานการณ์ในสนาม โดยวิธีการเงยหน้าขึ้นแต่อย่ามองลูกบอล และถ้าจำเป็นต้องมองลูกบอลก็ให้มองด้วยหางตาเท่านั้น การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการดำเนินเกมรุก การเลี้ยงบอลเข้าหาห่วงที่จะได้คะแนนง่ายที่สุด มือจะต้องขึ้นลงตามบอล การเลี้ยงบอลมีทักษะการฝึกหลายวิธีดังนี้

1. การเลี้ยงบอลเร็ว (Speed or High Dribble)
2. การเลี้ยงบอลช้า (Control or Low Dribble)
3. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอล (Change of Direction)

4 การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยคร่อมหน้า (Cross Over)

5. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยตวัดบอลอ้อมหลัง (Behind the Back)
6. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble)
7. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยกระดอนบอลระหว่างขา (Between the Legs)

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจึงมีจุดมุ่งหมายให้นำลูกบาสเกตบอลไปโยนห่วงประตูหรือยิงประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงข้าม การพาลูกบอลเคลื่อนที่ไปนั้น จะต้องใช้การทุ่มลูกบอลให้กระดอนกับพื้นด้วยมือข้างเดียว หรือด้วยมือสองข้างสลับมือกัน เรียกว่า "การเลี้ยงบอล" (Dribbling)

3. ทักษะการยิงประตู

ทักษะการยิงประตูในการเล่นบาสเกตบอลนับว่าเป็นหัวใจของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทีมที่สามารถนำลูกบอลไปโยนหรือยิงประตู (Shooting) ลงห่วงประตูของฝ่ายตรงกันข้ามได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมที่ชนะ เนื่องจากในเกมการเล่นจะมีฝ่ายตรงกันข้ามคอยป้องกันไม่ให้ยิงประตูได้สะดวก การยิงประตูจะให้ได้ผล มีความแม่นยำ ควรปล่อยลูกบอลให้วิ่งลอยเป็นวิถีโค้ง และควรให้ลูกบอลหมุนกลับเล็กน้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงได้ง่ายขึ้น ซึ่งมุมที่ใช้ในการยิงประตูควรจะประมาณ 15 – 60 องศา ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ยิงประตู

3.1 การยิงประตูแบบกระโดดยิง (Jump Shot) และสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

3.1.1 การกระโดดยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ

3.1.2 การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ

3.2 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อท (Lay - up Shot)

3.2.1 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อท แบบคว่ำมือ

3.2.2 การยิงประตูแบบเลช์ อัพ ช้อท แบบหงายมือ



4. แบ่งตามลักษณะมือที่ยิงประตู

4.1 การตั้งมือยิงประตู

4.2 การหงายมือยิงประตู

4.3 การคว่ำมือยิงประตู

การยิงประตูใต้ห่วง (Lay-up shot)

การยิงประตูใต้ห่วง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Lay-up shot เป็นทักษะการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการยิงลูกระหว่างการเคลื่อนที่ในขณะที่วิ่งแล้วกระโดดขึ้นยิงประตู มักใช้ในการบุกเร็วและเมื่อเจาะผ่านเข้าใต้แป้น ซึ่งสามารถเข้าใกล้ห่วงประตูได้มากที่สุด ผู้เล่นทุกคนจะต้องฝึกฝนทักษะนี้ให้เกิดความชำนาญ รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถยิงได้ทุกมุมทั้งมือซ้ายและมือขวา

ทักษะที่ใช้ในการเล่นบาสเกตบอลจึงประกอบด้วย ทักษะใหญ่ ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการเล่น 3 ประการ คือ การรับ - ส่ง การเลี้ยงลูก และการยิงประตูบาสเกตบอล จุดมุ่งหมายของการยิงประตู คือ เพื่อชัยชนะโดยพยายามนำลูกบอลไปยิงให้ลงประตูมากที่สุด การยิงประตูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการฝึกทักษะต่าง ๆ นั้น ล้วนแต่ต้องการนำลูกบอลไปยิงประตู ชัยชนะในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้มากกว่า ทักษะที่สำคัญยิ่ง คือ การยิงประตู เพราะการแพ้ชนะในเกมการเล่นและการแข่งขันขึ้นอยู่กับการยิงประตูเพื่อทำคะแนนให้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน

5. กติกาบาสเกตบอล

กติกาหมวด 1 เกมการแข่งขัน (THE GAME)

ข้อ 1 คำจำกัดความ (Definitions)

1.1 การแข่งขันบาสเกตบอล (Basketball game)

บาสเกตบอลเป็นการเล่นที่ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่น 5 คน จุดมุ่งหมายของแต่ละทีม คือ ทำคะแนนโดยการโยนลูกบอลให้ลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ทำคะแนน การแข่งขันบาสเกตบอลจะถูกควบคุมโดยกรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่โต๊ะบันทึกคะแนน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน

1.2 ห่วงประตูฝ่ายตรงข้าม / ฝ่ายตนเอง (Basket : opponents/own)

ฝ่ายรุกทำคะแนน โดยนำลูกบอลโยนให้ลงห่วงประตูของฝ้ายตรงข้ามและป้องกันห่วงประตูของฝ่ายตนเอง

1.3 ผู้ชนะของเกมการแข่งขัน (Winner of a game)

เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมการแข่งขัน

กติกาหมวด 2 สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน (COURT AND EQUIPMENT)

ข้อ 2 สนาม (Court)

2.1 สนามต้องเป็นพื้นผิวเรียบ แข็ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ความยาว 28 เมตร ทว้าง 15 เมตร วัดจากขอบในของเส้นหลัง

2.2 แดนหลังของทีมประกอบด้วยห่วงตาข่ายของทีมตนเอง ส่วนของแป้นกระดานหลังห่วงที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นข้างของทีมไปจนถึงเส้นกลางสนาม

2.3 แดนหน้าของทีเป็นห่วงตาข่ายของทีมฝ่ายตรงข้าม ประกอบไปด้วย แป้น กระดานหลัง กำหนดโดยเส้นหลังของฝ่ายตรงข้าม เส้นข้าง และขอบในของเส้นกลางสนาม ใกล้กับห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม

2.4 เส้น (Line) เส้นทุกเส้นต้องเป็นสีขาว มีขนาดความกว้างของเส้น 5 เซนติเมตร และต้องทำให้เห็นชัดเจน

2.4.1 เส้นแบ่งเขตแดน สนามถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งเขต ซึ่งประกอบด้วย เส้นด้านข้าง และเส้นหลัง รวมทั้งเก้าอี้ที่นั่งของทีมต้องอยู่ห่างจากสนามแข่งขันอย่างน้อยที่สุด 2 เมตร

2.4.2 เส้นกลาง วงกลมกลาง และครึ่งวงกลม

เส้นกลาง ต้องขนานกับเส้นหลัง โดยลากจากจุดกึ่งกลางเส้นข้างด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งและต้องต่อยื่นออกไปจากเส้นข้างทั้งสองด้าน ๆ ละ 15 เซนติเมตร เส้นกลางเป็นส่วนของแดนหลัง

วงกลมกลาง อยู่ตรงกลางสนาม มีรัศมี 1.80 เมตรถึงขอบนอกของเส้นรอบวง ถ้าจะทาสีพื้นวงกลมกลาง จะต้องเป็นสีเดียวกับสีพื้นเขต 3 วินาที

ครึ่งวงกลม ทำไว้ในสนาม โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกึ่งกลางเส้นโยนโทษ มีรัศมี 1.80 เมตร ถึงขอบนอกของเส้นรอบวง

2.4.3 เส้นโยนโทษ และเขต 3 วินาที

เส้นโยนโทษ (Free Throw Line) ต้องลากให้ขนานกับเส้นหลัง วัดจากขอบในของเส้นหลังเข้าไปในสนาม 5.80 เมตร เส้นโยนโทษมีความยาว 3.60 เมตร

เขต 3 วินาที (Restricted Areas) คือ พื้นที่ในสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นโยนโทษ และเส้นที่ลากจากจุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางเส้นหลังออกไปข้างละ 2.45 เมตร ถือเป็นส่วนของเขต 3 วินาที บริเวณเขต 3 วินาทีต้องทาสี

ช่องยืนแย่งบอล (Rebound places) ตลอดแนวเขต 3 วินาที สำหรับให้ผู้เล่นยืนระหว่างโยนโทษ ให้ทำเป็นเส้นตามที่กำหนดไว้

2.4.4 พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน

พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนนของทีม คือ พื้นที่ทั้งหมดของสนามแข่งขัน ยกเว้น พื้นที่ใกล้ห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้ามที่กำหนดไว้ด้วยเส้นดังนี้

- เส้นขนาน 2 เส้น ที่ลากออกไปจากเส้นหลัง และตั้งฉากกับเส้นหลัง เส้นขนานทั้งสองเส้นห่าง 90 เซนติเมตรจากขอบด้านในของเส้นข้าง

• เส้นโค้งมีรัศมี 6.75 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้าม ระยะห่างของจุดกึ่งกลางจากขอบด้านในของจุดกึ่งกลางเส้นหลัง ห่าง 1.575 เมตร ให้เส้นโค้งต่อกับเส้นขนานทั้ง 2 เส้นนั้น

ข้อ 3 อุปกรณ์ (Equipment)

อุปกรณ์ต่อไปนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น

3.1 แป้นบาสเกตบอล (Bask stop units) ประกอบด้วย :

- กระดานหลัง (Backboards)
- ห่วงตาข่าย (มีแรงอัด) ห่วง และตาข่าย
- สิ่งยึดกระดานหลังที่มีเบาะหุ้มตลอด

3.2 ลูกบาสเกตบอล (Basketball)

3.3 นาฬิกาแข่งขัน (Game clock)

3.4 ป้ายคะแนน (Scoreboard)

3.5 อุปกรณ์จับเวลา 24 วินาที (Twenty-four second device)

3.6 นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) หรือเครื่องจับเวลาที่เหมาะสม (ไม่ใช่นาฬิกาแข่งขัน) ใช้สำหรับเวลานอก

3.7 สัญญาณเสียง 2 เสียงที่แตกต่างกันและดังอย่างชัดเจน

3.8 ใบบันทึกคะแนน (Scoresheet)

3.9 ป้ายแสดงการฟาวล์ของผู้เล่น (Player foul markers)

3.10 อุปกรณ์แสดงการฟาวล์ทีม (Team foul markers)

3.11 อุปกรณ์แสดงทิศทางการสลับกันครอบครองบอล (Alternating possession indicator)

3.12 พื้นสนามแข่งขัน (Playing Court)

3.13 สนามแข่งขัน (Playing court)

3.14 แสงสว่างที่มีความสว่างเพียงพอ (Adequate lighting)

กติกาหมวด 3 ทีม (TEAMS)

ข้อ 4 ทีม (Teams)

4.1 นิยมศัพท์ (Definition)

4.1.1 คุณสมบัติของสมาชิกที่ถูกต้องในการแข่งขัน ให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการแข่งขัน โดยเฉพาะการจำกัดอายุ

4.1.2 สมาชิกของทีมที่อยู่ในการแข่งขัน ต้องมีชื่อในใบบันทึกคะแนนก่อนเริ่มการแข่งขัน และเป็นระยะเวลานานพอ ซึ่งเขาต้องไม่ถูกขานฟาวล์เสียสิทธิ์หรือกระทำฟาวล์ครั้งที่ 5

4.2 กติกา (Rule)

4.2.1 แต่ละทีมจะประกอบด้วย :

1) จำนวนผู้เล่นของทีมต้องไม่เกิน 12 คนรวมหัวหน้าทีม

2) มีผู้ฝึกสอน 1 คน และมีผู้ช่วยฝึกสอนได้อีก 1 คน

3) ผู้ติดตามทีมให้มีได้ไม่เกิน 5 คน ที่สามารถนั่งในที่นั่งของทีมและมีหน้าที่รับผิดชอบพิเศษ คือ ผู้จัดการทีม แพทย์ประจำทีม นักกายภาพบำบัด นักสถิติ ล่าม เป็นต้น

4.2.2 ผู้เล่น 5 คนของแต่ละทีม จะอยู่ในสนามแข่งขันระหว่างเวลาแข่งขันและอาจเปลี่ยนตัวได้

4.2.3 ผู้เล่นสำรองกลายเป็นผู้เล่น และผู้เล่นกลายเป็นผู้เล่นสำรอง เมื่อ :

1) กรรมการผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามแข่งขัน

2) ระหว่างเวลานอกหรือช่วงพักการแข่งขัน ผู้เล่นสำรองขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่อผู้บันทึกคะแนน

4.3 ชุดแข่งขัน (Uniforms)

4.3.1 ชุดแข่งขันของสมาชิกทีม จะประกอบด้วย :

1) เสื้อ มีสีที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ผู้เล่นทุกคนต้องสวมชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงระหว่างเกมการแข่งขัน ชุดที่เป็นชุดเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง อนุญาตให้ใช้ได้

2) เสื้อคอกลม (T-shirts) ไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม**ไม่อนุญาต**ให้สวมใส่เป็นเสื้อชั้นในของเสื้อแข่งขัน ยกเว้น ผู้เล่นคนนั้นมีใบรับรองแพทย์อนุญาต ถ้าได้รับอนุญาตเสื้อคอกลมนั้นต้องเป็นสีที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเสื้อแข่งขัน

3) กางเกง ต้องเป็นสีที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่ไม่จำเป็นต้องมีสีเหมือนกับสีเสื้อแข่งขัน

4) กางเกงชั้นใน (Undergarments) ที่ยาวกว่ากางเกงแข่งขัน อาจสวมใส่ได้ แต่สีของกางเกงชั้นในต้องเป็นสีเดียวกับสีของกางเกงแข่งขัน

4.3.2 สมาชิกแต่ละคนจะต้องสวมใส่เสื้อที่มีหมายเลขทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยหมายเลขที่ชัดเจนมีสีแตกต่างกับสีของเสื้อแข่งขัน หมายเลขจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะดังนี้

1) หมายเลขด้านหลังจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

2) หมายเลขด้านหน้าจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร

3) หมายเลขจะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

4) ทีมจะใช้หมายเลขจาก 4 ถึง 15 สมาคมแห่งชาติ มีอำนาจประยุกต์ใช้หมายเลขไม่เกิน 2 หลัก สำหรับรายการแข่งขันของสมาคมแห่งชาติเอง

5) ผู้เล่นทีมเดียวกันจะต้องไม่สวมใส่เสื้อแข่งขันที่มีหมายเลขซ้ำกัน

6) การโฆษณาหรือสัญลักษณ์ของทีม จะอยู่ห่างจากหมายเลขอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

4.3.3 ทีมจะต้องมีเสื้อแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด:

1) ทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขัน (ทีมเหย้า) จะสวมใส่เสื้อสีอ่อน (โดยส่วนมากเป็นสีขาว)

2) ทีมชื่อหลังในโปรแกรมการแข่งขัน (ทีมเยือน) จะสวมใส่เสื้อสีเข้ม

3) แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้ง 2 ทีมตกลงกันได้ อาจจะสลับสีเสื้อแข่งขันได้

4.4 อุปกรณ์อื่น ๆ (Other equipment)

4.4.1 อุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้เล่นใช้ต้องเหมาะสมกับเกมการแข่งขันอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความสูงหรือความยาวช่วงแขนของผู้เล่น หรือทำให้เกิดการได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ไม่อนุญาตให้ใช้

4.4.2 ผู้เล่นจะไม่สวมใส่อุปกรณ์ (เครื่องประดับ) ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เล่นคนอื่น

1) ไม่อนุญาตในสิ่งต่อไปนี้ :

(1) อุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือ มือ ข้อมือ ข้อศอก หรือแขนท่อนล่าง เฝือกหรือเครื่องประดับที่ทำด้วยหนัง พลาสติก พลาสติกอ่อนนุ่ม โลหะ หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็ง ถึงแม้จะห่อหุ้มด้วยสิ่งอ่อนนุ่มก็ตาม

(2) เครื่องประดับที่มีความคมหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขูดขีด (เล็บนิ้วมือต้องตัดให้สั้น)

(3) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เครื่องประดับผม และเครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย

2) อนุญาตในสิ่งต่อไปนี้ :

(1) อุปกรณ์ป้องกันไหล่ แขนท่อนบน ต้นขา หรือขาท่อนล่าง ถ้าห่อหุ้มโดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เล่นคนอื่น

(2) สนับเข่า ถ้าเป็นแบบที่คลุมมิดชิด

(3) อุปกรณ์ป้องกันจมูก ถึงแม้เป็นวัสดุที่ทำด้วยโลหะแข็ง

(4) แว่นตา ถ้าไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นคนอื่น

(5) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ทำจากผ้าสีเดียวกันพลาสติกอ่อน หรือยาง

4.4.3 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาข้อนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติก่อน

กติกาการเล่นบาสเกตบอล

กติกาบาสเกตบอลมีหลายข้อและครอบคลุมหลายด้านของการเล่น เพื่อให้เกมเป็นธรรมและมีความยุติธรรม นี่คือสาระสำคัญของกติกาบาสเกตบอล:

1. **ผู้เล่น**: แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 5 คนในสนามและสามารถมีตัวสำรองได้ ทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา
2. **เวลาเล่น**: การแข่งขันทั่วไปแบ่งเป็น 4 ควอเตอร์ แต่ละควอเตอร์ใช้เวลา 10 หรือ 12 นาที ขึ้นอยู่กับกติกาของการแข่งขัน
3. **การเริ่มเกม**: เกมเริ่มต้นด้วยการกระโดดลูกบอลที่กลางสนามโดยผู้ตัดสิน
4. **การทำคะแนน**:
   - การโยนลูกบอลลงห่วงในเขตสามแต้ม จะได้ 3 คะแนน
   - การโยนลูกบอลลงห่วงในเขตสองแต้ม จะได้ 2 คะแนน
   - การโยนลูกโทษ จะได้ 1 คะแนน
5. **การเดินและการเลี้ยงลูก**:
   - ผู้เล่นต้องเลี้ยงลูกบอลตลอดเวลาที่เคลื่อนที่
   - หากผู้เล่นเดินโดยไม่เลี้ยงลูกบอลจะถือว่าเป็นการทำผิดกติกา (การเดิน)

6. **การทำฟาวล์**:
    - การสัมผัสหรือชนกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะถือเป็นการฟาวล์
    - การฟาวล์สามารถนำไปสู่การโยนลูกโทษหรือการเสียการครองบอล
7. **การหมดเวลา**: แต่ละทีมสามารถขอหมดเวลา (time - out) ได้ระหว่างเกม เพื่อพูดคุยกับผู้เล่นหรือปรับแผนการเล่น
8. **การยิงลูกโทษ**: ผู้เล่นจะได้รับโอกาสยิงลูกโทษจากการถูกทำฟาวล์ในขณะที่พยายามทำคะแนน
9. **การครองบอล**: เมื่อผู้เล่นครองบอลในฝั่งของตนเอง จะต้องนำบอลข้ามเส้นกลางสนามภายใน 8 วินาที
10. **การเปลี่ยนการครองบอล**: หากทีมหนึ่งทำผิดกติกา อีกทีมจะได้รับการครองบอล

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 10 กิจกรรมทางกายและกีฬา

เรื่องที่ 1 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน



กิจกรรม

แนวคำตอบ:

1. กิจกรรมทางกายช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ ลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก รวมถึงช่วยลดน้ำหนักและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ในชุมชนสามารถมีกิจกรรมทางกายได้หลายรูปแบบ เช่น การเดินหรือวิ่งในสวนสาธารณะ การปั่นจักรยาน การออกกำลังกายแบบกลุ่ม เช่น โยคะ แอโรบิก หรือการเล่นกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรือวอลเลย์บอล

เรื่องที่ 2 กิจกรรมทางกายกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม



กิจกรรม

แนวคำตอบ:

1. กิจกรรมทางกายช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างงานและรายได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามัคคี สุขภาพจิตที่ดี และลดพฤติกรรมเสี่ยงในสังคม
2. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชุมชน, การจัดกิจกรรมเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล, การเปิดคลาสออกกำลังกายฟรีในสวนสาธารณะ
3. การทำกิจกรรมทางกายช่วยลดความเครียด เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างสมาชิกในชุมชน

เรื่องที่ 3 กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ



กิจกรรม

1) **ทำไมกิจกรรมทางกายถึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ**
   แนวคำตอบ :
   - การมีกิจกรรมทางกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและเบาหวาน และยังช่วยในการรักษาสมดุล และป้องกันการหกล้ม
2) **เราควรเลือกกิจกรรมทางกายแบบไหนสำหรับผู้สูงอายุ**
   แนวคำตอบ :
   - ควรเลือกกิจกรรมที่ไม่หนักเกินไปและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินเล่น การเต้นรำเบา ๆ การเล่นโยคะ หรือการเล่นเกมที่ใช้การเคลื่อนไหวเบา ๆ
3) **ควรทำกิจกรรมทางกายบ่อยแค่ไหน**
   แนวคำตอบ :
   - ควรทำกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 20 - 30 นาทีขึ้นไป
4) **มีข้อควรระวังอะไรบ้างในการทำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ**
   แนวคำตอบ :
   - ควรเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายทุกครั้ง สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมและรองเท้าสำหรับการออกกำลังกาย ดื่มน้ำให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม

เรื่องที่ 4 กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ



กิจกรรมที่ 1

แนวคำตอบ: การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดความเครียด เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยในการพัฒนาทักษะทางสังคมจากการเล่นกีฬาเป็นทีม



กิจกรรมที่ 2

1. ค. วิ่งจ๊อกกิ้ง
2. ก. ช่วยลดความเครียด
3. ข. การเดินเร็ว
4. ง. เล่นกีฬาให้เก่งขึ้น
5. ค. 30 นาที

เรื่องที่ 5 กีฬาบาสเกตบอล



กิจกรรมที่ 1

แนวคำตอบ:

1. ถือบอลด้วยสองมือที่ระดับหน้าอก
2. ยืนแยกเท้าเพื่อความสมดุล
3. ดันบอลออกไปด้วยความแรงจากหน้าอก โดยใช้ข้อมือและแขนช่วย ปล่อยบอลออกไปตรงๆ และระวังไม่ให้บอลสูงเกินไป



กิจกรรมที่ 2

แนวคำตอบ:

1. ใช้ปลายนิ้วในการสัมผัสบอล ไม่ใช่ฝ่ามือ
2. งอเข่าเล็กน้อยและอยู่ในท่าครึ่งยืนครึ่งนั่ง
3. เลี้ยงบอลระดับเอวหรือต่ำกว่า เพื่อความปลอดภัยจากคู่ต่อสู้
4. มองไปข้างหน้าเสมอ ไม่มองบอล เพื่อให้สามารถเห็นเพื่อนร่วมทีมและศัตรูได้



กิจกรรมที่ 3

แนวคำตอบ:

1. ยืนแยกเท้าให้มั่นคง โดยเท้าข้างที่ถนัดอยู่ด้านหน้าเล็กน้อย
2. ถือบอลด้วยสองมือที่ระดับหน้าอก
3. งอเข่าและลำตัวเล็กน้อยเพื่อเตรียมตัวชู้ต
4. ยกบอลขึ้นด้านหน้าหน้าและใช้ข้อมือเหวี่ยงบอลออกไป
5. ปล่อยบอลด้วยการเหวี่ยงข้อมือและปลายนิ้ว เพื่อให้บอลมีการหมุนและตรงเป้าหมาย

บทที่ 11
ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต

สาระสำคัญ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะชีวิตทั้ง 10 ประการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงาน การแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถนำกระบวนการทักษะชีวิตไปใช้ในการแก้ปัญหาแก่ครอบครัวผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. บอกความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต ได้ทั้ง 10 ประการ
2. บอกทักษะชีวิตที่จำเป็น ได้อย่างน้อย 3 ประการ
3. ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัวและการแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
4. แนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาแก่ครอบครัว เพื่อน และผู้อื่น

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ
เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จำเป็น 3 ประการ
- 2.1 ทักษะการตระหนักรู้ในตน
- 2.2 ทักษะการจัดการกับอารมณ์
- 2.3 ทักษะการจัดการกับความเครียด

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ปัญหาชีวิต
เรื่องที่ 4 การแนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ

ทักษะชีวิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมศักยภาพให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทำงาน ความสามารถที่ช่วยให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น พร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. **ทักษะชีวิตมีประโยชน์อย่างไร ที่จะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ**
2. **การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ ควรนำทักษะชีวิตข้อใดมาใช้**

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม และร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

1. ความหมายของทักษะชีวิต
2. ความสำคัญของทักษะชีวิต มีอะไรบ้าง
3. ทักษะชีวิต 10 ประการ มีอะไรบ้าง



เนื้อหาสาระ

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบุคคลอันประกอบด้วย การมีความรู้ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะที่สามารถจะจัดการกับปัญหาด้านใด ด้านหนึ่งของตนเองได้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและและสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคต

ทักษะชีวิต มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตชีวิตประจำวัน เช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน สุขภาพ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การปรับตัว ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ และยังเป็นความสามารถที่มีความจำเป็นสำหรับการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

10 ทักษะชีวิตที่ควรฝึกฝน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่

1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลที่ได้จากการตัดสินใจ เลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระบบ ไม่เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้

3.ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) เป็นความสามารถในทางความคิด ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการ คิดแบบสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆรวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นในแต่ละทางเลือก และสามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และประเมินปัญหาหรือสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถช่วย ให้วัยรุ่นตระหนักและประเมินผลสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง เช่น การรู้จักคุณค่าในตนเอง การจัดการกับความกดดันจากเพื่อน ๆ หรือการรับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) เป็นความสามารถในการใช้คำพูดและท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การแสดงความต้องการ การแสดงความชื่นชม การขอร้อง การเจรจาต่อรอง การตักเตือน การช่วยเหลือ การปฏิเสธ

6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) เป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน สามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว

7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self - awareness) เป็นความสามารถในการ ค้นหา รู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น รู้ข้อดีข้อด้อยของตนเอง รู้ความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจตัวเอง เวลาเผชิญกับความเครียดหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และทักษะนี้ยังเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นความสามารถในการเข้าใจความ เหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับ การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ สีผิว อาชีพฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้สามารถยอมรับ บุคคลที่ต่างจากเรา เกิดการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่า หรือได้รับความเดือด ร้อน

9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion) เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไร รู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธและความโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสม

10. ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) เป็นความ สามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียด รู้วิธีผ่อนคลายความเครียด และแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

ทักษะชีวิตทั้ง 10 ทักษะนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องอาศัยการฝึกฝน ซึ่งการจะเป็นวัยรุ่นที่พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะที่ดีนั้น ต้องฝึกตนเองให้มีจุดแข็งในด้านทักษะการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม รู้จักที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเอง และพร้อมที่เผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความพร้อมที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง

เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จำเป็น 3 ประการ

ทักษะชีวิต มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคล เพื่อมีความเข้าใจในกฎระเบียบ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีความเข้าใจและเห็นใจของผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีทักษะทั้ง 3 ได้แก่ ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- ถ้ามีเพื่อนชวนไปปาร์ตี้ในยามวิกาล เราควรมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร
- “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” มีความหมายว่าอย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เล่นเกม “บอกความลับของฉัน” โดยครูกำหนดข้อความให้แต่ละกลุ่ม แล้วให้ผู้เรียนต่อแถวตอนลึก และพูดกระซิบข้างหูสมาชิกในกลุ่มจนครบคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายของกลุ่มเป็นผู้ตอบข้อความให้ถูกต้อง ครูและผู้เรียนสรุปร่วมกัน



กิจกรรมที่ 2

บทบาทสมมติ

สยาม เป็นผู้เรียน สกร.ระดับอำเภอแห่งหนึ่ง กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำงานพิเศษ ปัญหานี้ทำให้ สยามมีความเครียดสูง และส่งผลกระทบต่อการเรียนและสุขภาพของเธอ สยาม จะใช้ทักษะชีวิตการในจัดการเวลาและการจัดการความเครียดเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไร ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหานี้คืออะไร





เนื้อหาสาระ

ทักษะชีวิตเป็นความจำเป็นที่บุคคลแต่ละบุคคลควรได้มีการฝึกฝนให้เกิดทักษะเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี ตลอดทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะชีวิตที่จำเป็น มี 3 ประการ ประกอบด้วย

1. ทักษะการตระหนักรู้ในตน

ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self - Awareness) การตระหนักรู้ในตน คือ ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่าของตนเอง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น การพัฒนาทักษะนี้ช่วยให้สามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ได้ดีขึ้น และเข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

วิธีพัฒนาทักษะการตระหนักรู้ในตน

1) การติดป้ายอารมณ์ความรู้สึก : ระบุและเข้าใจอารมณ์ของตนเอง
2) การระบุสิ่งกระตุ้นอารมณ์ : ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์
3) การวิเคราะห์ผลกระทบ : เข้าใจว่าอารมณ์เหล่านี้ส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร
4) การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม

2. ทักษะการจัดการกับอารมณ์

ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Emotional Management) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม การตระหนักรู้ในตนเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะนี้

วิธีพัฒนาทักษะการจัดการกับอารมณ์

1) การรับรู้อารมณ์ : ตระหนักถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ
2) การควบคุมอารมณ์ : ใช้เทคนิคการหายใจลึกหรือการผ่อนคลายเพื่อลดความเข้มข้นของอารมณ์
3) การแสดงออกอย่างเหมาะสม : หาแนวทางที่ดีที่สุดในการแสดงอารมณ์ออกมา เช่น เดินออกจากสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า หยุดคิดก่อนที่จะพูด เป็นต้น

3. ทักษะการจัดการกับความเครียด

ทักษะการจัดการกับความเครียด (Stress Management) เป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถรับมือกับความกดดันและความเครียดในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีพัฒนาทักษะการจัดการกับความเครียด

1) การออกกำลังกาย : ช่วยลดความเครียดและทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี
2) การฝึกสมาธิหรือการทำสมาธิ : ช่วยให้จิตใจสงบ ลดความกังวล และรู้เท่าทันอารมณ์
3) การวางแผนและจัดการเวลา : ช่วยลดความกดดันจากการทำงานหรือภาระหน้าที่ได้

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ปัญหาชีวิต

การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ปัญหาชีวิต เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี ทักษะเหล่านี้ช่วยให้เรามีการจัดการตนเองที่ดี สามารถรับมือกับความเครียด และปรับตัวได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ทำให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในงานที่ทำ

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- ทักษะในการทำงานแบบใดที่คนยุคใหม่ต้องรู้
- ทักษะในการทำงานแบบใดที่ต้องพัฒนาหรือเรียนรู้เพิ่มเติม และนำไปประยุต์ใช้ในการทำงาน

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1

ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลแล้วตอบคำถาม

กรณีศึกษา:

นายสมชาย อายุ 35 ปี ทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เขามีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการหลายโครงการพร้อมกัน แต่ละโครงการมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ เขายังต้องบริหารทีมงานและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวัน

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นายสมชายเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้นและแรงกดดันจากผู้บริหาร เขาเริ่มมีปัญหาในการนอนหลับ รู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน และบางครั้งก็หงุดหงิดกับทีมงานโดยไม่มีเหตุผล นายสมชายรู้สึกว่า ความเครียดนี้กำลังส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพของเขา

คำถามที่ 1 ปัญหาหลักที่นายสมชายกำลังเผชิญคืออะไร

คำถามที่ 2 สิ่งที่นายสมชายควรทำเพื่อลดความเครียดคืออะไร

คำถามที่ 3 นายสมชายสามารถใช้วิธีใดเพิ่มเติมในการจัดการกับความเครียด

คำถามที่ 4 นายสมชายควรทำอย่างไรเพื่อจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามที่ 5 หากนายสมชายยังคงรู้สึกเครียดและเหนื่อยล้า แม้จะพยายามลดความเครียดแล้ว เขาควรทำอย่างไร

กิจกรรมที่ 2



จับคู่ทักษะชีวิตในคอลัมน์ A กับคำอธิบายในคอลัมน์ B ที่สอดคล้องกัน

คอลัมน์ A: ทักษะชีวิต

1. การจัดการเวลา
2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การแก้ไขปัญหา
4. ความยืดหยุ่นในการปรับตัว
5. การจัดการความเครียด

คอลัมน์ B: คำอธิบาย

..... : ความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสถานการณ์

..... : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

..... : ความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

..... : การติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

..... : การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความเครียดและรักษาสมดุลในชีวิต

เนื้อหาสาระ

การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ปัญหาชีวิต เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

1. การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน

ทักษะชีวิตมีความสำคัญในการทำงาน เนื่องจากช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างทักษะที่สำคัญ ได้แก่

1) การวางแผนและการบริหารจัดการ ช่วยให้ทำงานเสร็จตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ
2) การสื่อสาร เป็นกุญแจสำคัญในการประสานงานกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3) การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ช่วยให้สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบ

2. การปรับตัว

การปรับตัว เป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวช่วยให้สามารถยืดหยุ่นและรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น

3. การแก้ปัญหาชีวิต

การแก้ปัญหาชีวิต เป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการแก้ปัญหาที่ดี ได้แก่

1) กำหนดปัญหา ระบุปัญหาที่แท้จริง
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาทางแก้ไข

4) ประเมินและเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

ทักษะชีวิตมีความสำคัญในการทำงานและการแก้ปัญหาชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การปรับตัว และการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต

เรื่องที่ 4 การแนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น

การใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาผู้อื่นต้องอาศัยความเข้าใจและการสื่อสารที่ดี การจัดการอารมณ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- เมื่อเพื่อนของเรามีปัญหากันภายในทีม ในฐานะเพื่อน เราควรมีเทคนิคในการแก้ปัญหาชี้แนะอย่างไร เพื่อไม่ให้เพื่อนผิดใจกัน

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

ให้ผู้เรียน “อธิบายกระบวนการที่ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาผู้อื่น โดยให้ตัวอย่างการนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี”



กิจกรรมที่ 2

ให้ผู้เรียนจับคู่ที่เกี่ยวกับกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น

.....1. การประเมินสถานการณ์

.....2. การฟังอย่างตั้งใจ

.....3. การวิเคราะห์ปัญหา

.....4. การเสนอทางเลือก

.....5. การติดตามผล

ก. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดที่มีอยู่

ข. การตั้งคำถามและพูดคุยเพื่อให้เข้าใจปัญหาของผู้อื่น

ค. การวางแผนและเสนอทางออกที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหา

ง. การตรวจสอบและติดตามว่าการแก้ปัญหามีผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่

จ. การตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและผลกระทบ



เนื้อหาสาระ

การแนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น สามารถทำได้โดยการใช้กระบวนการที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเต็มใจและเปิดใจรับฟังมุมมองของผู้อื่น โดยไม่ขัดจังหวะหรือให้ความคิดเห็นในระหว่างที่เขากำลังพูด การฟังที่ดีช่วยให้เราเข้าใจปัญหาจริง ๆ เป็นการสร้างความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าได้รับความเคารพ

2. การระบุปัญหา หลังจากฟังความเห็นจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ต้องทำการระบุปัญหาที่แท้จริงอย่างชัดเจน อาจจะพูดกลับหรือสรุปสิ่งที่เข้าใจ เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปัญหา

3. การแสดงความเห็นและความรู้สึก ใช้การพูดคุยที่เคารพความรู้สึกของผู้อื่น โดยใช้ “ภาษาไม่ก้าวร้าว” หรือ “การใช้คำพูดในเชิงบวก” เพื่อแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้สึกโดยไม่ทำให้เกิดการปะทะหรือบาดหมาง

4. การเสนอทางเลือก คิดหาทางเลือกในการแก้ปัญหาหลาย ๆ ทาง และเสนอให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย การมีหลายทางเลือกทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจ

5. การตัดสินใจร่วมกัน เมื่อตัดสินใจแล้ว ควรมีความเข้าใจร่วมกันในวิธีการที่เลือกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

6. การติดตามผลและประเมินผล หลังจากดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว ควรมีการติดตามผลและประเมินความสำเร็จของการแก้ปัญหา เพื่อดูว่าแนวทางที่เลือกนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ และหากมีปัญหาหรือความผิดพลาด ควรแก้ไขได้ทันที

การใช้กระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้การแก้ปัญหากับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 11 ทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิต

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต 10 ประการ



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน?

1. ความหมายของทักษะชีวิตคืออะไร

ตอบ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. ความสำคัญของทักษะชีวิตมีอย่างไร

ตอบ เป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้เผชิญกับปัญหาที่พบและผ่านเข้ามาในชีวิตชีวิตประจำวัน

3. ทักษะชีวิต 10 ประการมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ทักษะการตัดสินใจ
2. ทักษะการแก้ปัญหา
3. ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
4. ทักษะการคิดอย่างมีจารณญาณ
5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน
8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์
10. ทักษะการจัดการกับความเครียด

เรื่องที่ 2 ทักษะชีวิตที่จำเป็น 3 ประการ



กิจกรรมที่ 1

การเล่นเกม บอกฉันความลับ

การตระหนักรู้ในตนเองในการรับข่าวสารข้อมูล การปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีเหตุมีผล รู้จักเคารพให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความเข้าใจสถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลือกรับ เลือกปฏิเสธ มีความสามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น



กิจกรรมที่ 2

บทบาทสมมติ

1. วางแผนจัดการเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนและการทำงาน
2. พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ
3. ปรึกษาเพื่อน หรือครู อาจารย์ของ สกร. ที่ตนเองศึกษาอยู่
4. ค้นหางานพิเศษใหม่ที่มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นกว่า

5 ทบทวนแผนการจัดการเวลาและความเครียดอีกครั้ง

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการทำงาน การปรับตัว และการแก้ปัญหาชีวิต



กิจกรรมที่ 1

1. ปัญหาหลักที่นายสมชายกำลังเผชิญคืออะไร

   ตอบ ความเครียดจากปริมาณงานและแรงกดดัน

2. สิ่งที่นายสมชายควรทำเพื่อลดความเครียดคืออะไร

   ตอบ ปรึกษากับผู้บริหารเกี่ยวกับการลดปริมาณงาน

3. นายสมชายสามารถใช้วิธีใดเพิ่มเติมในการจัดการกับความเครียด

   ตอบ ออกกำลังกายเป็นประจำ

4. นายสมชายควรทำอย่างไรเพื่อจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   ตอบ จัดลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้น

5. หากนายสมชายยังคงรู้สึกเครียดและเหนื่อยล้า แม้จะพยายามลดความเครียดแล้ว เขาควรทำอย่างไร

   ตอบ ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต



กิจกรรมที่ 2

คอลัมน์ B: คำอธิบาย

.....4..... : ความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสถานการณ์

.....1..... : การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

.....3..... : ความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

.....2..... : การติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

.....5..... : การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความเครียดและรักษาสมดุลในชีวิต

เรื่องที่ 4 การแนะนำกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น



กิจกรรมที่ 1

แนวคำตอบ

การใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาผู้อื่น เป็นกระบวนการที่สำคัญและมีหลายขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การฟังอย่างตั้งใจ

กระบวนการ: เริ่มต้นด้วยการฟังผู้อื่นอย่างเต็มที่และตั้งใจเพื่อเข้าใจปัญหาจริง ๆ ที่พวกเขากำลังเผชิญ

ตัวอย่าง: เมื่อเพื่อนของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน ลองฟังสิ่งที่เขาพูดโดยไม่ขัดจังหวะ หรือไม่รีบร้อนในการเสนอแนวทางแก้ไขทันที การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นและสร้างความรู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจ

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ: ใช้การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยเพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณ

ตัวอย่าง: หลังจากฟังปัญหาของเพื่อนแล้ว คุณสามารถพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถช่วยได้ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในลักษณะที่เป็นกลางและสร้างสรรค์

3. การจัดการอารมณ์

กระบวนการ: ควบคุมอารมณ์ของตนเองและช่วยให้ผู้อื่นจัดการกับอารมณ์ของเขาได้ดีขึ้น

ตัวอย่าง: หากการสนทนากลายเป็นเรื่องที่ตึงเครียด คุณสามารถช่วยลดความตึงเครียดโดยการพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่สงบ และเสนอแนวทางที่ช่วยบรรเทาความเครียด

4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

กระบวนการ: วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง: เมื่อได้ยินปัญหาจากเพื่อน คุณสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ และช่วยเขาหาทางออกที่เป็นไปได้ เช่น การจัดการเวลาที่ดีขึ้น หรือการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา

5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กระบวนการ: พยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้เพื่อนรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยปัญหาของเขากับคุณ และอาจทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ที่เขาสามารถพึ่งพาได้ การใช้ทักษะเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยให้การแก้ปัญหาผู้อื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน



กิจกรรมที่ 2

ให้ผู้เรียนจับคู่ที่เกี่ยวกับกระบวนการทักษะชีวิตในการแก้ปัญหากับผู้อื่น

..... จ.....1. การประเมินสถานการณ์

.....ก.....2. การฟังอย่างตั้งใจ

.....ข.....3. การวิเคราะห์ปัญหา

.....ค.....4. การเสนอทางเลือก

.....ง.....5. การติดตามผล

บทที่ 12
ศิลปะสากล

สาระสำคัญ



ศิลปะสากล (International Art) คือ ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยสุนทรียะ และสื่อสารให้รับรู้ร่วมกันหลากหลายประเทศ หรือหลากหลายวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับนานาชาติเป็นประการสำคัญ เป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรม ความเจริญ รุ่งเรือง และความเชื่อจากการปกครอง ศาสนา และความเชื่อของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสรรค์ความงามให้เป็นที่ยอมรับได้ต่อเนื่อง โดยไม่สามารถแบ่งแยกความงามของอดีตและปัจจุบันได้

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายความหมาย ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ ความสำคัญ รูปแบบ ประเภทและหลักองค์ประกอบศิลป์

2. อธิบายรูปแบบในการนำ จุด เส้น สี แสง - เงา รูปร่างและรูปทรงจินตนาการสร้างสรรค์ประกอบให้เป็นงานศิลปะสากล

3. สร้างสรรค์งานศิลปะสากล

4. ชื่นชมและเห็นคุณค่าของศิลปะสากลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท คุณค่าความสำคัญของศิลปะสากล

เรื่องที่ 2 หลักองค์ประกอบศิลป์

เรื่องที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาประดับตกแต่งร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งสถานที่ สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป

เรื่องที่ 1 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท คุณค่าความสำคัญของศิลปะสากล

ศิลปะสากลเป็นการแสดงออกที่สะท้อนถึงความคิด ความรู้สึก และวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั่วโลก ผ่านรูปแบบที่หลากหลายและสืบทอดมาแต่โบราณ วิวัฒนาการของศิลปะสากลได้พัฒนาไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ทางสังคม ศิลปะถูกจำแนกออกเป็นหลายประเภท เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ที่มีคุณค่าและความสำคัญทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และการสื่อสาร ความคิดระหว่างวัฒนธรรม

ศิลปะสากล คือ ภาษาสากลที่มนุษย์ใช้สื่อสารความรู้สึกและความคิดผ่านภาพ เสียง หรือการเคลื่อนไหว มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ่านหลายยุคสมัย เช่น ยุคหิน ยุคเรเนซองส์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพวาด ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะการแสดง ศิลปะไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ ช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ตีความและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. ถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะ จะเป็นอย่างไร
2. ภาพวาดบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์กับภาพวาดสมัยใหม่ มีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง
3. ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะสากล

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีจำนวนสมาชิกที่เหมาะสมต่อการทำงานกลุ่ม
2. ให้แต่ละกลุ่มเลือกผลงานศิลปะสากลที่ตนเองสนใจ
3. กำหนดหัวข้อการอภิปรายที่ชัดเจน เช่น ประวัติความเป็นมาของผลงาน วิวัฒนาการและกระบวนการสร้างสรรค์ รูปแบบและองค์ประกอบ ประเภทและแนวคิดทางศิลปะของผลงาน คุณค่าและความสำคัญ
4. ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ และสารคดี
5. ให้แต่ละกลุ่มเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม เช่น การทำป้ายนิทรรศการ การทำสไลด์นำเสนอ หรือการแสดงบทบาทสมมติ
6. เน้นให้การนำเสนอครอบคลุมหัวข้อที่กำหนดไว้ และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่ชัดเจน
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตั้งคำถามเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ
8. สรุปผลการอภิปรายโดยเน้นประเด็นสำคัญที่ได้จากการศึกษาและอภิปรายร่วมกัน

ใบงานศิลปะสากล

คำชี้แจง:ให้ผู้เรียนค้นคว้าหาข้อมูลผลงานศิลปะที่ตนเองสนใจแล้วนำมาอภิปรายในชั้นเรียน

1. **ประวัติความเป็นมาและที่มาของผลงาน**

2. วิวัฒนาการและกระบวนการสร้างสรรค์

3. รูปแบบและองค์ประกอบของผลงาน

4. ประเภทและแนวคิดทางศิลปะของผลงาน

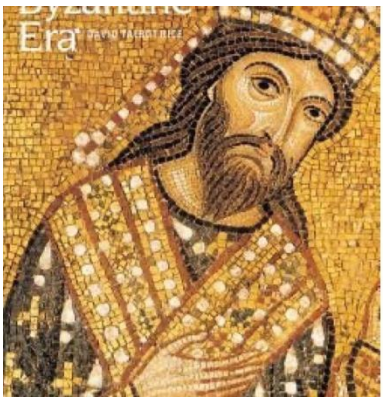
5. คุณค่าและความสำคัญ



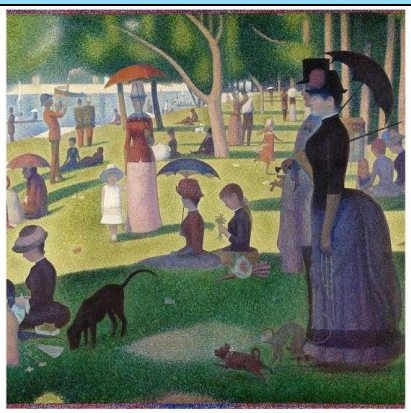
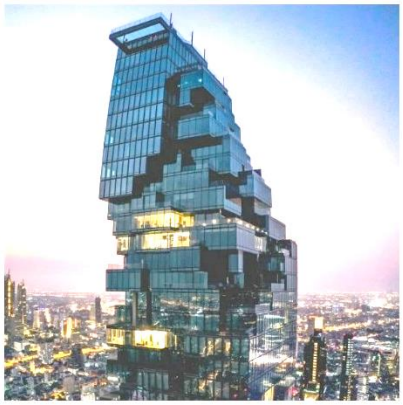
เนื้อหาสาระ

1. ความหมาย: ศิลปะสากลหมายถึงการสร้างสรรค์ที่มีความเป็นสากล ซึ่งสามารถเข้าใจและรับรู้ได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ภาษา หรือวัฒนธรรม เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ความคิด และความงามผ่านรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือศิลปะสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ศิลปะสากลมีลักษณะที่สามารถเชื่อมโยงคนจากวัฒนธรรมและสังคมต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแปลความหมาย ศิลปะสากลยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารความคิด ความรู้สึก และปรัชญาของมนุษย์ในมิติที่ลึกซึ้งกว่าภาษาพูดหรือเขียน นอกจากนี้ ศิลปะสากลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความสุนทรียะ

2. ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของศิลปะสากล

ยุคของศิลปะสากล	ตัวอย่างผลงานศิลปะ
ยุคโบราณ: เน้นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อทำเป็นสุสานของฟาโรห์ ซึ่งภายหลังถูกจัดเป็นเทวสถาน เป็นส่วนใหญ่ ภายในห้องพีระมิด นอกจากจะบรรจุพระศพของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่า ผนังภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนสี บรรยายด้วยอักษรโบราณ แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ **(พีระมิดอียิปต์)**	
ยุคกลาง: เป็นศิลปะที่มีลักษณะเชื่อมโยงความคิดและรูปแบบระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกัน มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ศิลปะมีลักษณะใหญ่โต คงทนถาวร ประดับตกแต่งด้วยการใช้พื้นผิว (Texture) อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการนำโมเสกมาตกแต่งเป็นรูปพระเยซูตามผนังโบสถ์ **(โมเสกประดับพระเยซูคริสต์)**	
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา: ภาพหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอันลึกลับ (mystic smile) ที่โด่งดังไปทั่วโลก ศิลปินสร้างสรรค์ในรูปความงามตามธรรมชาติ และความงามที่เป็นศิลปะแบบคลาสสิก โดยจัดองค์ประกอบภาพให้มีความงาม มีความเป็นมิติ มีความสัมพันธ์กับการมองเห็น ใช้เทคนิคการเน้นแสงเงาให้เกิดดุลยภาพ มีระยะตื้นลึก ตัดกันและความกลมกลืน เน้นรายละเอียดได้อย่างสวยงาม **(ภาพโมนาลิซา)**	

ยุคของศิลปะสากล	ตัวอย่างผลงานศิลปะ
ยุคบาร็อค: งานสถาปัตยกรรม ที่มีการตกแต่งประดับประดาที่ให้ความรู้สึกอ่อนไหว มีลวดลายประดิษฐ์มากและซับซ้อน จนฟุ้งเฟ้อเกินความพอดี **(พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส)**	
ยุคโรโคโค: สิ่งที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการ วิจิตรพิสดารจนเกินงาม เป็นลักษณะการจัดองค์ประกอบของศิลปะที่เน้นรายละเอียดส่วนย่อยอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการใช้ส่วนโค้ง ส่วนเว้า งานจิตรกรรม และประติมากรรม ยังคงเน้นรูปร่างรูปทรงธรรมชาติ (Realistic) แต่ใช้สีรุนแรงขึ้น **เฟอร์นิเจอร์โรโคโค (Rococo furniture)**	
ยุคนีโอคลาสสิค: เป็นรูปแบบศิลปะที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่า ภาพเขียนจะสะท้อนเรื่องราวทางอารยธรรม เน้นความสง่างามของรูปร่างทรวดทรงของคนและส่วนประกอบของภาพ มีขนาดใหญ่โต แข็งแรง มั่นคง ใช้สีกลมกลืน มีดุลยภาพของแสง และเงาที่งดงาม **(พระราชวังบักกิงแฮม)**	
ยุคโรแมนติก: ไมเคิล แองเจลโล (Michel Angelo) เป็นศิลปินผู้มีความสามารถ และรอบรู้ในวิทยาการแทบทุกแขนง โดยเฉพาะรอบรู้ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม งานประติมากรรมสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงและเป็นผลงานชิ้นเอก คือรูปเดวิด (David) หนุ่มผู้มีเรือนร่างที่งดงาม แสดงถึงรายละเอียดของกายวิภาค (anatomy) **(David, by Michelangelo)**	

ยุคของศิลปะสากล	ตัวอย่างผลงานศิลปะ
ยุคอิมเพรสชันนิสม์: กลุ่มศิลปินอิมเพรสชันนิสม์เริ่มเบื่อรูปแบบที่มีหลักความงามแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ เปลี่ยนเป็นสิ่งเชื่อมโยง เน้นด้วยแสง สี บรรยากาศ ศิลปินที่สำคัญของกลุ่มอิมเพรสชันนิสม์ ได้แก่ โคลด โมเนต์ (Claude Monet) **(A Sunday on La Grande Jatte)**	
ยุคโพสต์อิมเพรสชันนิสม์: ศิลปะแบบโพสต์อิมเพรสชันนิสม์จะไม่เลียนแบบจากสิ่งที่เป็นจริงโดยการสร้างรูปทรงใหม่ แต่นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น การระบายสีด้วยเทคนิคขีด ๆ จุด ๆ เน้นสี แสงเงาให้เกิดมิติ บรรยากาศ ความงามและความประทับใจ ศิลปินในกลุ่มนี้ ได้แก่ แวนโกะห์ (Van Gogh) โกแกง (Gauguin) **(วินเซนต์ แวน โก๊ะ)**	
ศิลปะสมัยใหม่: เน้นความริเริ่มสร้างสรรค์ มีการนำวัสดุ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมมากขึ้น โดยการนำเอากระจก เหล็ก และระบบการก่อสร้างที่เรียกว่า ระบบสำเร็จรูป ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ ๆ ตามยุคสมัย **(คิง เพาเวอร์ มหานคร)**	
ศิลปะร่วมสมัย: เป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปินแต่ละคน เน้นความเป็นตัวของตัวเองที่แสดงความประทับใจในความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ ๆ รวมถึงเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานมากขึ้น **(Cloud Gate เมล็ดถั่วกระจก)**	

3. คุณค่าความสำคัญของศิลปะสากล

- คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์: ความสวยงามและความประณีต
- คุณค่าทางวัฒนธรรม: สะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมของสังคม
- คุณค่าทางประวัติศาสตร์: บันทึกเหตุการณ์และวิถีชีวิตในอดีต
- คุณค่าทางการศึกษา: ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเกต และจินตนาการ

เรื่องที่ 2 หลักองค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์ เป็นเสมือนภาษาที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารความคิดและอารมณ์ของตนเอง การศึกษาและทำความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์จะช่วยให้สามารถตีความและชื่นชมผลงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และจินตนาการของเราให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. ในชีวิตประจำวันของเรา เราพบเจอกับศิลปะรูปแบบใดบ้าง
2. การเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์จะช่วยให้เราทำอะไรได้บ้าง มีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน และอาชีพในอนาคต
3. สี รูปทรง และองค์ประกอบอื่น ๆ ของศิลปะสามารถสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างไร และเราสามารถใช้องค์ประกอบศิลป์ในการสื่อสารความรู้สึกของเราได้หรือไม่

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

ให้ผู้เรียนออกแบบเครื่องประดับร่างกายและสถานที่จากวัสดุธรรมชาติ

1. **สำรวจธรรมชาติ:**ให้ผู้เรียนออกไปสำรวจธรรมชาติรอบ ๆ ศกร.ระดับตำบล หรือในสวน เพื่อเก็บวัสดุธรรมชาติที่หลากหลายและน่าสนใจ
2. **สังเกตและวิเคราะห์:** ให้ผู้เรียนสังเกตสี รูปทรง ลวดลาย และพื้นผิวของวัสดุที่เก็บมา พูดคุยถึงความแตกต่างและความสวยงามของแต่ละชิ้น
3. **ออกแบบ:** ให้ผู้เรียนร่างแบบผลงานที่ต้องการจะสร้างสรรค์ โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เก็บมาเป็นองค์ประกอบหลัก
4. **นำเสนอผลงาน:** ให้แต่ละคนนำเสนอ พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และองค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้



กิจกรรมที่ 2

ให้ผู้เรียนนำองค์ประกอบศิลป์ออกแบบผลงานศิลปะสากล

ใบงานเรื่ององค์ประกอบของศิลป์

คำชี้แจง: ให้ผู้เรียนนำองค์ประกอบศิลป์มาออกแบบผลงานศิลปะสากล



เนื้อหาสาระ

องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน น้ำหนัก แสงและเงา ลักษณะพื้นผิว ที่ว่างและสี ที่นำมาใช้เป็นสื่อในการแสดงออก และสร้างความหมาย โดยนำมาจัดเข้าด้วยกันเป็นผลงาน อันเกิดเป็นรูปร่างและเนื้อหาเรื่องราวเด่นชัดในงานศิลปะและการออกแบบ ที่แสดงออกเพื่อการสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้น

องค์ประกอบศิลป์: พื้นฐานของการสร้างสรรค์

องค์ประกอบศิลป์เปรียบเสมือนตัวอักษรที่นำมาเรียงต่อกันเป็นประโยค เพื่อสร้างสรรค์ภาพที่สื่อความหมายและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ศิลปินทุกคนต้องเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

องค์ประกอบศิลป์หลัก ๆ ได้แก่

- **จุด (Point):** เป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่ง จุดสามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย เช่น ความสนใจ ความตื่นเต้น หรือการเคลื่อนไหว



- **เส้น (Line):** เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด เส้นสามารถสื่อความหมายได้หลากหลาย เช่น ความแข็งแรง อ่อนโยน ความเคลื่อนไหว หรือทิศทาง



- **รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form)** รูปร่าง คือ พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้างและความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ต่อเนื่องจากรูปร่าง โดยมีความหนาหรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมีความชัดเจนและสมบูรณ์



- **สี (Color):** เป็นองค์ประกอบที่สร้างความรู้สึกและอารมณ์ได้มากที่สุด สีสามารถแบ่งได้เป็น สีหลัก สีรอง และสีเสริม



- **แสงและเงา (Light and Shade):** สร้างความรู้สึกของมิติและความสมจริงให้กับภาพ



- **พื้นผิว (Texture):** คือ ลักษณะผิวสัมผัสของวัตถุ พื้นผิวสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น เรียบเนียน หยาบ ขรุขระ เป็นต้น



- **ขนาด (Size):** คือ ขนาดของวัตถุเมื่อเทียบกับวัตถุอื่น ๆ ขนาดสามารถสร้างความรู้สึกของความสำคัญ ความโดดเด่น หรือความเล็กน้อย



- **รูปแบบ (Pattern):** คือการจัดเรียงขององค์ประกอบซ้ำ ๆ กัน รูปแบบสามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นระเบียบ ความสวยงาม หรือความน่าเบื่อหน่าย



หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

เมื่อนำองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ มาจัดรวมกัน จะต้องคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบ เพื่อให้ภาพมีความสมดุล สวยงาม และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน หลักการจัดองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

- **สมดุล (Balance):** การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้มีความสมดุลกันทางสายตา
- **จังหวะ (Rhythm):** การสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวหรือการไหลของสายตา
- **ความสามัคคี (Harmony):** การสร้างความรู้สึกของความเป็นหนึ่งเดียวกัน
- **ความตัดกัน (Contrast):** การสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ
- **จุดสนใจ (Emphasis):** การเน้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในภาพ

การนำองค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้

การเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ผลงานศิลปะของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

ตัวอย่างการนำองค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้

ภาพวาด: ศิลปินใช้สีเส้น รูปร่าง และขนาด เพื่อสร้างภาพที่สวยงามและสื่อความหมายได้หลากหลาย



ประติมากรรม: ศิลปินใช้รูปทรง ขนาด และพื้นผิว เพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่มีมิติ



สถาปัตยกรรม: สถาปนิกใช้เส้น รูปร่าง และสัดส่วน เพื่อออกแบบอาคารที่สวยงามและใช้งานได้จริง



การออกแบบกราฟิก: นักออกแบบใช้สี รูปร่าง และตัวอักษร เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบที่ดึงดูดสายตา



เรื่องที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาประดับตกแต่งร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งสถานที่ สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป

การตกแต่งเป็นเสมือนการเติมสีสันให้กับชีวิต การเลือกสิ่งของมาประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ต่าง ๆ นั้น ล้วนสะท้อนรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน การเรียนรู้หลักการในการเลือกและจัดวางสิ่งของเหล่านี้ จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์พื้นที่ที่สวยงามและน่าอยู่ได้อย่างลงตัว



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. การตกแต่งร่างกายและที่อยู่อาศัยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานความงามแบบใด
2. การส่งเสริมให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
3. การผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมจากหลากหลายแหล่งมีความน่าสนใจอย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประดับตกแต่งร่างกายและสถานที่จากวัสดุธรรมชาติ

1. ลงมือปฏิบัติ : ให้ผู้เรียนเลือกวัสดุธรรมชาติที่ต้องการนำมาใช้ และสร้างสรรค์ผลงานตามแบบที่ออกแบบไว้

2. นำเสนอผลงาน: แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง พร้อมอธิบายแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์



เนื้อหาสาระ

การตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ต่าง ๆ ล้วนเป็นการสื่อสารและแสดงออกถึงตัวตนของผู้คน การตกแต่งที่สวยงามและลงตัวไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่น แต่ยังช่วยสร้างความสุขและอารมณ์ที่ดีให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสอีกด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจสำคัญของการตกแต่ง การนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายมาประยุกต์ใช้ การผสมผสานสีสันและลวดลายที่แตกต่าง หรือการนำเอาองค์ประกอบทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ ล้วนเป็นตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ได้

นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว ความงามก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ การเลือกใช้สีสันที่กลมกลืน การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างสมดุล และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ล้วนส่งผลต่อความสวยงามของผลงาน

ความเหมาะสม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การเลือกใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการตกแต่ง การคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและสังคม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมล้วนเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

การตกแต่งจึงไม่ใช่เพียงแค่การทำให้สิ่งของสวยงาม แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของเรา การเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และตกแต่งสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จะช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

สรุปได้ว่า การตกแต่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความงาม และความเหมาะสมเข้าด้วยกัน การใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ จะช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและมีความหมาย ดังตัวอย่างการนำองค์ประกอบศิลป์ไปประยุกต์ใช้

ประเภทการตกแต่ง	ตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์	ตัวอย่างความงาม	ตัวอย่างความเหมาะสม
ร่างกาย	การทำผมทรงใหม่ๆ, การแต่งหน้าแบบยูนิคอร์น	การเลือกเครื่องประดับที่เข้ากับสีผิว	การเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับโอกาส
ที่อยู่อาศัย	การนำของเก่ามาดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์	การใช้สีสันที่สดใสในห้องนั่งเล่น	การเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากับขนาดห้อง
สถานที่	การตกแต่งร้านกาแฟด้วยสไตล์วินเทจ	การใช้ไฟส่องสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติก	การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ



ภาพตกแต่งร่างกาย



ภาพตกแต่งที่อยู่อาศัย



ภาพตกแต่งสถานที่

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 12 ศิลปะสากล

เรื่องที่ 1 ความหมาย ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท คุณค่าความสำคัญของศิลปะสากล



กิจกรรม

ตัวอย่างหัวข้อการอภิปราย

ภาพโมนาลิซาของเลโอนาร์โด ดา วินชี เป็นผลงานชิ้นเอกที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมาหลายศตวรรษ การอภิปรายเกี่ยวกับภาพวาดชิ้นนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเปิดกว้างสำหรับการตีความที่หลากหลาย ดังนั้น เราลองมาเจาะลึกหัวข้อการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ประวัติความเป็นมาและที่มาของภาพวาด

- ใครคือโมนาลิซา: เราจะสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของหญิงสาวในภาพได้หรือไม่
- ทำไมเลโอนาร์โด ดา วินชี ถึงเลือกที่จะวาดภาพนี้?: มีแรงบันดาลใจใดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
- ภาพวาดนี้ถูกสร้างขึ้นในบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมอย่างไร: การเมือง ศิลปะ และวัฒนธรรม ในยุคเรเนซองส์มีอิทธิพลต่อภาพวาดอย่างไรบ้าง

2. วิวัฒนาการและกระบวนการสร้างสรรค์

- เทคนิคการวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเลโอนาร์โด ดา วินชี คืออะไร
- การใช้แสง เงา และสี: เลโอนาร์โด ดา วินชีใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อสร้างผลกระทบทางสายตาอย่างไร
- การเปลี่ยนแปลงของภาพวาดตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์: มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเลโอนาร์โด ดา วินชีได้ทำการแก้ไขภาพวาดบ้างหรือไม่

3. รูปแบบและองค์ประกอบของภาพวาด

- การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ: ทำไมเลโอนาร์โด ดา วินชี จึงจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ทิวทัศน์ มือ และใบหน้า ในตำแหน่งนั้น
- การใช้เส้นและรูปทรง: เส้นและรูปทรงต่าง ๆ ในภาพมีความหมายอย่างไร
- ความสมดุลและความกลมกลืนในภาพ: เลโอนาร์โด ดา วินชี สร้างความสมดุลและความกลมกลืนในภาพได้อย่างไร

4. ประเภทและแนวคิดทางศิลปะ

- โมนาลิซาจัดอยู่ในประเภทของภาพวาดแบบใด: ภาพเหมือน ภาพบุคคล หรือภาพแนวอื่น ๆ
- แนวคิดทางศิลปะที่สะท้อนออกมาในภาพวาด: เลโอนาร์โด ดา วินชี ต้องการสื่อสารอะไรผ่านภาพวาดชิ้นนี้

- การเปรียบเทียบกับผลงานศิลปะอื่น ๆ ในยุคเดียวกัน: โมนาลิซามีความแตกต่างและความคล้ายคลึงกับผลงานศิลปะอื่น ๆ ในยุคเรเนซองส์อย่างไร

5. คุณค่าและความสำคัญ

- เหตุผลที่ทำให้โมนาลิซากลายเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก: อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ภาพวาดชิ้นนี้เป็นที่รู้จักและชื่นชมทั่วโลก
- อิทธิพลของโมนาลิซาต่อวงการศิลปะ: ภาพวาดชิ้นนี้มีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังอย่างไรบ้าง
- ความหมายของโมนาลิซาในปัจจุบัน: โมนาลิซายังคงมีความหมายและความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันอย่างไร

เรื่องที่ 2 หลักองค์ประกอบศิลป์



กิจกรรมที่ 1

ตัวอย่างเครื่องประดับที่สามารถสร้างได้:

1. สร้อยคอ: ใช้เมล็ดพืชหลากสีมาเรียงต่อกันเป็นลวดลาย
2. กำไลข้อมือ: ใช้กิ่งไม้แห้งและเชือกมาพันเป็นกำไล
3. ต่างหู: ใช้ใบไม้แห้งและดินเหนียวปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ
4. มงกุฎ: ใช้ดอกไม้หลากสีมาประดับ



กิจกรรมที่ 2



เรื่องที่ 3 ความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความเหมาะสมของสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาประดับตกแต่งร่างกาย ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งสถานที่ สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป



กิจกรรม

ตัวอย่างผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้

- ประดับตกแต่งร่างกาย: สร้อยคอจากเมล็ดพืชและเปลือกหอย กำไลข้อมือจากกิ่งไม้และดอกไม้แห้ง ที่คาดผมจากใบไม้และดอกไม้สด
- ประดับตกแต่งสถานที่: ภาพวาดจากใบไม้และดอกไม้ โมบายล์จากกิ่งไม้และเปลือกหอย กระถางต้นไม้จากเปลือกไม้

บทที่ 13
ดนตรีสากล

สาระสำคัญ



ดนตรีสากลเป็นภาษาสากลที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงทุกคนทั่วโลกได้อย่างมีความหมาย ดังนั้นจึงควรมีความเข้าใจถึงที่มา รูปแบบ เทคนิควิธีการบรรเลงดนตรีสากล และคุณค่าความไพเราะของดนตรีสากล

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบและเทคนิค วิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
2. อธิบายคุณค่า และความไพเราะของการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล
3. ชื่นชม และเห็นคุณค่าของดนตรีสากล

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ
เรื่องที่ 2 รูปแบบและเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท
เรื่องที่ 3 คุณค่าและความไพเราะของการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ

การกำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่าย ๆ จากธรรมชาติรอบข้าง คือ เริ่มจากการปรบมือ ผิวปาก เคาะหิน หรือนำกิ่งไม้มาตีกัน ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกที่นำมาเล่นกันแพร่หลายในปัจจุบัน การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณที่สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิด คือ ไลรา คีธารา และออโรส จนต่อมามีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- ผู้เรียนเคยเล่นดนตรีสากลอะไรบ้าง และเครื่องดนตรีที่เล่นมีวิวัฒนาการจากอะไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและทำการนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ศึกษา รวมถึงการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญในประวัติศาสตร์และการพัฒนาของดนตรี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

เนื้อหาสาระ



1. ประวัติความเป็นมา

ยุคโบราณ: เครื่องดนตรีในยุคแรกมักทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หนัง และโลหะ มีการใช้เครื่องดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อความบันเทิงในชีวิตประจำวัน

ยุคกลาง: ดนตรีในยุคกลางมีความสำคัญในศาสนจักร มีการพัฒนาเครื่องดนตรีประเภทสาย เช่น ไวโอลิน และเครื่องดนตรีประเภทลม เช่น ฟลุต เป็นต้น

ยุคเรอเนซองส์: ดนตรีมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการพัฒนาระบบโน้ตเพลง และเกิดวงดนตรีขนาดใหญ่

ยุคบาโรค: ดนตรีมีลักษณะที่โอ่อ่าอลังการ มีการใช้เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด เช่น ออร์แกน เปียโน เป็นต้น

ยุคคลาสสิก: ดนตรีมีความสมดุลและสง่างาม มีการพัฒนารูปแบบดนตรี เช่น ซิมโฟนี คอนเชอร์โต้

ยุคโรแมนติก: ดนตรีเน้นอารมณ์และความรู้สึก มีการใช้เครื่องดนตรีหลากหลายชนิด และเกิดแนวเพลงใหม่ ๆ เช่น โอเปรา เป็นต้น

ยุคสมัยใหม่: ดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานดนตรีจากวัฒนธรรมต่าง ๆ และเกิดแนวเพลงใหม่ ๆ เช่น แจ๊ส ร็อก ป๊อป เป็นต้น

2. วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล



เครื่องดนตรีประเภทสาย: วิวัฒนาการจากเครื่องดนตรีสายโบราณ เช่น ไวโอลิน มาเป็นเครื่องดนตรีสายสมัยใหม่ เช่น กีตาร์ เบส เป็นต้น

เครื่องดนตรีประเภทลม: วิวัฒนาการจากเครื่องดนตรีลมโบราณ เช่น ฟลุต มาเป็นเครื่องดนตรีลมสมัยใหม่ เช่น แซกโซโฟน ทรัมเป็ต เป็นต้น

เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด: วิวัฒนาการจากออร์แกน มาเป็นเปียโน และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซินธิไซเซอร์ เป็นต้น

เครื่องดนตรีประเภทตี: วิวัฒนาการจากกลองโบราณ มาเป็นชุดกลอง และเครื่องดนตรีตีอื่น ๆ เช่น ไซโลโฟน เป็นต้น

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล



เทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เกิดเครื่องดนตรีไฟฟ้า เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ดนตรี

วัฒนธรรม: การผสมผสานวัฒนธรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดดนตรีแนวใหม่ ๆ และการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรี

สังคม: ความต้องการของสังคมและความนิยมในแนวเพลงต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาเครื่องดนตรี

เศรษฐกิจ: การพัฒนาทางเศรษฐกิจทำให้เกิดอุตสาหกรรมดนตรี และมีการผลิตเครื่องดนตรีจำนวนมาก

4. ความสำคัญของดนตรีสากล

เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร: ดนตรีสามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวต่าง ๆ ได้

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม: ดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตก และมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

เป็นเครื่องมือในการศึกษา: การเรียนรู้ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น สมาธิ ความอดทน และความคิดสร้างสรรค์

การศึกษาความเป็นมาของเครื่องดนตรีสากลจำเป็นต้องเข้าใจพัฒนาการและบทบาทในสังคม ว่าไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการแสดงดนตรี แต่ยังมีความสำคัญในด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ และการแสดงออกทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ดนตรีสากลมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเครื่องดนตรี รูปแบบดนตรี และแนวเพลงต่าง ๆ ที่หลากหลาย

เรื่องที่ 2 รูปแบบและเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท

เครื่องดนตรีสากลมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป การทำความเข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการเล่นของแต่ละประเภท จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะกับความสนใจและสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- เครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันอย่างไร

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ให้ผู้เรียนทำวิดีโอสั้น ๆ แสดงการเล่นเครื่องดนตรีจำลอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจ เพื่อนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

เนื้อหาสาระ



1. ประเภทของเครื่องดนตรี

1.1 เครื่องสาย (String Instruments)

ลักษณะเด่น: สร้างเสียงโดยการดีดหรือขูดเส้นสายที่ยึดติดอยู่กับตัวเครื่องดนตรี

ตัวอย่าง: กีตาร์ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล เบส

วิธีการเล่น: ใช้คันชักในการขูดเส้นสาย เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล หรือใช้ปลายนิ้วดีดเส้นสาย เช่น กีตาร์ เบส

เทคนิค: การดีด การขูด การกด การเลื่อนนิ้ว วิบริโต้



1.2 เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)

ลักษณะเด่น: สร้างเสียงโดยการเป่าลมผ่านปากเป่า ทำให้ลิ้นสั่น

ตัวอย่าง: ฟลุต ปี่ชวา คลาริเน็ต โอโบ

วิธีการเล่น: เป่าลมผ่านปากเป่า ควบคุมลมหายใจและการเคลื่อนไหวของลิ้น

เทคนิค: การเป่า การควบคุมลมหายใจ การเล่นลิ้น การใช้คีย์



1.3 เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

ลักษณะเด่น: สร้างเสียงโดยการเป่าลมผ่านริมฝีปากสั่น ทำให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนในท่อโลหะ

ตัวอย่าง: ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา ฮอร์น

วิธีการเล่น: เป่าลมผ่านริมฝีปากสั่น ควบคุมลมหายใจและการสั่นของริมฝีปาก

เทคนิค: การเป่า การควบคุมลมหายใจ การสั่นริมฝีปาก การใช้วาล์ว



1.4 เครื่องเป่า (Wind Instruments)

ลักษณะเด่น: รวมเครื่องดนตรีที่สร้างเสียงโดยการเป่าลม โดยมักจะใช้ในการบรรเลงดนตรีแจ๊สและป๊อป

ตัวอย่าง: แซกโซโฟน

วิธีการเล่น: เป่าลมผ่านปากเป่า คล้ายคลึงกับเครื่องลมไม้

เทคนิค: การเป่า การควบคุมลมหายใจ การเล่นลิ้น การใช้คีย์

1.5 เครื่องกระทบ (Percussion Instruments)

ลักษณะเด่น: สร้างเสียงโดยการตีหรือกระทบ

ตัวอย่าง: กลองชุด กลองไทโกะ

วิธีการเล่น: ใช้ไม้กลองหรือมือตีหรือกระทบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดนตรี

เทคนิค: การตี การกระทบ การควบคุมจังหวะ





1.6 เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments)

ลักษณะเด่น: สร้างเสียงโดยการกดปุ่มหรือคีย์

ตัวอย่าง: เปียโน ออร์แกน ซินธิไซเซอร์

วิธีการเล่น: กดปุ่มหรือคีย์เพื่อสร้างเสียง

เทคนิค: การกดคีย์ การใช้เท้าเหยียบคันเหยียบ การควบคุมเสียง

การเลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสม: **ความสนใจ**: เลือกเครื่องดนตรีที่คุณชอบเสียงและอยากเล่น

ความสามารถ: พิจารณาความสามารถทางกายภาพและความถนัดของตนเอง

โอกาสในการเรียนรู้: มีครูสอนหรือแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายหรือไม่

งบประมาณ: พิจารณาค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริม

การเรียนรู้เครื่องดนตรี ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทักษะทางดนตรีเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ความอดทน สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจ







เรื่องที่ 3 คุณค่าและความไพเราะของการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล



คุณค่าของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ มนุษย์รู้จักนำดนตรีมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หลังจากที่มนุษย์รู้จักการจดบันทึกข้อมูล จึงทำให้คนรุ่นหลังได้ทราบประวัติความเป็นมาของดนตรี การศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรี ทำให้เราเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจการสืบทอดทางวัฒนธรรมดนตรี



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

- เราได้อะไรจากการฟังเพลง
- ดนตรีแนวใดที่เหมาะกับการผ่อนคลายยามเช้า

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

ให้ผู้เรียนร่วมกันสร้างไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ดนตรี พร้อมระบุเหตุการณ์สำคัญและนักดนตรีที่ชื่นชอบ พร้อมนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน





เนื้อหาสาระ

สุนทรียศาสตร์ของดนตรี

คำว่า "สุนทรียศาสตร์" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Aesthetics” มาจากภาษากรีกว่า “Aistheticos” ซึ่งแปลว่า รู้ด้วยผัสสะ และคำว่าผัสสะนี้ หมายถึง การสัมผัสรู้หรือหยั่งรู้สุนทรียะหรือความงามอย่างเข้าใจ กล่าวโดยสรุปคือ คำว่า สุนทรียศาสตร์ เป็นเนื้อหาว่าด้วยการศึกษาเรื่อง มาตรฐานของความงามในเชิงทฤษฎี อันเกี่ยวกับประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ กฎเกณฑ์ทางศิลปะ ศิลปินใช้ธาตุ 4 อย่าง เป็นองค์ประกอบในการสร้างงานศิลปะ ซึ่งธาตุทั้ง 4 อย่างนั้น ได้แก่

1. สื่อ (Media) เช่น ศิลปะทางดนตรีใช้ เสียงเป็นสื่อ
2. เนื้อหา (Context) เช่น ศิลปะทางดนตรีใช้ สเกลเสียง โหมดเสียง สังคีตลักษณ์หรือไวยากรณ์เพลงและเนื้อร้องที่เป็นเนื้อหาของดนตรี

3. สุนทรียธาตุ (Aesthetical elements) ซึ่งมี 3 อย่าง คือ ความงาม (Beauty) ความน่าเพลิดเพลินเจริญใจ (Picturesqueness) และความเป็นเลิศ เช่น ศิลปะทางดนตรีใช้สังคีตลักษณ์ในกระบวนแบบต่าง ๆ เป็นสุนทรียธาตุ เป็นต้น

4. ศิลปินธาตุ (Artistic elements) หมายถึง ความในใจหรือประสบการณ์เดิม หรือความใฝ่ฝันหรือความเฉลียวฉลาดเฉพาะตัว ที่ศิลปินแต่ละคนนำออกมาสอดแทรกไว้ในชิ้นงานของตนเอง

การรับรู้ความงามหรือสุนทรียะของดนตรี

ดนตรีเป็นสุนทรียะหรือที่เรียกกันว่า ความงาม ความไพเราะ เป็นเรื่องของนามธรรมยากที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยภาษาเพราะแต่ละคนจะมีรสนิยมในเรื่องของความงามที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับจะมีอิทธิพลต่อความชอบ ความรัก ความไพเราะ ความงามที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ถึงแม้ว่าสุนทรียะทางดนตรีเป็นเรื่องนามธรรมเกิดขึ้นจำเพาะตัวบุคคลแต่เราสามารถสร้างประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ได้



การสืบสานภูมิปัญญาทางดนตรีสากล

คุณค่าทางดนตรี ดนตรีเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ วิถีชีวิต จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ลักษณะนิสัย ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนท้องถิ่นต่าง ๆ ในยุคสมัยต่างกัน ดังนั้น ดนตรีจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ และนับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรได้รับการบำรุงรักษา เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป การที่ดนตรีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงมีประโยชน์และช่วยพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกหลายประการ เช่น



ประโยชน์ของดนตรี

1. ช่วยทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปล่อยอารมณ์ไม่ให้เครียด ผ่อนคลายอารมณ์ได้
2. ช่วยทำให้จิตใจสงบ และมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยพัฒนาด้านการเรียนรู้ โดยนำไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์
4. ช่วยเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและใช้เป็นกิจกรรมทำร่วมกัน ของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เช่น การร้องเพลงและเต้นรำด้วยกัน

การอนุรักษ์ผลงานทางดนตรี

ผลงานทางดนตรีที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยศิลปินในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและศิลปินทั้งหลาย และบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติจึงมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป มีหลากหลายวิธีดังต่อไปนี้

1. ศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของวงดนตรีประเภทต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปินที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

3. ถ้ามีโอกาสให้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับงานดนตรี เพื่อดูข้อมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีและวิวัฒนาการทางดนตรี

4. เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี เช่น การแสดงดนตรี การจัดงานรำลึกถึงศิลปิน เป็นต้น

5. ถ้ามีโอกาสได้เรียนดนตรีโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านควรให้ความสนใจและตั้งใจเรียนเพื่อสืบทอดงานดนตรีต่อไป

6. ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่นของตนและท้องถิ่นอื่น

ดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มอบความสุข
และประสบการณ์อันน่าประทับใจ การเรียนรู้และเข้าใจดนตรีสากล
จะช่วยให้เราสามารถอิ่มเอมกับความงามและคุณค่าของดนตรีได้อย่างเต็มที่

ดนตรีสากลนั้นเปรียบเสมือนภาษาสากลที่สามารถสื่อสารความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ได้หลากหลาย นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ดนตรีสากลยังมีคุณค่าและสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจ

คุณค่าของดนตรีสากล

การสื่อสารผ่านดนตรีเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ดนตรี เป็นศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ ดนตรีมีบทบาทสำคัญในการบำบัดทางจิตวิทยา ช่วยลดความเครียดและสร้างความผ่อนคลาย การเรียนรู้ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การฟัง การจำ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น และดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ ช่วยสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 13 ดนตรีสากล

เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ



กิจกรรม

การนำเสนอเครื่องดนตรี: ไวโอลิน

การศึกษา

- ประวัติไวโอลินเริ่มต้นในยุคไหน
- วิวัฒนาการจากการทำด้วยไม้ธรรมชาติสู่การใช้วัสดุสมัยใหม่
- ความสำคัญในห้องดนตรีคลาสสิกและยุคใหม่
- เปรียบเทียบไวโอลินกับเครื่องดนตรีประเภทอื่น เช่น เชลโล่ ว่ามีลักษณะเฉพาะหรือความต่างกัน
- ให้แต่ละคนลองเล่นไวโอลิน ทำให้เพื่อนสามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานไปพร้อมกัน

เรื่องที่ 2 รูปแบบ และเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท



กิจกรรม

ตัวอย่างหัวข้อวิดีโอ

การแสดง:

- วันนี้ผมจะมาโชว์การเล่นกีตาร์แอร์จากกล่องกระดาษครับ
- พบกับการแสดงไวโอลินสุดพิเศษจากหลอดดูด
- มาสนุกกับการตีกลองชุดจากถ้วยพลาสติกกันเถอะ

การเล่าเรื่อง:

- เรื่องราวของไวโอลิน: เครื่องดนตรีที่สร้างเสียงแห่งความรัก
- เปิดโลกของกลองไทโกะ: ดนตรีจากแดนอาทิตย์อุทัย

เรื่องที่ 3 คุณค่าและความไพเราะของการบรรเลงเครื่องดนตรีสากล



กิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม:

1. ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ นักดนตรีชื่อดัง เครื่องดนตรีที่นิยม และลักษณะเด่นของดนตรีในยุคนั้น
2. เหตุการณ์สำคัญ 5.Gun N’ Roses Not in this Lifetime Tour. Live in Bangkok



3. นักดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ เช่น กุสตาฟ มาห์เลอร์ (Gustav Mahler) คาร์ล เซอร์นี (Carl Czerny) · คาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) โกล้ด เดอบูซี (Claude Debussy) ·ชอร์ช บีเซ (Georges Bizet)

บทที่ 14
นาฏศิลป์สากล

สาระสำคัญ



นาฏศิลป์ และละครสากล มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน มีความหลากหลายทางรูปแบบ และเนื้อหา การศึกษาประวัติ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และละครสากล จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะการแสดงเหล่านี้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลในโอกาสต่าง ๆ
2. เรียนรู้จากดูการแสดงทางนาฏศิลป์ และการละครสากลประเภทต่าง ๆ
3. ชื่นชม และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์สากล

ขอบข่ายเนื้อหา

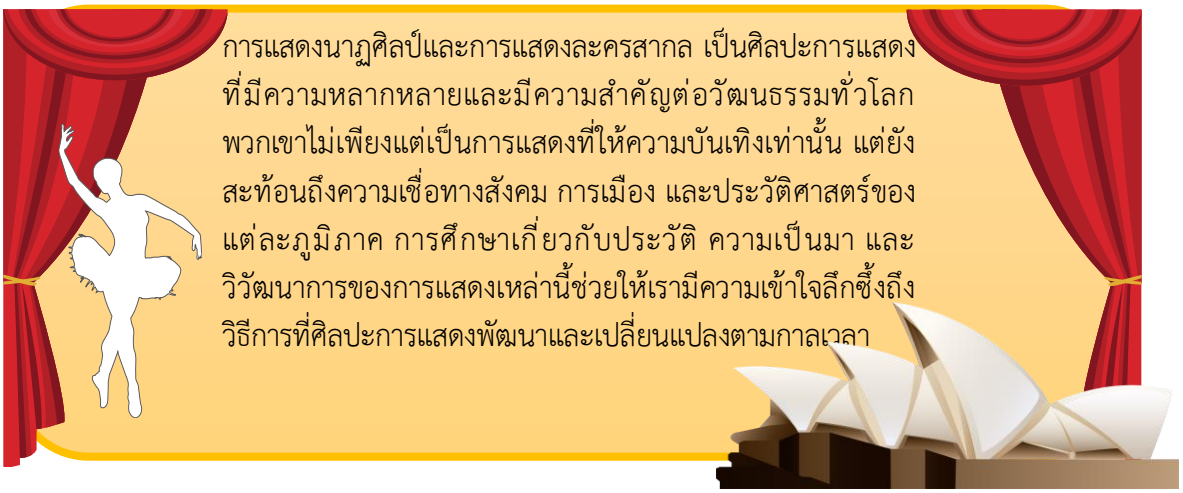
เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลประเภทต่าง ๆ

เรื่องที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลในโอกาสต่าง ๆ

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลประเภทต่าง ๆ

นาฏศิลป์ และละครสากล มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน มีความหลากหลายทางรูปแบบ และเนื้อหา การศึกษาประวัติ วิวัฒนาการของนาฏศิลป์ และละครสากล จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของศิลปะการแสดงเหล่านี้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การแสดงนาฏศิลป์และการแสดงละครสากล เป็นศิลปะการแสดงที่มีความหลากหลายและมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมทั่วโลก พวกเขาไม่เพียงแต่เป็นการแสดงที่ให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค การศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการของการแสดงเหล่านี้ช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งถึงวิธีการที่ศิลปะการแสดงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

คุณสนใจประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์สากลประเภทใดเป็นพิเศษ ?



กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

1. ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และวิวัฒนาการของการแสดงนาฏศิลป์สากล โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือ วารสาร และอินเทอร์เน็ต
2. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนรู้ เช่น วิดีโอสารคดี อินโฟกราฟิก หรือบทความออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลที่ค้นคว้าได้
3. ผู้เรียนเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปยังห้องเรียนหรือชุมชนออนไลน์ และเปิดให้เพื่อนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็น



เนื้อหาสาระ

ประวัติ ความเป็นมา

นาฏศิลป์สากล คือ ศิลปะการเคลื่อนไหวที่สื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวผ่านร่างกาย เป็นภาษาสากลที่ข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรม มนุษย์ใช้การเต้นรำเพื่อสื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ การเต้นรำในยุคแรกเริ่ม มักมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา และการเฉลิมฉลองต่าง ๆ การแสดงออกทางกายภาพเหล่านี้ได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย

รากฐานของนาฏศิลป์สากล

ยุคกรีกโบราณ นาฏศิลป์กรีกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแสดงละครกรีกที่แบ่งออกเป็นโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม การแสดงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและมนุษย์ โดยใช้ท่ารำและบทพูดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์

ยุคโรมัน นาฏศิลป์โรมันได้รับอิทธิพลมาจากกรีก แต่มีการพัฒนาให้มีความบันเทิงมากขึ้น โดยเน้นการแสดงที่ยิ่งใหญ่และอลังการ

ยุคกลาง นาฏศิลป์ในยุคกลางมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ โดยมีการแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิล

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์สากลในยุคปัจจุบัน แบ่งตามประเภท ดังนี้

บัลเลต์ มีต้นกำเนิดมาจากราชสำนักยุคฟื้นฟูวิทยาของอิตาลี ในศตวรรษที่ 15 ต่อมาได้แพร่หลายไปยังราชสำนักฝรั่งเศสและรัสเซีย เน้นความสง่างามและการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ มีท่าทาง ที่ซับซ้อนและสวยงาม

โมเดิร์นแดนซ์ เกิดจากการต่อต้านรูปแบบดั้งเดิมของบัลเลต์ เน้นการแสดงออกทางอารมณ์ที่อิสระและการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย

คอนเทมโพรารีแดนซ์ เป็นการผสมผสานระหว่างบัลเลต์ และโมเดิร์นแดนซ์ เน้นการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและสร้างสรรค์

ละครเพลง ผสมผสานการร้องเพลง การเต้น และการแสดงละคร มีเนื้อเรื่องที่สนุกสนานและทันสมัย

การแสดงละครสากลประเภทต่าง ๆ

โอเปรา เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการร้องเพลง ดนตรี และการแสดง โดยมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและอารมณ์ขัน

ละครพูด เป็นการแสดงที่เน้นการพูดบทบาท โดยไม่มีการร้องเพลงหรือเต้น

ละครตลก เป็นการแสดงที่เน้นความตลกขบขันเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม

สรุป

การแสดงนาฏศิลป์สากล เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการทางศิลปะและวัฒนธรรมของมนุษย์ตลอดจนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสังคมและวัฒนธรรม

เรื่องที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลในโอกาสต่าง ๆ

การแสดงนาฏศิลป์ และละครสากลมีบทบาทสำคัญในการสร้างสีสันและความหมายให้กับชีวิตของเรา การแสดงเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิง แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมและผู้คนทั่วโลก การได้ชมการแสดงเหล่านี้ จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

ในบทเรียนนี้ เราจะมาสำรวจกันว่า การแสดงนาฏศิลป์และละครสากลถูกนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อย่างไร และมีรูปแบบการแสดงที่หลากหลายเพียงใด





ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. **ผู้เรียนเคยชมการแสดงนาฏศิลป์ หรือละครสากลประเภทใดบ้าง**
2. **ผู้เรียนคิดว่าการแสดงเหล่านี้มีความสำคัญต่อสังคมอย่างไร**

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

1. **ศึกษาและสวมบทบาท** ให้ผู้เรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลป์จากยุคต่าง ๆ เช่น บัลเล่ต์ในยุคเรอเนซองส์ โอเปร่าในศตวรรษที่ 19 หรือการแสดงละครในยุคกรีกโบราณ
2. **เตรียมการแสดง** ให้แต่ละกลุ่มเตรียมการแสดงบทบาทสมมติที่แสดงถึงยุคสมัยหรือรูปแบบการแสดงที่ได้รับมอบหมาย

3. **การแสดง** ให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติต่อหน้าห้องเรียน โดยเน้นการใช้ท่าทาง การเคลื่อนไหว และบทพูด ที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคนั้น

4. **การสะท้อนผล** หลังการแสดง ให้ผู้เรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสดงบทบาทสมมติ ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และความรู้สึกส่วนตัว



เนื้อหาสาระ

2.1 การแสดงนาฏศิลป์ และละครสากลในโอกาสต่าง ๆ

นาฏศิลป์และละครสากลไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและสังคมที่ใช้ในการสื่อสาร แสดงออก และเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ มากมาย การแสดงเหล่านี้สามารถสร้างความบันเทิง สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์โอกาสสำคัญที่มักมีการแสดงนาฏศิลป์และละครสากล

2.1.1 เทศกาลและงานเฉลิมฉลอง

1) เทศกาลประจำชาติ การแสดงนาฏศิลป์และละครสากลมักถูกนำมาใช้เพื่อการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมประจำชาติ เช่น วันชาติ วันชาติของชาติต่าง ๆ

2) เทศกาลทางศาสนา การแสดงมักมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น คริสต์มาส อีสเตอร์

3) เทศกาลดนตรีและศิลปะ เป็นเวทีที่เหล่าศิลปินได้มาแสดงผลงานและสร้างสรรค์ร่วมกัน





2.1.2 งานเฉลิมฉลองส่วนบุคล

1) งานแต่งงาน การแสดงเต้นรำของคู่บ่าวสาว และแขกผู้มีเกียรติ

2) งานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

2.1.3 กิจกรรมทางสังคม

1) การกุศล การแสดงเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้

2) การรณรงค์ การใช้การแสดงเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การแสดงเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ

2.1.4 งานประชุมและสัมมนา

1) การแสดงเปิดงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจ และต้อนรับผู้เข้าร่วม

2) การแสดงปิดงาน เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญ และสร้างความประทับใจในงาน

2.1.5 การแข่งขัน

1) การประกวด เป็นเวทีให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์และละครได้แสดงออกและแข่งขันกัน

2) การแสดงโอลิมปิก การแสดงเปิดและปิดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วโลก





2.1.6 ความสำคัญของการแสดงนาฏศิลป์และละครสากลในโอกาสต่าง ๆ



สร้างความบันเทิง



สร้างแรงบันดาลใจ



เชื่อมโยงผู้คน



ส่งเสริมวัฒนธรรม



ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สรุป

การแสดงนาฏศิลป์และละครสากลมีบทบาทสำคัญในการสร้างสีสันและความหมายให้กับชีวิตของเรา การแสดงเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิง แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมและผู้คนทั่วโลก การได้ชมการแสดงเหล่านี้ จึงเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน

การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน นำทักษะและศิลปะจากการเต้นรำมาใช้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารและแสดงออก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยนาฏศิลป์สากลไม่เพียงแค่เป็นการแสดงศิลปะ แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลในชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตประจำวัน

ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. ผู้เรียนเคยลองนำการเต้นรำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไหม
2. เราสามารถประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวันในเรื่องใดบ้าง





กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

1. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการที่นาฏศิลป์สากลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การแสดงออก หรือการแก้ปัญหา

2. แต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในบริบทชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำ หรือการใช้การเต้นรำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีม

3. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบไว้ต่อหน้าชั้นเรียน โดยสาธิตและอธิบายวิธีการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

4. ครูประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการสร้างสรรค์และการนำเสนอกิจกรรม



เนื้อหาสาระ

การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน

การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน สามารถทำได้หลายวิธี โดยเน้นการนำเอาศิลปะและทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้และฝึกฝนนาฏศิลป์มาใช้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพจิต และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

1. การออกกำลังกาย และสุขภาพ

1.1 การฝึกการเคลื่อนไหว ท่าทางและการเคลื่อนไหวจากการเต้นรำ เช่น บัลเลต์ หรือการเต้นรำสมัยใหม่ สามารถนำมาใช้ในการออกกำลังกายประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว

1.2 การผ่อนคลายและสมาธิ การเคลื่อนไหวแบบช้า ๆ และมีสมาธิ เช่น ในการเต้นรำสมัยใหม่หรือการเต้นแบบร่วมสมัย (contemporary dance) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิและการผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนัก

2. การพัฒนาความมั่นใจ และการสื่อสาร

2.1 การแสดงออกทางร่างกาย การเรียนรู้วิธีการใช้ภาษากายจากนาฏศิลป์สากลช่วยให้สามารถสื่อสารความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน การนำเสนอ หรือการพูดในที่สาธารณะ

2.2 การสร้างความมั่นใจ การฝึกการเคลื่อนไหวที่สง่างามและการแสดงออกทางศิลปะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการเดิน การนั่ง และการยืน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. การสร้างความคิดสร้างสรรค์

3.1 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงาน ทักษะการออกแบบการเคลื่อนไหวและการจัดวางท่าทางในนาฏศิลป์สากลสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบท่าเต้น การทำวิดีโอคอนเทนต์ หรือการจัดอีเวนต์

3.2 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ได้จากนาฏศิลป์สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตประจำวัน โดยการมองหาวิธีการใหม่ ๆ และการคิดนอกกรอบ

4. การเสริมสร้างสุขภาพจิต

4.1 การปลดปล่อยอารมณ์ การเต้นรำสามารถเป็นวิธีการระบายความเครียดและปลดปล่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

4.2 การสร้างสมดุลในชีวิต การผสมผสานศิลปะการเคลื่อนไหวเข้ากับกิจวัตรประจำวัน ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว โดยใช้เวลาในการฝึกฝนหรือเต้นรำเพื่อผ่อนคลายและเติมพลังให้ตัวเอง





5. การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกัน การแสดงนาฏศิลป์มักต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งทักษะนี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงานหรือในการจัดการโครงการต่าง ๆ

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 14 นาฏศิลป์สากล

เรื่องที่ 1 ประวัติ ความเป็นมา วิวัฒนาการ การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลประเภทต่าง ๆ



กิจกรรม

การวิจัยข้อมูล

กิจกรรม ผู้เรียนจะเริ่มต้นด้วยการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์สากล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ในยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคเรอเนซองส์ ศตวรรษที่ 19 - 21 และศตวรรษที่ 21 โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนานาฏศิลป์ในแต่ละยุค

แหล่งข้อมูล ผู้เรียนจะใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือวิชาการ วารสารทางประวัติศาสตร์ เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ วิดีโอจากช่องสารคดี และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์

การสร้างสื่อ

กิจกรรม หลังจากการรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนจะใช้ทักษะเทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนรู้ โดยเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย เช่น

- **วิดีโอสารคดี**: ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอในการรวมภาพ ข้อความ และเสียง เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของนาฏศิลป์สากล
- **อินโฟกราฟิก**: ใช้เครื่องมือออกแบบกราฟิกในการสร้างภาพรวมของประวัติและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ โดยสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
- **บทความออนไลน์**: ใช้แพลตฟอร์มบล็อกหรือเว็บไซต์ในการเขียนบทความที่มีเนื้อหาลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติของนาฏศิลป์สากล พร้อมภาพประกอบและลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเสนอและเผยแพร่

กิจกรรม ผู้เรียนจะนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นต่อหน้าห้องเรียน โดยอธิบายถึงเนื้อหา และวิธีการที่ใช้ในการสร้างสื่อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมชั้นแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ

การเผยแพร่ หลังการนำเสนอ ผู้เรียนจะเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสถานศึกษา ช่อง YouTube หรือบล็อกที่ผู้เรียนสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ และชุมชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

เรื่องที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครสากลในโอกาสต่าง ๆ



กิจกรรม

1. ศึกษาและสวมบทบาท

กิจกรรม ผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาการแสดงนาฏศิลป์ในยุคหรือรูปแบบที่ต่างกัน เช่น บัลเล่ต์ในยุคเรอเนซองส์ โอเปร่าในศตวรรษที่ 19 หรือละคร ในยุคกรีกโบราณ ผู้เรียนจะต้องศึกษาและเข้าใจถึงพื้นฐานของการแสดงในแต่ละยุค ทั้งในเรื่องของท่าทาง การเคลื่อนไหว การใช้เสียง และบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล: ผู้เรียนจะใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ วิดีโอการแสดง หรือการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการแสดงบทบาทสมมติ

2. เตรียมการแสดง:

กิจกรรม แต่ละกลุ่มจะนำข้อมูลที่ศึกษาได้มาวางแผนและเตรียมการแสดง โดยการออกแบบท่าทาง การเคลื่อนไหว และการพูด ที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ในยุคนั้น ๆ ผู้เรียนจะต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงออกมาสมจริงและถูกต้องตามประวัติศาสตร์

3. การแสดง

กิจกรรม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะขึ้นแสดงบทบาทสมมติต่อหน้าชั้นเรียน การแสดงจะต้องเน้นที่การใช้ท่าทาง การเคลื่อนไหว และบทพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยที่ได้รับมอบหมาย เช่น ท่าทางที่สง่างาม ในบัลเล่ต์ยุคเรอเนซองส์ หรือการใช้เสียงในโอเปร่าที่มีพลังและการแสดงอารมณ์ที่เข้มข้น

ผู้ชม ผู้เรียนคนอื่น ๆ ในชั้นจะรับบทเป็นผู้ชม ซึ่งสามารถสังเกต และวิเคราะห์การแสดงของเพื่อน ๆ เพื่อเรียนรู้และเปรียบเทียบระหว่างยุคต่าง ๆ

4. การสะท้อนผล

กิจกรรม หลังจากการแสดงแต่ละกลุ่มเสร็จสิ้น ผู้เรียนทุกคนจะเข้าร่วมในกิจกรรมการสะท้อนผล โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่ได้ชม รวมถึงการสะท้อนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสวมบทบาท และการแสดง

ประเด็นการสะท้อน ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้รับจากการสวมบทบาท โดยเน้นถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าการแสดงนั้น ๆ ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงบริบทของยุคสมัย และการแสดงนาฏศิลป์สากลมากขึ้นอย่างไร

เรื่องที่ 3 การประยุกต์ใช้นาฏศิลป์สากลในชีวิตประจำวัน



กิจกรรม

1. การเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐาน

ผู้เรียนจะได้ชมวิดีโอหรือดูตัวอย่างที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้การเต้นรำในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ท่าทางจากบัลเลต์ในกีฬา การใช้การเต้นเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน หรือการเต้นรำเพื่อสุขภาพ

2. การระดมความคิด

หลังจากการระดมความคิดแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดของตนเองต่อหน้าชั้นเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้นจะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น

3. การออกแบบกิจกรรม

หลังจากออกแบบกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนจะต้องฝึกซ้อมและปรับปรุงการนำเสนอ เพื่อให้การนำเสนอกิจกรรมนั้นมีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ครูและเพื่อนร่วมชั้นจะร่วมกันให้คำแนะนำในการปรับปรุง

4. การนำเสนอและการเรียนรู้จากการลงมือทำ

แต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมที่ออกแบบไว้ต่อหน้าชั้นเรียน โดยสาธิตวิธีการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น การแสดงกิจกรรมออกกำลังกายด้วยท่าทางจากบัลเลต์ หรือการจัดกิจกรรมเต้นรำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม

5. การประเมินผล

ครูประเมินผู้เรียนจากการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม ตั้งแต่การระดมความคิด การออกแบบกิจกรรม การนำเสนอ รวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและการใช้ความคิดสร้างสรรค์

บทที่ 15
การประกอบอาชีพด้านศิลปะ

สาระสำคัญ



มีทักษะความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการออกแบบ และอธิบายเนื้อหาของงานออกแบบ มีทักษะและเทคนิค กระบวนการที่สูงขึ้นในการสร้างสรรค์งานออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา แนวคิด เทคนิควิธีการ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีคุณธรรม จริยธรรมในการออกแบบสร้างสรรค์งานที่เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องและในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของนักออกแบบที่ดีได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/สรรถนะย่อย

1. อธิบายประเภทของการออกแบบ
2. สามารถออกแบบ และประยุกต์ผลงานได้สวยงามตรงกับประโยชน์ใช้สอย
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ออกแบบที่ดี

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ประเภทของการออกแบบ
- 1.1 การออกแบบตกแต่ง
- 1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์
- 1.3 การออกแบบนิเทศศิลป์

เรื่องที่ 2 การประยุกต์ใช้ศิลปะกับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบ

เรื่องที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะของนักออกแบบ

เรื่องที่ 1 ประเภทของการออกแบบ

การออกแบบ (Design) หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิด ความต้องการและการวางแผน ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา หรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะที่สามารถสื่อความหมาย ด้วยการมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านความงาม เพื่อสนองตอบความต้องการของมนุษย์และสังคมตามวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งการออกแบบมีหลายประเภทแล้วแต่การใช้งานของการออกแบบนั้น



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. การที่จะเป็นผู้ออกแบบที่ดีควรต้องมีความคิดอย่างไร
2. ศิลปะกับการออกแบบมีความสำคัญอย่างไร

กิจกรรม คำถามชวนคิด

ร่วมกันหาคำตอบ

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

1. ให้ผู้เรียนร่างแบบผลิตภัณฑ์มา คนละ 1 แบบ

ร่างแบบ

2. ให้ผู้เรียนอธิบายการเป็นนักออกแบบที่ดีควรเป็นอย่างไร



เนื้อหาสาระ

ประเภทของการออกแบบ

ในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ล้วนเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิต และเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในสังคม โดยการใช้ความคิดและความพยายามในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ผ่านการออกแบบและพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทของการออกแบบ ที่นักออกแบบได้คิดและสร้างขึ้น เพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิต และประโยชน์ใช้สอย โดยใช้ทฤษฎี ศิลปะและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเป็นเครื่องช่วยในการสร้างสรรค์ วางแผนและผลิตออกมาเป็นผลงาน

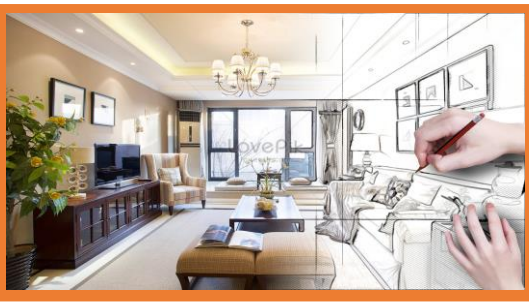
การออกแบบ จึงนับได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยถ่ายทอดทางความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ให้ผู้อื่นทราบได้อย่างรวดเร็ว เพราะการออกแบบที่ดีจะช่วยจัดระเบียบข้อมูล ให้มีความกระชับและสร้างสรรค์สัญลักษณ์ทางสังคมเพื่อการสื่อความหมายร่วมกันได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความฉับไวและรัดกุม นอกจากนี้ยัง ทำให้ผู้รับสารเกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ มีจินตนาการ สนับสนุนสร้างค่านิยมทางด้านความงามและมีแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางธุรกิจและการเรียนรู้ทางการศึกษา

การออกแบบที่ดี จึงต้องมีการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความรู้พื้นฐานในลักษณะของงานที่ออกแบบ ดังนั้น การศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในงานออกแบบแต่ละอย่างโดยเฉพาะก่อน จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้นักออกแบบจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการณ์ไกล ทั้งทางด้านรูปแบบ วัสดุ ลักษณะเด่น ความงาม การสื่อสาร โดยเฉพาะต้องตระหนักถึงประโยชน์การนำไปใช้ ความต้องการและรสนิยมตามช่วงเวลา รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

การออกแบบ จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ

1.การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design)

1.1. การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) เป็นการสร้างรูปแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและ ความงาม โดยใช้พฤติกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นหลัก



1.2 งานตกแต่งภายนอก (Exterior Design) เป็นการจัดหรือออกแบบตกแต่งบริเวณต่าง ๆ ที่ภายนอกอาคารให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและรูปทรงของอาคาร โดยส่วนมากจะนิยมตกแต่งโดยการจัดสวนและบริเวณ (Landscape Design) ซึ่งเป็นการใช้ศิลปะการออกแบบตกแต่งสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่ดีให้แก่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ



1.3 การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หมายถึง การแสดงกิจกรรม หรือ ผลงานที่เป็นสื่อกลางของบุคคลหรือหน่วยงาน ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งทางด้านการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้



2.การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เครื่องใช้ อุปกรณ์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ของมนุษย์ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องแต่งกาย วัสดุเพื่ออำนวยความสะดวกที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือพัฒนาสร้างขึ้นมาทดแทนสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงจำเป็นกับมนุษย์ การให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและ มีคุณภาพนั้น นักออกแบบ จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับกระบวน การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่โครงร่าง รูปแบบ สัดส่วน กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยและความงามสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาด โดยการนำเอาหลักการออกแบบมาสร้างสรรค์ สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าต่าง ๆ ให้เกิดลักษณะเด่น สะดุดตา ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคเห็นแล้วอยากจะซื้อ





จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันงานออกแบบจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลิตสินค้าตั้งแต่ในเชิงหัตถกรรมพื้นบ้านไปถึงในเชิงธุรกิจการค้า พัฒนาการของออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความก้าวหน้า ไปอย่างอย่างหลากหลาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้มีรูปแบบใหม่ ๆ ที่สะดุดตา และมากด้วยความสะดวก ครบเครื่องในการใช้สอยมากขึ้น



3. การออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)

3.1 การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์ (Printing Graphics) ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากการออกแบบตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ การจัดรูปเล่มหนังสือ การออกแบบปก ออกแบบภาพประกอบหนังสือ ออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือ ภาพโฆษณา เครื่องหมายการค้า และสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ



3.2 การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อม (Environmental Graphics) การออกแบบที่แสดงสินค้า นิทรรศการ ตัวอักษรสัญลักษณ์ของอาคารสถานที่ เครื่องหมายจราจร แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กลางแจ้ง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในที่สาธารณะ



3.3 การออกแบบเรขศิลป์ภาพยนตร์โทรทัศน์ แถบบันทึกภาพ และสื่อดิจิทัล เป็นการออกแบบผลงานตัวอักษรพร้อมทั้งภาพนำเรื่อง หัวเรื่อง (Title) และลงท้ายเรื่อง (End Credits) ของภาพยนตร์และโทรทัศน์ ภาพนิ่งโฆษณาทางโทรทัศน์ การออกแบบคาแรกเตอร์การ์ตูนแอนิเมชัน การออกแบบเกม การออกแบบเว็บไซต์ และภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชัน เป็นต้น



เรื่องที่ 2 การประยุกต์ใช้ศิลปะกับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบ

การประยุกต์ใช้ศิลปะกับการประกอบอาชีพการออกแบบนั้นมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามและการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทั้งในด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น และการออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งการนำความรู้ด้านศิลปะไปประยุกต์หรือไปประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบในหลากหลายสาขา เช่น ผู้กำกับศิลป์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

ในปัจจุบันเรามีการนำความรู้ด้านศิลปะมาออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างไร





กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรม

1. การออกแบบกราฟิกถือเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันอย่างไร ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการใช้งานที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและอธิบายบทบาทของการออกแบบกราฟิกในด้านนั้น ๆ

2. ให้ผู้เรียนอธิบายถึงการใช้ศิลปะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

3. ให้ผู้เรียนอธิบายการประยุกต์ใช้ศิลปะในการออกแบบแฟชั่น และความสำคัญของการออกแบบแฟชั่นในอาชีพต่าง ๆ เช่น ดีไซเนอร์เสื้อผ้า



เนื้อหาสาระ

การประกอบอาชีพด้านการออกแบบ ได้แก่

1. ผู้กำกับศิลป์

ผู้กำกับศิลป์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและการจัดองค์ประกอบของงานต่าง ๆ เพื่อให้ภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ สวยงามและตอบโจทย์ในการสื่อสารถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ผู้กำกับศิลป์ทำงานโดยดูแลภาพรวมของนักออกแบบและศิลปินในสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ การแสดงสด หรือโฆษณา ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบและแนวทางเพื่อส่งสารหรือข้อมูลให้แก่ผู้ชม



2. นักบิดแสงและสี

อาชีพนักบิดแสงและสีหรือคัลเลอร์ลิสต์ (Colorist) คือ ผู้ปรับแต่งสี และแก้สีภาพในงานสื่อต่าง ๆ เช่น งานวิดีโอ MV, ภาพยนตร์ หรือภาพยนตร์โฆษณา เพื่อให้ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ การบิดหรือปรับสีสามารถช่วยให้สื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกได้ดีมากขึ้น

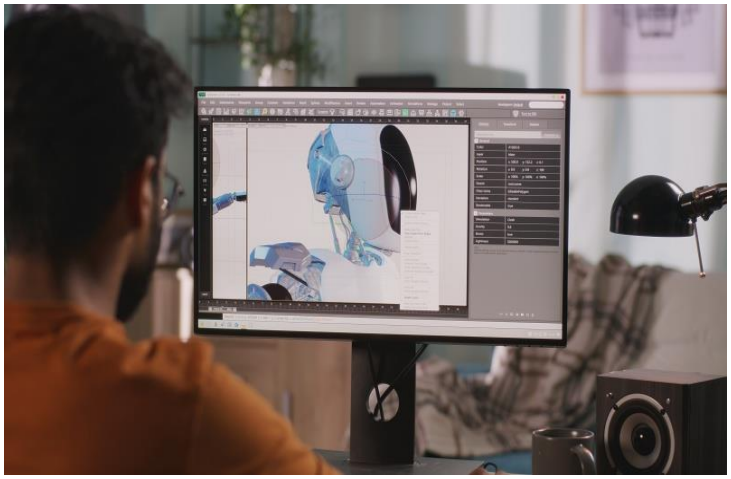


ภาพประกอบ นัดบิดแสง

3. นักออกแบบสามมิติ

นักออกแบบสามมิติ คือ ผู้ที่สร้างสรรค์และจำลองสิ่งต่าง ๆ ให้มีมิติขึ้นมา โดยการออกแบบผ่านโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน โครงสร้างอวัยวะของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างไดโนเสาร์ หรือแม้กระทั่งตัวละคร Animation ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า งานออกแบบสามมิติมีส่วนเกี่ยวข้องกับแทบทุกวงการ

ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ การ์ตูน เกม โฆษณา สถาปัตยกรรม การศึกษา หรือกระทั่งการแพทย์ เพราะการรับรู้ของคนเราเป็นแบบสามมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว ความลึก ดังนั้น การนำเสนอแบบสามมิติจะช่วยให้น่าสนใจ สมจริง สามารถเข้าใจและคล้อยตามได้ง่ายขึ้น



ภาพประกอบ นักออกแบบสามมิติ

4. นักออกแบบผลิตภัณฑ์

เป็นอาชีพที่ดูเป็นงานแนวศิลปะ แต่ความจริงแล้วผสมผสานศาสตร์อื่น ๆ ไว้อย่างหลากหลาย ทำหน้าที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ตามรูปแบบของงานหรือโจทย์ที่ได้รับ



ภาพประกอบ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

5. นักทำโมเดลอาหาร

ปัจจุบันในประเทศไทย การทำโมเดลอาหารได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ เพราะส่วนใหญ่ร้านอาหารจะใช้โมเดลในการจัดแสดงเมนูอาหารหน้าร้านเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น เกาหลี และร้านอาหารไทยแบรนด์ดังต่าง ๆ นักทำโมเดลอาหารจะทำหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานโมเดลอาหารจากวัสดุต่าง ๆ ให้เหมือนของจริง หรือน่ารับประทานกว่าของจริง โดยใช้ความรู้และทักษะทางศิลปะ เพราะต้องทำทั้งหล่อแบบ แกะสลัก ปั้นขึ้นรูป การลงสี การเคลือบเงา



ภาพประกอบ นักทำโมเดลอาหาร

6. นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์ / หนังสือ / การ์ตูน

นักวาดภาพประกอบเป็นผู้สร้างและเขียนหรือวาดภาพจากจินตนาการหรือจากแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ และสื่อสารในสื่อต่าง ๆ



ภาพประกอบ นักวาดภาพประกอบภาพยนตร์

7. นักออกแบบแสงสถาปัตยกรรม

นอกจากข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องความสว่าง เราต้องสนใจทั้งฟังก์ชันและความสวยงาม ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจว่าส่วนไหนจะเน้นเรื่องอะไร นักออกแบบแสงสถาปัตยกรรมจะมีหน้าที่หลัก ๆ คือ ออกแบบแสงของอาคารสถาปัตยกรรม เขียนวงจรไฟ เลือกวัสดุ และตรวจสอบงาน การออกแบบแสงสว่าง เป็นศาสตร์เฉพาะด้าน ซึ่งจะผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ (ศิลปะการใช้แสง) โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้านมาประกอบกัน



ภาพประกอบ นักออกแบบแสงสถาปัตยกรรม

8. ช่างภาพ

ช่างภาพเป็นอาชีพที่สำคัญมากต่องานต่าง ๆ เพราะการถ่ายภาพคือการบันทึกเหตุการณ์ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดความงาม เรื่องราว เหตุการณ์ ความรู้สึก สถานที่ หรือบุคคลต่าง ๆ



ภาพประกอบ ช่างภาพ

9. นักออกแบบกราฟิก

นักออกแบบกราฟิก คือ ผู้ออกแบบภาพและตัวอักษรเพื่อใช้ในการสื่อสาร เราจะสังเกตได้ว่างานออกแบบกราฟิกมักจะปรากฏอยู่แทบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา ปกหนังสือ ลายเสื้อ โลโก้สินค้าต่าง ๆ ตัวอักษร และอีกมากมายรอบตัว เพื่อใช้ในการสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อให้เห็นภาพนั่นเอง เนื่องจากกราฟิกนั้นมีอยู่ในทุกวงการ ทั้งโฆษณา สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ เว็บไซต์ต่าง ๆ งานอีเวนต์ และอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าทุกสายงานล้วนต้องการนักออกแบบกราฟิก



ภาพประกอบ นักออกแบบกราฟิก

10. นักออกแบบผลิตภัณฑ์และไอเท็ม

เป็นอาชีพที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่จากโลก Metaverse ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกำลังพัฒนาโลกของ Metaverse กันอยู่ ซึ่ง Metaverse ก็คือ เป็นโลกเสมือนจริง ดังนั้น โลกเสมือนจริง กำลังจะเป็นพื้นที่ตลาดใหม่ในอนาคตที่หลายอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจ



ภาพประกอบ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และไอเท็ม

11. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design) : สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน เรียกว่า มัณฑนากร เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร โดยมีการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะการออกแบบ การผลิต และการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จ สมบูรณ์ สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารและสถานที่ ให้มีความสะดวก และง่ายดายมากยิ่งขึ้น ในที่นี้จะกล่าวถึงด้านการออกแบบและการจัดนิทรรศการ

การออกแบบและการจัดนิทรรศการ ให้น่าสนใจนั้นจะต้องสามารถนำเสนอข้อมูลและสื่อสารไปยังผู้ชมได้สมบูรณ์ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การออกแบบนิทรรศการนั้น ๆ

เรื่องที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะของนักออกแบบ

นักออกแบบตกแต่งที่มีคุณภาพ ต้องมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีองค์ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการออกแบบตกแต่งและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความรู้ในสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ และมีทักษะในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งและออกแบบกราฟิก ตลอดจนความรู้ในหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สามารถวางแนวความคิด และการสร้างสรรค์งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในวิธีการ วิเคราะห์โจทย์งานออกแบบและวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบได้อย่างเหมาะสม และจะต้องสามารถจินตนาการถึงความเป็นไปได้และสามารถลงรายละเอียดในการออกแบบในภาพรวมได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน



ประเด็นอภิปรายเพื่อการเรียนรู้

1. ผู้เรียนคิดว่า อาชีพนักออกแบบเป็นอย่างไร และผู้ที่จะมีอาชีพนี้ ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
2. ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อนักออกแบบอย่างไร
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการออกแบบจะมีผลกระทบต่อนักออกแบบรุ่นหลังหรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมคำถาม ชวนคิด

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้



กิจกรรมที่ 1

จงอธิบายความหมาย นักออกแบบตกแต่ง มาพอสังเขป



กิจกรรมที่ 2

ให้ผู้เรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความถนัดมาคนละ 1 ชิ้น

ออกแบบผลิตภัณฑ์



เนื้อหาสาระ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

นักออกแบบ คือ อาชีพการออกแบบพื้นที่ใช้สอย โดยคำนึงถึงการใช้งานต่าง ๆ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตลอดจนการออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ ที่ต้องออกแบบให้บริการแนะนำ และแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ที่ต้องการมีอาชีพด้านนี้ จะต้องเป็นคนที่ความละเอียดถี่ถ้วน และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดี สามารถเลือกที่จะทำงานได้ทั้งในหน่วยราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ หรือมัณฑนากร ตลอดจนการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และในสำนักงาน บริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจด้านรับตกแต่งบ้าน หรือ อินทีเรียดีไซน์ หรือบริษัทที่รับจัดงาน (Event และ Exhibition Organizer) และการประกอบธุรกิจส่วนตัว เรียกได้ว่า เป็นอีกอาชีพที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นอาชีพ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนมากที่สุดอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

คุณสมบัติของนักออกแบบที่ดี

"นักออกแบบ" เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้วิชาชีพที่สูงมาก เพราะการที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้จะต้องมีการฝึกฝน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อให้ได้งานที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด ดังนั้น นักออกแบบที่ดีนอกจากจะมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบงานที่เป็นวิชาชีพโดยตรงแล้ว ควรมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น

1. มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล และมีจินตนาการ
2. มีความสามารถและทักษะในการออกแบบ
3. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีวินัยและมีความรับผิดชอบ
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้ศิลปะการสื่อความหมายประเภทต่าง ๆ
5. มีความสนใจใฝ่หาความรู้ด้านต่าง ๆ เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของวงการและการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการออกแบบ ทั้งในด้านการตลาดและธุรกิจ เพื่อที่จะได้รู้และออกแบบงานให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานอยู่เสมอ
6. คิดนอกกรอบ และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการแก้ปัญหา
7. มีคุณธรรมและจริยธรรม
8. มีรสนิยมที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์
9. มีความพร้อมในการทำงานและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน
10. มีสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทักษะนักออกแบบ

นอกจากจะมีความรู้และทักษะเฉพาะทางของสายวิชาชีพแล้วนักออกแบบตกแต่ง ควรมีทักษะ

1. ต้องผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย
2. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เข้าใจถึงลักษณะงานและสภาพแวดล้อมของงานนั้น ๆ
3. มีทักษะและมีความเข้าใจทางด้านงานศิลปะในเชิงสร้างสรรค์และมองการณ์ไกล สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ได้ หมั่นสังเกต
4. เป็นนักตั้งปัญหาและคำถามที่ดีถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว
5. มีรสนิยมที่ดี
6. มีระเบียบวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา
7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางธุรกิจ

แนวคำตอบกิจกรรม
บทที่ 15 การประกอบอาชีพด้านศิลปะ

เรื่องที่ 1 ประเภทการออกแบบ



กิจกรรม

การออกแบบที่ดี จึงต้องมีการคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความรู้พื้นฐานในลักษณะของงานที่ออกแบบ ดังนั้น การศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในงานออกแบบแต่ละอย่างโดยเฉพาะก่อน จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การออกแบบสอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตนเองตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้นักออกแบบจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการณ์ไกลทั้งทางด้านรูปแบบ วัสดุ ลักษณะเด่น ความงาม การสื่อสาร โดยเฉพาะต้องตระหนักถึงประโยชน์การนำไปใช้ความต้องการและรสนิยมตามช่วงเวลา รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

เรื่องที่ 2 การประยุกต์ใช้ศิลปะกับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบ



กิจกรรม

1. การออกแบบกราฟิก ถือเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะในชีวิตประจำวันอย่างไร ยกตัวอย่างการใช้งานที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและอธิบายบทบาทของการออกแบบกราฟิกในด้านนั้น ๆ

แนวตอบ การออกแบบกราฟิกเป็นการนำหลักการของศิลปะมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อที่มีการสื่อสารข้อมูลหรือความรู้สึกไปยังผู้รับสาร เช่น โปสเตอร์โฆษณา แบนเนอร์เว็บไซต์ หรือโลโก้ของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้หลักการศิลปะ เช่น สัดส่วน สี รูปทรง และการจัดวาง เพื่อดึงดูดความสนใจและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบกราฟิกจึงมีบทบาทสำคัญในด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ เช่น การออกแบบโลโก้ของบริษัท หรือการออกแบบแผ่นพับเพื่อโฆษณาสินค้า

2. ให้อธิบายถึงการใช้ศิลปะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

แนวตอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งในด้านความสวยงามและฟังก์ชันการใช้งาน การออกแบบที่ดีจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ เช่น การออกแบบเก้าอี้ที่มีดีไซน์ทันสมัยและสะดวกสบาย หรือโต๊ะทำงานที่มีทั้งความสวยงามและการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การเลือกสีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบาย

3. ให้อธิบายการประยุกต์ใช้ศิลปะในการออกแบบแฟชั่น และความสำคัญของการออกแบบแฟชั่นในอาชีพต่าง ๆ เช่น ดีไซเนอร์เสื้อผ้า

แนวตอบ การออกแบบแฟชั่นใช้ศิลปะในการเลือกใช้สี รูปทรง ลวดลาย และวัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การออกแบบเสื้อผ้าไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความสวยงาม แต่ยังสะท้อนถึงเทรนด์แฟชั่นและอารมณ์ในแต่ละยุคสมัย เช่น การออกแบบเสื้อผ้า

สำหรับงานแต่งงานที่ใช้วัสดุหรูหราและมีดีไซน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หรือการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้สวมใส่ที่ต้องการการใช้งานที่สะดวกสบายและทนทาน การออกแบบแฟชั่นมีบทบาทสำคัญในอาชีพดีไซเนอร์เสื้อผ้าและอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีผลต่อการสร้างรายได้และการตลาด

เรื่องที่ 3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้ออกแบบ



กิจกรรมที่ 1

นักออกแบบตกแต่ง คือ อาชีพการออกแบบพื้นที่ใช้สอย โดยคำนึงถึงการใช้งานต่าง ๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ตลอดจนการออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ ที่ต้องออกแบบให้บริการแนะนำ และแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ว่าจ้าง



กิจกรรมที่ 2



ภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่น

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. ระบบใดมีหน้าที่หลักในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย และนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย
   ก. ระบบย่อยอาหาร
   ข. ระบบประสาท
   ค. ระบบไหลเวียนโลหิต
   ง. ระบบขับถ่าย

2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีผลดีต่อระบบอวัยวะใดมากที่สุด
   ก. ระบบสืบพันธุ์
   ข. ระบบกล้ามเนื้อและระบบหัวใจ
   ค. ระบบประสาท
   ง. ระบบต่อมไร้ท่อ

3. การปฏิบัติในข้อใดที่เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของร่างกาย
   ก. การเที่ยวสถานบันเทิง
   ข. การรับประทานอาหารเสริมราคาแพง
   ค. การอ่านหนังสือบันเทิง
   ง. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการพักผ่อนที่เพียงพอมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกายของวัยรุ่น
   ก. ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและเพิ่มการเจริญเติบโต
   ข. ช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดและจำ
   ค. ช่วยให้มีพลังงานและอารมณ์ดีขึ้น
   ง. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง

5. ข้อใดเป็นหลักการโภชนาการที่สำคัญ
   ก. การกินอาหารที่หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม
   ข. การกินอาหารที่มีไขมันสูงเพื่อให้ได้พลังงานมากขึ้น
   ค. การหลีกเลี่ยงการกินผักและผลไม้เพื่อลดการเสี่ยงต่อโรค
   ง. การทานอาหารประเภทโปรตีนเท่านั้นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

6. การขาดธาตุเหล็กในร่างกายอาจทำให้เกิดอาการใด
   ก. อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ และหายใจลำบาก
   ข. การมีอาการปวดท้องและท้องเสีย
   ค. การบวมของข้อและกล้ามเนื้อ
   ง. การรู้สึกเจ็บปวดในกระดูก

7. อาหารในข้อใดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวานมากที่สุด
   ก. ข้าวสวย หมูหวาน และเค้กส้ม
   ข. ข้าวผัดหมู และกล้วยบวชชี
   ค. สลัดทูน่ากับถั่วลันเตาและอะโวคาโด
   ง. สลัดผักกับหมูสามชั้น และข้าวเหนียวมะม่วง

8. การเลือกอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง ควรเน้นอาหารประเภทใด
   ก. ขนมหวาน
   ข. ผักสดและผลไม้
   ค. เนื้อหมูและเนื้อวัว
   ง. น้ำผลไม้และเครื่องดื่มหวาน

9. ข้อใดคือข้อควรปฏิบัติหากไม่**แน่ใจ**เกี่ยวกับการใช้ยา
   ก. ใช้ยาตามที่เห็นในโฆษณา
   ข. ใช้ยาตามคำแนะนำจากเพื่อน
   ค. ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
   ง. อ่านคำแนะนำจากฉลากยาแล้วใช้เอง

10. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
   ก. การใช้ยาที่หมดอายุไม่มีผลต่อสุขภาพ
   ข. การใช้ยาสามารถใช้ยาร่วมกับเพื่อนที่มีอาการเดียวกัน
   ค. การใช้ยาที่ไม่ได้รับการตรวจจากแพทย์อาจทำให้เกิดอันตราย
   ง. การใช้ยาที่สามารถหาซื้อกินเองได้ตามร้านค้าโดยไม่ต้องพบแพทย์

11. โรคทางพันธุกรรม หมายถึง ความผิดปกติในข้อใด
   ก. ความผิดปกติของเซลล์สมอง
   ข. ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
   ค. เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
   ง. ความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย

12. ข้อใด**ไม่ใช่**โรคทางพันธุกรรม
   ก. ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome)
   ข. โรคอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม (dementia syndrome)
   ค. โรคถุงน้ำในไต (Polycystic Kidney Disease)
   ง. โรคประสาทชักกระตุก (Huntington's disease)

13. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมได้ดีที่สุด
   ก. เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว
   ข. หากพ่อหรือแม่มีลักษณะโครโมโซมที่ผิดปกติไม่ควรจะมีบุตร
   ค. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อให้ทราบวิธีวางแผนการมีครอบครัวหรือมีบุตร
   ง. โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่ไม่สามารถคาดเดาการเกิดได้จึงไม่มีวิธีการป้องกัน

14. ผลกระทบที่สำคัญที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ป่าคือข้อใด
   ก. การเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า
   ข. การขยายพื้นที่ของสัตว์ป่าบางชนิด
   ค. การเพิ่มจำนวนสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
   ง. การสูญพันธุ์ของสัตว์บางชนิดที่ไม่สามารถปรับตัวได้

15. ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด
   ก. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
   ข. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม
   ค. ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับบุคคลรอบข้าง
   ง. การตระหนักรู้ถึงการกระทำต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

16. ข้อใด**ไม่ใช่**ลักษณะของคนที่มีความฉลาดด้านสุขภาพ
    ก. การรู้เท่าทันสื่อ
    ข. การโต้ตอบ ซักถามแลกเปลี่ยน
    ค. การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ
    ง. ความสามารถในการกำหนดทางเลือกและปฏิเสธ

17. ข้อใด**ไม่ใช่**สาเหตุที่ฝุ่น PM 2.5 ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
    ก. เด็กมีอัตราการหายใจมากกว่ากว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า
    ข. เด็กมีอัตราการหายใจน้อยกว่ากว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า
    ค. เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันปอด และสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่
    ง. เด็กมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบที่ออกไปเล่นในพื้นที่กลางแจ้ง

18. การป้องกันการเสพติดในครอบครัว การให้การสนับสนุนและการฟังปัญหาจากสมาชิกในครอบครัวมีผลในข้อใด
    ก. ช่วยลดความเครียดและความกดดันจากปัญหาต่าง ๆ
    ข. ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกได้รับการดูแลและเข้าใจ
    ค. ช่วยป้องกันการหันไปพึ่งยาเสพติดเป็นทางออก
    ง. ไม่มีผลต่อการป้องกันการเสพติด

19. ข้อใดเป็นอันดับแรกในการป้องกันการเสพติดในครอบครัว
    ก. การทำโทษสมาชิกที่มีพฤติกรรมเสพติด
    ข. การหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องการเสพติด
    ค. การสอนทักษะในการใช้ชีวิตและการเลือกเพื่อน
    ง. การปฏิเสธไม่ให้สมาชิกในครอบครัวออกจากบ้าน

20. ในกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ข้อใดเป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่
    ก. การทำตามกระบวนการที่เคยใช้มาก่อน
    ข. การระดมความคิดโดยไม่มีข้อจำกัด
    ค .การคัดลอกแนวคิดจากผู้อื่น
    ง. การมองหาวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหา

21. ทักษะการจัดการเวลาเป็นทักษะสำคัญในการทำงานและครอบครัวอย่างไร
    ก. ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น
    ข. ช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว
    ค. ช่วยลดปริมาณงานที่ต้องทำ
    ง. ช่วยให้มีเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการ

22. ข้อใดต่อไปนี้**ไม่ใช่**วิธีการจัดการความเครียดที่ดี
    ก. การออกกำลังกาย
    ข. การทำงานหนักขึ้น
    ค. การหาความรู้เพิ่มเติม
    ง. การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจ

23. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวช่วยเสริมสร้างอะไร
    ก. การเพิ่มรายได้
    ข. การทำงานหนักขึ้น
    ค. การลดเวลาพักผ่อน
    ง. ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี

24. การเรียนดนตรีสากลช่วยพัฒนาทักษะใดในด้านการศึกษา
    ก. การพัฒนาทักษะการเขียน
    ข. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
    ค. การพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา
    ง. การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

25. ไวโอลิน มีวิวัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีชนิดใด
    ก. กีตาร์
    ข. เรเบก
    ค. เชลโล
    ง. ไวโอล่า

26. ข้อใด**ไม่ใช่**วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี “ฟลุต” ในปัจจุบัน
    ก. ปี่ชวา
    ข. ขลุ่ย
    ค. ฟลุตโบราณ
    ง. พิณ

27. องค์ประกอบใดที่ช่วยในการสร้างการเน้นและจุดสนใจในงานศิลปะ
    ก. สี
    ข. ขนาด
    ค. รูปทรง
    ง. ทิศทางของเส้น

28. ทัศนียภาพ (Perspective) เป็นการใช้เทคนิคใดในงานศิลปะ
    ก. การเน้นจุดสนใจ
    ข. การสร้างความลึกและมิติ
    ค. การใช้เส้นและสีในการแสดงอารมณ์
    ง. การจัดการความสมดุลของรูปทรง

29. การแสดงนาฏศิลป์สากลในกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมด้านใด
    ก. การส่งเสริมการแข่งขันในงาน
    ข. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
    ค. การพัฒนาทักษะทางการแสดง
    ง. การสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม

30. ข้อใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบอาชีพศิลปะที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน
    ก. การเจรจาและสร้างความสัมพันธ์
    ข. การจัดการเวลาและงานหลายอย่าง
    ค. การทำงานแบบอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
    ง. การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล

เฉลย

แบบทดสอบก่อนเรียน

1.	ง	11.	ง	21.	ง
2.	ข	12.	ข	22.	ข
3.	ง	13.	ค	23.	ง
4.	ข	14.	ค	24.	ค
5.	ง	15.	ก	25	ข
6.	ก	16.	ค	26.	ค
7.	ค	17.	ข	27.	ง
8.	ค	18.	ก	28.	ข
9.	ง	19.	ง	29.	ค
10.	ก	20.	ข	30	ง

แบบทดสอบหลังเรียน

1.	ค	11.	ข	21.	ง
2.	ข	12.	ข	22.	ข
3.	ง	13.	ค	23.	ง
4.	ก	14.	ง	24.	ง
5.	ก	15.	ค	25	ข
6.	ก	16.	ก	26.	ง
7.	ค	17.	ค	27.	ก
8.	ข	18.	ค	28.	ข
9.	ค	19.	ค	29.	ง
10.	ค	20.	ข	30	ก

บรรณานุกรม

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2554). เพศวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย. **วารสารประชากรและสังคม, 15(1),** 43-66.

เกษแก้ว เสียงเพราะ. (2562). **สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2)**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร. (2554). **ความฉลาดทางสุขภาพ**. กรุงเทพฯ: นิวธรรมดาการพิมพ์.

ณฐวัฒน์ ล่องทอง. (ม.ป.ป.). **การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (เพื่อความสุข (ใจ) ในการทำงาน).** เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถนัด ม่วงมณี, และประยนต์ ทรัพย์เจริญ. (2559). **หนังสือเรียนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002** (พิมพ์ครั้งที่ 2). หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด.

ศ.ดร. กภ. ประวิตร เจนวรรธนะกุล ผศ.ดร. กภ.รสลัย กัลยาณพจน์พร และ คณะสสส. (ม.ป.ป.) **ขยับบ่อย ๆ.** สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย”

มูลนิธิแพธทูเฮลท์. (2561). **คู่มือครู แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ.** กรุงเทพฯ

วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2562). **ความฉลาดด้านสิ่งแวดล้อม: Environmental Intelligence.** กรุงเทพฯ: ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้.

สำนักงาน กศน. (2560). **หนังสือเรียนสาระทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช31002) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.**

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย. (2563). **คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด.** บริษัท เนเบอร์มีเดีย จำกัด.

----------. (2563). **คู่มือวิทยากรยุวกาชาด สำหรับการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน ยุวกาชาด**. บริษัท เนเบอร์มีเดีย จำกัด.

กองควบคุมวัตถุเสพติด.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. https://www.narcotic.fda.moph.go.th

ขนิษฐา จันทร์เจริญ. (2566, 4 กรกฎาคม). **รู้จัก “ฮีโมฟีเลีย” โรคเลือดออกง่าย แม้ไม่หายขาด แต่โอกาสชีวิตดี ยังมี.** https://www.chula.ac.th/highlight/67489/.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566, 4 กรกฎาคม). **เด็กติดยาเสพติด.** https://www.rama.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/06212014-1613

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566, 8 กรกฎาคม). **ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย.** https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/gender-identity.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566, 8 กรกฎาคม). **รู้และเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ.** https://www.chula.ac.th/cuinside/23302/.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566, 7 สิงหาคม). **เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5.** https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/chula-pm25-booklet-1.pdf

ชนัญญา ศรีหะวรรณ์. (2566, 7 สิงหาคม). **PM 2.5 ฝุ่นละอองเล็กจิ๋วแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ.** https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/อันตรายจากฝุ่น-PM2.5.

ไทยรัฐออนไลน์. (2566, 7 สิงหาคม). **มลพิษทางอากาศในเมืองส่งผลต่อปอด.** https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1643665.

นพวรรณ ศรีวงค์พานิช. (2566, 9 สิงหาคม). **ดาวน์ซินโดรม คืออะไร ?.** https://www.princsuvarnabhumi.Com/articles/content-what-is-down-syndrome.

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน. (2566, 3 กรกฎาคม). **ความหมายของ ยา** . https://dictionary.orst.go.th

พบแพทย์ ดอท คอม. (2566, 8 สิงหาคม). **โรคทางพันธุกรรม.** https://www.pobpad.com/โรคทางพันธุกรรม.

_____. (2566, 8 สิงหาคม). **โรคฮันติงตัน (HUNTINGTON'S DISEASE).** https://www.pobpad.com/โรคฮันติงตัน-huntingtons-disease.

_____. (2566, 9 สิงหาคม). **Gene Therapy บำบัดโรคด้วยพันธุกรรม ทางเลือกการรักษาในอนาคต.** https://www.pobpad.com/gene-therapy-บำบัดโรคด้วยพันธุกรรม.

พัสมณฑ์ คุมทวีพร. (2566, 9 สิงหาคม). **การจัดการความเครียด.** https//ns.mahidol.ac.th/English/th/department/FN/COE_gerontological/Article/other/การจัดการความเครียด.pdf.

ภาวินี น้อยนารถ. (2566, 8 สิงหาคม). **ธาลัสซีเมีย.** https//www.medparkhospital.com/disease-and-Treatment/thalassemia.careerdevelopment-.

ภูฟ้าเรสท์โฮม. (2566, 3 กรกฎาคม). **ผลกระทบกับสุขภาพของผู้ป่วยติดยาเสพติด.** https://www.phufaresthome.com/blog/effect-on-patient-from-drug-addiction/

มติชนออนไลน์. (2566, 7 สิงหาคม). **10 อันดับข่าวมลพิษ ในประเทศไทยปี 2562.** https://www.matochon.co.th/local/quality-life/news_1848749.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2566, 8 กรกฎาคม). **สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ .** สืบค้น กรกฎาคม 8, 2566, จาก https://www.law.tu.ac.th/how-to-respect-lgbtq/.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (2566, 10 สิงหาคม). **วิธีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา.** https://www.spu.ac.th/uploads/content/2018080764758.pdf.

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์. (2566, 8 กรกฎาคม). **แตกต่างอย่างเข้าใจ เมื่อลูกเป็น LGBTQ.** https://www.sosthailand.org/blog/supporting-your-lgbtq-child?gad=1&gclid=EAIaIQobChMI2_jwhKvMgAMVPCWDAx1daAxTEAAYASAAEgK9-vD_BwE.

มูลนิธิยุวพัฒน์. (2566, 7 กรกฎาคม). **ทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่ 21.** https://www.Yuvabadhanafoundation.org/th/ข่าวสาร/บทความทั่วไปก/บทความ-วัยรุ่น-ทักษะชีวิต.

โรงพยาบาลเพชรเวช. (2566, 7 กรกฎาคม). **โรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดที่ไม่มีใครอยากได้.** https://www.petcharavejhospital.com/en/Article/article_detail/Genetic_Disorders.

โรงพยาบาลศิครินทร์. (2566, 9 สิงหาคม). **ตาบอดสี ความผิดปกติในการมองเห็นที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวัน.** https://www.sikarin.com/health/โรคตาบอดสี-เป็นอย่างไร.

โรงเรียนจุนวิทยาคม. 2566, 7 กรกฎาคม). **ยาเสพติดให้โทษคืออะไร.** http://www.cwkpy.ac.th/datashow_90400

วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์. (2566, 7 สิงหาคม). **ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : อยู่รอดแม้จุดยืนมนุษย์สั่นคลอนในโลกดิจิทัลที่ไม่ย้อนกลับหลัง.** https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/21st-centuryskills.html

เลิร์นนีโอ. (2566, 8 สิงหาคม). **โรคทางพันธุกรรม ที่เกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซม.** https://learnneo.in.th/โรคทางพันธุกรรม-ที่เกิด/.

วิกานดา รัตนพันธ์. (2566, 8 สิงหาคม). **โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle Cell Anemia) : อาการ สาเหตุ การรักษา.** https://ihealzy.com/sickle-cell-anemia-0605/.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2566, 8 สิงหาคม). **คลังความรู้ SciMath ยาเพิ่มพลังทางเพศ...เรื่องจริงหรืออิงความเชื่อ.** https://www.scimath.org/article-biology/item/1315-drug-boost-sexual

สหประชาชาติ ประเทศไทย. (2566, 7 สิงหาคม). **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.** https://thailand.un.org/th/173511-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.

สำนักข่าวไทย. (2566, 7 สิงหาคม). **รู้หรือไม่? เผาหญ้า เผาขยะ ผิดกฎหมาย.** https://tna.mcot.net/pick-593291.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.กระทรวงยุติธรรม. https://www.oncb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.). (2566, 6 กรกฎาคม). **ยาที่คนมักใช้แบบผิด ๆ.** https://oryor.com/media/checkSureShare/media_specify/712?ref=search

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ. (2566, 11 สิงหาคม). **ความฉลาดทางสุขภาพคือระดับคุณภาพของชีวิต**. https://bkpho.moph.go.th/bungkanpho/index.php?page=article-view-detail&id=25&fb_comment_id=829923870456775_848721141910381

สำนักบริการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2566, 9 สิงหาคม). **6 ทักษะที่ควรมีไว้ ทำงานที่ไหนก็ปัง.** https://www.sa.chula.ac.th/6-skills/.

อบต.ดอนคา. (2566, 9 สิงหาคม). **การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด.** http://www.nw-local.go.th/networknews/detail/61194/data.html

Ampro_content. (2566, 5 กรกฎาคม). **โรคถุงน้ำในไตคืออะไร อาการ สาเหตุ รักษา และการป้องกัน.** https://amprohealth.com/symptoms/polycystic-kidney-disease/.

MedPark Hospital. (2566, 7 กรกฎาคม). **โรคซิสติกไฟโบรซิส.** https://www.medparkhospital.com/disease-and-treatment/cystic-fibrosis.

NGGThailand. (2566, 8 สิงหาคม). **โรคทางพันธุกรรม" และ "โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม" ต่างกัน คุณพ่อและคุณแม่จึงควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง.** https://www.nggthailand.com/article/173/.

PlookExplorer1. (2566, 9 สิงหาคม). **ทักษะการจัดการกับอารมณ์.** http://www.trueplookpanya.comKnowledge/content/93414-careeroverview-careedevelopment-.

Thai PBS. (2566, 9 สิงหาคม). **พิษยาเสพติด พ่อเลี้ยงล่วงละเมิดลูกเลี้ยง.** https://wwwthaipbs.or.th/news/content/322448

https://www.sdgmove.com/2023/05/16/thaihealthreport-2566-situation-ten/

https://www.tokiomarine.com/th/th/life/about-us/media-centre/Protect-Yourself-from-These-Top-5-Common-Health-Issues.html

https://www.thaihealth.or.th/?p=166968

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบ
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

---

1. นายคมกฤช	จันทร์ขจร	รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน.
2. นายชัยพัฒน์	พันธุ์วัฒนสกุล	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร
3. นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
4. นางเอื้อมพร	สุเมธาวัฒนะ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา
5. นายทะนงศักดิ์	กลิ่นธรรม	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเผยแพร่ ระดับ7 แผนกรร.ช่างฝีมือในวัง (ชาย) กองศิลปกรรม กรมสนับสนุน
6. ดร.สมพร	สามทองกล่ำ	ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
7. นางอัจฉรา	พรนิมิตร	ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
8. นายอนวัช	นกดารา	ข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลำเหย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
9. นางนิรมล	บุญชู	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
10. นางตติยา	ใจบุญ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุตรดิตถ์
11. นางสาวอำภรณ์	ช่างเกวียน	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
12. นางสาวสุดใจ	บุตรอากาศ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
13. นายเริง	กองแก้ว	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
14. นางสาวมนทา	เกรียงทวีทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดปทุมธานี
15. นางสาวนวลพรรณ	ศาสตร์เวช	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครปฐม
16. นางเกล็ดแก้ว	เจริญศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดราชบุรี
17. นางนฤมล	อันตะริกานนท์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดราชบุรี
18. นางนันฐินี	ศรีธัญญา	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสระบุรี
19. นางสาวพัชรา	จงโกรย	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลพบุรี
20. นางสาวนันทยา	ทวีศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21. นางวัชรี	สวัสดี	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุรินทร์
22. นางสาวแก้วตา	บุญไทย	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
23. นายโยซิน	สมโนนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

24. นางสาวณัฐภัสสร	แดงมณี	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิษณุโลก
25. นายอภิชาติ	โชติแสงทอง	รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
26. นางสาววิมล	เล็กสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
27. นางเบญจพร	จั่นเจริญ	ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
28. นางสาวจุฑาทิพย์	มหานาม	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
29. นางจิรัชยา	เฟื่องฟูรัตน์	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
30. นางสาวอรทัย	จารุภัทรพาณิชย์	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
31. นางศิริพร	สุดเล็ก	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
32. นายจิรพงศ์	ผลนาค	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
33. นางศิริประภา	หลงพิมาย	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
34. นางสาวฉันทลักษณ์	ศรีผา	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
35. นายปกรณ์	คามวัลย์	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
36. นายเทวัญ	จันทเขต	ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
37. นางสาวเอมอร	แก้วกล่ำศรี	ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
38. นางจันทนี	กิ่งไทรงาม	ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
39. นางสาวอรทัย	ปานขาว	ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
40. นางประทุม	โพธิ์งาม	ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง
41. นางรสาพร	หม้อศรีใจ	ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
42. นางสาวธัญรัศม์	มิ่งไชยอนันต์	ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
43. นายจักรกฤษณ์	สัณฑมาศ	ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี
44. นายกริชชัย	บุญกอง	ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

45. นางสาวปัทมา	โกวิทยากร	ครูชำนาญการ กศน.อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
46. นายธัญญา	ศรีเอม	ครูชำนาญการ กศน.อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
47. นางสาวเยาวภา	บุญญาธิการ	ครูชำนาญการ กศน.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
48. นางสาวปัทมาภรณ์	ปิ่นทอง	ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
49. นางสาวกฤษณา	โสภี	ครู ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
50. นางสุปราณี	จูฑามาตย์	ครู กศน.อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
51. นางสาวอภิญญา	พลอาสา	ครู สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
52. นายเชวงศักดิ์	นวลพุดซา	ครู กศน.อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
53. นายอินทัช	แสนจันแดง	ครู กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
54. นายอภิรมย์	จันทร์จีรัสถ์	ครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
55. นายสวรรค์	จันทร์อุไร	ครู กศน.อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
56. นางสาวเจริญศรี	ศุภภะ	ครู กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
57. นายนนทชัย	สิทธิตัน	ครู กศน.อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
58. นายณัฐพงศ์	แก้วทุ่ง	ครู กศน.อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
58. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู กศน.อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
60. นางสาววิไร	สุใจยา	ครู กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
61. นายศาตพรพงษ์	สงวนสินวัฒนา	ครู กศน.อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
62. นายวันชัย	พฤกษาชีพ	ครู กศน.อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
63. นางสาวสุภาภรณ์	สังฆมณี	ครู กศน.อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
64. นางสาวชลจีรัศมิ์	ชิตเจริญอยู่	ครู กศน.อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
65. นางสาวสิรินิภา	สิงหเลิศ	ครู กศน.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
66. นายเอกวิทย์	สุระโคตร	ครู ช่วยราชการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
67. นายกฤตนนท์	จันทร์คลาย	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
68. นางนวลถนอม	พิขุนทด	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
69. นางสาวรจนา	ปันสา	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
70. นางสาวนภาพร	นิฏฐิยานนท์	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
71. นายอนัตชัย	เกตุแก้ว	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
72. นางสาวกวินทิพย์	ดิษฐอาย	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
73. นายไตรทศ	มะโนสด	ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

74. นายปิยะกัลป์	ศรีเมือง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย
75. นายสุเมธ เอี่ยมประชา	ศรีหงส์	นักวิชาการช่างศิลป์ วิทยาลัยในวัง
76. นางสาวเบ็ญจวรรณ	อำไพศรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
77. นางเยาวรัตน์	ปิ่นมณีวงศ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
78. นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
79. นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
80. นายธานี	เครืออยู่	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
81. นายกันตภณ	พิมพาลัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
82. นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
83. นางสาวทิพวัลย์	ธรรมวงค์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
84. นางสาวกันต์สินี	พูลสวัสดิ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
85. นางสาวกาญจนรัตน์	วรพงศ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
86. นางสาวพรรณปภรณ์	หินชัยภูมิ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
87. นางสุกัญญา	กุลเลิศพิทยา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
88. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
89. นางสาวสุพรรษา	ศิริบุรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
90. นางวีรวรรณ	หว่างแสง	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
91. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
92. นางสาวหทัยมาดา	ดิฐประวรรตน์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
93. นางสาวอติพร	ยิ่งยงค์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
94. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
95. นางสาวจารีรัตน์	ชูมณี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
96. นางสาวกิตติมา	แก้วลำหัด	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
97. นางสาวธนธรณ์	เสมอหน้า	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
98. นางวรรณี	ศรีศิริวรรณกุล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
99. นางสาวฐานิตา	คล้ายอ่อน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือเรียนตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

1.	นายคมกฤช	จันทร์ขจร	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
			รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
2.	นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
			การเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
			พ.ศ.2566
3.	นางเอื้อมพร	สุเมธาวัฒนะ	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและ
			เครือข่าย
4.	นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
			การศึกษา
5.	นายโยชิน	สมโนนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
6.	นายทนงศักดิ์	กลิ่นธรรม	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเผยแพร่ ระดับ 7
			แผนกโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) กองศิลปกรรม
			กรมสนับสนุน
7.	นางสาวปาริฉัตร	พยุงศรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
			จังหวัดปทุมธานี
8.	นางกนกวลี	อุชณกรกุล	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
9.	นายรณชัย	มาเจริญทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
10.	นางตติยา	ใจบุญ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุตรดิตถ์
11.	นางสาววิเลขา	ลีสุวรรณ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
12.	นางสาวสุดใจ	บุตรอากาศ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
13.	นายสุธี	วรประดิษฐ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดตราด
14.	นางสาวนันทยา	ทวีศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15.	นางเกล็ดแก้ว	เจริญศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดราชบุรี
16.	นายเริง	กองแก้ว	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
17.	นางสาวพัชรา	จงโกรย	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลพบุรี
18.	นางอัจฉรา	พรนิมิตร	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19.	นางสาวนวลพรรณ	ศาสตร์เวช	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครปฐม
20.	นายอนวัช	นกดารา	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครปฐม
21.	นางวัชรี	สวัสดี	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสุรินทร์
22.	นางสาวฉันทลักษณ์	ศรีผา	ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์
			จังหวัดอุบลราชธานี
23.	นายปกรณ์	คามวัลย์	ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
24.			

25. นายจิรพงศ์	ผลนาค	ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
26. นางสาวจุฑาทิพย์	มหานาม	ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
27. นายอภิชาติ	โชติแสงทอง	รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดปทุมธานี
28. นางสาววิมล	เล็กสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี
29. นางสาวธัญรัศม์	มิ่งไชยอนันต์	ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน .ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
30. นางสาวอรทัย	ปานขาว	ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
31. นางรสาพร	หม้อศรีใจ	ครูชำนาญการพิเศษ สกร.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
32. นางสาวปัทมาภรณ์	ปิ่นทอง	ครูชำนาญการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
33. นายกริชชัย	บุญกอง	ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี
34. นายสุรพงษ์	ลาตวงษ์	ครูชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
35. นางสาวเยาวภา	บุญญาธิการ	ครูชำนาญการ สกร.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
36. นายธัญญา	ศรีเอม	ครูชำนาญการ สกร.อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
37. นางผกามาศ	เรืองจิรัษเฐียร	ครู สกร.เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
38. นางสาวรจนา	ปันสา	ครู สกร.อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
39. นางเสาวลักษณ์	แก้วบุตร	ครู สกร.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
40. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู สกร.อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
41. นายวันชัย	พฤกษาชีพ	ครู สกร.อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
42. นางสาวสุภาภรณ์	สังฆมณี	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
43. นายกรณิศ	โอภาสพินิจ	ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
44. นางสาวชลจีรัศมิ์	ชิตเจริญอยู่	ครู สกร.อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
45. นางสาวสิรินิภา	สิงหเลิศ	ครู สกร.อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
46. นางสุปราณี	จูฑามาตย์	ครู สกร.อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
47. นายอภิรมย์	จันทร์จีรัสถ์	ครู สกร.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
48. นายสวรรค์	จันทร์อุไร	ครู สกร.อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
49. นายวิศวกร	กิ่งจันทร์	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
50. นางสาวอภิญญา	พลอาสา	ครู สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี

51. นายเชวงศักดิ์	นวลพุดซา	ครู สกร.อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
52. นางสาวอังคณา	จั๋นตา	ครู สกร.อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
53. นายวันชนะ	อ่อนสุวรรณ	ครู สกร. อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
54. นางสาวเพ็ญรัตน์	ผลบุญ	ครู สกร.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
55. นายไชยเดช	ไฝทอง	ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
56. นางสาววิภาวี	หนูภักดี	ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
57. นางสาวกวินทิพย์	ดิษฐอาย	ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
58. นายปิยะกัลป์	ศรีเมือง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย
59. นางสาวพิมพ์ชนก	วิทยอุดม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สกร.จังหวัดอุดรธานี
60. นางสาวเบ็ญจวรรณ	อำไพศรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
61. นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
62. นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
63. นายกันตภณ	พิมพาลัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
64. นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
65. นายจตุรงค์	ทองดารา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
66. นางสุกัญญา	กุลเลิศพิทยา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
67. นางสาวพรรณปภรณ์	หินชัยภูมิ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
68. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
69. นางสาวทิพวัลย์	ธรรมวงค์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
70. นางสาวกันต์สินี	พูลสวัสดิ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
71. นางสาวกาญจนรัตน์	วรพงศ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
72. นางสาวสุพรรษา	ศิริบุรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
73. นางวรรณี	ศรีศิริวรรณกุล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
74. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
75. นางสาวจารีรัตน์	ชูมณี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
76. นางสาวอติพร	ยิ่งยงค์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
77. นางสาวฐานิตา	คล้ายอ่อน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
78. นางวีรวรรณ	หว่างแสง	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
79. นางสาวธนธรณ์	เสมอหน้า	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
80. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
81. นางสาวกิตติมา	แก้วลำหัด	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำหนังสือเรียน
ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2566
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

---

1. นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. นางสาววิเลขา	ลีสุวรรณ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวนวลพรรณ	ศาสตร์เวช	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนครปฐม
4. นางสาววิมล	เล็กสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี
5. นายจิรพงศ์	ผลนาค	ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
6. นางศิริประภา	หลงพิมาย	ผู้อำนวยการ สกร .อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
7. นางสาวบุญเลื่อน	สายสินธิ์	ครูชำนาญการ สกร.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู คศ.1 สกร.อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
9. นางสาวชลจีรัศมิ์	ชิตเจริญอยู่	ครู คศ.1 สกร.อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
10.นายนนทชัย	สิทธิตัน	ครู คศ.1 สกร.อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
11.นายอภิรมย์	จันทร์จีรัสถ์	ครู คศ.1 สกร.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
12.นางสาวอังคณา	จั๋นตา	ครู คศ.1 สกร.อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
13.นางสาวกวินทิพย์	ดิษฐอาย	ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
15.นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16.นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
17. นายจตุรงค์	ทองดารา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18. นางสุกัญญา	กุลเลิศพิทยา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
20. นางสาวกาญจนรัตน์	วรพงศ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
22. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23. นางสาวกิตติมา	แก้วลำหัด	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการเอกสารประกอบหลักสูตร
และจัดทำสื่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

---

1. นายชัยพัฒน์	พันธุ์วัฒนสกุล	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
2. นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นายเริง	กองแก้ว	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
2. นางสาวปริญญารัตน์	ม้าทอง	ครูชำนาญการ สกร.ระดับเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
3. นางผกามาศ	เรืองจิรัษเฐียร	ครู สกร.ระดับเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
4. นายเอกชัย	เอกวนาการ	ครู สกร.ระดับเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
5. นายธีระศักดิ์	สวัสดิ์อภิธรรม	ครู สกร.ระดับอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
6. นางนุชจรินทร์	พงษ์สุวรรณ	ครู สกร.ระดับอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
7. นายไชยเดช	ไฝทอง	ครู สกร.ระดับอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
8. นางสาวชมพู	มรุธาวานิช	ครู สกร.ระดับอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
9. นายวุฒินันท์	นามนาค	ครู สกร. ระดับอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
10. นางสาวภัคสรณ์สิริ	ศิลวันต์	ครู สกร.ระดับอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
11. นางสาวสิรินิภา	สิงหเลิศ	ครู สกร.ระดับอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
12. นางสาววนิชญา	นางา	ครู สกร.ระดับอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
13. ว่าที่ ร.ต.หญิงดุษฎี	ศรีดำ	ครู สกร.ระดับอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
14. นางสาวยารอนะ	ลาเตะ	ครู สกร.ระดับอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
15. นายอรรถกร	สิงทะบุตร	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
16. นางสาวเบ็ญจวรรณ	อำไพศรี	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
17. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2. นายรัฐศาสตร์	สุขสวัสดิ์	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
3. นางสาวณัฐนิชา	ท้วมนาค	ครู สกร.ระดับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
4. นางสาวกุลธิดา	นิลเพ็ชร	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
5. นางสาวธัญชนก	โรจน์โยธินพิพัฒน์	ครู สกร.ระดับอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
6. นายนิตินัย	คนเพียร	ครู สกร.ระดับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
7. นางสาวสุนีย์	ใจบุญ	ครู สกร.ระดับอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

8. นางสาวมนันยา	สุทธิกุล	ครู สกร.ระดับอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมหญิง	ไทรสาย	ครู สกร.ระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
10. นางสาวพรรณนิดา	เร็วเรียบ	ครู สกร.ระดับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. นางสาวชลจีรัศมิ์ ชิตเจริญอยู่		ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
12. นางสาวสุกัญญา กิ่งชา		ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13. นางสาวกวิตา	สวยสอาด	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
14. นางพัฒน์นรี	พานแก้วชูวงศ์	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
15. นายสุทธินันท์	โอดลี	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
16. นายอารัมภ์	คันธี	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
17. นางสาวกวินทิพย์	ดิษฐอาย	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18. นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
2. นางสาววรณัน	ขุนศรี	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
3. นายจักรกฤษณ์	สัณฑมาศ	ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
4. นายจิรวัฒน์	ช่อชั้น	ครูชำนาญการ สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวเสาวลักษณ์	แก้วบุตร	ครู สกร.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6. นายพิสันติ์	ศรีสุขา	ครู สกร.ระดับอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. นางสาวสุกัญญา	ธรรมนูญรักษ์	ครู สกร.ระดับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
8. นางสาวภัทรธิดา	จันทะวงษ์	ครู สกร.ระดับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
9. นางสาวกมลลฎา	บัวฝั่น	ครู สกร.ระดับอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
10. นางสาวเจนจิรา	วงค์ลังการ์	ครู สกร.ระดับอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์	เปอสุวรรณ	ครู สกร.ระดับอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
12. นายอชิรวิทย์	บรรเทากุล	ครู สกร.ระดับอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
13. นายเชวงศักดิ์	นวลพุดซา	ครู สกร.ระดับอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
14. นายกิตติกร	ภารไสว	ครู สกร.ระดับอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

15. นายวีรสิทธิ์	หารัญดา	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
16. นางสาวบานเย็น	จูบ้านไร่	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
17. นางสาวพิมพกานต์	สารวิชัย	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
18. นางสาวบุณฑริก	พลทะอินทร์	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
19. นางสาวฐิติชญาณ์	กิ่งกลาง	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
20. ว่าที่ ร.ต.จำลอง	โพธิ์น้ำเที่ยง	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
21. นางจุฑารัตน์	พรหมศร	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. นายภาณุวิชญ์	ชื่นชอบ	ครู อาสาสมัคร สกร.ระดับอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
23. นางพิชชาภา	บัวทอง	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
24. นายกันตภณ	พิมพาลัย	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นางตติยา	ใจบุญ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุตรดิตถ์
2. นางสาวนันทยา	ทวีศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. นางสาวลัคนา	ชำนาญกุล	ครูชำนาญการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
4. นายเอกรินทร์	กำแก้ว	ครู สกร.ระดับเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. นายเอกวิทย์	สุระโคตร	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี
6. นางสาวนิภาพร	เชื้อพราหมณ์	ครู สกร.ระดับอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
7. นายกรณิศ	โอภาสพินิจ	ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. นายวิศวกร	กิ่งจันทร์	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
9. ว่าที่ ร.ต.ราชันต์	ทองสัน	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
10. นายจักรภพ	สายสุยะ	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
11. นายจักรกฤษณ์	รากจันทึก	ครู สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จังหวัดนครราชสีมา
12. นายสุนทร	จันทร์เปล่ง	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
13. นายวิทวัส	ทานาฤทัย	ครู สกร.ระดับอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
14. นางสาววราภรณ์	ยาชะรัด	ครู สกร.ระดับอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
15. นางสาวมัซณี	เจะแม็ง	ครู สกร.ระดับอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
16. นางสาวสุไรนี	มะเด็ง	ครู สกร.ระดับอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

17. นางสาวจิตต์ทิพย์	ลิ้มปรีดากูล	ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี
18. นายองค์การ	เกตุแก้ว	ครูผู้ช่วย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19. นางสาวอาพิศรา	ดวงธนู	ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี
20. นายจักรพรรดิ	สุรินทร์เลิศ	ครูผู้ช่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
21. นางสาวเพ็ญใจ	บริบูรณ์	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22. นางสาวภิชญาพร	สว่างเนตร	นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี
23. นายธราธิป	พรหมบุบผา	นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและสินทรัพย์ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
24. นางสาวกาญจนรัตน์	วรพงศ์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
25. นางสาวณัฐรัตน์	แก้ววินิตย์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

1. นายบุญวิทย์	รัตนทิพยาภรรณ์	ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. นายกิตติ	ละครสิงห์	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นางสาวณาริฐา	ดานุวงศ์	ครู สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
4. ว่าที่ ร.ต.คมชาญ	รอดประเสริฐ	ครู สกร.ระดับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
5. นายพรนรงค์	บุตรแก้ว	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
6. นายสกลศักดิ์	พงศ์วุฒิดก	ครู สกร.ระดับอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
7. นายทศพร	สุขาทิพย์	ครู สกร.ระดับอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
8. สิบเอกชยุต	อสิพงษ์	ครู สกร.ระดับอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
9. นายเฉลิมเกียรติ	ใจแก้ว	ครู สกร.ระดับอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
10. นายเพียว	เรียนชารี	ครู สกร.ระดับอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
11. นายวรรธนพงศ์	ทับธานี	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายปิยะพงษ์	กาละเมฆ	ครู สกร.ระดับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
13. นายกษิดิศ	นิลนนท์	ครู สกร.ระดับอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิถต์
14. นายศศิศ	นุชบาง	ครู สกร.ระดับอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิถต์
15. นายวัฒนพันธุ์	มั่นอ้น	ครู สกร.ระดับอำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
16. นายธนัชพัชญ์	ดียิ่ง	ครู สกร.ระดับอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

17. นายอุเทน	ชูวา	ครู สกร.ระดับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้;
18. นางสาวอุไรวรรณ	ฟักฉิม	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
19. นายสุทธินันท์	บัวทอง	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
20. นายปิยะกัลป์	ศรีเมือง	นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี
21. นายศรัณญ์	เนื่องเกตุ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.ระดับอำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
22. นางสาวหทัยมาดา	ดิฐประวรรตน์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้สุขภาวะและศิลปะ

1. นางสาวมนทา	เกรียงทวีทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดปทุมธานี
2. นางสาวจุฑาทิพย์	มหานาม	ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
3. นายธัญญา	ศรีเอม	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4. นางสาวโชติกา	ชัยชนะ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5. นายศิวะ	ปลั่งกลาง	ครู สกร.ระดับเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวอภิญญา	สังข์ทุ่ง	ครู สกร.ระดับเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
7. ว่าที่ ร.ต.อุทัย	พลมารักษ์	ครู สกร.ระดับเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
8. นายเสฏฐวุฒิ	เรื่องศิริ	ครู สกร.ระดับอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
9. นางสาวพัชรา	เพ็ชรดี	ครู สกร.ระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
10. นางอรรชนา	ชินทะวัน	ครู สกร.ระดับอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
11. นางดวงจันทร์	ประดับทอง	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
12. นางสาวเรืองนิตย์	สิ้นภัย	ครู สกร.ระดับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
13. นางสาวหงษ์ฟ้า	ปัสบาล	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
14. นายมูฮัมหมัดอัสรี	ยูโซะ	ครู สกร.ระดับอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
15. นางสาวซัลซาบีล	สะแม	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
16. นางสาวอิงอร	เอกนิล	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
17. นายปรัชญา	ป่องนันท์	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
18. นายจิระวัฒน์	วัฒนะกูลอิทธิ	นักวิชาการศึกษา สกร.ระดับเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
19. นายเผ่าไท	ภูมิสาขา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่

20. นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21. นางสาวอภิญญา	วงษา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. นางสาวอำภรณ์	ช่างเกวียน	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
2. นางสาวกิตติมา	ตั้งจิตเจริญกิจ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
3. นางสาวฐณัชญ์พร	นาห่อม	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
4. นายกิตติพันธ์	ปัญญาวงค์	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
5. นางสาวพิชชาพิมพ์	เพ็ชรเวียง	ครู สกร.ระดับอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
6. นางสาววราภรณ์	แสงดอกไม้	ครู สกร.ระดับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
7. นางสาวนริศรา	อิ่มวงษ์	ครู สกร.ระดับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
8. นางกมลชนก	วิสิษฐดำรงค์กุล	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
9. นางสาวพรทิพย์	ภัทรโชตินันท์	ครู สกร.ระดับอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
10. นางสาวรานี	รัศมีโรจน์	ครู สกร.ระดับอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
11. นายไตรทศ	มะโนสด	ครู สกร.ระดับอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
12. นางอุษา	สิ้วนัด	ครู อาสาสมัคร สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
13. นางสาวชนัญชิดา	ทองเมือง	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
14. นางสาวปานวดี	เสือหนู	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
15. นายภาณุวัฒน์	ไชยราช	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
16. นางสาวชญาน์นันท์	สีวิสุทธิ์	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
17. นายพิพัฒพงศ์	บุญเย็น	นักจัดการงานทั่วไป สกร.ระดับอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
18. นายจตุรงค์	ทองดารา	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

1. นางสาวสุดใจ	บุตรอากาศ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
2. นายจรินทร์	อุตสาหะ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
3. นายศุภวิชญ์	จิตธรรมมา	ครู สกรระดับอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

4. นางสาวอารยา	วิชาสวัสดิ์	ครู สกร.ระดับอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นางวิภาพร	คำมุงคุณ	ครู สกร.ระดับอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
6. นางสาวธัญวลัย	จัตุกูล	ครู สกร.ระดับอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
7. นางสาวตวงพร	ศรีศักดา	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
8. นางนิพัทธา	ไชยราช	ครู สกร.ระดับอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
9. นายศฤงคาร	โอคง	ครู สกร.ระดับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10. นางพิรุฬห์พร	ทำทอง	ครู สกร.ระดับอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
11. นางจิตรานันท์	ศรีวิลัย	ครู สกร.ระดับอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12. นายกฤตนนท์	จันทร์คลาย	ครู สกร.ระดับอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
13. นายพลพิทักษ์	ธิมาชัย	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14. นางสาววชิราภรณ์	เห็นพร้อม	ครู สกร.ระดับอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
15. นางฟาตีเมาะ	เหมมา	ครู สกร.ระดับอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
16. นางสาวอารีนา	เจะแต	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
17. นางสาวซามีฮ๊ะ	สาและ	ครู สกร.ระดับอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
18. นายภูริพงษ์	วีศรี	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
19. นางสาวปทิตตา	วิริยะธรรม	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
20. นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21. นางสาวอติพร	ยิ่งยงค์	กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567
ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
ณ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพมหานคร

---

1. นายชัยพัฒน์	พันธุ์วัฒนสกุล	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
2. นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยกกองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิการศึกษา

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นายเริง	กองแก้ว	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
2. นางสาวปริญญารัตน์	ม้าทอง	ครูชำนาญการ สกร.ระดับเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
3. นายเอกชัย	เอกวนาการ	ครู สกร.ระดับเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวรัชนก	โชติวิไลวรรณ	ครู สกร.ระดับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. นายไชยเดช	ไฝทอง	ครู สกร.ระดับอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
6. นางสาวภัคสรณ์สิริ	ศิลวันต์	ครู สกร.ระดับอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
7. นางสาวเบ็ญจวรรณ	อำไพศรี	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
8. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1. นางสาววิเลขา	ลีสุวรรณ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายโยฑิน	สมโนนนท์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
4. นางสาวธัญชนก	โรจน์โยธินพิพัฒน์	ครู สกร.ระดับอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
5. นายรัฐศาสตร์	สุขสวัสดิ์ครู	สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
6. นายนิตินัย	คนเพียร	ครู สกร.ระดับอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
7. นายอารัมภ์	คันธี	ครู สกร.ระดับอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
8. นางสาวสุกัญญา	กิ่งชา	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
9. นายสุทธินันท์	โอดลี	ครูผู้ช่วย สกร.ระดับอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
10. นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
11. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
2. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ภณัฐ	ก้วยเจริญพานิชก์	ผู้เชี่ยวชาญ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ดร.สุธารส	นิลรอด	นักวิชาการอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาววรณัน	ขุนศรี	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
5. นางธัญสินี	ฐานา	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
6. นายพรเทพ	พรมตา	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. นายเชวงศักดิ์	นวลพุดซา	ครู สกร.ระดับอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
8. นายวีรสิทธิ์	หารัญดา	ครู สกร.ระดับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
9. นายพิสันติ์	ศรีสุขา	ครู สกร.ระดับอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. นางสาวสุกัญญา	ธรรมนูญรักษ์	ครู สกร.ระดับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
11. นางสาวภัทรธิดา	จันทะวงษ์	ครู สกร.ระดับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
12. นายกันตภณ	พิมพาลัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
13. นางสาวจันทร์จิรา	ชูศรีเอี่ยม	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นางสาวธนพรรณ	ชาลี	ผู้ชำนาญ สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางตติยา	ใจบุญ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. นางสาวนันทยา	ทวีศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. นายเอกรินทร์	กำแก้ว	ครู สกร.ระดับเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
5. นางสาวนิภาพร	เชื้อพราหมณ์	ครู สกร.ระดับอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
6. นางสาวจิตต์ทิพย์	ลิ้มปรีดากูล	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี
7. นายกรณิศ	โอภาสพินิจ	ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. ว่าที่ ร.ต.ราชันต์	ทองสัน	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
9. นายวิทวัส	ทานาฤทัย	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
10. นายสุนทร	จันทร์เปล่ง	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11. นายวิศวกร	กิ่งจันทร์	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
12. นายจักรภพ	สายสุยะ	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด
13. นางสาวเพ็ญใจ	บริบูรณ์	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. นางสาวทิพวัลย์	ธรรมวงศ์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
15. นางเฉลิมขวัญ	รัตนโกศล	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
16. นางสาวฐานิตา	คล้ายอ่อน	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
17. นางสาวจิตติมา	โพธิ์จินดา	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

1. นายบุญวิทย์	รัตนทิพยาภรณ์	ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ว่าที่ ร.ต.คมชาญ	รอดประเสริฐ	ครู สกร.ระดับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
3. นายอนัตชัย	เกตุแก้ว	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นายปิยะพงษ์	กาละเมฆ	ครู สกร.ระดับอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
5. นายวรรธนพงศ์	ทับธานี	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายทศพร	สุขาทิพย์	ครู สกร.ระดับอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
7. นายธนัชพัชญ์	ดียิ่ง	ครู สกร.ระดับอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
8. นายปิยะกัลป์	ศรีเมือง	นักวิชาการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
9. นายศรัณญ์	เนื่องเกตุ	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สกร.ระดับอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
10. นายสุรเกียรติ	รัตนรอด	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
11. นางสาวหทัยมาดา	ดิฐประวรรตน์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้สุขภาวะและศิลปะ

1. นางสาวมนทา	เกรียงทวีทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดปทุมธานี
2. นางสาววิมล	เล็กสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดลพบุรี
3. นายธัญญา	ศรีเอม	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
4. นางสาวโชติกา	ชัยชนะ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5. นางอรรชนา	ชินทะวัน	ครู สกร.ระดับอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวพัชรา	เพ็ชรดี	ครู สกร.ระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
7. นายปรเมศวร์	ป้องนานาค	ครู สกร.ระดับอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
8. นายจิระวัฒน์	วัฒนะกูลอิทธิ	นักวิชาการศึกษา สกร.ระดับเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
9. นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
10. นางวรรณี	ศรีศิริวรรณกุล	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. นางสาวอำภรณ์	ช่างเกวียน	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
2. นายอัมพร	มากเพชร	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดราชบุรี
3. นางนัฏยา	ชูประดิษฐ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดสงขลา

4. นางสาวกิตติมา	ตั้งจิตเจริญกิจ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
5. นางสาวพิชชาพิมพ์	เพ็ชรเวียง	ครู สกร.ระดับอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
6. นางสาวพรทิพย์	ภัทรโชตินันท์	ครู สกร.ระดับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
7. นายไตรทศ	มะโนสด	ครู สกร.ระดับอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
8. นางสาวชญาน์นันท์	สีวิสุทธิ์	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
9. นายจตุรงค์	ทองดารา	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
10. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

1. นางสาวสุดใจ	บุตรอากาศ	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
2. นายอนุสรณ์	สุชาตานนท์	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอรทัย	ปานขาว	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4. นางสาวอารยา	วิชาสวัสดิ์	ครู สกร.ระดับอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นางสาวธัญวลัย	จัตุกูล	ครู สกร.ระดับอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
6. นางสาววชิราภรณ์	เห็นพร้อม	ครู สกร.ระดับอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
7. นางนิพัทธา	ไชยราช	ครู สกร.ระดับอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
8. นางสาวปทิตตา	วิริยะธรรม	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
9. นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
10. นางสาวอติพร	ยิ่งยงค์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2567
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2568
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

---

1. นายธนากร	ดอนเหนือ	อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
2. นายชัยพัฒน์	พันธุ์วัฒนสกุล	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
3. นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นายเริง	กองแก้ว	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดนนทบุรี
2. นางสาวปริญญารัตน์	ม้าทอง	ครูชำนาญการ สกร.ระดับเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
3. นางผกามาศ	เรืองจิรัษเฐียร	ครู สกร.อระดับเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวรัชนก	โชติวิไลวรรณ	ครู สกร.ระดับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. นายอรรถกร	สิงทะบุตร	ครู กศน.ตำบล สกร.ระดับเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวเบ็ญจวรรณ	อำไพศรี	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
7. นางสาวชมพูนท	สังข์พิชัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

1. นางสาววิเลขา	ลีสุวรรณ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดเชียงใหม่
2. นายโยทิน	สมโนนนท์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. นางสาวปรารถนา	พุทธศรี	ครู สกร.ระดับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
4. นายอารัมภ์	คันธี	ครู สกร.ระดับอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
5. นางสาวสุกัญญา	กิ่งชา	ครู สกร.ระดับอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวชนัญชิดา	สยานันท์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
7. นางสาวสุดารัตน์	ชาญชัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
2. นางสาววรณัน	ขุนศรี	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
3. นางธัญสินี	ฐานา	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
4. ดร.สุธารส	นิลรอด	นักวิชาการอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายพรเทพ	พรมตา	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. นายอชิรวิทย์	บรรเทากุล	ครู สกร.ระดับอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
7. นายกันตภณ	พิมพาลัย	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
8. นางสาวปิยวดี	คะเนสม	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

9. นางสาวจันทร์จิรา	ชูศรีเอี่ยม	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. นางสาวธนพรรณ	ชาลี	ผู้ชำนาญ สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวนันทยา	ทวีศักดิ์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. นางสาวนิภาพร	เชื้อพราหมณ์	ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
4. นายกรณิศ	โอภาสพินิจ	ครู อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. นายสุนทร	จันทร์เปล่ง	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
6. นายจักรภพ	สายสุยะ	ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด
7. นายนิยม	โพธิ์ทอง	ครู สกร.ระดับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
8. นางสาวทิพวัลย์	ธรรมวงศ์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
9. นางเฉลิมขวัญ	รัตนโกศล	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
10. นางสาวฐานิตา	คล้ายอ่อน	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

1. นายบุญวิทย์	รัตนทิพยาภรณ์	ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ว่าที่ ร.ต.คมชาญ	รอดประเสริฐ	ครู สกร.ระดับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
3. นายอนัตชัย	เกตุแก้ว	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นายวรรธนพงศ์	ทับธานี	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นางสาวหทัยมาดา	ดิฐประวรรตน์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้สุขภาวะและศิลปะ

1. นางสาวมนทา	เกรียงทวีทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดปทุมธานี
2. นายจิรพงศ์	ผลนาค	ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3. นายสยาม	สมใจ	ครู สกร.ระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
4. นายนิรุตติ์	วงษ์สุวรรณ	ครูอาสามัคร กศน สกร.ระดับอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
5. นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
6. นางวรรณี	ศรีศิริวรรณกุล	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1. นางสาวอำภรณ์	ช่างเกวียน	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลำปาง
2. นายอัมพร	มากเพชร	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดราชบุรี
3. นางสาวกิตติมา	ตั้งจิตเจริญกิจ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
4. นางสาวพรทิพย์	ภัทรโชตินันท์	ครู สกร.ระดับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
5. นายจตุรงค์	ทองดารา	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
6. นางสาววีราภรณ์	เกิดศิริ	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

1. นายอนุสรณ์	สุชาตานนท์	ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวพัชรา	จงโกรย	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดลพบุรี
3. นางสาวอรทัย	ปานขาว	ครู สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
4. นางสาวอารยา	วิชาสวัสดิ์	ครู สกร.ระดับอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
5. นางสาววชิราภรณ์	เห็นพร้อม	ครู สกร.ระดับอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6. นางสาวฐิติมา	วงศ์บัณฑวรรณ	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
7. นางสาวอติพร	ยิ่งยงค์	กองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

คณะผู้จัดทำ

คณะที่ปรึกษา

นายธนากร	ดอนเหนือ	อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายชัยพัฒน์	พันธุ์วัฒนสกุล	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายเอกราช	ชวีวัฒน์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นางยุพิน	บัวคอม	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นางพรรณทิพา	ชินชัชวาล	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ

คณะบรรณาธิการ

1. นายธานี	เครืออยู่	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ
2. นางสาวมนทา	เกรียงทวีทรัพย์	ข้าราชการบำนาญ
3. นางสาววิมล	เล็กสูงเนิน	รองผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร. ประจำจังหวัดลพบุรี
4. นายจิรพงศ์	ผลนาค	ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
5. นายธัญญา	ศรีเอม	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
6. นางสาวโชติกา	ชัยชนะ	ครูชำนาญการ สกร.ระดับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
7. นางอรรชนา	ชินทะวัน	ครู สกร.ระดับอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8. นางสาวพัชรา	เพ็ชรดี	ครู สกร.ระดับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
9. นายสยาม	สมใจ	ครู สกร.ระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
10. นายนิรุตติ์	วงษ์สุวรรณ	ครูอาสามัคร กศน สกร.ระดับอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
11. นายจิระวัฒน์	วัฒนะกูลอิทธิ	นักวิชาการศึกษา สกร.ระดับเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ประสานงาน

นางสาวทิพวรรณ	วงค์เรือน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวรรณี	ศรีศิริวรรณกุล	นักวิชาการศึกษา

ออกแบบปก

นายปรเมศวร์	ป้องนานาค	ครู

หนังสือเรียนรายวิชา
สุขภาวะและศิลปะ

รหัสรายวิชา สศ310001

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2567
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ